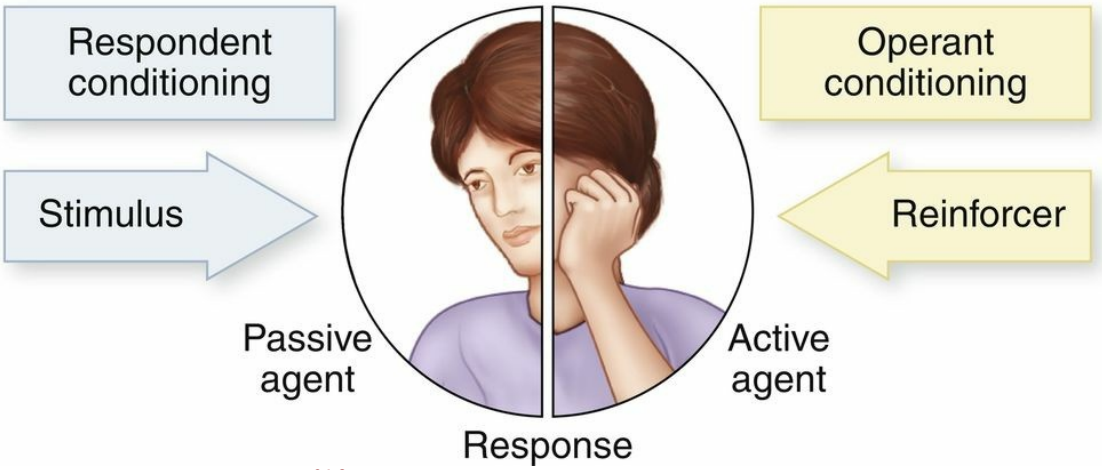
- Хабеас корпусын эрх
- Бие даасан сэтгэцийн эрүүл мэндийн үзлэгт байх эрх
- Төрийн албан хаагчийн статустай байх эрх
- Жишээлбэл жолоочийн эсвэл мэргэжлийн лиценз зэрэг хуулиар тогтоосон зөвшөөрөл, эрх, тусгай зөвшөөрлийг хадгалах эрх
- Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах болон нэхэмжлэл хүлээн авах эрх
- Гэрлэх болон салах эрх
- Шаардлагагүй механик хориг сааднаас ангид байх эрх
- Статусын тогтмол хяналт шалгалтын эрх
- Хууль зүйн төлөөлөл авах эрх
- Нууцлалын эрх
- Мэдээлэлд суурилсан зөвшөөрөл өгөх эрх
- Эмчилгээ авах эрх
- Эмчилгээг татгалзах эрх
- Хамгийн бага хязгаарлагдмал орчинд эмчилгээ авах эрх

Анхаар: Улсын болон мужийн хуулийг үргэлж дагах ёстой.

Стюарт Г-ийн *«Психиатрийн сувилахуйн зарчим ба практик»*, 10 дахь хэвлэл, Сент-Луис, 2013, Mosby.



Зураг 64-2. . Хариулагч ба үйлдэл дээр суурилсан нөхцөлжүүлэлт.

Хайрцаг 64-3

Өөрөө туслах болон дэмжлэгийн бүлгүүд

- Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэгч эцэг эхийн насанд хүрсэн хүүхдүүд
- Аль-Анон

- Согтууруулах ундаа хэт хэрэглэгчдийн нэрээ нууцлах холбоо
- Гашуудлын бүлгүүд
- Хавдрын дэмжлэгийн бүлгүүд
- Хамааралтай хүмүүсийн нэрээгүй бүлэг
- Мөрийтэй тоглогчдын нэрээ нууцлагдсан бүлэг
- Гэр бүлийн гишүүдээ асрахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах бүлгүүд
- Мастэктоми эсвэл колостоми зэрэг биеийн дүр төрхийн гэнэтийн өөрчлөлттэй зохицоход туслах бүлгүүд
- Сэтгэцийн эрүүл мэндийн дэмжлэгийн бүлгүүд
- Наркомануудын Нууцлаг Холбоо
- Их иддэгчдийн нэрээ нууцлах холбоо
- Ханьгүй эцэг эхчүүд
- Гэмтэл амссан хүмүүст зориулсан сэргэлтийн бүлгүүд
- Тамхи татдаггүй болох бүлгүүд

Дасгалын асуултууд

787. Сэтгэл гутралтай гэж оношлогдсон, амиа хорлох оролдлого хийсэн үйлчлүүлэгч сувилагчид "Би үхэх ёстой байсан. Би үргэлж бүтэлгүйтдэг. Надад юу ч хэзээ ч бүтдэггүй" гэж хэлэв. Сувилагчийн ямар хариу эмчилгээний харилцааны жишээ болох вэ?
    1. "Чи амьдрахын төлөө бүхнээ авч явах ёстой."
    2. "Яагаад чи өөрийгөө бүтэлгүйтэн гэж үздэг юм бэ?"
    3. "Ийм мэдрэмж төрж байгаа нь сэтгэл гутралын нэг хэсэг юм."
    4. "Чи удаан хугацаанд өөрийгөө бүтэлгүйтэн гэж мэдэрч байна уу?"
788. Сувилагч нь үйлчлүүлэгчийнхээ гэрт очиж уулзав. Үйлчлүүлэгч "Сүүлийн хэдэн шөнө огт унтаж чадаагүй" гэж хэлэв. Сувилагчийн аль хариулт эмчилгээний харилцааны жишээ мөн вэ?
    1. "Ойлголоо."
    2. "Үнэхээр үү?"
    3. "Та унтахад хүндрэлтэй байна уу?"
    4. "Заримдаа би ч бас унтахад хэцүү байдаг."
789. Бодол санаа нь эмх замбараагүй болсон нэгэн үйлчлүүлэгч хоолоо хордуулж байна гэж итгэдэг. Сувилагч үйлчлүүлэгчийг хооллохыг уриалахын тулд ямар харилцааны аргыг ашиглах ёстой вэ?
    1. Нээлттэй асуулт болон чимээгүй байдлыг ашиглах
    2. Хоол сонгохтой холбоотой хувийн таашаалыг хуваалцах
    3. Өвчтөн хооллохыг хүсэхгүй байгаа шалтгааныг тэмдэглэх
    4. 790. Хангалттай тэжээллэг хоол хүнсний шаардлагатай байдлын талаар

санал дэвшүүлэх. Сувилагч бүлгийн дуусгах шатны аль зорилгыг төлөвлөх ёстой вэ?
хөгжлийн аль зорилгыг төлөвлөх вэ? **Хамаарах бүгдийг сонгоно уу.**

- ☐ 1. Бүлэг туршлагыг үнэлдэг.
- ☐ 2. Бүлгийн жинхэнэ ажил нь биеллээ.

☐ 3. Бүлгийн харилцан яриа нь гадаргын шинжтэй байдаг.

☐ 4. Бүлгийн гишүүд бие биенээ танилцдаг.

☐ 5. Бүлгийн дүрэм, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох тодорхой зохион байгуулалт явагддаг.

☐ 6. Бүлэг гишүүдийн бүлэгт хандах мэдрэмжийг судалж, хүн удахгүй болох салалт.

791. Төгсгөл шатандаа орсон хорт хавдартай гэж оношлогдсон нэгэн үйлчлүүлэгч сувилагчид хэлэв: "Би үхэх гэж байна, гэр бүл маань эмчилгээг хүлээх найдлагаа зогсоож өгөөч! Тэд ингэж найдаад байхаар би маш их уурладаг. Эцэст нь үхэх гэж байгаа хүн чинь би шүү дээ." Сувилагчийн аль хариулт эмчилгээний үр дүнтэй вэ?

1. "Та гэр бүлдээ сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлсэн үү?"
2. "Би таны уур хилэнг гэр бүлийнхэнтэйгээ илүү ярилцах хэрэгтэй гэж бодож байна."
3. Таны гэр бүл таныг эдгэрнэ гэж найдаж байгаагаас та уурлаж байна уу?
4. "Та магадгүй маш их гутралд автсан байгаа, ийм оноштой үед энэ нь ойлгомжтой."

792. Өвчтөний бүртгэлийг хянаж үзэхэд сувилагч өвчтөн өөрөө сайн дураараа хэвтэн эмчлүүлэхээр ирсэн гэдгийг тэмдэглэсэн. Энэ мэдээлэлд үндэслэн сувилагч өвчтөний ямар зан байдал илрэхийг урьдчилан таамаглан асаргаа үйлчилгээний төлөвлөгөө гаргана вэ?

1. Эмчилгээний арга хэмжээтэй холбоотой айдас
2. Бусдад чиглэсэн уур хилэн ба түрэмгий зан
3. Диагнозын патологи, шинж тэмдгүүдийг ойлгох
4. Эмчилгээ, асаргааны төлөвлөгөөнд оролцох хүсэл эрмэлзэл

793. Сэтгэл түгшүүрийн эмчилгээнд өөрийн хүсэлтээр хэвтсэн үйлчлүүлэгч эмнэлгээс гарахыг шаардаж байна. Сувилагч **эхлээд** ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?

1. Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчтэй (HCP) холбогдох.
2. Тээврийн зохицуулалтыг хийхийн тулд үйлчлүүлэгчийн гэр бүлтэй холбогдох.
3. Өвчтөнд "зөвхөн хэдхэн хоног" үлдэхийг ятгахыг оролдох.
4. Өвчтөнд эмнэлгээс гарвал албадан хэвтүүлэх магадлалтай гэж хэл.

794. Эмчилгээнд хүлээн авах үнэлгээг хянаж байхдаа сувилагч нь үйлчлүүлэгчийг сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасагт албадан хүлээн авсан болохыг анзаарсан. Энэ төрлийн хүлээн авалтын дагуу сувилагч нь үйлчлүүлэгчид ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?

1. Өөртөө болон бусдад хохирол учруулахыг анхааралтай ажигла.
2. Элсэлтийн өргөдөл бөглөхөд туслах.
3. Клиентд түүний сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлын талаар бичгээр мэдээлэл өгөх.
4. Гэр бүлд хүлээн авалт яагаад шаардлагатай гэж үзсэнийг хэлэлцэх боломж олгох.

795. Хэрэв үйлчлүүлэгчийг анорексиа нервоза оноштойгоор сэтгэцийн эрүүл мэндийн хэвтэн эмчлүүлэх тасагт хүлээн авсан бол эмчилгээний төлөвлөгөөнд когнитив зан үйлийн аргыг ашиглана. Сувилагч энэ аргын аль зорилго дээр үндэслэн асаргааг төлөвлөдөг вэ?

1. Дэмжлэгтэй орчныг бүрдүүлэх
2. Дотоод сэтгэлзүйн зөрчил, өнгөрсөн асуудлуудыг судлах
3. Харилцаанаас татгалздаг үйлчлүүлэгчидтэй нийгмийн харилцааг онцлох
4. Клиентээсээ хэвийн бус бодол, итгэл үнэмшлээ эргэцүүлэн харахад нь туслах

796. Клиент анх удаа Мөрийтэй тоглогчдын нэрээ нууцлах бүлгийн уулзалтад оролцохоор бэлдэж байна удаа. Сувилагч энэ 12 алхмын хөтөлбөрийн эхний алхам юу болохыг үйлчлүүлэгчдээ хэлэх ёстой вэ?

1. Асуудалтай гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх
2. Мөрийтэй тоглоомыг бусад үйл ажиллагаагаар орлуулах
3. Мөрийтэй тоглоомыг зогсооно гэж мэдэгдэх
4. Мөрийтэй тоглодог хүмүүстэй харилцаагаа таслах

797. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн эмнэлэгт ажилладаг сувилагч орон нутгийн хүнсний дэлгүүрт хөрштэйгээ тааралдлаа. Хөрш нь сувилагчид "Кэрол яаж байна? Тэр миний хамгийн сайн найз бөгөөд долоо хоног бүр танай эмнэлэгт үзүүлдэг" гэжээ. Сувилагчийн **хамгийн зохистой** хариу аль вэ?

1. "Би ямар ч үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдлын талаар тантай ярилцаж чадахгүй."
2. "Хэрвээ та Каролын тухай мэдэхийг хүсч байвал түүнээс нь өөрөө асуух хэрэгтэй."
3. "Зөвхөн та найзынхаа төлөө санаа зовж байгаа учраас түүний бие сайжирч байгааг хэлж өгье."
4. Түүний найз хүний хувьд чи түүнийг хэцүү үедээ байгааг мэдэж, хувийн орон зайг нь хүндэтгэх ёстойг ойлгож байна.

798. Сувилагч нь өвчтөн өөрийн хүсэлтээр хэвтсэн боловч аман доромжлол гаргаж, эмнэлгээс гарахыг шаардаж эхлэхэд аюулгүй байдлын албанд дуудлага өгч, бие махбодийн хязгаарлалт тогтоосон. Эдгээр арга хэмжээтэй холбоотой сувилагчид тулгарч болох хууль эрх зүйн үр дагаврыг **доорх жагсаалтаас бүгдийг сонгоно уу.**

1. Гүтгэлэг
2. Хүний биед халдах
3. Хүний биед халдах
4. Гүтгэлэг
5. Хууль бусаар хорих

799. Сэтгэцийн [illegible] мэндийн тасгийн сувилагч үйлчлүүлэгчтэй харилцахдаа ямар эмчилгээн[illegible]рилцааны аргыг ашиглахаар төлөвлөж байна вэ? **Хамаарах бүгдийг сонгоно уу.**

1. Дахин илэрхийлэх
2. Актив сонсох
3. Клиентээс "Яагаад?" гэж асуух
4. Төвийг сахисан хариу үйлдэл үзүүлэх
5. Хүлээн зөвшөөрөл болон санал сэтгэгдэл өгөх
6. Зөвлөгөө өгөх ба зөвшөөрөх эсвэл зөвшөөрөхгүй байх

800. Бүлгийн эм[illegible]ээний хуралдааныг дангаар эзэгнэж буй манийн үеийн үйлчлүүлэгчийг зохицуулахад **хамгийн зохистой** сувилагчийн арга хэмжээ юу вэ?

1. Энэ удаагийн хуралдаанд л бүлгээс гарахыг үйлчлүүлэгчээс хүс.
2. Өвчтөнийг бусад манийн өвчтөнүүдтэй хамт өөр бүлэгт шилжүүл.
3. Өвчтөнд давамгайлахыг зогсоохыг шийдэмгий боловч энэрэнгүйгээр хэл.
4. Өгсөн саналд нь талархал илэрхийлээд, одоо бусад хүмүүс ч мөн санал гаргах боломжтойг мэдэгдээрэй.

801. Нэг үйлчлүүлэгч эмчилгээний бүлэгт оролцож, бүлгийн бүх гишүүдийг үйлчлүүлэгчдэд зорилгодоо хүрэхэд тэнцүү ач холбогдолтой гэж үздэг. Сувилагч ямар эмчилгээний аргыг хэрэгжүүлж байна вэ?
    1. Орчны эмчилгээ
    2. Хувь хүмүүсийн хоорондын эмчилгээ
    3. Зан төлөвийн өөрчлөлт
    4. Дэмжлэгийн бүлгийн эмчилгээ

802. Сувилагч нь баатарлаг хүчин чармайлт гаргасан ч гэр шатаж буй байшин дотор гацсан хөршөө аварч чадаагүй үйлчлүүлэгчтэй ажиллаж байна. Сувилагч–үйлчлүүлэгчийн харилцааны ажиллах үе шатанд сувилагч ямар үйлчлүүлэгч төвтэй үйлдэл хийх ёстой вэ?
    1. Үйлчлүүлэгчийн өөрийгөө авч явах чадварыг судлах
    2. Үйлчлүүлэгчийн өөрийгөө гэмтээх эрсдэлийг судлах
    3. Үйлчлүүлэгчийн аврах ажиллагаа яагаад амжилтгүй болсон талаарх ойлголт, үнэлгээг лавлах
    4. Дасан зохицох чадварт саад учруулж болзошгүй үйлчлүүлэгчийн ямар ч мэдрэмжийг лавлан асууж, судлах

Хариултууд

787. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Клиентийн илэрхийлсэн сэтгэл хөдлөлд хариу өгөх нь үр дүнтэй эмчилгээний харилцааны техник юм. Зөв сонголт нь дахин илэрхийлэх (restating) аргыг ашигласан жишээ юм. Бусад сонголтууд нь клиентийн туршлагыг багасгах, түүний илэрхийлсэн сэтгэл хөдлөлийг судлахад саад учруулдаг тул харилцааг хаадаг. Мөн *"яагаад" гэдэг* үгийг ашиглах нь эмчилгээний харилцаанд тохиромжгүй, учир нь клиентүүд *"яагаад"* гэсэн асуултыг ихэвчлэн буруутгал гэж ойлгодог. *"Яагаад"* гэсэн асуултууд нь уур хилэн, итгэлгүй байдал, үл итгэлийг үүсгэж болно.

Шалгалт өгөх стратеги: **Эмчилгээний харилцааны техник** ашиглан үйлчлүүлэгчийн мэдрэмж, санаа зовнилыг шууд хөндсөн сонголтыг ол. Мөн зөв сонголт нь нээлттэй асуултын хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн цорын ганц сонголт бөгөөд энэ нь мэдрэмжээ үгээр илэрхийлэхийг дэмжинэ.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа ***Гол ойлголтууд:*** Харилцаа; Сэтгэл хөдлөл ба нөлөөлөл ***Дүгнэлт:*** Varcarolis (2017), 97–98-р тал.

788. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Зөв хувилбар нь дахин илэрхийлэх эмчилгээний харилцааны техник ашигладаг. Дахин илэрхийлэх нь асуулт өдөөх бүрэлдэхүүн хэсэгтэй ч үйлчлүүлэгчийн гол сэдвийг давтан хэлж, сувилагчид асуудлыг илүү тодорхой ойлгоход тусалдаг. Үлдсэн хувилбарууд нь эмчилгээний хариултууд биш бөгөөд аль нь ч үйлчлүүлэгчийг асуудлаа дэлгэрүүлэхэд урамшуулдаггүй. Хувийн туршлагаа хуваалцах нь анхаарлыг үйлчлүүлэгчээс сувилагч руу шилжүүлдэг.

Шалгалт өгөх стратеги: **Эмчилгээний харилцааны техник** ашиглах**.** "Би ойлгож байна" гэдэг нь ерөнхий эхлэл боловч үйлчлүүлэгчид яриагаа үргэлжлүүлэх боломж олгодоггүй. "Үнэхээр үү?" гэдэг нь үйлчлүүлэгчийг итгэгдээгүй мэт мэдрэмж төрүүлэх хариу болж болно. Хувийн туршлагаа хуваалцах нь сувилагчийн асуудалд төвлөрч, үйлчлүүлэгчийн санаа зовнилыг багасгана. Зөв сонголт нь үйлчлүүлэгчийн өнцгөөс асуудлыг хэрхэн ойлгож байгааг харуулах мэдээлэл өгнө.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Өвчтөний хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүтэн байдал

Нэгдмэл процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Харилцаа; Унтах

Эшлэл: Varcarolis (2017), 96-97-р хуудас.

789. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Нээлттэй асуултууд болон чимээгүй байдал нь үйлчлүүлэгчдийг асуудлаа ярилцахад урамшуулах стратеги юм. Хувийн хоолны дуртай зүйлээ хуваалцах нь үйлчлүүлэгч төвтэй оролцоо биш юм. Үлдсэн сонголтууд нь үйлчлүүлэгчийг мэдрэмжээ илэрхийлэхийг урамшуулахгүй тул түүнд тустай биш. Сувилагч нь өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхгүй, үйлчлүүлэгчийг зан үйлдээ нөлөөлсөн шалтгааныг тодорхойлоход нь дэмжлэг үзүүлэх ёстой.

Шалгалт өгөх стратеги: **Эмчилгээний харилцааны техникүүдийг** ашигла**.** Эхлээд үйлчлүүлэгчийн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд дэмжлэг үзүүлэхгүй сонголтуудыг хас. Дараа нь үйлчлүүлэгч төвтэй бус аливаа сонголтыг хас. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл хөдлөлд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Харилцаа; Психоз

Дэлгэрэнгүй: Varcarolis (2017), 92, 95-р хуудас.

790. ***Хариулт:*** 1, 6

Үндэслэл: Бүлгийн хөгжлийн үе шатууд нь эхний үе шат, ажиллах үе шат, дуусгах үе шатнаас бүрдэнэ. Эхний үе шатанд бүлгийн гишүүд бие биенээ танилцаж, бүлгийн дүрэм, үүрэг, болон

хариуцлага тогтоогддог. Эхний шатанд бүлгийн харилцан яриа гүн биш, гадаргын шинжтэй байдаг. Ажлын шатанд бүлгийн жинхэнэ ажил хийгддэг. Хаалтын шатанд бүлэг туршлагаа үнэлж, гишүүдийн бүлэгт хандах болон тун удахгүй салах тухай мэдрэмжийг судладаг.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв болон** хаалтын шатны талаар төвлөр. Өгөгдсөн тус бүрийн зүйлийг уншиж, бүлгийн хөгжлийн шатнууд болон хаалтын тодорхойлолтыг санаж байх нь энэ асуултад хариулахад тусална.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Хамааралгүй

Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд: Хамтын ажиллагаа; Харилцаа холбоо

Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 111-113-р хуудас.

791. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Дахин хэлэх нь эмчилгээний харилцааны техник бөгөөд сувилагч үйлчлүүлэгчийн хэлсэн зүйлийг ойлгосон гэдгээ харуулах, хэлсэн зүйлийг дахин хянах зорилгоор давтан хэлдэг.
Сувилагч үйлчлүүлэгчийн гэр бүлийн гишүүдтэйгээ мэдрэмжээ илэн далангүй ярилцах чадварыг үнэлэх гэж оролдох нь зохистой ч энэ нь үйлчлүүлэгчид уур бухимдлыг үүсгэж буй мэдрэмжээ ярилцахад нь тусалдаггүй. Сувилагчийн үйлчлүүлэгчээс уур бухимдлынхаа талаар илүү ярихыг шууд шаардах оролдлого нь хэтэрхий эрт байна. Сувилагч үйлчлүүлэгчийн мэдрэмжийн шалтгааныг хэзээ ч дүгнэх ёсгүй; энэ нь нэг-нэг харилцаанд эмчилгээний бус юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Эмчилгээний харилцааны техникүүдийг** ашигла**.** Зөв сонголт нь эмчилгээний техник (дахин илэрхийлэх) ашигласан бөгөөд үйлчлүүлэгчийн мэдрэмжид төвлөрдөг ганц сонголт юм.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа

Голчлон анхаарах ойлголтууд: Харилцаа; Гэр бүлийн динамик ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 96-р тал.

792. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Ерөнхийдөө үйлчлүүлэгчид сайн дураараа хэвтэн эмчлүүлэх хүсэлт гаргадаг. Хэрэв үйлчлүүлэгч сайн дураараа хэвтэн эмчлүүлэх хүсэлт гаргавал, тухайн хүн тусламж эрж байгаа тул эмчилгээний хөтөлбөрт оролцоно гэж хамгийн их хүлээгддэг. Үлдсэн сонголтууд нь энэ төрлийн хэвтүүлэлтийн онцлог биш юм. Айдас, уур хилэн, түрэмгий зан нь албадан хэвтүүлэлтийн илүү нийтлэг шинж тэмдэг юм. Сайн дураараа хэвтэн эмчлүүлэх нь үйлчлүүлэгч сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлаа ойлгосон гэдгийг баталгаажуулдаггүй, зөвхөн тусламж хүсэх хүсэл эрмэлзлийг нь илтгэнэ.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт** анхаарлаа төвлөрүүлж**,** сайн дураараа гэдгийг анхаар. Энэ нь таныг зөв сонголтод хөтлөх ёстой. *"voluntary"* гэдэг үгтэй холбоог анхаар.

болон зөв хариулт.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд:
Хямрал. ***Эрэмбэлэх ойлголтууд:*** Эмчилгээний
зааврыг дагах; Асран халамжлах**.** ***Лавлагаа:*** Varcarolis
(2017), 63-р тал.

793. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Ерөнхийдөө үйлчлүүлэгчид сайн дурааараа хэвтэн эмчлүүлэх хүсэлт гаргадаг. Сайн дурааараа хэвтсэн үйлчлүүлэгчид өөрсдийгөө эсвэл бусдыг шууд аюулд оруулахгүй бол суллагдах эрхтэй бөгөөд энэ нөхцөлд тухайн бүс нутаг, байгууллагын журам, нөхцөл байдлаас хамааран хэвтүүлсэн эмчилгээг албадан үргэлжлүүлэх боломжтой. Сувилагч нь улсын болон байгууллагын бодлого, журам, үйл явцтай танил байх шаардлагатай. Эхний сувилахуйн арга хэмжээ нь РНСР-тэй холбогдох явдал бөгөөд түүнд үйлчлүүлэгчтэй гарах талаар ярилцах эрх олгогдсон байдаг. Аюулгүй тээвэрлэлтийг зохион байгуулах нь зохистой ч энэ нөхцөлд хэтэрхий эрт бөгөөд зөвхөн үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрлөөр хийгдэх ёстой. Өвчтөн яагаад гарах шаардлагатай гэж мэдэрч байгаа болон эмчийн зөвлөгөөг үл тоон гарах боломжит үр дагаврыг хэлэлцэх нь зүйтэй ч, түүнийг "зөвхөн хэдхэн хоног илүү" үлдэхээр зөвшөөрүүлэх оролдлого нь үнэ цэнэгүй бөгөөд амжилт олох магадлал багатай. Олон мужид үйлчлүүлэгч нь бичгээр чөлөөлөх мэдэгдлийг байгууллагын сэтгэл зүйчид өгөх шаардлагатай бөгөөд сэтгэл зүйч нь хуульд заасан шалгуурын дагуу шаардлагатай бол үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдлыг дахин үнэлж, албадан эмчлэх статустай болгох боломжийг авч үздэг. Энэ нь боломжтой ч үйлчлүүлэгчид сүрдүүлэг болгон ашиглаж болохгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: *Эхлээд* **стратегийн үгийг** тэмдэглэ. Эмнэлэгт хэвтэх төрлийг тодорхойлох нь боломжгүй хувилбаруудыг хасаж, зөв хувилбар руу чиглэхэд тусална. Өвчтөний эрх, нууцлалын асуудлаас шалтгаалан гэр бүлд нь залгахыг хасах ёстой. Өвчтөнийг эмнэлэгт үлдэхийг "ятгах" нь зохимжгүй. Өвчтөнд заналхийлэх нь зохимжгүй бөгөөд хууль бус.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилтийн
агуулгын салбар: Удирдлага/Менежмент: Этик/Хууль эрх зүйн
эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хямрал
Эрэмбэлэх ойлголтууд: Клиникийн шийдвэрлэлт; Эрүүл мэндийн тусламжийн хууль
Эшлэл: Varcarolis (2017), 63-64-р хуудас.

794. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Хүнийг өөртөө болон бусдад аюултай эсвэл сэтгэцийн эмчилгээ шаардлагатай үед, үйлчлүүлэгчийн эмнэлэгт хэвтэх зөвшөөрөл өгөх эсэхээс үл хамааран албадан хэвтүүлэх шаардлагатай. Бичгээр өгсөн хүсэлт нь сайн дурааараа хэвтэх нэг бүрдэл хэсэг юм. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлын талаар бичгээр мэдээлэл өгөх нь эхэндээ хэтэрхий эрт байж болно. Гэр бүл үйлчлүүлэгчийг хэвтүүлэхэд оролцоогүй байж болно.

Шалгалт өгөх стратеги: Шалгалтын **сэдэв** нь албадан хэвтүүлэх явдал **юм**. **Маслоугийн хэрэгцээний иерархийн онолыг** ашигла**.** Физиологийн хэрэгцээ байхгүй бол аюулгүй байдал хамгийн чухал тул энэ нь таныг зөв сонголтод хөтлөх ёстой. Мөн үлдсэн сонголтууд нь албадан хэвтүүлэх тохиолдолд үргэлж үнэн биш гэдгийг анхаарна уу.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэл-нийгмийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хямрал

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Хүмүүсийн хоорондын хүчирхийлэл; Аюулгүй байдал

Дүрийн ишлэл: Varcarolis (2017), 63-р тал.

795. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Когнитив зан үйлийн эмчилгээ нь үйлчлүүлэгчид хэвийн бус бодлуудаа тодорхойлж, шинжлэх, мөн эдгээр бодлыг хадгалдаг үнэт зүйлс, итгэл үнэмшлээ тодорхойлж, шинжлэхэд тусалдаг. Үлдсэн сонголтууд нь тодорхой нөхцөлд эмчилгээний ач холбогдолтой ч когнитив зан үйлийн эмчилгээний гол анхаарал биш юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт** төвлөр**,** когнитив зан үйлийн хандлагын зорилгод анхаар. Асуулга дахь *"cognitive"* гэдэг үг болон зөв хариулт дахь *бодлуудын* хоорондын харилцааг анхаар.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хооллолтын эмгэг ***Гол ойлголтууд:*** Асран халамж; Танин мэдэхүй

Дүрийн лавлагаа: Varcarolis (2017), 24, 318-р тал.

796. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: 12 алхмын хөтөлбөрийн эхний алхам нь асуудал байгааг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Мөрийтэй тоглоомын оронд өөр үйл ажиллагаа хийх нь стратеги байж болох ч энэ нь эхний алхам биш юм. Үлдсэн сонголтууд нь 12 алхмын хөтөлбөрийн эхний алхамд бодитой стратеги биш юм.

Шалгалт өгөх стратеги: Анхаарлаа **сэдэвт** төвлөрүүл**,** 12 алхмын хөтөлбөрийн эхний алхам. Энэ нь таныг зөв сонголтыг хийхэд чиглүүлэхэд тусална.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал

Нэгдмэл процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Донтолт

Эрхэмлэх ойлголтууд: Донтолт; Асран халамж ***Лавлагаа:***
Varcarolis (2017), 318–319-р тал.

797. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Сувилагч нь үйлчлүүлэгч болон түүний асаргааны талаарх нууцыг хадгалах шаардлагатай. Нууцлал нь эмчилгээний харилцааны суурь бөгөөд үйлчлүүлэгчийн эрх юм. Хөршид өгөх хамгийн зохистой хариу бол энэ үүргийг шулуухан боловч эелдгээр илэрхийлэх явдал юм. Сувилагч яагаад үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг илчилж чадахгүйг тайлбарлаагүй шулуухан мэдэгдэл нь хүндэтгэлгүй, халамжгүй мэт ойлгогдож болно. Үлдсэн сонголтууд нь үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалдаггүй мэдэгдлүүдийг зааж байна.

Шалгалт өгөх стратеги: *Хамгийн зохистой* **стратегийн үгсийг** тэмдэглэ. Нууцыг хадгалахад анхаарлаа төвлөрүүлэх нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно. Мөн энэ анхаарал нь ийм мэдээллийг зохисгүйгээр илчилдэг сонголтуудыг хэт шулуун эсвэл бүдүүлгээр хэлэлгүйгээр хасах боломжийг олгоно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үйлчилгээний орчин ***Интеграцчилсан процесс:*** Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Удирдлага/Менежмент: Ёс зүй/Хууль

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа

Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд: Этика; Эрүүл мэндийн тусламжийн хууль

Дэлгэрэнгүй: Potter et al. (2017), 306, 798-р тал.

Хариулт: 2, 3, 5

Үндэслэл: Хүнийг худал хорих нь хүнийг тодорхой газарт хорих зорилготой үйлдэл юм. Хэрвээ сувилагч өвчтөнийг сайн дурааараа хэвтэн эмчлүүлэхээр ирсэн бөгөөд түүнийг баривчлах ямар ч байгууллага эсвэл хууль ёсны бодлого байхгүй үед эмнэлгээс гарахыг нь хориглосон бол худал хорих гэмт хэрэгт буруутгагдаж болно. Хүч хэрэглэх болон бие махбодийн халдлага нь өвчтөнийг ийм оролцооны шаардлага хангаагүй нөхцөлд хязгаарлах үйлдэлтэй холбоотой. Гүтгэлэг болон гүтгэлгийн үг энд хамаарахгүй, учир нь сувилагч өвчтөний тухай худал мэдэгдэл бичгээр болон аман хэлбэрээр гаргаагүй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв болон** эмнэлэгт хэвтэхтэй холбоотой сувилагчийн үйлдлийн эрх зүйн үр дагаварт анхаарлаа төвлөрүүл. ″Сайн дурааараа хэвтсэн" *гэсэн* үгийг тэмдэглэх нь үйлчлүүлэгчийг эмнэлгээс гарах эрхээс нь зохисгүйгээр саад хийхтэй холбоотой сонголтуудыг олоход тусална. Үлдсэн сонголтууд нь үйлчлүүлэгчийг эмнэлгээс гарах эрхээс нь саад хийх үйлдэлтэй холбоогүй.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Клиентын хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үзүүлэх орчин

Интеграцчилсан процесс: Асаргаа үйлчилгээний процесс— хэрэгжилт ***Агуулгын салбар:*** Удирдлага/Менежмент: Этик/Эрх зүй

Эрүүл мэндийн асуудал: Хамааралгүй

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Эрүүл мэндийн тусламжийн хууль; Аюулгүй байдал

Дэлгэрэнгүй: Varcarolis (2017), 68-69-р хуудас.

799. ***Хариулт:*** 1, 2, 4, 5

Үндэслэл: Эмчилгээний харилцааны техникүүдэд сонсох, чимээгүй байдлыг хадгалах, төвийг сахисан хариу үйлдэл үзүүлэх, өргөн нээлттэй болон хаалтгүй асуултуудыг ашиглах, анхаарлаа төвлөрүүлэх ба дахин төвлөрүүлэх, давтан хэлэх, тодруулах ба баталгаажуулах, мэдээлэл хуваалцах

ойлголтуудаа хуваалцах, тусгах, хүлээн зөвшөөрөл болон санал сэтгэгдэл өгөх, мэдээлэл өгөх, бодит байдлыг танилцуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахыг дэмжих, үггүй урам зориг өгөх, дүгнэлт хийх. "Яагаад" гэж асуух нь үйлчлүүлэгчдэд буруутгах маягаар ойлгогдох тул зайлсхийх хэрэгтэй. Зөвлөгөө өгөх, зөвшөөрөх эсвэл зөвшөөрөхгүй байх нь харилцаанд саад болдог.

Шалгалт өгөх стратеги: **Эмчилгээний харилцааны техникүүдийг** ашигла**.** Энэ нь зөв хариултыг сонгоход болон эмчилгээний бус харилцааны жишээг хасахдаа тусална.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал

Нэгдмэл процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Асран халамж; Харилцаа холбоо

Дарав: Varcarolis (2017), 95, 98-р хуудас.

800. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Хэрэв үйлчлүүлэгч бүлгийг дангаар эзэгнэж байвал сувилагч шулуун, шийдэмгий байх ёстой. Хамгийн зөв арга хэмжээ нь үйлчлүүлэгчид талархал илэрхийлж, ярихаа зогсоогоод бусдыг сонсохыг санал болгох явдал юм. Үйлчлүүлэгчид бүлгийг дангаар эзэгнэхээ зогсоохыг баттай боловч энэрэнгүйгээр хэлэх нь шууд хариу байж болох ч зөв сонголт нь илүү тодорхой бөгөөд үйлчлүүлэгчид чиглэсэн зааварчилгаа өгдөг. Үлдсэн сонголтууд нь эмчилгээний аргаар үйлчлүүлэгчид туслахад чиглээгүй тул зохимжгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: *Хамгийн зохистой* **стратегийн үгсийг** тэмдэглэ. Зөв сонголтыг чиглүүлэхэд туслахын тулд **эмчилгээний харилцааны техникүүдийг** ашигла. Зөв сонголт нь тодорхой бөгөөд үйлчлүүлэгчид чиглэл өгдөг гэдгийг анхаар.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Гүйцэтгэл

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа

Хамгийн чухал ойлголтууд: Харилцаа; Сэтгэл хөдлөл ба илэрхийлэл ***Лавлагаа:***
Varcarolis (2017), 30, 97-98-р тал.

801. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Орчны эмчилгээнд бүх эмчилгээний багийн гишүүдийг үйлчлүүлэгчийн амжилттай эмчилгээний үр дүнд чухал, үнэ цэнэтэй гэж үздэг. Харилцааны эмчилгээ нь нэг-нэг эсвэл бүлгийн эмчилгээний аргад тулгуурладаг бөгөөд эмчилгээч-үйлчлүүлэгчийн харилцааг үйлчлүүлэгчид амьдралдаа буй бусад харилцаагаа судлах боломж болгон ашигладаг. Зан төлөвийн өөрчлөлт нь урамшуулал ба шийтгэлд суурилдаг. Дэмжлэгийн бүлгүүд нь тухайн асуудлыг туулж, түүнд гүнзгий ойлголттой болсон хүмүүс нь ижил асуудалтай бусдыг тусалж чадна гэсэн зарчимд тулгуурлана.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв болон** эмчилгээний төрөл бүрийн онцлогт анхаарлаа төвлөрүүлэх. Үгүүдийн хоорондын харилцааг анхаарч үзээрэй, тэдгээр нь *үйлчлүүлэгчдэд зорилгодоо хүрэхэд нь тусалдаг* ба

зөв сонголт.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал

Интеграччилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Гүйцэтгэл

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Хамаарахгүй

Эрэмбэлсэн ойлголтуud: Эмнэлгийн тусламжийн зохицуулалт; Асран халамж

Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 86-р тал.

802. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Клиент эхлээд сэтгэл хөдлөл, сөрөг хариу үйлдлүүдээ зохицуулах ёстой, тэгээд л хямралын утгыг ойлгож чадна. Зөв сонголт нь шууд клиентийн сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой бөгөөд клиент төвтэй. Үлдсэн сонголтууд нь клиентийн сэтгэл хөдлөлд шууд анхаарал хандуулахгүй, шийдвэрлэхгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: Сувилагч-клиентийн харилцааны ажиллах үе шатанд **анхаарлаа** төвлөрүүл. Мөн *"клиент төвтэй үйлдэл"* гэсэн үгийг анхаар. Энэ үе шатанд явагддаг оролцооны арга хэмжээнүүдийг бодож үз. Клиентийн мэдрэмжид төвлөрсөн сонголтыг сонго.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүтэн байдал

Нэгтгэсэн процесс: Сувилахуйн процесс: Гүйцэтгэл

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд:

Хямралын ***тэргүүлэх ойлголтуud:*** Харилцаа; Даван гарах. ***Лавлагаа:*** Varcarolis (2017), 109-110-р тал.

БҮЛЭГ 6 5

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлууд

http://evolve.elsevier.com/Silvestri/comprehensiveRN/

Эрэмбэлсэн ойлголтууд

Сэтгэл хөдлөл ба илэрхийлэл; Аюулгүй байдал

I. Сэтгэл түгшил

A. Тайлбар

1. Стресст хэвийн хариу үйлдэл
2. Сэтгэл түгших, таагүй мэдрэмж, тодорхойгүй байдал эсвэл айдсыг агуулсан субъектив туршлага
3. Буруу ойлгогдох эсвэл буруу тайлбарлагдах аюул занал, эсвэл өөрийн танин мэдэхүй, өөртөө итгэх итгэлд заналхийлэх үед үүсдэг
4. Үнэт зүйлс аюулд өртөх эсвэл шинэ туршлага эхлэх үед түгшүүр үүсч болно.

B. Сэтгэл түгшүүрийн төрөл

1. Энгийн: Эрүүл төрлийн түгшүүр
2. Хурц: Нэг хүний аюулгүй байдлыг заналхийлэх ойрын хугацааны алдагдал эсвэл өөрчлөлтөөс үүдэлтэй

3. Архаг: Сэтгэл түгшилт нь ... байдлаар үргэлжилдэг

өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэвийн хариу үйлдэл

C. Сэтгэл түгшүүрийн түвшин

1. Хөнгөн
   a. Хөнгөн түвшний түгшүүр нь өдөр тутмын амьдралд тохиолддог хурцадмал туршлагуудтай холбоотой.
   b. Мэдээллийг ойлгох чадвар нэмэгдсэн
   c. Харах болон сонсох мэдрэмж нэмэгдсэн.
   d. Ойлголтын талбар өргөждөг.
   e. Урам зориг өгч, өсөлт хөгжлийг дэмжиж, бүтээлч сэтгэлгээг сайжруулж, суралцах чадварыг нэмэгдүүлдэг
   f. Бие махбодийн шинж тэмдгүүдэд тайвангүй байдал, уур уцаартай байдал эсвэл хөнгөн түгшүүр орно.
2. Дунд зэргийн
   a. Анхаарал шууд тулгамдсан асуудлууд дээр төвлөрдөг.
   b. Хязгаарлагдсан хүлээн авах талбар
   c. Харах, сонсох мэдрэмж буурна

songomol анхааралгүй байдал илэрнэ.

d. Суралцах болон асуудал шийдвэрлэх

бирхон тохиолддог.

e. Бие махбодийн шинж тэмдгүүдэд зүрхний цохилт түргэсэх, хөлс их гарах, ходоодны таагүй мэдрэмж, толгой өвдөх, шээс алдах яаралтай хэрэгцээ, болон/эсвэл хөнгөн чичиргээ орно.

3. Хүнд

a. Хүчтэй түгшүүр нь ямар нэг муу зүйл тохиолдох гэж байгаа мэт мэдрэмж юм.

b. Оюун ухааны хүрээ эрс хумигддаг.

c. Анхаарал нь жижиг эсвэл тарсан нарийн ширийн зүйлсэд төвлөрдөг.

d. Бүх зан үйл нь түгшүүрээ намжаахад чиглэдэг.

e. Суралцах болон асуудал шийдвэрлэх боломжгүй.

f. Арга хэмжээ нь түгшүүрийг бууруулах эсвэл намжаахад чиглэдэг.

g. Бие махбодийн шинж тэмдгүүд нь симпатик мэдрэлийн системийн өдөөлтөөс үүдэлтэй (жишээ нь: толгой өвдөх, дотор муухайрах, толгой эргэх, нойргүйдэл), чичиргээ нэмэгдэх, зүрх дэлсэх, амьсгал хурдасгах.

h. Хүн анхаарлаа төвлөрүүлэх чиглэл

длагатай.

иг, цочрол болон ойртож буй сүйрлийн мэдрэмжтэй холбоотой

b. Зохион байгуулалтгүй байдал, бодит байдлыг ойлгоход хүндрэлтэй, анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар алдагдах

4. Паник

c. Ухаалаг бодлууд алдагдэж, хүлээн мэдэхүйн гажилт үүсдэг.

d. Хүн харилцаа холбоо тогтоох, үр дүнтэй ажиллах чадваргүй болдог.

e. Хэрэв удаан үргэлжилбэл паник нь туйлдсан ядаргаа болон үхэлд хүргэж болно.

f. Хөдөлгөөний идэвхижил нэмэгдэх (шахаж алхах, хашгирах, орилох) эсвэл тусгаарлагдах

g. Түгшүүртэй, тогтворгүй зан үйл

D. Оролцоо: Ерөнхий сувилахуйн арга хэмжээ (хамгийн чухал сувилахуйн үйлдлүүдийг үзнэ үү)

Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд

Өвчтөнд үүссэн түгшүүр

1. Тайван орчныг бүрдүүлж, орчны өдөөлтийг бууруулж, үйлчлүүлэгчийн дэргэд бай.
2. Клиентээс юуг, хэрхэн мэдэрч байгаагаа тодорхойлохыг хүс.
3. Клиентийг өөрийн мэдрэмжээ дүрслэн ярьж, түүнийхээ талаар ярилцахад нь урамшуул.
4. Хэрвээ үйлчлүүлэгч сэтгэл хөдлөлөө үүсгэж буй шалтгааныг тодорхойлоход хүндрэлтэй байвал түүнд туслаарай.
5. Клиентээс ямар ч аргагүйд орсон, найдваргүйдсэн гэх мэт илэрхийллийг сонсох.
6. Тохиолдлыг, чухал мэдээллийг, авсан арга хэмжээ болон дагалдах арга хэмжээг, үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдлийг баримтжуул.

Дүгнэлт

Varcarolis (2017), 134-р тал.

1. Сэтгэл түгшүүрийг хүлээн зөвшөөр.
2. Итгэлцлийг бий болгох.
3. Клиентийг хамгаалах.
4. Орчныг хязгаар тогтоох эсвэл бусадтай харилцааг хязгаарлах замаар өөрчлөх.
5. **Даван туулах арга барилыг** шүүмжлэхгүй.
6. Бүтээлч гарцыг олго.
7. Гэнэт сүйтгэх үйлдэл гаргах шинж тэмдгүүдийг ажигла.
8. Амьсгалын дасгал болон удирдамжтай дүрслэл зэрэг тайвшрах аргуудыг дэмж.
9. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг хянаж, эмчийн зааврааар сэтгэл түгшүүр намжаах эмчилгээг хийх.
10. Өвчтөнийг түгшүүр төрүүлэх нөхцөл байдалд шахаж оруулж болохгүй.

Сэтгэл түгшүүртэй үйлчлүүлэгчид сувилагчийн яаралтай арга хэмжээ нь орчны өдөөгч хүчин зүйлсийг бууруулж, тайван, нам дүрдүүлэх явдал юм.

E. Оролцоо: Хөнгөн ба дунд түвшний

1. Клиентийнхээ түгшүүрийн эх үүсвэрийг тодорхойлоход нь туслах.
2. Өвчтөнд сэтгэл хөдлөл, санаа зовнилоо ярилцахад нь урамшуулах.
3. Сэтгэл түгших байдал эхлэхээс өмнө үүссэн бодол, мэдрэмжийг тодорхойлоход туслах.
4. Асуудлыг шийдвэрлэхэд урамшуулах.
5. Их биеийн хөдөлгөөний дасгалыг дэмжих.

F. Оролцоо: Хүндээс паникийн түвшин хүртэл

1. Сэтгэл түгшүүрийг хурдан бууруул.

2. Тайван байдлаар хандана уу.
3. Үргэлж үйлчлүүлэгчийн дэргэд бай.
4. Орчны өдөөлтийг аль болох багасга.
5. Тодорхой, энгийн өгүүлбэр хэлнэ.
6. Доогуур хоолойгоор ярь.
7. Үйлчлүүлэгчийн бие махбодийн хэрэгцээг хангана.
8. Их биеийн хөдөлгөөнийг хангах.
9. Сэтгэл түгшүүр намжаах эмчилгээг эмчийн зааврааар олгоно.
10. Аюулгүй байдлыг хангах.

II. Ерөнхий түгшүүрийн эмгэг

A. Тайлбар (Хайрцаг 65-1)

1. Ерөнхий түгшүүрийн эмгэг нь өдөр тутмын санаа зовнилтуудад бодит бус түгшүүр төрүүлж, дор хаяж 6 сарын турш ихэнх өдрүүдэд үргэлжилдэг бөгөөд бусад сэтгэцийн эсвэл биеийн эрүүл мэндийн асуудалтай холбоогүй байдаг.
2. Бие махбодийн шинж тэмдгүүд илэрнэ.

B. Үнэлгээ

1. Тайвангүй байдал ба тайвшрах чадваргүй байдал
2. Чичирхийлэл, саажилттай үеүүд
3. Мөчрийн булчингийн байнгын таталт
4. Толгой эргэх
5. Анхаарал төвлөрүүлэх чадваргүй
6. Архаг ядаргаа ба нойрны асуудал
7. Сэтгэл түгшил болон бие махбодийн шинж тэмдгүүдийн хоорондын холбоог таньж чадахгүй байх
8. Клиент бие махбодийн таагүй мэдрэмжид төвлөрч байна.

C. Гэнэтийн болон урьдчилан таамаглаж байсан паникийн дайралтууд

1. Тайлбар
   a. Ааш авирын эмх замбараагүй байдалд хүргэдэг түгшүүрийн хамгийн хэтэрхий түвшин
   b. Гэнэт эхэлдэг хүчтэй түгшүүр, айдсын мэдрэмж төрүүлдэг
   c. Шалтгааныг ихэвчлэн тогтоож чаддаггүй.
   d. Хүнд, дахин дахин тохиолддог, завсрын шинжтэй түгшүүрийн дайралтууд 5–30 минут үргэлжилдэг.
2. Үнэлгээ
   a. Амь боогдох мэдрэмж
   b. Амьсгал давчдах
   c. Зүрх хүчтэй цохилох
   d. Хөхний өвдөлт
   e. Толгой эргэх
   f. Дотор муухайрах
   g. Хараа бүдгэрэх
   h. Гар, хөлний мэдээгүйрэл эсвэл зөөлөн хатгалга

i. Бодит бус мэт мэдрэмж ба аргагүйдэл
j. Багтаж гацах айдас
k. Үхэхээс айх

3. Оролцоо

a. Клиенттэй хамт үлд.
b. Бие махбодийн шинж тэмдгүүдэд анхаарал хандуулах.
c. Клиентийн түгшүүрийг өдөөсөн бодлуудыг тодорхойлж, эдгээр бодлын үндэслэлийг олж тогтооход туслах.
d. Клиентийн бодит бус бодлыг илүү бодитой болгоход туслах.
e. Эвдэрхий бодлыг орлуулахын тулд танин мэдэхүйн дахин зохион байгуулалтыг ашигла.
f. Эмчийн зааврааp сэтгэл түгшүүр намжаах эмчилгээг хийх.

III. Гэмтлийн дараах сэтгэл зүйн хямрал

A. Тайлбар: Сэтгэл зүйн хувьд туршлага туулсны дараа сэтгэл зүйн хүчтэй цочролыг туулсны дараа тухайн хүн тухайн үйл явдлыг дахин дахин туулж, давтагддаг, хүчээр орж ирдэг зүүд эсвэл дурсамжийн гэнэтийн дүрслэлд өртөх хандлагатай байдаг.

B. Диагноз: Шинж тэмдгүүд дор хаяж 1 сар үргэлжилж, травматик үйл явдлаас хойш хэдэн сараас хэдэн жил хүртэл илрэх боломжтой.

C. Стрессийн хүчин зүйлс

1. Байгалийн гамшиг
2. Террорист халдлага
3. Тулалдааны туршлага
4. Осол
5. Хүчирхийлэлд өртөх
6. Гэмт хэрэг эсвэл хүчирхийлэл
7. Бэлгийн, бие махбодийн болон сэтгэл санааны **хүчирхийлэл**
8. Үйл явдлыг дахин туулж, дурсамж буцаж ирэх

D. Үнэлгээ

1. Харьцахаас зайлсхийх эсвэл мэдрэмжгүй болох
2. Уур уцаартай болох эсвэл гэнэт уурлах
3. Хөндийрөх
4. Өөрийгөө алах тухай бодлыг багтааж болох депрессия
5. Сэтгэл түгшил
6. Унтах явцад үүсэх хүндрэл ба аймшигт зүүд
7. Үйл явдлын флешбэк
8. Хэт болгоомжлол ба хэтрүүлсэн цочирдолын хариу
9. Тохиолдлоос амьд үлдсэндээ гэмших
10. Анхаарал төвлөрөх чадвар муудах болон үйл явдлын дурсамжийг сэргээдэг үйл ажиллагаанаас зайлсхийх

E. Оролцоо (65-2-р хайрцаг)

Хавдартай тулгарч буй үйлчлүүлэгчид сэтгэл зүйн дараах цочролын дараах стресс (PTS) үүсгэж болно. Хавдар-хавдартай холбоотой PTS эмчилгээний явцад эсвэл дараах үед хэзээ ч илрэх боломжтой. PTS-ийн шинж тэмдгүүд нь посттравматик стрессийн эмгэгийнхтэй төстэй боловч ихэвчлэн тийм ч хүнд байдаггүй.

IV. Тодорхой фоби

A. Тайлбар

1. Объект, үйл ажиллагаа эсвэл нөхцөл байдлаас үүдэх, удаан үргэлжилж, зайлсхийхэд хүргэдэг учир утгагүй айдас.
2. Хэрвээ тухайн зүйл, нөхцөл байдал эсвэл үйл ажиллагааг зайлсхийж чадахгүй бол паник түвшний түгшүүр эсвэл айдастай холбоотой
3. Ерөнхийдөө **хамгаалалтын механизмын хувьд** дарж хаях (repression) болон шилжүүлэн гаргах (displacement) аргуудыг ашигладаг.

B. Төрөлүүд (65-3 дугаар хайрцаг)

C. Оролцооны арга хэмжээ

1. Сэтгэл түгшүүрийн үндсийг тодорхойлох.
2. Клиентээс түгшүүр төрүүлж буй зүйл эсвэл нөхцөл байдлын талаарх мэдрэмжээ үгээр илэрхийлэхийг зөвшөөр; айдас төрүүлж буй зүйлийн тухай байнга ярилцах нь десенситизацийн үйл явцын эхний алхам юм.
3. Амьсгалын дасгал, булчингийн сулралын дасгал, таатай нөхцөл байдлыг төсөөлөх зэрэг тайвшруулах аргуудыг зааж сургах.
4. Аажмаар дасалтыг дэмжих

зүйл эсвэл нөхцөл байдлыг бага багаар танилцуулах.

Сэтгэл түгшүүртэй үйлчлүүлэгчийн дэргэд үргэлж байж Аюулгүй байдал, хамгаалалтыг дэмжих. Фоби үүсгэсэн зүйл эсвэл нөхцөлтэй үйлчлүүлэгчийг хэзээ ч хүчээр холбож болохгүй.

V. Давтагддаг-компульсив болон түүнтэй холбоотой эмгэгүүд

A. Ой санамж: тасралтгүй орж ирдэг бодол, хүсэл, дүрс, санаанууд

B. Компульсууд: Ямар нэгэн үйл явдал тохиолдохыг зогсоох, хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй бодлуудаас анхаарлыг сарниулах, түгшүүрээ бууруулах зорилгоор хүн өөрийгөө заавал гүйцэтгэхэд хүргэгддэг зан үйл, давтагддаг үйлдлүүд.

1. Өөрт тулгамдсан бодлууд болон шахалт зан үйлүүд ихэвчлэн зэрэгцэн илэрч, өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулж болно.
2. Сэтгэл түгшүүр нь хүн доторх шахалт эсвэл зан үйлийг эсэргүүцэх үед, мөн бодол эсвэл зан үйлийг эсэргүүцэх чадваргүй байхад үүсдэг.
3. Шуудлан бодлууд нь дараах асуудлуудыг агуулж болно:

хүчирхийлэл, довтолгоо, бэлгийн харьцаа, эмх цэгц эсвэл шашинтай холбоотой байж, хяналтгүйгээр ухамсартай бодлыг тасалдуулж, хэвийн үйл ажиллагаа явуулах чадварыг алдагдуулах боломжтой.

C. Компульсив зан үйл (зан үйл эсвэл ёслол)

1. Компульсив зан үйлийн хэв маяг нь түгшүүрийг бууруулдаг.
2. Эдгээр хэв маяг нь тулгамдсан бодлуудтай холбоотой байдаг.
3. Эдгээр хэв маяг нь бодлыг төвийг сахиулах үүрэгтэй.
4. Стресстэй үед ёслолын шинжтэй зан үйл нэмэгддэг.
5. Хамгаалалтын механизмд дарж нуух, шилжүүлэх, буцаан залруулах орно.

D. Холбогдох эмгэгүүд

1. Хуримтлуулах эмгэг
2. Экскориацийн (арьс хуулж) эмгэг
3. Бодис эсвэл эмийн нөлөөгөөр үүссэн шахалт-компульсив болон түүнтэй холбоотой эмгэг
4. Өөр эмгэгээс үүдэлтэй шахалттай, дагалдах эмгэг
5. Трихотилломания (үс татах эмгэг) E.

Оролцоо (65-4-р хайрцаг)

VI. Соматийн шинж тэмдэг болон холбогдох эмгэгүүд

A. Тайлбар

1. Соматик шинж тэмдгийн эмгэгүүд нь баттай бие махбодийн илрэл, эмнэлгийн оношгүйгээр бие махбодийн өвчний талаар тасралтгүй санаа зовох эсвэл гомдоллох болон түүнтэй холбоотой зохисгүй хариу үйлдлийг агуулдаг.
2. Клиент бие махбодийн шинж тэмдгүүдэд төвлөрч, тэдгээрийг хянах чадваргүй болдог.
3. Сэтгэлзүйн болон нийгмийн стресст өртөхөд бие махбодийн шинж тэмдгүүд нэмэгдэж, үр дүнд нь үйл ажиллагааны алдагдал өндөр түвшинд хүрдэг.
4. Сэтгэл түгшүүр бие махбодийн түгшүүрт шилждэг.
5. Клиент ухамсаргүйгээр бие махбодийн шинж тэмдэг илэрхийлж болно

хоёрдогч ашиг тус, жишээлбэл илүү их анхаарал татах, үүрэг хариуцлагаас мултрах.

B. Хөрвөлтийн эмгэг (функциональ мэдрэлийн шинж тэмдэг эсвэл ...ж)

1. Тайлбар
   a. Нервийн шинж тэмдэг эсвэл дутагдал гэнэт илрэх бөгөөд үүнд мэдрэлийн шалтгаан эсвэл онош тогтоогдоогүй байдаг.
   b. Хөрвөлтийн эмгэг нь ...-ийн илэрхийлэл юм

сэтгэл зүйн зөрчил эсвэл хэрэгцээ.

c. Хамгийн түгээмэл хөрвөлтийн шинж тэмдгүүд нь хараагүй болох, дүлий болох, мэдрэмжгүй болох, саажилт, алхах явцад хүндрэл үүсэх, ярьж чадахгүй болох юм.

d. Конверсийн эмгэг нь органик шалтгаангүй.

e. Шинж тэмдгүүд нь үйлчлүүлэгчийн ухамсартай хяналтаас гадуур бөгөөд зөрчилдөөнтэй шууд холбоотой байдаг.

f. Бие махбодийн шинж тэмдгүүд хөгжихийн хэрээр түгшүүр буурдаг.

2. Үнэлгээ

a. Шинж тэмдэг эсвэл дутагдлын физиологийн шалтгааныг үгүйсгэх.

b. "*La belle indifference*": шинж тэмдгүүдэд үл тоомсорлох

c. Бие махбодийн хязгаарлалт эсвэл хөгжлийн бэрхшээл

d. Гэмшил, түгшүүр эсвэл бухимдал мэдрэх

e. Өөртөө итгэх итгэл сул, хангалтгүй байдлын мэдрэмж

f. Илэрхийлээгүй уур бухимдал эсвэл зөрчилдөөн

g. Хоёрдогч ашиг

h. Бие махбодийн эсвэл бэлгийн хүчирхийллийн түүх

C. Оролцоо

1. Сувилахуйн түүхийг авч, бие махбодийн асуудлуудыг үнэлнэ.
2. Физик шинж тэмдгүүдээр хангагдаж буй хэрэгцээг үйлчлүүлэгчтэй хамт судал.
3. Клиенттэй хамтран хэрэгцээгээ хангах өөр аргуудыг тодорхойлоход туслах.
4. Клиенттэй хамтран түүний сэтгэл хөдлөл, зөрчилдөөнийг бие махбодийн шинж тэмдгүүдтэй холбон ойлгуулах.
5. Бие махбодийн бэлгийн шинж тэмдгүүд нь үйлчлүүлэгчийн хувьд бодит гэдгийг ойлгуулах.
6. Физик өвчин илрээгүйг үйлчлүүлэгчид баталгаажуул.
7. Шинээр илэрсэн бие махбодийн аливаа гомдлыг мэдээлж, үнэлнэ.
8. Хэрэв үйлчлүүлэгч өвдөлтөө илэрхийлбэл өвдөлтийн үнэлгээний шкалаар үнэлж, шаардлагатай бол өвдөлтийг бууруулах арга хэмжээ авна.
9. Сэтгэл түгшүүрийн үүсэл шалтгааныг судлан, түүнийг үгээр илэрхийлэхэд нь дэмжлэг үзүүл.
10. Клиентд өөрийнхөө мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг танихад нь туслах.

11. Сэтгэл түгшүүр нэмэгдэх үед тайвшрах аргуудыг ашиглахыг урамшуул.
12. Анхаарал сарниулах үйл ажиллагааг дэмжинэ.
13. Эерэг санал өг.
14. Эмчийн зааврааp сэтгэл түгшүүр намдаах эмчилгээг хийх.

Соматик шинж тэмдгийн эмгэгтэй үйлчлүүлэгчийн хувьд тодорхой бие маходлийн гомдлоо ярилцах тодорхойДайсагналттай эмгэгТайлбар: Дайсагналттай эмгэг нь ой санамж, ухамсар эсвэл өөрийгөө тодорхойлох чадварын интеграцчилсан үйл ажиллагаанд саатал үүсгэх эмгэг юм.

VII. Диссоциатив эмгэг

A. Тайлбар

1. Диссоциатив эмгэг нь ой санамж, ухамсар эсвэл өөрийгөө тодорхойлох чадварын интеграцчилсан үйл ажиллагаанд үүссэн алдагдал юм.
2. Энэ нь маш хүчтэй сэтгэл зүйн цочролыг үүсгэх үйл явдалд өртөхтэй холбоотой.

B. Диссоциатив өөрийн таних эмгэг (DID), өмнө нь *олон зан чанарын эмгэг* гэж нэрлэгддэг байсан

1. Тайлбар
   a. Клиентийн дотор хоёр буюу түүнээс дээш бүрэн хөгжсөн, ялгаатай, давтагдашгүй хувь хүнүүд оршиж, тэд давтамжтайгаар зан үйлд хяналт тавьдаг.
   b. Хост нь гол хувь хүн бөгөөд бусад хувь хүмүүсийг *alter* гэж нэрлэдэг.
   c. Өөр дүрүүд нь үйлчлүүлэгчийг нэг бүрчлэн бүрэн хянах боломжтой бөгөөд хоорондоо ухамсарлаж мэдэх эсэх нь тодорхойгүй.
   d. Альтерүүд нь хостыг мэдэж байж болох ч хост нь ихэвчлэн альтерүүдийг мэддэггүй.
2. Үнэлгээ
   a. Клиент чухал мэдээллийг (ердийн мартах байдлаас ялгаатай) санах чадваргүй байж болно.
   b. Нэг зан чанараас нөгөө рүү шилжих нь ихэвчлэн стресс эсвэл сэтгэл зүйн хүчтэй цочролын үед тохиолдож, гэнэт явагддаг.
   c. Диссоциаци нь сэтгэл түгшүүр болон сэтгэл зүйн шархлуулах туршлагуудаас өөрийгөө зайлуулах, хамгаалах аргаар ашиглагддаг.

C. Диссоциатив амнези

1. Тайлбар
   a. Чухал хувийн мэдээллийг санах чадваргүй

чухал хувийн мэдээллийг санах чадвар ихэвчлэн травма эсвэл түгшүүр төрүүлэхээс болж алдагддаг

b. Санах ой алдагдал хэсэгчлэн эсвэл бараг бүрэн байж болно.

c. Клиент шинэ орчинд шинэ дүрд хувирч, газраас газарт шилжин, цөөн хэдэн харилцаа тогтоож, дараа нь амнезиагаа санахгүйгээр гэртээ буцдаг.

2. Үнэлгээ

a. Төвлөрсөн: үйлчлүүлэгч тодорхой хугацааны бүх дурсамжийг хаадаг.

b. Сонгомол: үйлчлүүлэгч тодорхой хугацааны зарим дурсамжийг санадаг боловч бүгдийг нь санадаггүй.

c. Ерөнхий: үйлчлүүлэгч өнгөрсөн амьдралынхаа бүх дурсамжаа алддаг.

D. Хувь хүний мэдрэмжийн тасалдал/бодит бус байдлын эмгэг

1. Тайлбар: Өөрийгөө хүлээн ойлгох байдал өөрчлөгдөж, өөрийн бодит байдал түр зуур алдагдсан эсвэл өөрчлөгдсөн байдал

2. Үнэлгээ

a. Хөндийрсөн мэдрэмж

b. Бодит байдлыг шалгах чадвар хэвийн

E. Оролцоо

1. Клиентийг чиглүүлэх.
2. Үйлчлүүлэгчтэй итгэлцлийн харилцаа үүсгэх.
3. Өвдөлттэй туршлага, түгшүүр, санаа зовнилоо үгээр илэрхийлэхийг дэмжих.
4. Давахад туслах аргуудыг судлах.
5. Мөргөлдөөний эх үүсвэрийг тодорхойлох.
6. Клиентийн давуу тал, ур чадварт анхаарлаа төвлөрүүл.
7. Шаардлагагүй, энгийн дадал хэв маягийг санал болго.
8. Клиентийг өөрийнхөө хэмнэлээр ахиц гаргах боломж олго.
9. Стресс бууруулах аргуудыг хэрэгжүүлэх.
10. Хувь хүний, бүлгийн эсвэл гэр бүлийн сэтгэл засал эмчилгээг төлөвлөх нь зан төлөв эсвэл дурсамжийн тусгаарлагдсан талуудыг нэгтгэж, өөрийгөө ухамсарлах чадварыг өргөжүүлэхэд чиглэнэ.

VIII. Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд

A. Биполяр болон түүнтэй холбоотой эмгэгүүд

1. Тайлбар (Бох 65-5)

a. Биполяр эмгэг нь сэтгэл хөдлөл, эрч хүч, үйл ажиллагаа явуулах чадварын туйлшралтай өөрчлөлтөөр илэрдэг.

b. Биполяр эмгэгийн ангилалд Биполяр I эмгэг, Биполяр II эмгэг,

циклотимийн эмгэг, болон холимог шинжүүд.

c. Биполяр I эмгэг: маниагаас депрессийн хүнд сэтгэл хөдлөлийн үе шаттай хамгийн хүнд хэлбэр.

d. Биполяр II эмгэг: сэтгэл хөдлөлийн өргөгдөл зөөлөн хэлбэртэй; зөөлөн гипоманийн үе шат нь хүнд депрессийн үе шаттай ээлжлэн давтагддаг.

e. Циклотимийн эмгэг: богино хугацааны гипоманийн шинж тэмдгүүд богино хугацааны депрессийн шинж тэмдгүүдтэй ээлжлэн гардаг бөгөөд эдгээр нь бүрэн гипоманийн эсвэл бүрэн депрессийн үед илэрдэг шинж тэмдгүүд шиг өргөн хүрээтэй, удаан үргэлжилдэггүй.

f. Холимог шинж чанарууд: манийн, гипоманийн эсвэл депрессийн үед сэтгэл хөдлөлийн эсрэг туйлшралтай шинж тэмдгүүд зэрэгцэн илэрдэг. Үүнд их эрч хүч, нойргүйдэл, бодол санаа хурдацтай явах зэрэг шинжүүд орно. Мөн нэгэн зэрэг хүн найдваргүй, гутралтай, уур уцаартай, амиа хорлох хүсэлтэй байж болно.

g. Уламжлал ёсоор сонгодог эм нь литийн карбонат бөгөөд энэ нь хортой тул эмийн эмчилгээний индексийг зохистой түвшинд хадгалахад туслахын тулд цусанд литийн хэмжээг тогтмол хянах шаардлагатай; хордлогоос сэргийлэхийн тулд хоол хүнсээр хангалттай натри болон шингэн (өдөрт 2–3 литр) тогтмол хэрэглэх ёстой.

h. Бусад эм бэлдмэлүүдийг биполярын манийн хурц үеийн шинж тэмдгүүдийг бууруулах болон арчилгааны эмчилгээнд зааж өгч болно.

i. Манийн үед илэрдэг психомотор түгшүүрийг зохицуулахад туслах зорилгоор сэтгэл түгшүүр намжаах эмүүдийг бичиж өгч болно; эдгээр эмийг бодисын хэт хэрэглээний түүхтэй өвчтөнд хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

j. Атипик антипсихотик эмүүдийг тайвшруулах болон сэтгэл хөдлөлийг тогтворжуулах үр нөлөөгөөр нь бичиж өгч болно.

2. Үнэлгээ

a. Өвчтөн өөртөө болон бусдад аюултай эсэхийг үнэлж, хянана.
b. Архи болон мансууруулах бодисын хэрэглээ/зөрчилтэй хэрэглээг үнэл.
c. Сэтгэл хөдлөл
d. Загвар
e. Яриа (идеалын нислэг, сэдвээс хазайсан)
f. Танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа
g. Өөрийгөө хэт өндөр үнэлэх (ихэрхүү төсөөлөл)
h. Унтах хэв маяг
i. Туршлага хяналт

3. Манийн үед авах арга хэмжээ (65-6-р хайрцаг)
a. Орчны аюултай зүйлсийг зайлуул (энэ нь бүх үйлчлүүлэгчдэд хийгдэх ёстой).
b. Клиентийн ядаргааг нарийвчлан үнэл.
c. Тусгаарлагдсан амралтын завсарлагаа олон удаа өгч, үйлчлүүлэгчийн унтах хэв маягийг хянаж; унтыг дэмжих зорилгоор тав тухын арга хэмжээ авах.
d. Хэрэв боломжтой бол тусгаарлагдсан өрөө өг.
e. Клиентийг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхийг дэмж.
f. Тайван, удаан харилцаа үүсгэнэ.
g. Ярилцлагын явцад үйлчлүүлэгчийг нэг сэдэвт төвлөрөхөд нь туслах.
h. Клиентийн хэт их сүржин бодлыг үл тоомсорлож эсвэл анхаарлыг нь сарниулах; түүнд бодит байдлыг тайлбарлах.
i. Клиенттэй маргалдаж болохгүй.
j. Бүлгийн үйл ажиллагааг хязгаарлаж, үйлчлүүлэгчийн тэсвэр тэвчээрийн түвшинг үнэл; ганцаарчилсан үйл ажиллагаа шаардлагатай байж болно.
k. Өндөр калоритой хуруугаар идэх хөнгөн зууш болон шингэн зүйлс өг.
l. Орчны өдөөлтийг бууруулах.
m. Зохисгүй зан үйлд хязгаар тогтоо.
n. Биеийн идэвхтэй байдлыг хангах болон стресс тайлах боломжуудыг олго.
o. Тэмцээнтэй тоглоомуудаас зайлсхий.
p. Явган алхах зэрэг биеийн томоохон хөдөлгөөний үйл ажиллагаа санал болго.
q. Сувилагчтай хамт зохион байгуулалттай эсвэл нэг-нэгээр явагдах үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
r. Өдөр тутмын үйл явцад энгийн, тодорхой тайлбар өг.
s. Эм уух явцыг хянах.

3. Гүн гашуудал: IX хэсгийг үзнэ үү.

IX. Депрессийн эмгэгүүд

A. Тайлбар

1. Депресс нь сэтгэл хөдлөл, бодол санаа, зан үйлд нөлөөлдөг.
2. Энэ нь ямар нэгэн хохирол амссаны дараа, жишээлбэл өөртөө итгэх итгэлээ алдсан, чухал харилцаа дууссан, хайртай хүнийхээ нас барсан эсвэл сэтгэл зүйн хүчтэй цочрол үүссэн үед тохиолдож болно.
3. Алдагдалын дараа гашуудал, гашуудах явц дагалддаг; хэрэв энэ явц шийдэгдэхгүй бол депрессийн байдал үүсдэг.
4. Депрессийн хүндрэл хөнгөн, дунд зэргийн эсвэл хүнд байж болно.
5. Эмчилгээнд зөвлөгөө, антидепрессант эм, цахилгаан таталт эмчилгээ (ECT) орно.
6. Ерөнхий үнэлгээний дүнгүүдтэй танилцахын тулд 65-5-р хайрцгийг үзнэ үү.

B. Хөнгөн депрессия

1. Хөнгөн депрессийг гадаад үйл явдал өдөөж, хэвийн гашуудлын хариу үйлдлийн дараа үүсдэг.
2. Хөнгөн депрессийн хугацаа 2 долоо хоногоос бага үргэлжилдэг.
3. Гомдолтой мэдрэх
4. Сэтгэл гонсойж, урам хугарсан мэдрэмж
5. Унтах хэв маягт хөнгөн өөрчлөлтүүд
6. Анхаарал сулрах
7. Уур уцаартай
8. Бусадтай цагийг өнгөрүүлэхэд сонирхолгүй
9. Хоолны дуршил нэмэгдэх эсвэл буурах
10. Архи, мансууруулах бодис зэрэгт хэт ихээр донтсон

C. Дунд зэргийн депресси

1. Дунд зэргийн депрессия удаан хугацаанд үргэлжилдэг.
2. Хүн өөрчлөлтийг мэдэрч, ихэвчлэн тусламж эрж хайдаг.
3. Урам хугарсан, гунигтай
4. Сэтгэл унасан
5. Өөртөө итгэх итгэл сул
6. Гэмгүйдэл ба хүчгүйдэл
7. Хүчтэй түгшүүр, уур хилэн мэдрэх магадлалтай
8. Өдөр тутмын хэлбэлзэл: Хүн өдрийн тодорхой цагт өөрийгөө илүү сайн мэдрэх боломжтой.
9. Бодох үйл явц удаашрах, анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хүндрэлтэй байх
10. Давтан эргэцүүлэл: тодорхой нэг сэдвийн талаар тасралтгүй бодох, ярилцах
11. Сөрөг бодол ба амиа хорлох бодол (67-р бүлгийг үзнэ үү)
12. Унтах алдаа, өглөө эрт сэрэх эсвэл хэт их унтах
13. Нийгмийн харилцаанаас татгалзах
14. Анорексиа, жин хасах эсвэл нэмэгдэх, ядаргаа
15. Бие махбодийн зовиур
16. Илүү удаан хөдөлж, илүү удаан ярих

17. Архи, мансууруулах бодис зэрэгт хэт ихээр донтох

D. Хүнд депрессийн эмгэг

1. Хоёр долоо хоног буюу түүнээс дээш хугацаанд сэтгэл гутралтай байх эсвэл үйл ажиллагаанаас таашаал авах чадвар алдагдах
2. Нийгмийн, мэргэжлийн болон/эсвэл боловсролын үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсэх
3. Хүний ердийн сэтгэл хөдлөлийн байдлаас сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөх
4. Өдөр бүр дараах шинж тэмдгүүдээс дор хаяж 5-ыг мэдэрдэг:
    a. Өдөрт ихэнх хугацаанд, бараг өдөр бүр уур уцаартай эсвэл гутранги сэтгэлтэй байх (өөрийн мэдрэмж эсвэл бусдын ажиглалтаар)
    b. Ихэнх үйл ажиллагаанд сонирхол буурах эсвэл таашаал мэдрэх чадвар буурах
    c. Илэрхий жингийн өөрчлөлт (5%) эсвэл өлсгөлөнгийн өөрчлөлт
    d. Хөдөлгөөний түвшинд өөрчлөлт
    e. Ядаргаа эсвэл эрч хүчгүй болох
    f. Гэмшил/үнэгүй мэт санагдах
    g. Бодох, анхаарал төвлөрүүлэх чадвар буурах эсвэл шийдвэр гаргахдаа илүү эргэлзээтэй болох
    h. Үхэл эсвэл амиа хорлох тухай

бодлууд Е. Оролцоо (65-7 дугаар хайрцаг)

Өөрийгөө гэмтээх эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчээс шууд асуу: "Та бодож байсан уу өөрөө өөрийгөө гэмтээх тухай бодож байсан уу?"

X. Цахилгаан таталт эмчилгээ (ECT)

A. Тайлбар

1. Электроконвульсив эмчилгээ (ЭКТ) нь депрессийн үед үр дүнтэй эмчилгээ (эмгэг бүрэн эдгэрүүлэхгүй) бөгөөд чихний хоёр талд наалттай электродуудаар дамжуулан тархинд түр зуурын таталт үүсгэх бага хэмжээний цахилгаан гүйдэл өгдөг; булчинг сулруулах урьдчилсан эмчилгээ хийдэг тул гадагш хөдөлгөөн ихэвчлэн гар, хөл эсвэл хөлийн хурууны хөнгөн хөдөлгөөн байдаг. Мөн богино хугацааны мэдээ алдуулах эм өгдөг.
2. Ерөнхийдөө 2–5 хоног тутамд 6–12 удаа эмчилгээ хийдэг; сэргээн заслын ECT-ийг сард нэг удаа хийх нь дахилттай депрессийн өвчтөнд дахилтын давтамжийг бууруулахад тусалж болно.
3. Дизтимийн депрессийн үед, депрессийн болон зан төлөвийн эмгэгтэй, мансууруулах бодисын хамааралтай эсвэл нөхцөл байдал, нийгмийн хүндрэлээс үүдэлтэй депрессийн үед ECT үргэлж үр дүнтэй байдаггүй.
4. Эрсдэлтэй өвчтөнүүдэд сүүлийн үеийн миокардын

миокардын шинэ инфаркт, тархины харвалт (цус харвалт), эсвэл тархины доторх хавдартай өвчтөнүүд орно.

B. Хэрэглээ (65-8-р хайрцаг)

1. Хүнд депрессив болон биполяр депрессийн эмгэгтэй өвчтөнүүд, ялангуяа гэм буруугийн төөрөгдөл, бие махбодийн төөрөгдөл, үнэнч бус байдлын төөрөгдөл зэрэг психотик шинж тэмдэг илэрсэн үед
2. Сэтгэл хөдлөл буурах, сэтгэл хөдлөлгүй байдал давамгайлсан депрессийн өвчтөнүүд
3. Лити болон антипсихотик эмэнд тэсвэртэй манийн эмгэгтэй өвчтөнүүд болон хурдан циклтэй өвчтөнүүд (биполяр эмгэгтэй, сэтгэл хөдлөлийн олон удаагийн ойр ойрхон хэлбэлзэлтэй)
4. Шизофрениатай өвчтөнүүд (ялангуяа кататониатай), шизоаффектив синдромтой өвчтөнүүд болон психотик өвчтөнүүд

C. Процедурын өмнөх

1. Клиентд процедурыг тайлбарлах.
2. Клиент болон түүний гэр бүлийг ЭКТ-тэй холбоотой домгууд болон бусад мэдрэмжээ ярилцахад нь урамшуулах.
3. Клиент болон түүний гэр бүлд юу хүлээж байгаагаа зааж зааварлах.
4. Сайн дурааараа ирсэн үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээ хийхдээ мэдээлэлд суурилсан зөвшөөрөл авах шаардлагатай.
5. Албадан эмчилгээнд хамрагдаж буй өвчтөнд мэдээлэлд суурилсан зөвшөөрөл авах боломжгүй үед ойрын төрөлхнийхөө хүний зөвшөөрлийг авч болно; зарим мужид ЭКТ-д зөвшөөрлийг шүүхээс авах шаардлагатай байдаг.
6. Шөнө дунд болон эмчилгээ эхлэхээс дор хаяж 4 цагийн өмнө NPO (амнаас юу ч өгөхгүй) статустай байлгах.
7. Анхны амьдралын чухал үзүүлэлтүүдийг авна.
8. Өвчтөнийг шээхээр хүсдэг.
9. Үсний хавчаар, контакт линз, хиймэл шүд зэргийг авна.
10. Журмын өмнөх эмийн эмчилгээг зааврын дагуу хийх.

D. Журмын явцад

1. Судас доторх шугам тавигдах үед электроэнцефалографийн болон электрокардиографийн электродүүдийг холбоно.
2. Эмчилгээний туршид цусны даралт, зүрхний цохилт, хүчилтөрөгчийн ханыг хянана.
3. Нэг шагайн эргэн тойронд цусны даралт хэмжигч манжет тавьж, эмийг хөл рүү орохоос сэргийлэхийн тулд агааржуулна. Процедур эхлэхэд таталтын үйл ажиллагааг тухайн хөлний хөдөлгөөнөөр ажиглан хянаж болно.
4. Өгөх эмийн бүрэлдэхүүнд богино үйлчлэлтэй мэдээ алдуулагч болон булчин сулруулагч орж болно.
5. Оксигенийг нүүрний маск ашиглан өгдөг.
6. Амьсгалын зам эсвэл амны хамгаалалтыг байрлуулдаг

Клиент хэлээ хазаж байна.

7. Цахилгаан өдөөлт өгөгдөнө; богино хугацааны таталт үүснэ.

E. Жагсаалтын дараах

1. Өвчтөнийг цусны даралт хэмжигч манжет болон оксиметр зүүсэн байдалтай сэргээх хэсэгт шилжүүлнэ; тэнд хүчилтөрөгч, соруулагч болон бусад яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж бэлэн байдаг.
2. Процедурын дараа ойролцоогоор 15 минутын дараа үйлчлүүлэгч сэрнэ.
3. Клиент сэрэхэд түүнтэй ярилцаж, амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн температур зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг авна.
4. Өвчтөн хэдэн цагийн турш төөрөлдөж, орчноо таньж чадахгүй байж болно; товч, тодорхой, энгийн танин мэдэхүйн мэдээлэл өгч, тайвшруулах хэрэгтэй.
5. Өвчтөнийг хүчилтөрөгчийн хангалт дор хаяж 90% байгааг, амьсгал, зүрх судасны үзүүлэлт тогтвортой, сэтгэл зүйн байдал хангалттай гэж үнэлэгдсэн тохиолдолд сувилахуйн тасагт буцаана.
6. Өвчтөнд шингэн, хоол эсвэл эм өгөхөөс өмнө залгиулах рефлекс (gag reflex)-ийг шалгана.

F. Боломжит гаж нөлөө

1. Төөрөлдөх, чиг баримжааг алдах, богино хугацааны ой санамж алдагдах
2. Клиент сэрэхдээ төөрсөн, чиг баримжаагаа алдсан байж болно.
3. Бусад гаж нөлөөнд толгой өвдөх, даралт буурах, булчин өвдөх, дотор муухайрах, зүрх дэлсэх зэрэг орно.
4. Санах ой алдагдал үүсч болно, гэхдээ ихэвчлэн санах ой бүрэн сэргэдэг; зарим өвчтөнд санах ой алдагдал 6 сар хүртэл үргэлжилдэг.

Сэтгэл гутралтай үйлчлүүлэгч болон саяхан

антидепрессант эмчилгээг саяханСкизофрениТайлбар: Скизофрени нь психозын шинжүүд (галлюцинаци болон төөрөгдөл), бодлын эмх замбараагүй байдал, харилцааны эвдрэлийг агуулсан сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлуудын бүлэг юм.

XI. Шизофрenia

A. Тайлбар

1. Схизофрени нь психозын шинжүүд (галлюцинаци болон төөрөгдөл), бодлын эмх замбараагүй байдал, харилцааны эвдрэлийг агуулсан сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлуудын бүлэг юм.

2. Сэтгэл хөдлөл, сэтгэл санаа, зан үйл болон

ын үйл явц алдагддаг.

3. Эмчилгээ нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой шинж тэмдгүүдийг хянадаг.

B. Үнэлгээ (Зураг 65-1)

1. Бие махбодийн онцлог шинжүүд
    a. Цэгцгүй төрх; ариун цэвэр, хооллолт, унтах, бие засахыг орхигдуулж болно
    b. Биеийн дүрсийн гажилт
    c. Бие махбодийн гомдлоор ихэд зовох
2. Хөдөлгөөний идэвхи (65-9-р хайрцаг)
    a. Кататоник байрлал: Урт хугацаанд хачирхалтай байрлал барих
    b. Кататоник догдлол: Орчны ямар ч өдөөлтгүйгээр догдолж хөдөлнө
    c. Бүхэлдээ хөдөлгөөнгүй болох боломжтой
    d. Тушаалд хариу өгөх чадваргүй эсвэл зөвхөн тушаалд хариу өгөх
    e. Лавлагчлаг уян хатан байдал
    f. Давтагдсан эсвэл хэвшмэл хөдөлгөөнүүд
    g. Хөдөлгөөний идэвхи нэмэгдэж болно: сэтгэл түгшүүр, эргэлдэх, унтаж чадахгүй байх, өлсгөлөн ба жин буурах, түргэн шийдвэр гаргах хандлагаар илэрнэ
    h. Үйл хөдлөл эхлүүлэх чадвар алдагдах (анерги)
3. Сэтгэл хөдлөлийн онцлог шинжүүд
    a. Итгэлгүй байдал
    b. Дэлхийг аюултай, аюулгүй бус гэж үзэх
    c. Сэтгэл хөдлөл сул, хөндий эсвэл зохисгүй
    d. Халлуцинаци эсвэл төөрөгдөлд хариу болгон эсвэл өвчний улмаас учирсан хохирлоос үүдсэн гашуудалтай холбоотойгоор хоёр талт мэдрэмж, тусламжгүй байдал, түгшүүр, уур хилэн, гэмшил эсвэл депрессийн мэдрэмжийг илэрхийлж болно
4. Компульсив ритуал: зөрчилдөж буй сэтгэл хөдлөлөө шийдвэрлэхийн тулд тогтмол давтагддаг үйлдэл
5. Хэт дагалдах байдал: Бусдын заасан яг л зүйлийг хийж, ямар ч үйлдлийнхээ хариуцлагыг үгүйсгэх оролдлого
6. Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд
    a. Хавтгай эсвэл зохицохгүй сэтгэл хөдлөл эсвэл зохимжгүй сэтгэл хөдлөл
    b. Өөрчлөгдсөн сэтгэх үйл явц
7. Хэвийн бус сэтгэлгээний үйл явц (Бох 65-10)
    a. Бодит байдлыг шалгах чадвар алдагдсан
    b. Бодлын бутархай байдал
    c. Бодол тасалдах
    d. Чөлөөт холбогдлууд

e. Эхолали: бусдын үгийг өвчний улмаас давтан хэлэх
f. Орчны гажигдсан хүлээн мэдрэхүй
g. Неологизм: зөвхөн үйлчлүүлэгчид утгатай зохиомол үгс
h. Шидэт сэтгэлгээ
i. Үг болон бодол дахь утгыг ойлгох чадваргүй байдал
j. Баримтуудыг логик дараалаар эмхлэх чадваргүй
k. Бодол боловсруулах үйл явц эсвэл агуулгатай холбоотой төөрөгдөлүүд

8. Төөрөгдлийн төрөлүүд (65-11-р хайрцаг)

a. Хамаарал алдах, үйлчлүүлэгч тодорхой үйл явдал, нөхцөл байдал эсвэл харилцан үйлчлэлийг шууд өөртэй нь холбоотой гэж үздэг
b. Хөөцөлдөх туйлшрал: үйлчлүүлэгч өөрийгөө ямар нэгэн хүчирхэг хүчний зүгээс дарамтлуулж, сүрдүүлж, хавчигдаж байна гэж итгэдэг
c. Өөрийгөө агуу гэж үзэх төөрөгдөлд үйлчлүүлэгч бусад хүн эсвэл ертөнцтэй харьцуулахад өөртөө онцгой ач холбогдол өгч, бодит байдалд үндэслэлгүйгээр өөрийгөө хэтрүүлэн үнэлдэг
d. Соматик төөрөгдөл, өвчтөн бие нь ер бусын байдлаар өөрчлөгдөж эсвэл хариу үйлдэл үзүүлж байна гэж итгэдэг боловч бодит байдалд үндэслэлгүй

9. Үзэхүйн гажиг

a. Иллюзиуд нь бодит байдлыг буруу тайлбарлах эсвэл буруу хүлээн ойлгох түр зуурын туршлага байж болно
b. Халлюцинаци (5 мэдрэхүй) нь бодит байдалд үндэслэлгүй (65-12-р хайрцаг), жишээлбэл биет зүйлс, мэдрэмж эсвэл дүрс зэргийг мэдрэх

10. Хэл болон харилцааны алдагдал (Бох 65-13)

a. Бодлын үйл явцын эмгэгийнтэй холбоотой
b. Хэл яриа зохион байгуулах чадвар алдагдах
c. Тодорхой ойлгомжтой харилцахад хүндрэлтэй
d. Нөхцөл байдалд зохисгүй хариу өгөх
e. Нэг үг эсвэл хэлц нь ярианы бүх утгыг илэрхийлж болох тул үйлчлүүлэгч хангалттай харилцсан мэт мэдрэх магадлалтай.

f. Хувийн хэлний хөгжил

C. Оролцоо: Скизофрени (65-14-р хайрцаг)

D. Оролцоо: Идэвхтэй галлюцинаци

1. Халлюцинацийн дохиог ажиглаж, халлюцинацийн агуулгыг үнэлнэ.
2. Нэг-нэгээр нь харилцан оролцох.
3. Стимулийг бууруулах эсвэл үйлчлүүлэгчийг өөр газар шилжүүлэх.
4. Бусад хүмүүс ч бас галлюцинацид өртөж байгаа мэт үйлчлүүлэгчид ойлгуулахгүй байх.
5. Клиент бодит зүйлсийн талаар ярьж байгаа аливаа зүйлд аман хариу өг.
6. Клиенттэй биеэр хүрэлцэхээс зайлсхий.
7. Клиентийг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхийг урамшуул.
8. Халлюцинацийн үед үйлчлүүлэгчийн анхаарлыг тодорхой нэгэн бодит үйл ажиллагаагаар татахыг оролдоно.
9. Үйлчлүүлэгчийн зан байдлыг хүлээн зөвшөөрч, инээдмийн сэдэв болгохгүй, шүүмжлэхгүй.
10. Хялбар үйл ажиллагаа болон өдөр тутмын амьдралын тогтмол дадалтай, зохион байгуулалттай орчныг бүрдүүл.
11. Айдас, түгшүүр эсвэл сандрал нэмэгдэж буй шинж тэмдгүүдийг ажигла.
12. Шаардлагатай бол өдөөлтийг бууруул.
13. Эмчилгээг эмчийн зааврааp яг заасан ёсоор нь өг.

Халлюцинацитай үйлчлүүлэгчийн хувьд аюулгүй байдал нь хамгийн түрүүнд тавигдана; Клиент өөрийгөө болон бусдыг гэмтээхийг тушаасан сонсголын тушаалгүй гэдгийг баталгаажуулах.

E. Оролцоо: Төөрөгдөлүүд

1. Бодит байдалд тулгуурлан харилцах.
2. Клиентийг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхийг урамшуулах.
3. Клиенттэй маргалдаж, түүний төөрөгдлийг худал гэж итгүүлэх гэж оролдохгүй.
4. Нэг-нэгээр нь үйл ажиллагаа эхлүүлнэ.
5. Шаардлагатай бол эмнэлгийн өдөр тутмын дэглэмийг өөрчилж, бэлэн савласан эсвэл гэрээс авчирсан хоол хүнс ашиглаж болно.
6. Амжилтыг нь хүлээн зөвшөөрч, эерэг санал сэтгэгдэл өг.

XII. Зан чанарын эмгэгүүд

A. Тайлбар

1. Зан төлөвийн эмгэгүүд нь янз бүрийн уян хатан бус, зохисгүй зан үйлийн хэв маягийг тогтмол илэрхийлэх буюу

Эдгээр шинж чанарууд нь үйл ажиллагаа болон харилцаанд сөргөөр нөлөөлж болно.

2. Клиент ихэвчлэн бодит байдлыг мэдэрч, өөрийн таних чадвар болон харилцааны зан үйл (эмпати эсвэл дотно харилцаа) талаарх ойлголт дутуу байдаг.
3. Стресс нь зан төлөвийн эмгэгийн илрэлийг улам хурцатгадаг.
4. Бодисын буруу хэрэглээний нөлөө эсвэл хүнд толгой гэмтэл зэрэг ерөнхий эмнэлгийн нөхцөлтэй шууд холбоогүй.

B. Онцлог шинжүүд

1. Өөрийн хөдөлгөөнийг хянах чадвар сул
    a. Дотоод өвдөлтөө зохицуулахын тулд гадаад үйлдлүүд гаргах
    b. Гарах үйлдлүүдэд бие махбодийн болон аман довтолгоо (жишээлбэл хашгирах, хараал ашиглах), өөртөө гэмтэл учруулах үйлдлүүд (жишээлбэл арьс зүсэх, толгойгоо цохих, өөрийгөө цохих), манипуляци, мансууруулах бодис хэрэглэх, олон хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох, **амиа хорлох оролдлого** зэрэг орно.
    c. Клиент өөртөө, шашинд эсвэл бэлгийн харьцаанд хэт их анхаарч болно.
2. Сэтгэл хөдлөлийн онцлог
    a. Орхигдсон мэдрэмж болон сэтгэл гутралтай тулгарч болно
    b. Сэтгэл хөдлөлд уур хилэн, гэмшил, айдас, хоосролын мэдрэмж орж болно.
3. Шүүмжлэх чадвар алдагдсан
    a. Асуудал шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй
    b. Зан үйлдлийн үр дагаврыг ухамсарлах чадваргүй
4. Бодит байдлыг шалгах чадвар алдагдах: бодит байдлыг гажуу ойлгох ба ихэвчлэн өөрийнхөө мэдрэмжийг бусад руу шидэх
5. Гэмтсэн объектын харилцаа: хатуу, уян хатан бус, дотно харилцаанд хүндрэлтэй
6. Өөрийгөө хүлээн ойлгох чадвар алдагдсан: өөрийгөө буруу төсөөлөх, өөрийгөө үзэн ядах эсвэл өөрийгөө идеалчлах туршлага
7. Бодох үйл явцын алдагдал
    a. Конкрет буюу тархсан сэтгэлгээ
    b. Анхаарал төвлөрүүлэхэд хүндрэлтэй
    c. Санаа бодох чадвар алдагдсан
8. Өдөөлтийн саад алдагдсан
    a. Ороод ирж буй мэдрэхүйн өдөөлтийг зохицуулах чадвар алдагдах
    b. Илүүдсэн сэрэлзэл
    c. Дуу чимээ, гэрэлд хэт их хариу үйлдэл үзүүлэх
    d. Анхаарал тогтоох чадвар сул
    e. Тэвдүүрхэл

f. Нойргүйдэл

C. А бүлгийн зан төлөвийн эмгэгүүдэд хачирхалтай төрөлүүд орно: схизоид, схизотипаль, параноид.

1. Скизоидын зан төлөвийн эмгэг нь дулаан, ойр дотно нийгмийн харилцаа үүсгэх чадваргүйгээр илэрдэг.

a. Нийгмийн тусгаарлал ба ойр дотно харилцааны дутагдал

b. Ганцаар ажиллах сонирхол

c. Хөндий байдал ба үл тоомсорлох байдал

d. Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх чадвар хязгаарлагдмал

e. Бусдад сонирхолгүй байх

2. Скизотипаль зан төлөвийн эмгэг нь хэвийн бус эсвэл маш ер бусын бодол, хүлээлт, яриа болон зан үйл, хэв маягийг илэрхийлдэг.

a. Сэжиглэмтгий байдал ба паранойя

b. Өөрийн үйлдэл нь бусдад хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгож чадахгүй

c. Хачирхалтай зан авир

d. Шидтэн сэтгэхүй

e. Хачирхалтай бодол ба яриа

f. Харилцааны дутагдал

g. Сэтгэл хөдлөл сулрах

h. Ганцаардмал байдал

3. Параноидын зан төлөвийн эмгэг нь бусдыг сэжиглэх, итгэлгүй байх (паранойя) (65-15-р хайрцаг) шинжүүдээр тодорхойлогдоно.

a. Сэжиглэмтгий, итгэлгүй байж болно

b. Маргаантай байж болно

c. Эсвэл дайсагнасан эсвэл хөндий байж болно

d. Хатуу чанд, шүүмжлэлтэй, бусдыг хянах хандлагатай байж болно

e. Өөрийгөө агуу гэж бодох бодолтой байж болно

Клиентынхаа өмнө шивнэн ярьж эсвэл инээж болохгүй

Параноидын зан төлөвийн эмгэгтэй үйлчлүүлэгчийн өмнө шивнэн ярих эсвэл инээх нь түүнийг таныг түүний тухай ярьж, инээж байна гэж бодоход хүргэнэ; энэ нь паранойдыг улам нэмэгдүүлдэг.

D. В бүлгийн зан төлөвийн эмгэгүүд нь драматик, сэтгэл хөдлөм, тогтворгүй төрөлд хамаарна: истери, нарциссист, антисоциаль болон хил хязгаартай.

1. Хистрион төрлийн зан төлөв нь хэтэрхий драматик, туйлын илэрхийлэлтэй ааш зантай байдаг.

a. Амьдралтай, драматик бөгөөд анхаарлын төвд байх дуртай

b. Хүмүүстэй харилцаа нь сул, гүехэн байдаг

c. Бэлгийн тал дээр дур булаам эсвэл өдөөн хатгасан байж болно

d. Өөрийнхөө амьдралыг хэтрүүлэн драмжуулдаг бөгөөд театрын шинжтэй харагдаж болно

e. Гадна төрхөндөө хэт их санаа тавьдаг

f. Амархан уйддаг

2. Нарциссист зан төлөвийн эмгэг нь өөрийгөө илүү чухал гэж үнэлэх мэдрэмж нэмэгдсэн, хязгааргүй амжилт, төсөөлөлд автсан байдлаар илэрдэг.

a. Хүндэлж бишрэх хэрэгцээ ба амжилтуудаа хэтрүүлэн томоор үзүүлэх

b. Өөрийн чадварыг хэт үнэлж, бусдын оруулсан хувь нэмрийг дутуу үнэлдэг

c. Өөр хүний хэрэгцээ, мэдрэмжид эмпатигүй, мэдрэг бус байдал

3. Антисоциаль зан төлөвийн эмгэг нь хариуцлагагүй, нийгмийн эсрэг зан үйл, хувиа хичээх байдал, тогтвортой харилцаа үүсгэж чадахгүй байх, бэлгийн харилцаанд зохицох чадвар муутай байх, нийгмийн дүрэм журамд захирагдахгүй байх, амархан уурлах, түрэмгий зан гаргах хандлага зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг.

a. Дэлхийг дайсагнасан гэж үздэг

b. Эмпатийн дутагдал ба гэмшил мэдрэхүйн дутагдал

c. Эгоцентризм ба хувийн таашаалд төвлөрсөн байдал

d. Мэхтэй, манипуляци хийдэг

e. Хариуцлагагүй

f. Туршлагагүй бөгөөд эрсдэлтэй үйлдэл хийх

g. Тогтмол эсвэл давтамжтай уур хилэнгийн мэдрэмж

h. Нийгмийн дүрэм, хэвийн зан үйлд дагахыг хүсэхгүй байх

4. Хилийн зан төлөвийн эмгэг нь харилцааны тогтворгүй байдал, сэтгэл хөдлөл болон өөртөө хандсан дүр төрхийн тогтворгүй байдал, түр зуурын болон урьдчилан тааварлашгүй зан үйлээр илэрдэг.

a. Өөртөө хандах үнэлэмж сул эсвэл өөрийн дүр төрх тогтворгүй

b. Өөрийгөө чиглүүлэх чадвар дутуу

c. Тогтворгүй, ширүүн хувийн харилцаа

d. Бусдын хэрэгцээ, мэдрэмжид өрөвч сэтгэлгүй байх

e. Сэтгэл хөдлөлийн хэт их хэлбэлзэл

f. Түрүүлж шийддэг

g. Эрсдэлтэй үйлдэл хийх

h. Өөрийг нь доромжилсон, доромжлох гэж үзсэн явдалд маргаантай, дайсагнасан хариу үйлдэл үзүүлдэг

i. Депрессийн эмгэг

j. Манёврлах

k. Стресст хариу болгон маш хүчтэй түгшүүрийн мэдрэмж

l. Тогтмол хоосон мэдрэмж болон няцаагдсаны хүчтэй айдас

m. Сплиттинг — бусдыг бүхэлд нь сайн эсвэл бүхэлд нь муу гэж хардаг; нэг хүнийг нөгөөгийнхөө эсрэг тавьж, хооронд нь зөрчилдөөн үүсгэдэг

E. С бүлгийн зан төлөвийн эмгэгүүдэд түгшүүртэй, аймхай төрлийн зан төлөвийн эмгэгүүд орно: шахалттай-даралттай зан төлөв, зайлсхийх зан төлөв, хамааралтай зан төлөв.

1. Компульсив шинж чанартай зан төлөв нь дулаан, энхрий сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд хүндрэлтэй, төгс төгөлдөрийн эрмэлзэлтэй, зөрүүд, бусдыг хянах хэрэгцээтэй, ажилд туйлын үнэнч байх шинжүүдээр тодорхойлогдоно.

a. Өөртөө хэт өндөр, бодитоос зөрүүтэй шаардлага тавьдаг төгс төгөлдөрийн үзэлтэй

b. Уян хатан бус, нарийн ширийн зүйлс болон дүрэм журамд хэт анхаардаг

c. Өөрийгөө голчлон ажлаараа тодорхойлдог

d. Нийгмийн болон хувийн харилцааг ажил, бүтээмжийн дараах ач холбогдолтой гэж үздэг

e. Бусдын санаа бодол, мэдрэмж, үйлдлийг ойлгоход хүндрэлтэй

f. Ритуалд автдаг

2. Хожуулах зан төлөвийн эмгэг нь нийгмээс татгалзах болон боломжит няцаалтад хэт мэдрэг байдлаар илэрдэг.

a. Өөрийгөө хангалтгүй гэж мэдрэх

b. Бусдын хариу үйлдэлд хэт мэдрэг, шүүмжлэлд сул хариу үйлдэл үзүүлдэг

c. Нийгмийн тусгаарлалт

d. Дэмжлэгийн тогтолцоо дутагдах

3. Хараат зан төлөвийн эмгэг нь

өөртөө итгэх итгэл эрс дутмаг, өөрийн үнэ цэнийг бага үнэлдэг, бие даан үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй байдлаар онцлог бөгөөд ингэснээр тухайн хүн амьдралынхаа чухал салбаруудад шийдвэр гаргах, хариуцлага хүлээхийг идэвхгүйгээр бусдад даатгадаг; хамааралтай үйлчлүүлэгч шийдвэр гаргахад маш их хүндрэлтэй байдаг.

F. Зан төлөвийн асуудалтай үйлчлүүлэгчид зориулсан ерөнхий арга хэмжээ

1. Өөрийгөө хорлох зан үйлээс хамгаалах.

2. Эрүүл мэндийн багийн мэдээлэл, үйлчлүүлэгчийн зохисгүй зан үйлд үзүүлэх хариу үйлдэл нэгэн жигд байгааг хангах.
3. Клиентээр сонголт хийх, аль болох бие даасан байх боломжийг олгох.
4. Клиентийг мэдрэмжээ үйлдлээр илэрхийлэхийн оронд ярилцаж хэлэлцэхийг уриалах.
5. Өдөр тутмын мэдрэмжээ тэмдэглэх тэмдэглэл хөтлөхийг үйлчлүүлэгчид урамшуулах.
6. Үйлчлүүлэгчтэй хүлээлтийн талаар болон үүрэг хариуцлагын талаар ярилцана.
7. Тодорхой зан үйлүүдэд дагалдах үр дагаврыг хэлэлц.
8. Өөртөө, бусдад болон эд хөрөнгөд хохирол учруулах нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй гэдгийг үйлчлүүлэгчид мэдэгд.
9. Үйлчлүүлэгчтэй бичгээр аюулгүй байдлын эсвэл зан үйлийн гэрээ боловсруул.
10. Сплиттинг зан үйлийг тодорхойл.
11. Клиенттэй уурыг шууд даван туулахад нь туслах.
12. Клиентийг бүлгийн үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалж, манипуляцийн бус зан үйлд магтаал өг.
13. Манипуляцийн зан үйлийг бууруулахын тулд хязгаар тогтоож, түүнийг баримтал.
14. Анхаарал татах зан үйл илэрдэг бүлгийн нөхцөл байдлаас үйлчлүүлэгчийг гаргах.
15. Нийгмийн нөхцөлд үзүүлсэн эерэг зан үйлд бодитой магтаал өгөх.

XIII. Нейрохөгжлийн эмгэгүүд

A. Аутизмын спектрийн эмгэг: 38-р бүлгийг үзнэ үү.

B. Анхаарал дутагдал, хэт идэвхитэй байдлын эмгэг: 38-р бүлгийг үзнэ үү.

XIV. Нейрокогнитив эмгэгүүд

A. Деменци ба Альцгеймерийн өвчин

1. Деменци

a. Деменц нь бүтцийн эсвэл үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн улмаас оюуны үйл ажиллагаа аажмаар доройтдог синдром юм.

b. Урт хугацааны болон богино хугацааны ой санамж алдагдаж, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, абстракт сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх чадвар болон зан үйлд алдаа гардаг.

c. Деменци нь өөрийгөө асрах чадварын дутагдалд хүргэдэг.

d. Деменцийн төстэй шинж тэмдгүүд нь физиологийн нөхцөл байдлаас үүдэлтэй байж болох тул эхлээд эдгээр нөхцөл байдлыг үгүйсгэх шаардлагатай.

e. Деменцийн хамгийн түгээмэл төрөл нь Альцгеймерийн өвчин юм.

2. Альцгеймерийн өвчин (65-16 дугаар хайрцаг)

a. Альцгеймерийн өвчин нь мэдрэлийн эсүүдийн доройтолоос үүдэлтэй, эргэн сэргээх боломжгүй хөгшрөлтийн деменцийн хэлбэр юм.

b. Альцгеймерийн өвчтэй хүмүүс танин мэдэхүйн чадвар доройтож, өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх чадвар нь аажмаар алдагддаг.

c. Өвчтөн бие махбодийн болон оюун ухааны үйл ажиллагаа тогтмол доройтож, өвчний сүүлчийн шатуудад ихэвчлэн мэргэжлийн байгууллагад урт хугацааны асаргаа шаардаг.

d. Альцгеймерийн өвчний үе шат ба гол онцлог шинжүүд: 1-р үе (хөнгөн): мартах; 2-р үе (дунд): төөрөгдөл; 3-р үе (дунд-хүнд): алхаж явдаг үеийн деменци; 4-р үе (сүүлчийн): төгсгөлийн үе.

3. Оролцоо

a. Үлдсэн ур чадварыг тодорхойлж, бэхжүүлэх.

b. Эмнэлгийн тусламжийн тасралтгүй байдлыг хангах.

c. Клиентийг орчны нөхцөл байдалд нь танилцуулах.

d. Орчныг танил эд зүйлсээр тохижуулах.

e. Клиентийн сэтгэл хөдлөлийг хүлээн зөвшөөр.

f. Клиент болон түүний гэр бүлийн гишүүдэд ой санамжийн дутагдал болон зан үйлийн өөрчлөлтийг зохицуулахад туслах.

g. Гэр бүлийн гишүүдийг асран халамжийн талаарх сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхийг уриал.

h. Хамгаалагчид дэмжлэг үзүүлж, боломжит нөөц болон дэмжлэгийн бүлгүүдийг тодорхойл.

i. Үйлчлүүлэгчийн өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагааг хянаж бай.

j. Үйлчлүүлэгчид өөрийгөө арчлах үйл ажиллагааг хэрхэн гүйцэтгэхээ сануулах.

k. Үйлчлүүлэгчийн бие даасан байдлыг хадгалахад туслах.

l. Үйлчлүүлэгчид тогтмол хэвшилтэй байдлыг хангах.

m. Клиенттэй хамт дасгал хөдөлгөөн хийх, жишээлбэл дагалдан алхах.

n. Ой санамжид их ачаалал өгдөг үйл ажиллагаанаас зайлсхий.

o. Үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхэд үйлчлүүлэгчид хангалттай цаг олго.

p. Түүнд тогтмол урам зориг өгөх

клиентд энгийн алхам алхмаар хандлага баримтлах.

q. Клиентэд дуу сонсох, зураг будалт хийх, телевиз үзэх зэрэг анхаарал сарниулах, цагийг өнгөрүүлэх үйл ажиллагаа санал болго.

r. Үйлчлүүлэгчид энгийн тоглоом эсвэл үйл ажиллагаагаар оюуны сэргэлт өг.

4. Төөрөлт

a. Клиентд ил задгай болон аюултай зүйлсгүй аюулгүй орчинг бүрдүүлнэ.

b. Аюулгүй алхах нөхцөлийг бүрдүүлэх, үүнд тав тухтай, хөлөнд нь зохих хэмжээтэй гутал, хөдөлгөөний туслах хэрэгсэл ашиглах.

c. Ойр дотно ба тогтмол хяналт тавь.

d. Хаалгыг нарийн ба найдвартай хаах.

e. Таних бугуйвч болон электрон хяналт ашигла.

f. Өдрийн хоёрдугаар хагасд амрахыг урамшуул, учир нь шөнө тэнүүчлэл улам ихэсдэг.

g. Тогтмол хяналттай дасгалжуулалт эсвэл алхалтын хөтөлбөрүүдийг зохион байгуул.

h. Үдшийн хам шинж (sundowning) нь оройн цагаар шинж тэмдэг болон асуудалтай зан үйлүүд эрс нэмэгдэхээр илэрдэг.

Альцгеймерийн өвчтэй үйлчлүүлэгчийн асаргаанд аюулгүй орчныг бүрдүүлэх нь тэргүүлэх зорилт юм.

5. Харилцааны эмгэгүүд

a. Эдгээр эмгэгүүдэд хэлний эмгэг (илэрхийлэх–хүлээн авах эмгэг), ярианы авианы эмгэг (фонологийн эмгэг), хүүхэд наснаас эхэлсэн ярианы урсгал эмгэг (хавирах эмгэг) болон нийгмийн харилцааны эмгэг (нийгмийн харилцааны алдагдал) орно.

b. Харилцагчийн харилцааны түвшинд тохируулах.

c. Үг хэлэхгүй дохио зангааныг анхаар.

d. Харилцахад тогтвортой өндөр, нам хоолой ашигла.

e. Үйлчлүүлэгчийн яг өмнө зогсож, нүдний холбоог хадгал.

f. Клиент хариулах хангалттай хугацаа олго.

g. Тайван, итгэл төрүүлэм хоолой ашигла. Хэрвээ үйлчлүүлэгч сонсголын бэрхшээлтэй бол хүчтэй дуугаар ярьж болох ч бусад үед битгий чанга ярь.

h. Хэрвээ үйлчлүүлэгч ярьж буй үгийг ойлгохгүй бол пантомимын дохио ашигла.

i. Уртгүй үгс, энгийн өгүүлбэр ашиглан удаан, тод ярь.

j. Нэг дор зөвхөн нэг асуулт асууж, нэг дор нэг заавар өг.

k. Шаардлагатай бол асуултыг давтан хэл, гэхдээ утгыг нь өөрчлөхгүй.

l. Харилцааны өөр аргуудыг санал болго.

m. Харилцах үед гадаад шуугиан, анхаарал сарниулах зүйлсийг аль болох багасга.

6. Шүүмжлэх чадвар алдагдсан

a. Орчныхоо хивс, хортой бодис болон аюултай цахилгаан хэрэгслүүдийг зайлуул.

b. Шугаман халаагчийн температурыг бууруулах.

7. Өөрчлөгдсөн сэтгэх үйл явц

a. Клиентийг нэрээр нь дуудах.

b. Клиентийг байнга чиг баримжаажуулах.

c. Өрөөнд танил эд зүйлс ашигла.

d. Календарь болон цагийг харагдах газар байрлуул.

e. Танил хэв маягийг хадгал.

f. Клиентээ дурсамж сөхөхийг нь зөвшөөр.

g. Үүрэг даалгавруудыг энгийн болго.

h. Үйлчлүүлэгчид даалгаврыг гүйцэтгэхэд хангалттай цаг олго.

i. Сайн зан үйлд эерэг урамшуулал өг.

8. Өөрчлөгдсөн унтах хэв маяг

a. Клиентийг аюулгүй газар дамжин явахыг ядартал нь зөвшөөр.

b. Өрөөнд сүүдэр үүсэхээс сэргийлэхийн тулд шууд бус гэрэл ашигла.

c. Гипнотик эмүүдийг хэрэглэхээс зайлсхий, учир нь тэд төөрөгдөл үүсгэж, нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлдэг

үдшийн сэтгэл түгших нөлөө.

9. Тайвангүй байдал

a. Толгой сэргэх шалтгааныг үнэл.
b. Клиентийн сэтгэлийг тайвшруул.
c. Клиент догдолж буй үед аюултай байж болох зүйлсийг зайлуул.
d. Өвчтөнд урд талаас нь аажмаар, тайван ойртож, ярих, дохио өгөх, хөдөлгөөнөө удаан хий.
e. Клиентийг бага стресстэй орчинд шилжүүлж, илүүдэл өдөөлтийг бууруулах.
f. Хөнгөн мэдрэгчтэй хүрээрэй.
g. Клиенттэй маргалдаж болохгүй, түүнийг ямар нэг зүйл хийхэд албадахгүй.

Хаяг 65-1

Ерөнхий түгшүүрийн эмгэгийн шалгуур

- 6 сараас дээш хугацаанд хэд хэдэн үйл явдал эсвэл үйл ажиллагааны талаар хэт их түгшүүр, санаа зовнил
- Сэтгэл түгшүүртэй зохицож чадахгүй байх
- Доорх шинж тэмдгүүдээс гурваас (эсвэл түүнээс дээш) шинж тэмдэг 6 сараас дээш хугацаанд илэрсэн түгшүүр:
  1. Амар тайвангүй эсвэл түгшүүртэй мэдрэх
  2. Амархан ядардаг
  3. Анхаарал төвлөрөх чадвар сул
  4. Уур уцаартай байдал
  5. Цэнгэг булчингийн хурцадмал байдал
  6. Унтах хүндрэл (унтаж эхлэх эсвэл унтаж байхдаа сэрэхэд хүндрэлтэй)
- Сэтгэл түгшил нь ихээхэн зовнил үүсгэж, ажиллах болон харилцаа хадгалах чадварыг алдагдуулдаг
- Зэрэгцэн бодис хэрэглэх болон буруу хэрэглээ байхгүй
- Үндсэн эмгэг шалтгаан илрээгүй
- Өөр сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлаар тайлбарлагддаггүй

Америкийн сэтгэцийн эмч нарын холбоо: *Сэтгэцийн эмгэгийн оношилгоо, статистикийн жил тутмын эмхэтгэл,* 5 дахь хэвлэл, Вашингтон, DC, 2013.

Хавтас 65-2

Посттравматик стрессийн эмгэгийн эмчилгээ, оролцоо

- Шүүмжлэлгүй, дэмжлэгтэй ханд.
- Клиентэд түүний мэдрэмж, зан үйл нь хэвийн хариу үйлдэл болохыг баталгаажуул.
- Клиентийн сэтгэл хөдлөл, зан үйл болон травмын туршлагын хоорондын холбоог таньж мэдэхэд нь туслах.
- Клиентийг өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэхэд нь урамшуулах; хяналтаа алдах эсвэл уур хилэнтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх хувь хүний эмчилгээг үзүүлэх.
- Өөрийгөө алах эрсдэлийг хянах
- Стресс удирдах аргуудыг заах.
- Клиенттэй хамтран дасан зохицох арга барилыг хөгжүүлж, тайвшруулах техникүүдийг ашиглахад нь туслах.
- Дэмжлэгийн бүлгүүдийг ашиглахыг уриалах.
- Traumaны туршлагыг үе шаттайгаар эргэн хянаж (*flooding* гэж нэрлэдэг) боловсруулах үйл явцыг хөнгөвчлөх.
- Клиентийг харилцаа тогтоох, сэргээхэд нь урамшуулах.
- Эмчилгээнд гэр бүлийг оролцуулах.
- Клиентд гипнотерапи эсвэл системчилсэн мэдрэгжүүлэлтийг эмчилгээний нэг хэлбэр болгон санал болгож магадгүйг мэдэгд.

Хаяг 65-3

Фобийн зарим төрөл

Акрофоби: өндөрт айх ***Агорафоби:*** нээлттэй талбайд айх ***Астрафоби:*** цахилгаан бороонд айх
Клаустрофоби: хаалттай зайд айх ***Гематофоби:*** цусанд айх ***Гидрофоби:*** усанд айх ***Монофоби:*** ганцаараа байх айдас ***Мисофоби:*** бохир зүйлд эсвэл нянгийн айдас ***Никтофоби:*** харанхуйд айх
Пирофоби: галд айх
Нийгмийн фоби: Ичгүүртэй эсвэл шүүмжлүүлэх нөхцөл байдлаас айх; өөрийгөө тэнэг болгох вий гэж эмээх
ксенофоби: танихгүй хүмүүсээс айх
Зоофоби: Амьтдаас айх

Хаяг 65-4

Компульсив болон туунтэй холбоотой эмгэгүүдийн эмчилгээний арга хэмжээ

- Үндсэн хэрэгцээ (хоол, амралт, ариун цэвэр) хангагдсан байхыг баталгаажуул.

- Компульсив зан үйлд түлхэц болдог нөхцөл байдлыг тодорхойлж, үйлчлүүлэгчийг санаа зовнил, мэдрэмжээ үгээр илэрхийлэхийг дэмж.
- Клиентийн сэтгэл хөдлөлийг ойлгож, түүнийг зан үйлээ гүйцэтгэх шаардлагатай байгааг ухамсарла.
- Заавал дадал нь үйлчлүүлэгч эсвэл бусдын аюулгүй байдлыг эрсдэлд оруулж байвал тасалдуулахгүй (заавал дадлын улмаас үүсэх үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах).
- Клиентээс шаардлагатай зан үйлийг гүйцэтгэхэд нь цаг гаргаж өг, гэхдээ түүний бие махбодийн сайн сайханд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйлдлүүдэд хязгаар тогтоож, бие махбодийн гэмтлээс хамгаалах.
- Үйлчлүүлэгчийн анхаарлыг эдгээр зан үйлээс сарниулах хуваарь гарга (үйлчлүүлэгчид зориулсан энгийн үйл ажиллагаа, тоглоом эсвэл даалгавруудыг зохион байгуул).
- Үйлчлүүлэгчийн шахалттай зан үйлүүдийн давтамжийг аажмаар бууруулахад туслах бичгээр байгуулсан гэрээг байгуулах.
- Ритуал бус эерэг зан үйлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, урамшуул.

Хаяг 65-5

Биполяр болон холбогдох эмгэгийн үнэлгээ

Мания

- Хурдан уурлана
- Хуурамч өөртөө итгэх итгэл
- Хязгаарыг байнга давж, бусдыг удирдаж, алдаа хайх
- Аз жаргалтай, эрч хүчтэй сайн сайхны мэдрэмжтэй
- Хязгаарлалт бараг эсвэл огт байхгүй
- Орчны өдөөлтөд амархан анхаарал сарнидаг
- Экстраверт зан чанар
- Идеалын нислэг
- Агуулагч ба хавчигдсан туйлшрал
- Өндөр ба тогтворгүй сэтгэл хөдлөл
- Хоолны дуршил эрс буурсан
- Чухал зүйлд оролцож байгаагаас идэж, унтаж чадахгүй байх
- Хязгааргүй эрчим хүч
- Тохиромжгүй сэтгэл хөдлөл
- Тохиромжгүй этгээд, хэт тод эсвэл өнгөлөг хувцаслалт
- Нүүр будалт нь өнгөлөг, хэтрүүлсэн
- Хэт их зарцуулалт
- Шахагдсан болон/эсвэл хонх шиг авиатай яриа
- Тайвангүй байдал
- Бэлгийн харьцаа олон хүнтэй
- Яаралтай хөдөлгөөний үйлдэл

Депрессийн үед

- Өлсгөлөн нэмэгдэх эсвэл буурах
- Өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагаа буурах
- Сэтгэл хөдлөл болон биеийн идэвхи буурах
- Амархан ядардаг
- Шийдвэр гаргах чадвар алдагдах
- Анхаарал төвлөрөх чадвар муудах
- Дотогшоо дайсагнал
- Дотогшоо зан чанар
- Нийгмийн тусгаарлалт ба бүлгүүдээс татгалзах
- Эрч хүч дутагдах
- Инициатива дутагдах
- Өөртөө итгэх итгэлгүй байдал ба өөрийн үнэ цэнийг доогуур үнэлэх байдал
- Бэлгийн сонирхолгүй байдал
- Психомотор саатал
- Өөрийгөө алах тухай бодол

Бохь 65-6

Биполяр эмгэгийн холбоотой зохисгүй зан үйлтэй харьцах

Агрессив зан үйл

- Клиентд бухимдал, догшин зан мэдрэмжүүдийг танихад нь туслах.
- Үйлдэл хийхийн оронд бухимдлаа үгээр илэрхийлэхийг үйлчлүүлэгчид уриал.
- Клиенттэй хамтран дайсагналтай зан үйлд хүргэдэг эхлүүлэгч үйл явдал эсвэл нөхцөл байдлыг тодорхойлоход туслах.
- Энэхүү зан үйл нь өөрт болон бусдад хэрхэн нөлөөлдөгийг тайлбарлах.
- Клиентэд өмнө нь ашиглаж байсан дасан зохицох механизmuудаа тодорхойлоход туслах.
- Үйлчлүүлэгчид бухимдал эсвэл догшин зантай тэмцэхийн тулд асуудал шийдвэрлэх аргуудыг ашиглахад туслах.

Хүчтэй сэтгэл хөдлөлийг намжаах техникүүд

- Клиент, бусад үйлчлүүлэгчид болон өөрийн аюулгүй байдлыг хангах.
- Хувийн зайг хүндэтгэж, дайсагналгүй байрлалтай бай.
- Аман харилцаа тогтоо.
- Тайван хандлага баримталж, тайван, тод хоолойгоор харилцаарай (зөрүүд биш, шийдэмгий бай).
- Товчхон бай.

- Клиент юуг өөрийн хүсэл, мэдрэмж гэж үздэгийг тодорхойл.
- Клиент юу хэлж байгааг анхааралтай сонс.
- Аман маргаанаас зайлсхий: санал нийлэх эсвэл санал зөрөхөд тохиролцох.
- Үйлчлүүлэгчийн зан үйлтэй холбоотой тодорхой сонголтуудыг санал болго.
- Сонголт болон найдвар өг.
- Клиенттэй хамтран боломжуудын хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахад туслах.
- Клиент болон ажилтнуудтай үр дүнг хэлэлцэх.

Мэх зальтай зан үйл

- Тодорхой, тогтмол, бодитой, хэрэгжүүлэх боломжтой хязгаарыг тогтоож, хүлээгдэж буй зан үйлийг мэдэгд.
- Тогтоосон хязгаарыг давсны үр дагаврыг тодорхой мэдэгдэж, шаардлагатай бол шийтгэлгүйгээр тэдгээр үр дагаврыг хэрэгжүүлнэ.
- Клиентын зан байдлыг шүүмжлэлгүй, заналхийлэлгүйгээр хэлэлц.
- Клиенттэй эрх мэдлийн тэмцэлд бүү оролдож, маргалдахаас зайлсхий.
- Клиент өөрийн зан үйлд хязгаар тогтоох аргыг боловсруулахад нь туслах.

65-7-р хайрцаг

Сэтгэл гутралтай үйлчлүүлэгчдэд зориулсан оролцооны арга хэмжээ

Хохирлын эрсдэл

- Аллагын болон амиа хорлох бодол санааг үнэлнэ.
- Өөрийгөө аюулгүй байлгах арга хэмжээ авах (орчин тойронд аюултай зүйлс байхгүйг баталгаажуулах).
- Клиентийг удаан хугацаагаар ганцааранг нь бүү орхи.
- Хэрэв үйлчлүүлэгч амиа хорлох төлөвлөгөөтэй бол түүнийг нэг-нэг хяналтад шилжүүлнэ.
- Шаардлагатай бол үйлчлүүлэгчтэй "өөрийгөө алахгүй байх гэрээ" байгуул.

Үйл ажиллагаа

- Өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагаа болон нэгжийн эмчилгээний үйл ажиллагаанд оролцохыг зөөлөн урамшуулан дэмж.
- Клиент бэлэн биш байгаа шийдвэр гаргах эсвэл төвөгтэй сонголт хийхийг шахаж болохгүй.
- Клиент амжилттай гүйцэтгэж чадах, түүний давуу талыг хөгжүүлэх боломжтой бодит үйл ажиллагаа санал болго.
- Клиенттэй эхлээд ганцаарчилсан үйл ажиллагаа явуулна.
- Өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, гэмших сэтгэлийг намжаахад хялбар, их төвлөрөл шаардахгүй үйл ажиллагаа (энгийн карт тоглоом, зураг зурах) санал болго.

- Клиентийг ерөнхий хөдөлгөөний үйл ажиллагаанд (алхах) оролцуулах.
- Эцэст нь үйлчлүүлэгчийг жижиг бүлгийн үйл ажиллагаанд, дараа нь том бүлгийн үйл ажиллагаанд оролцуулах.

Хоол тэжээл

- Хоол тэжээлийн хэрэглээ болон жинг хянаж, хоол тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх.
- Хооллох үед үйлчлүүлэгчийн дэргэд байж хоолны хэмжээг нарийвчлан үнэлж, хангалттай шим тэжээл авахыг дэмжинэ.

Ариун цэврийн асаргаа

- Ерөнхий ариун цэвэр болон өөртөө арчилгаа хийх чадварын дутагдлыг хянаж, дутагдал нь сэтгэл гутрал гүнзгийрч байгааг илтгэж болно.
- Өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулсан уриалга өг.

Унтах хэв маяг

- Унтах хэв маягийг хянаарай.
- Унтахын өмнө орчны өдөөлтийг бууруул.
- Амраах техникүүдийг дэмжинэ.
- Унтахын өмнө үйлчлүүлэгчтэй хамт цагийг өнгөрүүлж, тав тухыг нэмэгдүүлж, ганцаардсан болон тусгаарлагдсан мэдрэмжийг бууруулна.

Өөрчлөгдсөн бодлын үйл явц

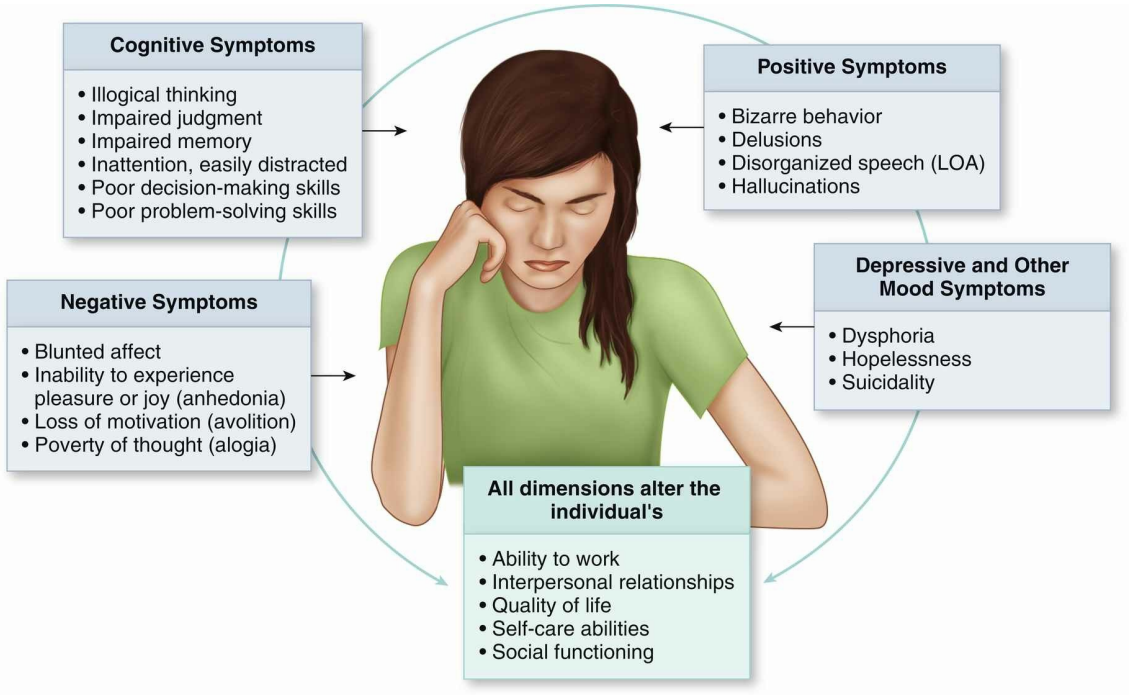
- Түүнд өөрийгөө илүү сайн, амжилттай байсан үеүүдээ сануулах.
- Клиенттэй хамт цагийг өнгөрүүлж түүний үнэ цэнэ, ач холбогдлыг ойлгуулах.
- Клиентийг амьдралын нөхцөл байдалд гарсан хохирол, өөрчлөлтүүдийн талаар ярилцахад нь урамшуулах.
- Клиентийг гуниг, уур хилэнгээ илэрхийлэхийг уриалж, аман хариулт өгөхөд хангалттай хугацаа олго.
- Уур хилэнг эмчилгээний аргаар хариу барина.

Хаяг 65-8

Цахилгаан таталт эмчилгээ (ECT): Хэрэглэх заалтууд

- Антидепрессант эмүүд үр дүнгүй тохиолдолд
- Хурдан, тодорхой шийдвэр гаргах шаардлагатай үед, жишээлбэл үйлчлүүлэгч амиа хорлох эсвэл хүний амь насанд халдах эрсдэлтэй үед
- Харилцагч маш их догдлол эсвэл гүн хойрго байдалд байх үед
- Бусад эмчилгээний эрсдэлүүд ECT-ийн эрсдлээс давуу байх үед

- Хэрэв үйлчлүүлэгч эмэнд хариу муутай түүхтэй, эсвэл ЭКТ-д сайн хариу үзүүлсэн түүхтэй, эсвэл аль аль нь
- Харилцагч эмчилгээний аргаар ЕСТ-ийг илүүд үзэх үед



Зураг 65-1. Шизофренийн эмчилгээнд хамаарах хэмжигдэхүүнүүд. *LOA,* холбоо харилцааны сулралт.

65-9-р хайрцаг

Хэвийн бус хөдөлгөөний зан үйл

Тайлбар

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн эмгэгийн улмаас сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалтай үйлчлүүлэгчид илэрдэг хэвийн бус хөдөлгөөний зан үйл эсвэл үйл ажиллагаа

Төрөл

Эхолалиа: Өөр хүний яриаг давтан хэлэх
Эхопраксия: Өөр хүний хөдөлгөөнийг давтан хийх
Лавлагч уян хатан байдал: Хүний гар эсвэл хөлийг тодорхой нэг байрлалд байлгаж, хэдэн цагийн турш тэр байрлалаа хадгалах

65-10 хайрцаг

Хэвийн бус бодлын явц

Тайлбар

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалтай үйлчлүүлэгчид сэтгэцийн эмгэгийн улмаас илэрдэг хэвийн бус бодлын явц

Төрөл

Нөхцөл байдлын дэлгэрэнгүй тайлбар: Яг гол зүйлдээ орох эсвэл асуултад хариулахынхаа өмнө үйлчлүүлэгч тоо томшгүй олон дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тайлбарт дарагддаг.
Конфабуляци: дурсамжийн хоосон зайг өгүүлэгч итгэдэг дэлгэрэнгүй төсөөлөөр нөхөх; конфабуляцийн зорилго нь өөртөө итгэх итгэлийг хадгалах; Корсаковын сэтгэцийн эмгэг зэрэг органик нөхцөлд илэрдэг
Идеалын нислэг: Өвчтөн нэг сэдвээс нөгөө сэдвэд хурдан шилжин, тасралтгүй ярьдаг; сэдвүүдийн хооронд холбоо байдаг ч заримдаа тодорхойлоход хэцүү; манийн төлөв байдалд ажиглагддаг
Холбоо сулралт: Санамсаргүй, логикгүй, будлиантай бодол санаа болон бодлын тасралтгүй холбоо; ихэвчлэн шизофренийн эмгэгүүдэд илэрдэг
Неологизм: Үйлчлүүлэгч зөвхөн өөрт нь утгатай шинэ үгс зохиодог; ихэвчлэн төөрөгдлийн тогтолцооны нэг хэсэг байдаг
Бодол тасалдах: Өгүүлбэрийн дунд гэнэт бодол тасалдах; үйлчлүүлэгч бодлоо үргэлжлүүлж чадахгүй; ихэвчлэн сэдвээс холбогдолгүй шинэ бодлууд гэнэт гарч ирдэг
Үгийн будаа: утгагүй үгс ба хэлцийн холимог

Хаяг 65-11

Эндүүрэл

Тайлбар

Үр дагавартай нотолгоо байхад ч үнэн гэж баримталдаг буруу итгэл

Төрөлүүд

Ихэмсэг байдал: Өөрийгөө хүчирхэг, чухал хүн гэж итгэх худал итгэл
Хардалт: Өөрийн хамтрагч эсвэл хань нь өөр хүнтэй болзож байна гэж итгэх буруу итгэл
Хөөцөлдөл: Өөрийгөө бусад хүмүүс хорлохын тулд зориудаар ялгаж байна гэж бодох

Оролцоо

- Клиентээс төөрөгдөлөө тайлбарлахыг хүс
- Харилцаандаа нээлттэй, шударга байж сэжиглэх сэтгэлийг бууруул.
- Яриаг бодит байдалд суурилсан сэдвүүд рүү чиглүүлж, төөрөгдөлд бус анхаарлаа төвлөрүүл.

- Клиентийг өөрийн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх, мөн төөрөгдөлөөс үүдэлтэй сэтгэл хөдлөлдөө анхаарал хандуулахыг урамшуулах.
- Хэрвээ үйлчлүүлэгч төөрөгдөлдөө хэт их анхаарч, түүн дээрээ байнга бодож байвал, тэр тухай ярилцахад зарцуулах хугацааг хатуу хязгаарла.
- Клиенттэй маргалдаж, түүний төөрөгдлийг худал гэж итгүүлэх гэж оролдох хэрэггүй.
- Хэрвээ төөрөгдлийн зарим хэсэг бодит бол түүнийг хүлээн зөвшөөр.

Хаяг 65-12

Халлюцинациуд

Тайлбар

Гадаад өдөөлтгүйгээр 5 мэдрэхүйн аль нэгээр үүсдэг мэдрэхүйн хүлээн авалт; органик эсвэл функциональ шалтгаантай байж болно

Төрөлүүд

Сонсголын: дуу хоолой сонсох (бодит байдалд дуу хоолой байхгүй үед)
Амталгын: амт мэдрэх (амтны өдөөгч байхгүй үед) ***Хурын:*** үнэрлэх (бодит байдалд үнэр байхгүй үед)
Хүрэх мэдрэмж: Гадаад өдөөгчгүйгээр хүрэх мэдрэмж мэдрэх
Харааны: Үнэндээ байхгүй зүйлсийг харах

Эмчилгээ

- Клиентээс шууд галлюцинацийн талаар асуу.
- Халлюцинацийг бодит мэтээр хариу үйлдэл үзүүлэхээс зайлсхий.
- Стимулыг бууруулах эсвэл үйлчлүүлэгчийг өөр газар шилжүүл.
- Клиентийн туршлагыг няцааж болохгүй.
- Бодит байдалд суурилсан сэдвүүдэд анхаарлаа төвлөрүүл.
- Тодорхой нэг үйл ажиллагаагаар үйлчлүүлэгчийн анхаарлыг татахыг оролдо.
- Клиент бодит зүйлсийн талаар ярьж байгаа бүхэнд аман хариу өг.
- Клиенттэй биеэр хүрэлцэхээс зайлсхий.
- Сэтгэл түгших эсвэл сандрах шинж тэмдгүүд нэмэгдэж байгааг ажиглаж, энэ нь хуурамч дүр төрхүүд нэмэгдэж байгааг илтгэж болно.

Хаяг 65-13

Хэл болон харилцааны эмгэгүүд

Аложиа (ярианы ядуурал): санаачлан хэлэх үгс цөөрөх эсвэл байхгүй, хариултууд хэт товч байх.
Холбоо сулралт: Бодлыг логик дараалаар холбох сэтгэлзүйн уялдаа тасалдсан.
Дуу авиаар холбогдох: Дуу авиаараа төстэй боловч утгаараа ямар ч холбоогүй үгс эсвэл хэлцийг давтан хэлэх
Эхолали: Бусдаас сонссон үг, өгүүлбэрийг давтан хэлэх
Мүтизм: Аман яриа байхгүй байх
Неологизм: Зөвхөн тухайн хүнтэй холбоотой тусгай утгатай шинээр зохиосон үг ***Шахалттай яриа:*** Үгс нь шахагдаж, хурдан гарах мэт яриа ***Шашны*** хэт их ***анхаарал:*** Шашны санаа бодлоор хэт их автсан байдал
Таганжал: Нэг сэдвээс нөгөө сэдвэд шилжиж, бодлоо дуусгалгүй, дүгнэлтэд хүрэлгүй явах.
Verbigeration: Үгс эсвэл хэлцийг утга учиргүй давтан хэлэх
Үгийн будаа (Schizophasia): үгс эсвэл хэлцийн утга учиргүй холбогдсон ярианы хэлбэр

Хаяг 65-14

Скизофрени өвчний эмчилгээний арга хэмжээ

- Аюулгүй орчныг хадгал.
- Хэрвээ үйлчлүүлэгч өөрөө зан үйлээ хянах боломжгүй бол, ялангуяа бусдад саад учруулж, эмх замбараагүй байдал үүсгэж байвал түүний зан үйлд хязгаар тогтооно.
- Үйлчлүүлэгчийн бие махбодийн хэрэгцээг үнэл.
- Нэг хүний харилцааг эхлүүлж, тэсвэрлэх чадвараас хамааран жижиг бүлэгт шилжинэ.
- Бодол санааны үйл явц өөрчлөгдсөнийг хянах.
- Өөрийн эго хязгаарыг хадгалж, үйлчлүүлэгчийг битгий хүр.
- Хэтэрхий дулаан хандлагаас зайлсхий; төвийг сахисан хандлага нь бага аюултай.
- Хүрч чадахгүй амлалтыг үйлчлүүлэгчид бүү өг.
- Өдөр тутмын тогтмол хэвшил тогтоо.
- Клиентэд биеэ арчлах дадлыг сайжруулахад тусалж, хувийн арчилгаагаа хариуцан хүлээхийг нь дэмжих.
- Клиенттэй товч, давтамжтай харилцаж, харилцааны хугацааг хязгаарла.
- Гарах үедээ үйлчлүүлэгчдэдээ мэдэгдээрэй.
- Тэр хүн юу хэлж байгааг та ойлгохгүй бол түүнд хэлээрэй.
- Клиентийн төөрөгдөл, хуурамч дүр эсгэх үзэгдэлд нь дагаж бүү ор.
- Зохион байгуулалттай таавар эсвэл үгийн тоглоом зэрэг энгийн, тодорхой үйл ажиллагаа санал болго.
- Шаардлагатай үед үйлчлүүлэгчийг дахин чиглүүл.
- Үйлчлүүлэгчид бодит болон бодит бус зүйлийг ялгахад нь туслаарай.
- Хэрвээ үйлчлүүлэгч айсан бол түүнтэй хамт бай.
- Үйлчлүүлэгчтэй энгийн, илэн далангүй, товчхон байдлаар ярилц.

- Клиентд орчны аюулгүйг баталгаажуул.
- Хэрвээ үйлчлүүлэгчийн зан үйл бусдад хэт этгээд, аймшигтай эсвэл аюултай бол түүнийг бүлгийн нөхцөл байдлаас зайлуул.
- Бодит боломжит зорилтуудыг тавь.
- Эхэндээ үйлчлүүлэгчид сонголт санал болгохгүй; дараа нь аажмаар түүнд өөрийн шийдвэрээ гаргахад нь туслах.
- Орчны хэт их өдөөлтийг бууруул.
- Өөрийгөө алах эрсдэлийг хянаарай.
- Клиентэд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд хөгжим, урлагийн эмчилгээ эсвэл бичвэр зэрэг өөр аргыг ашиглахад туслах.

Хаяг 65-15

Паранойд байдалд зориулсан оролцоо

- Аюулгүй орчныг бүрдүүлэх.
- Клиент аюулгүй байх болно гэдгийг баталгаажуул.
- Өөрийгөө хорлох эрсдэлийг үнэл.
- Шивнэн ярих зэрэг сэжиг төрүүлэх зан үйлүүдийг бууруул.
- Тайван, аюулгүй, шүүмжлэлгүй хандлагатай бай.
- Товч боловч давтамжтай харилцаагаар үйлчлүүлэгчтэй харилц.
- Итгэлцлийн харилцаа тогтоо.
- Физик зайг хадгалж, үйлчлүүлэгчийг шахсаж бүү ойртоорой.
- Өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүл.
- Клиенттэй илэн далангүй хариу үйлдэл үзүүл.
- Клиенттэй хийсэн амлалтаа биелүүл.
- Клиентын мэдрэмжийг хүлээн зөвшөөр, гэхдээ тухайн үйл явдлын талаар түүний тайлбарыг чи хуваалцдаггүй гэдгээ түүнд хэл.
- Өдөр тутмын үйл ажиллагааны хуваарийг өг.
- Үйлчлүүлэгчид анхаарал сарниулах үйл ажиллагааг тодорхойлоход туслах.
- Үйлчлүүлэгчийг аажмаар бүлгүүдтэй танилцуулах.
- Яриаг бодит байдалд суурилсан сэдвүүд рүү чиглүүл.
- Дүрд тоглох аргыг ашиглан үйлчлүүлэгчид бодол, мэдрэмжээ тодорхойлоход тусална.
- Амжилт бүрт эерэг урамшуулал олго.
- Төөрөгдөлтэй маргалдаж болохгүй.
- Клиентын өмнө шивнэн ярьж болохгүй.
- Клиентд жижиг даалгавруудыг гүйцэтгэх боломж олго.
- Хооллох, уух, унтах болон бие засах хэв маягийг хянаарай.
- Тэвдүүр, сандрал илэрхийлэхийг ажиглаж, шаардлагатай үед өдөөгч хүчин зүйлсийг бууруулна.

Альцгеймерийн өвчин

Агнози: мэдрэхүйн үйл ажиллагаа хэвийн байхад танил зүйлсийг таних, тодорхойлох чадвар алдагдах
Амнези: тархины деградацийн улмаас ой санамж алдагдах
Афази: Ярьж буй үгийг ойлгох, илэрхийлэх хэлний алдагдал
Апракси: Мотор үйлдэл гүйцэтгэх чадваргүй байдал, мотор үйл ажиллагаа хэвийн байхад

Дасгалын асуултууд

803. Клиент сувилагч руу "Холбооны харуулууд намайг алах гэж илгээсэн" гэж хэлэв. Клиентын санаа зовнилд сувилагч **хамгийн тохиромжтой** ямар хариу өгөх вэ?
    1. "Би үүнийг үнэн гэж бодохгүй байна."
    2. "Хамгаалагчид чамайг алах гэж ирээгүй."
    3. "Хүмүүс чамайг гэмтээх гэж оролдож байна гэж чи айж байна уу?"
    4. "Юунаас болж та хамгаалагчдыг таныг гэмтээхээр илгээсэн гэж бодож байна вэ?"

804. Делириум гэж оношлогдсон үйлчлүүлэгч шөнөдөө төөрч, будлиантдаг. Сувилагч **эхлээд** ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?
    1. Өвчтөнийг сувилагчийн пост дээр шилжүүлэх.
    2. Шууд бус гэрэлтүүлэг ашиглаж, телевизорыг унтраа.
    3. Шөнө телевизор болон зөөлөн гэрлийг асааж бай.
    4. Шөнө зөөлөн хөгжим тоглуулж, өрөөг сайн гэрэлтүүлсэн байлга. 805.

Депрессийн оноштой үйлчлүүлэгчийг сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасагт хэвтүүлэв. Сувилагч үйлчлүүлэгчийн асрах төлөвлөгөөнд ямар оролцоог оруулах ёстой вэ?
    1. Эхний хэдэн өдөрт чимээгүй унших, бичихийг дэмжих
    2. Дасгал хөдөлгөөн хийх боломж олгох биеийн үйл ажиллагааг тодорхойлох
    3. Клиент орчны үйл ажиллагаанд оролцох хүсэлт гаргах хүртэл нийгмийн харилцааны үйл ажиллагаа явуулахгүй
    4. Клиент оролцох боломжтой бүтэцтэй үйл ажиллагааны хөтөлбөр

806. Архаг түгшүүртэй үйлчлүүлэгчийг гадагш гаргах төлөвлөгөө боловсруулахдаа, аль нь **хамгийн тохиромжтой** хадгалах зорилго юу вэ?
    1. Сэтгэл түгшүүрийн мэдрэмжийг дарж барих
    2. Сэтгэл түгшүүр төрүүлэх нөхцөл байдлыг тодорхойлох
    3. Хямралын зөвлөхтэй харилцаагаа үргэлжлүүлэх
    4. Өдөр тутмын нөхцөл байдлаас бүх түгшүүрээ арилгах

807. Нэг үйлчлүүлэгч өмнөх найз охин нь тэнд явдаг тул түүнийг хараад инээх вий гэж бодож, сүмдээ явахыг хүсдэггүй. Түүний хариу үйлдэлд хэт мэдрэг хандсаны улмаас үйлчлүүлэгч гэрээсээ гарч чадахгүй байна. Гэрийн сувилагч ямар зан төлөвийн эмгэгт чиглэсэн асаргааны төлөвлөгөө боловсруулсан бэ?
    1. Дургуйцлалтай
    2. Хилийн
    3. Скизотипаль

4. Дуршлага-албадлагын

808. Сувилагч бүлгийн эмчилгээний хуралдаан явуулж байна. Хуралдааны явцад маниа оноштой үйлчлүүлэгч байнга бүлгийн харилцааг алдагдуулж байна. Сувилагч **эхлээд** ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?

1. Клиентийн зан үйлд хязгаар тогтоох
2. Клиентийг бүлгийн хуралдаанаас гарахыг хүсэх
3. Өөр сувилагчаас үйлчлүүлэгчийг бүлгийн хуралдаанаас гаргаж явахыг хүсэх
4. Клиент ирээдүйн бүлгийн ямар ч хуралдаанд оролцох боломжгүй гэж мэдэгдэх

809. Өвчтөнийг мөргөөд зугтсан осолд өртсөний улмаас хурц хараагүйдлийн оноштойгоор эмнэлгийн сувилахуйн тасагт хүлээн авсан. Шалгалтын явцад энэ өвчтөн яагаад харахгүй байгааг органик шалтгаантай холбоотой ямар ч эмгэг илрүүлж чадахгүй бол сэтгэцийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө заавал хийлгэхээр заасан. Сувилагч ямар сэтгэцийн эрүүл мэндийн нөхцөл байдлыг үндэслэн асаргаа үйлчилгээний төлөвлөгөөг боловсруулна вэ?

1. Психоз
2. Репрессион
3. Хөрвөлтийн эмгэг
4. Диссоциатив эмгэг

810. Манийн үед байсан үйлчлүүлэгч өдрийн өрөөнд зочилж буй хүмүүст бэлгийн дарамт үзүүлж эхэлнэ. Сувилагч энэ нь зохисгүй бөгөөд зөвшөөрөгдөхгүй гэж хатуу мэдэгдэхэд үйлчлүүлэгч аман доромжлол гаргаж, бие махбодийн хүчирхийлэл үйлдэнэ гэж сүрдүүлнэ. Энэ нөхцөл байдлыг шинжилсний үндсэн дээр сувилагч ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?

1. Клиентийг 30 минутын турш тусгаарлана.
2. Клиентд энэ зан үйл зохисгүй гэдгийг хэл.
3. Бусад ажилтнуудын тусламжтайгаар үйлчлүүлэгчийг өрөөнд нь хүргэж очиж.
4. Клиентийн утас ашиглах эрхийг 24 цагийн турш цуцалсан гэж мэдэгд.

811. Маниатай, манипуляцийн зан үйл гаргаж буй эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөнд ямар сувилахуйн арга хэмжээ тохиромжтой вэ? **Хамаарах бүгдийг сонгоно уу**.

☐ 1. Өвчтөнд хүлээгдэж буй зан байдлыг тайлбарлан мэдэгд.
☐ 2. Өвчтөнд сувилахуйн тасгийг удирдах эрхгүй гэдгийг ойлгуулах.
☐ 3. Клиенттэй хамтран хязгаар тогтоох аргуудыг тодорхойлоход туслах хүвийн зан үйлд.
☐ 4. Зан үйлийн үр дагаврыг шийтгэлгүйгээр биелүүлнэ.
☐ 5. Дүрмийг хэрэгжүүлэхдээ үйлчлүүлэгчид түүнийг ... терапийн бүлэгт оролцохыг зөвшөөрөгдөхгүй.
☐ 6. Клиентээс зан үйлээ тийм байдлаар илэрхийлбэл ямар үр дагавартай болохыг тодорхойлохыг шаардана зөвшөөрөгдөхгүй гэж үзэгддэг.

812. Сувилагч үйлчлүүлэгч хөлөө эргүүлэн алхаж, сэтгэл нь тогтворгүй, дайсагнасан дохио үзүүлж байгааг ажиглав. Үйлчлүүлэгчийн яриа хурдан, сэтгэл хөдлөл нь дайсагнасан байв. Эдгээр ажиглалтуудад үндэслэн сувилагчийн **яаралтай**

Асрах эрэмбэ?

1. Клиент болон тасгийн бусад үйлчлүүлэгчдэд аюулгүй байдлыг хангах.
2. Тус тасгийн үйлчлүүлэгчдэд тав тух, аюулгүй байдлын мэдрэмж төрүүлэх.
3. Хяналттай орчинд үйлчлүүлэгчийн асаргаанд ажилтнуудад туслах.
4. Өвчтөнд тайвшрах, хяналтаа сэргээхэд нь туслахын тулд бага өдөөлттэй орчныг санал болго.

813. Сувилагч шизофренитэй, өмнө нь тушаал гүйцэтгэх галлюцинацитай байсан өвчтөнд галлюцинаци болон түгшүүрийг удирдах арга хэмжээний зааварчилгаа өгч, эмнэлгээс гарах бэлтгэлд нь тусалж байна. Эдгээр зааварчилгаанд өвчтөн өгсөн ямар хариулт нь сувилагчид түүнд **нэмэлт мэдээлэл хэрэгтэй байгааг** илтгэх вэ?

1. "Эмүүд минь миний түгшүүртэй мэдрэмжийг намжаахад тусална."
2. "Би дэмжлэгийн бүлэгт явж, юу мэдэрч байгаагаа ярина."
3. "Надад тушаалтын галлюцинаци тохиолдох үед би тусламж хүсэж найздаа залгана."
4. "Сэтгэл түгшихээс сэргийлэхийн тулд хангалттай унтаж, сайн хооллох хэрэгтэй."

814. Сувилагч нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасагт саяхан хэвтэн орсон, кататоник ступортой гэж оношлогдсон үйлчлүүлэгчийг асарч байна. Үйлчлүүлэгч нь орон дээр урагын байрлалтай хэвтэж байна. Аль нь **хамгийн зохистой** сувилахуйн арга хэмжээ вэ?

1. Ярилцахад нь урам өгөхийн тулд шууд асуулт асуух.
2. Гадаад өдөөлтийг багасгахын тулд үйлчлүүлэгчийг ганцааранг нь орхи.
3. Түүний хажууд чимээгүй сууж, энгийн нээлттэй асуултууд асуух.
4. Өдөр өнгөрүүлэх өрөөнд бусад үйлчлүүлэгчидтэй хамт аваачиж сэргээх.

815. Сувилагч нь параноидын зан төлөвийн эмгэгтэй, бодлын үйл явц нь алдагдсан үйлчлүүлэгчийг асарч байна. Асаргааны төлөвлөгөө боловсруулахдаа сувилагч ямар **хамгийн тохиромжтой** арга хэмжээг төлөвлөх ёстой вэ?

1. Өвчтөнийг түүний хамтрагчидтай харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх.
2. Өвчтөний өмнө шивнэн ярихгүй байх.
3. Клиенттэй хамт олон нийтийн нийгмийн дэмжлэгийн талаар мэдээлэл өгөх ажлыг эхлүүлэх.
4. Үнэлгээний зорилгоор холбогдох талуудад мэдээлэл илгээх зөвшөөрлийг үйлчлүүлэгчээс ав.

816. Сувилагч нь хоёр туйлт эмгэгтэй, түрэмгий нийгмийн зан авиртай үйлчлүүлэгчид зориулан үйл ажиллагаа төлөвлөж байна. Энэ үйлчлүүлэгчид аль үйл ажиллагаа **хамгийн тохиромжтой** вэ?

1. Шатар
2. Бичих
3. Ширээний тоглоом
4. Бүлгийн дасгал хөдөлгөөн

Хариултууд

803. ***Хариулт***: 3

Үндэслэл: Сувилагч үйлчлүүлэгчийн туршлагад сэтгэл хөдлөлөөр хандах нь хамгийн эмчилгээтэй. Бусад сонголтууд үйлчлүүлэгчтэй ийм холбоо тогтоодоггүй. Санал зөрөх

худал итгэл үнэмшилтэй санал зөрөлдөх нь үйлчлүүлэгчийг илүү хамгаалалттай болгож, тэдгээр итгэл үнэмшилдээ улам ч баригдахад хүргэж болно. Худал итгэл үнэмшилтэй холбоотой яриа өдөөх нь зохимжгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн үг** болох "*best*"-ийг тэмдэглэ. **Эмчилгээний харилцааны техник** ашигла. Өвчтөнтэй санал зөрдөг эсвэл төөрөгдөлтэй холбоотой аливаа хэлэлцүүлгийг дэмждэг сонголтуудыг хас.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Клиентын хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүтэн байдал
Нэгтгэсэн процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Харилцаа; Психоз
Дүйнз: Varcarolis (2017), 257-258-р хуудас.

804. ***Хариулт***: 2

Үндэслэл: Клиент төөрсөн үед тогтмол өдөр тутмын хэвшил, бага өдөөлттэй орчин бүрдүүлэх нь чухал. Радио, телевиз зэрэг дуу чимээ нь төөрөлдөөн, будиалд нэмэр болж болно. Клиентиг сувилагчийн пост дээр шилжүүлэх нь шаардлагатай байж болох ч эхний алхам биш юм.

Шалгалт өгөх стратеги: *Эхлээд* **стратегийн үгийг** тэмдэглэ. Зөрчилтэй эсвэл хэт эрт шатанд хийгдэх, өдөөлтийг нэмэгдүүлж будлиан үүсгэж болзошгүй сонголтуудыг хас. Энэ нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Клиентийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Гүйцэтгэл
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Нейрокогнитив алдагдал
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Танин мэдэхүй; Аюулгүй байдал
Дүйнз: Varcarolis (2017), 275, 277-р хуудас.

805. ***Хариулт***: 4

Үндэслэл: Депрессийн үед үйлчлүүлэгч ихэвчлэн дотогшоо татгалзаж, анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хүндрэлтэй, сонирхол ба таашаал алдаж, эрч хүч бага, ядарч туйлдсан, өөрийгөө үнэ цэнэгүй мэтээр мэдэрч, өөртөө итгэх итгэл сул байдаг. Асаргаа үйлчилгээний төлөвлөгөө нь сэтгэл хөдөлгөм боловч зохион байгуулалттай орчинд амжилттай туршлагыг олгох ёстой. Үлдсэн сонголтууд нь хэтэрхий "хязгаарлагдмал" эсвэл зохион байгуулалт, сэтгэл хөдлөл өгөх нь тун бага эсвэл огт байхгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт**, депрессийн өвчтөнд зориулсан төлөвлөгөөнд анхаарлаа төвлөрүүл. Сэтгэл гутралтай үйлчлүүлэгч аюулгүй орчинд зохион байгуулалттай, сэргээх хөтөлбөртэй байх шаардлагатайг санаарай. Зөв сонголт нь аюулгүй, үр дүнтэй орчинг бүрдүүлэх цорын ганц боломж юм.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэг

Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд: Сэтгэл хөдлөл ба нөлөөлөл; Аюулгүй байдал
Эшлэл: Varcarolis (2017), 207-208-р хуудас.

806. ***Хариулт***: 2

Үндэслэл: Сэтгэл түгшүүр үүсгэдэг нөхцөл байдлыг таних нь үйлчлүүлэгчид сэтгэл түгшүүртэй тэмцэх эсвэл тодорхой өдөөгчөөс зайлсхийхийн тулд бэлтгэх боломж олгодог. Зөвлөхүүд сэтгэл түгшүүр үүсгэдэг бүх нөхцөлд байх боломжгүй бөгөөд энэ арга нь дотоод хүч чадлыг хөгжүүлэхийг дэмждэггүй. Сэтгэл хөдлөлөө дарж барих нь сэтгэл түгшүүрийг шийдвэрлэхгүй.
Амьдралаас бүх түгшүүрийг арилгах боломжгүй.
Шалгалт өгөх стратеги: *Хамгийн зохистой* **стратегийн үгсэд** анхаарлаа төвлөрүүл. "бүх" гэсэн **хаалттай үг** агуулсан эсвэл сэтгэл хөдлөлийг дарж нуух ёстой гэж заасан аливаа сонголтыг хас. Зөв сонголт нь үйлчлүүлэгч төвтэй бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд тэднийг түгшүүртэй нөхцөл байдлыг даван туулахад бэлтгэхэд тусална.
Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Ашиглах
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа сувилгын орчин ***Нэгдсэн процесс:*** Асаргаа сувилгын процесс—Төлөвлөлт ***Агуулгын салбар:*** Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл түгшүүрийн эмгэг ***Гол ойлголтууд:*** Сэтгэл түгшүүр; Эрүүл мэндийг дэмжих ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 143-р тал.

807. ***Хариулт***: 1

Үндэслэл: Хяналт тавих хандлагатай зан төлөвийн эмгэг нь нийгмээс татгалзах, боломжит няцаалтад хэт мэдрэг байдлаар илэрдэг. Хүн нийгмээс тусгаарлагдаж, ганцаарддаг. Хязгаарлагдмал зан төлөвийн эмгэг нь тогтворгүй сэтгэл хөдлөл, өөрийн дүр төрх, гэнэтийн, урьдчилан тааварлашгүй зан үйлээр тодорхойлогдоно. Скизотипаль зан төлөвийн эмгэг нь хэвийн бус бодол, хүлээлт, яриа, зан үйлээр илэрдэг. Компульсив зан төлөвийн эмгэг нь төгс төгөлдөрийн эрмэлзэл, бусдыг хянах хэрэгцээ, ажилд хэт их анхаарал хандуулах байдлаар илэрдэг.
Шалгалт өгөх стратеги: Анхаарлаа **сэдэв** дээр төвлөрүүл, энэ нь зан чанарын эмгэгийн нэг төрөл юм. *Реакцийн гиперэмзэг* байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.
Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Ажиллах
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Зан төлөвийн эмгэгүүд
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Сэтгэл түгшилт; Асран халамж
Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 173-174-р хуудас.

808. ***Хариулт***: 1

Үндэслэл: Маник үйлчлүүлэгчид их ярьж, бүлгийн уулзалт эсвэл эмчилгээний сессийг хэт их яриагаараа давамгайлах хандлагатай байж болно. Хэрэв ийм байдал үүсвэл сувилагч эхлээд үйлчлүүлэгчийн зан үйлд хязгаар тогтооно. Эхэндээ үйлчлүүлэгчийг сессиэс гарахыг хүсэх эсвэл

Өөр хүнийг тухайн үйлчлүүлэгчийг хуралдаанаас гаргахад дагуулахыг хүсэх нь зохисгүй. Энэ нь үйлчлүүлэгчийг уурлуулах, түүний зан байдлыг улам хурцатгах эрсдэлтэй. Мөн үйлчлүүлэгчийг бүлгийн хуралдаанд оролцохоос хасах нь түүний эмчилгээ авах эрхийг зөрчиж, сүрдүүлсэн үйлдэл тул зохисгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: *Эхлээд* **стратегийн үгийг** тэмдэглэ. **Ижил төстэй**, үйлчлүүлэгч сессиэс гарахтай холбоотой сонголтуудыг хас. Дараа нь үйлчлүүлэгчийн эмчилгээ авах эрхийг зөрчсөн, заналхийлэлтэй үйлдэл болсон сонголтыг хас. Эхэндээ үйлчлүүлэгчтэй тодорхой хязгаар тогтоох нь хамгийн зөв гэдгийг санаарай.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэг ***Гол ойлголтууд:*** Асран халамж; Психоз
Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 232–233-р тал.

809. ***Хариулт***: 3

Үндэслэл: Хөрвөлтийн эмгэг нь мэдэгдсэн патофизиологийн ямар ч механизмаар тайлбарлагдахгүй бие махбодийн үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх буюу алдагдахыг хэлнэ. Хөрвөлтийн эмгэгийг сэтгэл зүйн хэрэгцээ эсвэл зөрчилдөөний илэрхийлэл гэж үздэг. Энэ тохиолдолд үйлчлүүлэгч сэтгэл зүйн хувьд маш хүнд ослыг харсан тул хараагүй болсон. Психоз гэдэг нь хүний бодит байдлыг танин мэдэх, харилцаа холбоо тогтоох, бусадтай харилцах сэтгэл зүйн чадамж алдагдсан, амьдралын шаардлагад зохицох чадварт нь саад учруулдаг сэтгэлзүйн төлөв юм. Репрессив буюу дарж хадгалах механизм нь хүлээн зөвшөөршгүй мэдрэмжийг ухамсараас хасч, мэдрэхгүй болгодог зохицох арга юм. Диссоциатив эмгэг нь өөрийн таних байдал, ой санамж эсвэл ухамсрын ердийн нэгдмэл үйл ажиллагаанд алдаа, саатал эсвэл өөрчлөлт гарсан эмгэг юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт**, гэнэт хараа алдах шалтгаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх. Зөв хариултын гол нь үйлчлүүлэгчид хараа алдахад ямар ч органик шалтгаан илрээгүйд оршино—иймээс энэ нь хувиргалтын эмгэг юм.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэл-нийгмийн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Соматизацийн эмгэг
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: асран халамжлах; психоз
Дүйнз: Varcarolis (2017), 154-155-р хуудас.

810. ***Хариулт***: 3

Үндэслэл: Клиент өөрийгөө болон бусдыг гэмтээх эрсдэлтэй тул нийтийн өрөөнөөс дагалдан гаргах шаардлагатай. Энэ нөхцөлд тусгаарлах нь хэтэрхий эрт байна. Клиентд энэ зан үйл зохимжгүй гэж хэлэх аргыг сувилагч аль хэдийн туршиж үзсэн. Эрх нөхөн олголтыг хасах нь клиентийн аль хэдийн байгаа түгшүүрийг улам нэмэгдүүлж болзошгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: 2-р сонголтыг хас, учир нь энэ оролцоог аль хэдийн туршиж үзсэн. Дараа нь **Маслоугийн хэрэгцээний иерархийн онолыг** ашиглан хариулах

асуултад хариулахдаа физиологийн хэрэгцээ байхгүй бол аюулгүй байдалд анхаарна. Клиент, бусад үйлчлүүлэгчид болон ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах сонголтыг хай.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Ашиглах
Клиентийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үйлчилгээний
орчин ***Интеграцчилсан процесс:*** Асаргаа үйлчилгээний процесс—
Гүйцэтгэл ***Агуулгын салбар:*** Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд:
Хүчирхийлэл ***Гол ойлголтууд:*** Сэтгэл хөдлөл ба
илэрхийлэл; Аюулгүй байдал ***Лавлагаа:*** Varcarolis
(2017), 378-379-р хуудас.

811. ***Хариулт***: 1, 3, 4, 6

Үндэслэл: Манипуляци хийх үйлдэлтэй үйлчлүүлэгчтэй харьцах арга хэмжээ нь манипуляцийн үйлдэлд тодорхой, тогтмол, мөрдөгдөх хязгаар тогтоох; тогтоосон хязгаарыг давсны үр дагаврыг үйлчлүүлэгчид тодорхой мэдээлэх; үр дагаврыг шийтгэлгүйгээр хэрэгжүүлэх; мөн үйлчлүүлэгчид хувийн зан үйлдээ хязгаар тогтоох аргыг олоход нь туслахыг багтаана. Үйлчлүүлэгчид сувилахуйн тасгийг тэр удирддаггүй гэдгийг мэдүүлэх нь зохимжгүй; эрх мэдлийн тэмцлийг зайлсхийх шаардлагатай. Дүрэм журмыг мөрдүүлэх, үйлчлүүлэгчид эмчилгээний бүлэгт оролцохыг зөвшөөрөхгүй гэж мэдэгдэх нь үйлчлүүлэгчийн эрхийг зөрчих үйлдэл юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт** төвлөрч, манипуляцийн зан авир гаргах. Клиентын эрхийг сануулах, эрх мэдлийн тэмцлийг зайлсхийх шаардлагатайг сануулах нь зөв оролцоог сонгоход тусална.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх
Клиентийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Гүйцэтгэл
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн
эмгэг ***Гол ойлголтууд:*** Клиникийн шийдвэр гаргалт; Сэтгэл хөдлөл ба
илэрхийлэл ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 233-р тал.

812. ***Хариулт***: 1

Үндэслэл: Үйлчлүүлэгч болон бусад үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдал нь яаралтай тэргүүлэх ач холбогдолтой. Зөв сонголт нь үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын хэрэгцээг төдийгүй бусад үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй байдлын хэрэгцээг хангасан цорын ганц сонголт юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн үгс**, *яаралтай тэргүүлэх чиглэлийг* тэмдэглэж, тэргүүлэх эрэмбэ тогтоохдоо **Маслоугийн хэрэгцээний иерархийн онолыг** ашигла. *"Сэтгэл түгшсэн", "довтолгоотой", "дайсагнасан"* гэсэн үгсийг тэмдэглэ. Физиологийн хэрэгцээ байхгүй бол аюулгүй байдал тэргүүлэх анхаарал болно. Мөн зөв сонголт нь **хамгийн өргөн хүрээг хамарсан сонголт** бөгөөд бүх хүний аюулгүй байдлыг хангана.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үзүүлэх
орчин ***Нэгтгэсэн процесс:*** Сувилахуйн процесс—хэрэгжилт
Сэдвийн салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хүчирхийлэл
Эрэмбэлэх ойлголтууд: Сэтгэл хөдлөл ба илэрхийлэл; Аюулгүй байдал

Дорноо: Varcarolis (2017), 379-р тал.

813. ***Хариулт***: 3

Үндэслэл: Хэрэв үйлчлүүлэгч өөрийгөө эсвэл бусдыг хохироох тушаалтай галлюцинаци хүлээн авч байвал түргэн, түрэмгий зан үйл гаргах эрсдэл нэмэгдэж болно. Хэрэв үйлчлүүлэгч галлюцинаци мэдэрч байвал өөрийгөө эсвэл бусдыг хохироох санаатай эсэхийг ярилцахын тулд найз биш, сувилагч эсвэл эрүүл мэндийн зөвлөхтэй холбогдох ёстой. Сонсголын хуурамч үзэгдлийн тухай ярих нь тухайн үзэгдэлтэй холбоотой хоолойн булчингийн далд үйл ажиллагаанд саад учруулж болно. Үлдсэн сонголтуудад дурдсан үйлчлүүлэгчийн мэдэгдлүүд нь ерөнхий сайн сайхныг дэмжих боловч хэрэв хуурамч үзэгдэл гарвал тэдгээр нь тодорхой эмчилгээний арга биш юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн үгс**, *нэмэлт мэдээлэл авах шаардлагад* анхаарна уу. Эдгээр үгс нь **сөрөг үйл явдлын асуултыг** илэрхийлж, хариултанд буруу мэдэгдлийг сонгох шаардлагыг заадаг. Анхаарлаа **сэдвэд** төвлөрүүлж, галлюцинаци болон түгшүүрийг удирдах. Зөв сонголт нь тохирох тусламж авах тодорхой тохиролцоо юм. Үлдсэн сонголтууд нь үйлчлүүлэгч эрүүл мэндийн сайн сайхны төлөө хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд юм.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Үнэлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Сургалт ба суралцах

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Скизофрениіа

Эрхэмлэх ойлголтууд: Үйлчлүүлэгчийн боловсрол; Аюулгүй байдал

Дүрийн ишлэл: Varcarolis (2017), 256–257-р тал.

814. ***Хариулт***: 3

Үндэслэл: Өөртөө татгалзсан үйлчлүүлэгчид хөдөлгөөнгүй, дуугүй байж болох тул тэдэнд тогтмол, давтан хандлага шаардлагатай байж болно. Хаалттай, дотогшоо үйлчлүүлэгчидтэй харилцахад сувилагчаас ихээхэн тэвчээр шаардагдана. Оролцох арга хэмжээнд хувь хүний хоорондын харилцаа тогтоох нь багтана. Сувилагч нь чимээгүй сууж, шууд асуулт асуухын оронд энгийн, нээлттэй асуулт тавьж, үйлчлүүлэгчид хариулах боломж олгохын тулд түр зогсолт хийх замаар харилцааг хөнгөвчилдөг. Хэт их өдөөлт зохимжгүй ч үйлчлүүлэгчийг үл тоомсорлох нь эмчилгээний үнэ цэнэтэй биш юм. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал нь бусад үйлчлүүлэгчдийн үүрэг биш.

Шалгалт өгөх стратеги: *Хамгийн тохиромжтой* **стратегийн үгсийг** тэмдэглэ. Эмчилгээнд ашиггүй эсвэл хэт өдөөх нөхцөл үүсгэж болзошгүй сонголтуудыг хас. Мөн эмчилгээний харилцааны жишээ биш сонголтуудыг хас. Зөв сонголт нь үйлчлүүлэгчийн хяналт ба харилцааг зохих ёсоор хангана.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Гүйцэтгэл

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Скизофрениіа

Эрэмбэлэх ойлголтууд: Асран халамж; Психоз

Дүрийн ишлэл: Varcarolis (2017), 251-р тал.

815. ***Хариулт***: 2

Үндэслэл: Параноидын зан төлөвийн эмгэгтэй холбоотой бодлын үйл явцын алдагдал нь үйлчлүүлэгчийн асуудал бөгөөд асаргааны төлөвлөгөө энэ асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Үйлчлүүлэгч нь бусдыг итгэдэггүй, сэжигтэй ханддаг. Эрүүл мэндийн багийн гишүүд үйлчлүүлэгчтэй харилцан итгэлцэл, найдвартай харилцаа тогтоох шаардлагатай. Үйлчлүүлэгчийн өмнө инээх эсвэл шивнэн ярих нь үр дүнгүй. Үлдсэн сонголтууд нь үйлчлүүлэгчээс олон түвшний итгэлийг шаардаж байгаа бөгөөд энэ эмгэгтэй үйлчлүүлэгчид хэтэрхий халдварлаг үйлдлүүд юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт** төвлөрч, параноидын зан төлөвийн эмгэгийн эмчилгээний оролцоог анхаарч, **стратегийн үг** *"хамгийн сайн"*-ыг тэмдэглэ. Клиент паранойятай гэдгийг анхаар; түүний тодорхойлолтыг бодох нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Клиентийн хэрэгцээ: Психосоциал бүтэн байдал

Нэгтгэсэн процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Зан төлөвийн эмгэгүүд

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: асаргаа; психоз

Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 252-253, 257-р хуудас.

816. ***Хариулт***: 2

Үндэслэл: Богино анхаарал шаарддаг, хөнгөн биеийн хүч зарцуулах тусгаарлагдсан үйл ажиллагаа нь түрэмгий зан үйл гаргаж буй үйлчлүүлэгчид хамгийн тохиромжтой. Бичих (өдрийн тэмдэглэл хөтлөх), ажилтнуудтай алхах, хуруугаар зураг зурах нь өдөөлтийг багасгаж, түгшүүр, сэтгэл хөдлөлийг зохистойгоор гадагшлуулах боломж олгодог. Үлдсэн сонголтууд нь өрсөлдөөнтэй эсвэл бүлгийн үйл ажиллагаа тул түрэмгий зан үйлд өдөөлт өгч, сэтгэл хөдлөл-хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй тул зайлсхийх хэрэгтэй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн** *хамгийн тохиромжтой* **үгсийг** тэмдэглэ. Клиент ганцаараа хийх боломжгүй, өрсөлдөөнт шинжтэй үйл ажиллагааг агуулсан сонголтуудыг хас.
Зөв сонголт нь ганцаарчилсан үйл ажиллагааг заадаг.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Ашиглах

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал ***Интеграцчилсан процесс:*** Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт ***Сэдвийн хүрээ:*** Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд ***Эрхэмлэх ойлголтууд:*** Сэтгэл хөдлөл ба мэдрэмж; Аюулгүй байдал ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 232-р тал.

БҮЛЭГ 66

Донтолт

http://evolve.elsevier.com/Silvestri/comprehensiveRN/

Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд

Донтдог байдал; Даван туулах чадвар

I. Хоолны эмгэгүүд

A. Тайлбар: Хоолны эмгэгүүд нь өөрийгөө тодорхойлох итгэлгүй байдал болон хооллолтын дадал зуршил ихээхэн алдагдсан байдлаар илэрдэг (Зураг 66-1).

B. Компульсив хэт их хооллолт

1. Компульсив хэт их хооллолт гэдэг нь бие цэвэрлэх үйлдэлгүйгээр хэт их хэмжээний хооллох явдал юм.
2. Хоол хэрэглэх үйлдэл нь хувь хүний хяналтаас гарч, давтагдсан хэв маягаар явагддаг.
3. Хооллох нь зэвүүцэл төрүүлдэг, өөрөөр хэлбэл хооллох нь түгшүүр тайлдаг ч таашаал өгдөггүй
4. Хооллолтын хэв маяг хэвийн бус гэдгийг ухамсарлаж, хооллосны дараа сэтгэл гутралд автдаг
5. Хоолны хэт их хэрэглээний үед нууцаар өндөр калоритой, амархан шингэдэг хоол иддэг
6. Давтан хоолны дэглэм барьж ороллдог ч амжилтгүй болдог
7. Жингийнхээ талаар өөрийгөө хүчгүй, найдваргүй мэт мэдэрдэг

8. Гэмшил, уур хилэн зэрэг сэтгэл хөдлөлд хариу үйлдэл үзүүлдэг,

гашуун гуниг, уйтгар, ганцаардал, дутагдал эсвэл хоёрдмол мэдрэмжийг хооллох замаар хариу үйлдэл үзүүлдэг

C. Анорексиа нервоза

1. Тайлбар

a. Ихэвчлэн эхлэл нь стресстэй амьдралын үйл явдалтай холбоотой байдаг.
b. Маш ихээр таргалалтаас айдаг
c. Биеийн дүр төрх гажигдсан, өөрийгөө танин мэдэхүйн төвөгтэй байдал түгээмэл.
d. Жин нэмэхээс сэргийлэх хоол хүнсэнд хэтэрхий их анхаарч, жин нэмэгдүүлэх хоол хүнснээс фобитой
e. Хоолны эмгэг нь амь насанд аюултай байж болно.

f. Өлсөхөөс болж үхэл тохиолдож болно, **өөрийгөө хорлох,** зүрхний булчирхайн миопати эсвэл электролитийн тэнцвэргүй байдал.

2. Үнэлгээ

a. Хоолны дуршил буурах, хооллохоос татгалзах
b. Хоолны дуршилгүйдэл
c. Хяналтгүй байдлын мэдрэмж
d. Хүчээр дасгал хийх
e. Их амжилт гаргагч ба төгс төгөлдөрийн хөөцөлдөгч
f. Бие махбодийн өөрчлөлтүүд: Олон шинж тэмдэг илэрч болох ба үүнд биеийн температур, зүрхний цохилт, цусны даралт буурах; жин алдагдах; хоол боловсруулах замын эмгэг (жишээлбэл, өтгөн хаталт); шүд, буйлны элэгдэл; хүчээр бөөлжиснөөс үүдсэн хоолойн судасны өргөсөл; электролитийн тэнцвэргүй байдал; хуурай, хальсархаг арьс; гар, хөлөнд нарийн үсний ургалт; нойрны эмгэг; дааврын дутагдал; дараалан гурван сарын тэмдэг ирэхгүй байх (аменоре); гар, хөлөнд цианоз, мэдрэмжгүй болох; ясны эрдэс чанарын бууралт зэрэг орно.

D. Булимия нервоза

1. Тайлбар

a. Их хэмжээний хоолыг хэт их, хяналтгүйгээр идэх (binges) давтагдсан тохиолдлууд ба дараа нь өөрөө бөөлжих, өтгөрүүлэгч (жишээ нь, лаксатив) эмийн буруу хэрэглээ, шээс хөх эм болон/эсвэл өөрийгөө өлсгөх зэрэг зохисгүй нөхөн тэнцвэржүүлэх үйлдлүүд дагалддаг

b. Ихэнх үйлчлүүлэгчид нэг дотор үлддэг

й жингийн хүрээнд байдаг ч хооллолттой ротой зөрчилдөөн тэдний амьдралыг кож байна гэж боддог.

a. Биеийн хэлбэр, жингээ хэтэрхий их бодож явдаг
b. Хоолны тухай бодолд автсан байдал
c. Жин нэмэхээс туйлын их айх
d. Өндөр калоритой хоолыг нууцаар хэрэглэх; нууцаар идсэнээсээ болж гэмших

2. Үнэлгээ

e. Хоолны хэт их хэрэглээ ба цэвэрлэгээний синдром

f. Хоолны дэглэм, бөөлжих, клизма, өтгөн халаагч эм, амфетамин эсвэл диуретик хэрэглэн жинг хасах оролдлого

g. Хоол тэжээлийн байдал болон ямар ч эрүүл мэндийн асуудлын хүнд байдлыг үнэлнэ.

h. Хяналт тавих хэрэгцээтэй боловч өөрийнхөө хүчгүйдэх эсвэл хяналтаа алдсан мэдрэмжийг мэдэрдэг

i. Өөртөө итгэх итгэл сул

j. Хүмүүстэй харилцаа муутай

k. Бэлгийн харьцаанд сонирхол буурах эсвэл байхгүй байх

l. Сэтгэл хөдлөлийн хэлбэлзэл

m. Электролитийн тэнцвэргүй байдал

n. Бие махбодийн өөрчлөлтүүд: анорексиа нервоза өвчтөнд илэрдэгтэй адил

o. Чухал асуултууд нь тэдний асуудлыг хэрхэн хүлээн авч байгааг болон хооллолтын зуршлуудтай холбоотой байх ёстой

Е. Оролцоо: Хооллолтын эмгэгтэй үйлчлүүлэгчид

1. Клиенттэй ганцаарчилсан эмчилгээний харилцаа тогтоох; сувилагч итгэлийг бий болгож, харилцаа тогтоохыг хүсэхгүй байгаа аливаа эсэргүүцлийг таньж мэдэх шаардлагатай.
2. Өдрийн хооллолтын төлөвлөгөөг боловсруулах.
3. Хоолны эмгэг үүсгэх шалтгаануудыг тодорхойлоход туслах.
4. Клиентийг хооллолтын зан үйл болон биеийнхээ талаар ямар мэдрэмжтэй байгаагаа илэрхийлэхийг урамшуулах.
5. Хүлээн зөвшөөрч, шүүмжлэлгүй ханд.
6. Өөрийгөө танин мэдэхүйн үзэл баримтлалыг судлах, өөрийн онцлогийг тодорхойлох дээр ажиллах.
7. Зан үйлийн өөрчлөлтийн аргуудыг хэрэгжүүлэх.
8. Хувь хүний, бүлгийн болон гэр бүлийн эмчилгээ
9. Эрүүл мэндийн байгууллагад байгаа бол хооллох үед болон хооллосны дараа тодорхой хугацаанд хяналт тавьж, хоолны орц, гаралтыг хяна; хоол бүрт цагийн хязгаар тогтоож, хооллоход таатай, тайван орчныг бүрдүүл.
10. Хооллолтын эмгэгтэй холбоотой бие махбодийн хүндрэл үүсэх шинж тэмдгүүдийг хянана.
11. Хэрэв үйлчлүүлэгчийн жин нь идеал биеийн жингийн 75%-аас доогуур байвал хэвтэн эмчлүүлэх хэлбэрээр яаралтай эмнэлгийн тогтворжуулалт хийх.

12. Өдөр бүр нэгэн адил цагт, нэгэн адил жинлүүрээр, үйлчлүүлэгч шээсний дараа жинг нь тогтооно (өдөр бүр жинг тогтоох нь зарим үйлчлүүлэгчийн түгшүүрийг бууруулж болно); жинг нь тогтоох үед өмнөх жинг авсан үедээ өмссөн хувцастай байхыг баталгаажуулна.
13. Шингэн болон электролитийн тэнцвэрийг хянаж, сэргээнэ.
14. Шээх, биеийн гадагшлах хэв маягийг хянах.
15. Клиентийн идэвхийн түвшинг үнэлж, хязгаарлах (анорексиа нервоза болон булимиа нервоза).
16. Үйлчлүүлэгчийг анхаарал сарниулах үйл ажиллагаанд оролцохыг урамшуулах.
17. Өөрийгөө хорлох эрсдэлийг үнэл.
18. Жороор бичигдсэн бол антидепрессант эмчилгээг явуулах.
19. Сэтгэл засалын эмчилгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалах.

II. Мансууруулах бодисын хэрэглээний эмгэгүүд

A. Тайлбар: Бодис хэрэглэх эмгэгүүд (донтло) зан байдал болон физиологийн өөрчлөлтүүдийг үүсгэдэг (66-1-р хайрцаг).

B. Бодисын хамаарал

1. Бодисын хамаарал нь тухайн бодисыг давтан хэрэглэх хэв маяг бөгөөд ихэвчлэн тэсвэр тэвчээр, татгалзах шинж тэмдэг, албадлагын мансууруулах бодис хэрэглэх зан үйлд хүргэдэг.
2. Бодисыг анх төлөвлөснөөсөө илүү их хэмжээгээр, илүү удаан хугацаанд хэрэглэдэг.
3. Хэрэглээгээ бууруулах хүсэл төрдөг ч хэрэглээг бууруулах эсвэл бүр зогсоох оролдлого амжилтгүй болдог.
4. Өдөр тутмын үйл ажиллагаа бодис хэрэглэх эргэн тойронд эргэлддэг.

Бодис буруу хэрэглээг үнэлэхэд зориулсан скрининг хэрэгслүүд байдаг зөрчил; зарим нь Мичиганы архины хэрэглээг шалгах тест (MAST), мансууруулах бодисын хэт хэрэглээг шалгах тест (DAST) болон CAGE шалгалтын асуулга юм.

C. Бодисын тэсвэршил гэдэг нь хүссэн үр нөлөөг гаргахын тулд тухайн бодисыг улам их хэмжээгээр хэрэглэх шаардлага үүсэх явдал юм.

D. Бодисыг буруу хэрэглэх

1. Бодисыг давтан хэрэглэдэг
2. Давтагдсан, ноцтой хор хөнөөлтэй үр дагаврыг бодис хэрэглэхтэй холбоотойгоор туулдаг.
3. Хууль сахиулах тогтолцоотой холбогдох нь түгээмэл; үйлчлүүлэгч нь шийдвэрлэх шаардлагатай хууль эрх зүйн асуудлуудтай тулгарч болно.

E. Мансууруулах бодисын таталт

1. Физиологийн болон бодисын төрөлд онцлог когнитив шинж тэмдгүүд илэрнэ.

2. Бодисын таталт нь an үед тохиолддог хувь хүн физиологийн хувьд хамааралтай бодисын цусан дахь түвшин буурсан үед бодисын таталт үүсдэг.

хамааралтай.

F. Мөсөөрлөгтэй холбоотой эмгэгтэй үйлчлүүлэгчид анхаарах бусад хүчин зүйлс

1. Өсвөр насанд үзүүлэх эсэргүүцэл болон найз нөхдийн дарамт нь бодис хэрэглэх эхлэлд нөлөөлж болно.
2. Бодис хэрэглэх нь бие махбодийн болон сэтгэл хөдлөлийн өвдөлтийг бууруулах **арга** болж хувирч болно.
3. Депресс нь бодис хэрэглэхээс өмнө үүсч болно, эсвэл бодис хэрэглэх явцад эсвэл түүнтэй холбоотойгоор үүсч болно.
4. Гэмшил, алдагдал нь бодис хэрэглэхтэй холбоотой байж болно.

G. Бодисыг буруу хэрэглэхтэй холбоотой хэвийн бус зан үйлүүд

1. Бодис олж авах, хэрэглэх тухай тасралтгүй бодох
2. Зан үйлдлийн үр дагавраас зайлсхийхийн тулд бусдыг удирдах, мэхлэх
3. Түлхэцтэй зан
4. Уур хилэн, бие махбодийн болон аман **доромжлол**
5. Гэр бүлийн хүрээнээс гадуур харилцаанаас зайлсхийх
6. Гэр бүлийн доторх харилцаа хэвийн бус болж, хүүхдүүд гэр бүлийн нэгжийг хамгаалахын тулд ер бусын үүрэг гүйцэтгэдэг.
7. Өөрийгөө чухал гэж үзэх мэдрэмжтэй, онцгой хандалт шаардах
8. Үгүйсгэх—асуудлыг зөвхөн мансууруулах бодис хэрэглэхээс бусад бүх зүйлд тохох
9. Зөвшөөршгүй зан үйлээ зөвтгөхөд өөрийгөө тайлбарлах, бусдад тохсох аргыг ашиглах
10. Өөртөө итгэх итгэл сул
11. Депрессия

12. Хамааралтай байдлын асуудлууд

a. *Кодепенденси* гэдэг нь донтолттой эсвэл архичин хүний хажуудын хүн(үүд)-д илэрдэг, тэдний хариуцлагагүй хэрэглээний хэв маягийг үр дагаваргүйгээр үргэлжлүүлэхэд нь тусалдаг зэрэгцэн оршиж буй зан үйлүүдийг хэлнэ.

b. Хамааралтай зан үйлүүдийн жишээ: мансууруулах бодис хэрэглэгч эсвэл архичин хариуцлага хүлээх ёстой төлбөрүүдийг төлөх, тэднийг шоронгоос суллахад барьцаа төлөх, ажлын газарт нь өвчтэй гэж дуудлага өгч туслах.

c. **Донтлын** асуудалтай үйлчлүүлэгч болон хамааралтай зан үйлтэй хүний сэргэх боломжийг дээдлэх үүднээс гэр бүлийнхэнтэй хамтран хамааралтай зан үйлтэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх нь чухал.

III. Архины буруу хэрэглээ

A. Тайлбар

1. Архи нь төв мэдрэлийн систем (CNS)-ийг сааруулдаг бөгөөд бүх биеийн эд эсэд нөлөөлдөг.
2. Бие махбодийн хамаарал нь бие махбодийн татгалзалтын шинж тэмдгээс зайлсхийхийн тулд архи хэрэглэх биологийн хэрэгцээ бөгөөд сэтгэлзүйн хамаарал нь архины субъектив нөлөөг хүсэх хүсэл эрмэлзэл юм.

B. Эрсдлийн хүчин зүйлс

1. Биологийн өмнөх хандлага; генийн болон гэр бүлийн өмнөх хандлага нь бас эрсдлийн хүчин зүйл байж болно.
2. Депрессив ба өндөр түвшний сэтгэл түгшүүртэй шинж чанарууд
3. Өөртөө итгэх итгэл сул
4. Өөрийгөө хянах чадвар сул
5. Эсэргүүцэл үзүүлэх, сургуулийн амжилт муутай, гэмт хэрэгт холбогдож байсан түүх
6. Эцэг эхийн хоорондын муу харилцаа

C. Үнэлгээ

1. Тодорхой бус яриа
2. Хамрагдсан хөдөлгөөнүүд
3. Тогтворгүй алхалт
4. Тайвангүй байдал
5. Төөрөгдөл
6. Нууцаар архи уух, өглөө архи уух, ухаан алдах
7. Хэт их уух
8. Уух тухай маргаан
9. Ажлаас хоцрох
10. Архинд тэсвэр тэвчээр нэмэгдэх
11. Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үед цусанд агуулагдах архины хэмжээ (BAC) 0.1% (100 мл цусанд 100 мг архи) буюу түүнээс их байх (хууль ёсны BAC нь муж бүрт харилцан адилгүй байж болно)

Үнэлгээний нэг хэсэгт архины төрөл, хэмжээ, хугацаа, мөн хамгийн сүүлд хэзээ хэрэглэсэн зэргийг тодорхойлох ёстой.

D. Сэтгэлзүйн шинж тэмдгүүд

1. Депрессийн байдал
2. Уур уцаартай, дайсагнасан, дайсагналтай
3. Сэжиглэмтгий байдал
4. Өөрийгөө зөвтгөх
5. Тусгаарлагдах
6. Хяналт саадгүй болох
7. Өөртөө итгэх итгэл буурах
8. Асуудал байгаа гэдгийг үгүйсгэх

E. Архаг архи хэрэглэхтэй холбоотой хүндрэлүүд

1. Витамины дутагдал
    a. В витамины дутагдал нь периферийн мэдрэлийн эмгэг үүсгэдэг
    b. Тиамин дутагдал нь Корсаковын хам шинжийг үүсгэдэг
2. Архины улмаас үүссэн тогтмол амнезийн эмгэг нь ноцтой ой тогтоолын асуудал үүсгэдэг
3. Верникийн энцефалопати нь төөрөгдөл, атакси болон хэвийн бус нүдний хөдөлгөөн үүсгэдэг
4. Гепатит; элэгний цирроз
5. Өвөр хоолойн үрэвсэл ба ходоодны үрэвсэл
6. Панкреатитис
7. Цус багадалт
8. Иммун тогтолцооны үйл ажиллагааны доголдлууд
9. Тархины гэмтэл
10. Периферийн мэдрэлийн эмгэг
11. Зүрхний асуудал

IV. Архины таталт

A. Тайлбар

1. Архи хэрэглэхээ зогсоосон даруйд хэдхэн цагийн дотор эхний шинж тэмдгүүд илэрдэг.
2. Эдгээр шинж тэмдгүүд 24–48 цагийн дараа оргилд хүрч, дараа нь хурдан арилдаг; харин таталт архины таталтын манийн байдалд шилжвэл үргэлжилнэ.
3. Шалтгаант таталт эхлэх үед (66-2 дугаар хайрцаг), заасан таталтын үнэлгээний шкалаар нэгж эсвэл байгууллагын протоколыг дагана.
4. Хлордиазепоксидыг архины хурц таталтын үед бичгээр олгож болох ба ихэвчлэн аман замаар өгдөг; илүү хурдан нөлөө шаардлагатай бол (бензодиазепин эмүүд нь давхардсан тэсвэрлэх чадварын улмаас таталтын шинж тэмдгийг бууруулдаг; бензодиазепинуудын жагсаалтыг 68-р бүлэгт үзнэ үү) булчинд тарьж хэрэглэнэ.
5. Верникийн энцефалопатиас урьдчилан сэргийлэхийн тулд витамин $_{B1}$(тиамин)-ыг булчинд тарьж, дараа нь хэд хоног аман хэрэглэх эмчилгээг ихэвчлэн зааварладаг.

B. Хөндийрөх шинж тэмдэг (66-2-р хайрцгийг үзнэ үү)

C. Делириум тременс: Делириумын байдал ихэвчлэн хэрэглээг зогсоосон эсвэл бууруулснаас хойш 48–72 цагийн дараа оргилд хүрч (хожим илрэх тохиолдол ч бий) 2–3 хоног үргэлжилдэг (66-3-р хайрцаг).

Хургах делириум нь яаралтай эмнэлгийн тусламж шаарддаг. Үхэл миокардын миокардын инфаркт, өвхний эмболи, периферийн судасны цочмог сулралт, электролитийн тэнцвэргүй байдал, аспирацийн уушгины хатгалгаа эсвэл амиа хорлолт.

D. Оролцоо

1. Шүүмжлэлгүйгээр халамж үзүүлэх.
2. Клиентийг тогтмол шалгаж байх.
3. Амьсгал, зүрх судасны болон мэдрэлийн чухал үзүүлэлтүүдийг 15 минут тутамд хянаж, нэг-нэгээр хяналт тавьж ажиллана.
4. Цусны сийвэнгийн электролитууд, түүний дотор глюкоз ба магнийн хэмжээг хянах.
5. Тайван, өдөөлтгүй орчныг бүрдүүлж, сэтгэл түгшүүрийг бууруулахын тулд нэг удаад нэг гэр бүлийн гишүүнийг үйлчлүүлэгчтэйгээ хамт байлгахыг дэмжинэ.
6. Өвчтөнд байршил, цаг хугацаа, нөхцөл байдлын талаар тогтмол танилцуул.
7. Бүх эмчилгээ, процедурыг нам гүм, энгийн байдлаар тайлбарлана.
8. Таталтаас сэргийлэх арга хэмжээг авч эхлэх.
9. Шинж тэмдгийг хангалттай хянахын тулд их хэмжээний бензодиазепин төрлийн тайвшруулагч шаардлагатай байж болно.
10. Жижиг хэмжээний, давтамжтай, нүүрс ус ихтэй хоол хүнс өгөх (шаардлагатай үед хоолны өмнө бөөлхөөс сэргийлэх эм өгөх).
11. Хоол хүнс болон шингэний орц, гаралтыг хянах.
12. Витамин (олон витамин, тиамин, фолийн хүчил, С витамин агуулсан В комплексийн витамин) өгөх.
13. Хипомагниз илэрсэн тохиолдолд магни өгөх.
14. Өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагаанд болон тогтвортой бол алхахад туслах.
15. Клиентийн айдсыг илэрхийлэх боломжийг олгох.

E. Архи хэрэглээний алдаа болон архины хамааралд зориулсан эмийн эмчилгээ

1. Тайлбар: Эмийг зөвхөн архи уухаа больсон хүмүүст бичиж өгдөг.
2. Налтрексон: Утаа хэрэглэх үед хүмүүс мэдэрдэг "хай" мэдрэмжийг тархинд хааж үйлчилдэг
3. Акампросат: Архиа хаяхад хүмүүс ихэвчлэн мэдэрдэг бие махбодийн зовиур, сэтгэлзүйн таагүй байдлыг бууруулдаг
4. Дисульфирам: Энэ эм ууж байх үед архи ууснаар хүнд гаж хариу үйлдэл үүсгэдэг

F. Дисульфирам эмчилгээ

1. Тайлбар
   a. Эхний тунг өгөхөөс өмнө үйлчлүүлэгч дор хаяж 12 цагийн турш архи хэрэглэхгүй байх ёстой.
   b. Сөрөг нөлөө нь архи уусны дараа ихэвчлэн хэдхэн минутаас 30 минутын дотор эхэлж, 30 минут–2 цагийн турш үргэлжилж болно.
   c. Өвчтөн архи уухаас зайлсхийх ёстой

дисульфирам эмчилгээг зогсоосны дараах 14 хоногийн турш; эс бөгөөс үйлчлүүлэгч дисульфирам-архины урвалд өртөх эрсдэлтэй.

2. Сөрөг нөлөөлөл

a. Ядаргаа
b. Нүүр улайх
c. Хөлөрөх
d. Цохиж өвдөх толгой өвдөлт
e. Хацрын өвдөлт
f. Дотор муухайрах ба бөөлжих
g. Цусны даралт буурах
h. Таккардиа
i. Амьсгалын хүндрэл

3. Үйлчлүүлэгчийн боловсрол олгох

a. Эмийн нөлөөний талаар сургах.
b. Архи болон архи агуулсан аливаа бодис хэрэглэхгүй гэдгийг баталгаажуул.
c. Эмийн нөлөөг зогсоосны дараа хэд хоног үргэлжлэх боломжтойг үйлчлүүлэгчид мэдэгд.

G. Бодисын хэт хэрэглээний эмгэгтэй үйлчлүүлэгчийг удирдах

а 66-5 дугаартай хайрцаг)

Дисульфирам эмчилгээнд байгаа үйлчлүүлэгчид бодис хэрэглэхээс зайлсхийхийг зааварлах

Архи агуулсан кашмир эм, үрэвсэл намдаах түрхлэг, цуу, ам зайлах шингэн болон сахлын дараах лосьон зэрэг бодисыг хэрэглэхгүй байхыг зааж өг. Өвчтөн бүх бүтээгдэхүүний шошгыг унших шаардлагатай.

V. Мансууруулах бодисын хамаарал

A. Төв мэдрэлийн системийн дарангуйлагч

1. Төв мэдрэлийн системийн депрессантууд нь архи, бензодиазепинууд, барбитурат зэрэг бодис багтаадаг бөгөөд депрессант, седатив эсвэл гипнотик үйлдэл үзүүлдэг.
2. Согтуурууулах нөлөө (66-6-р хайрцаг)
3. Хэт тун нь зүрх-судасны эсвэл амьсгалын депресс, кома, цочрол, таталт болон үхэлд хүргэж болно.
4. Хэт тун: Хэрэв үйлчлүүлэгч сэрүүн байвал бөөлжис идэвхжүүлсэн нүүрсээр хордлогыг үүсгэн, идэвхжүүлсэн нүүрсээр ходоодонд угаалга хийдэг; хэрэв өвчтөн комотод байвал амьсгалын замыг нээж, ходоодонд идэвхжүүлсэн нүүрсээр угаалга хийх нь тэргүүлэх ач холбогдолтой; таталт үүсэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай.
5. Флумазенилыг судсаар тарьж болно

бензодиазепины хэт тунгийн нөлөөг буцаахын тулд.

6. Таталтын шинж тэмдгүүдэд дотор муухайрах, бөөлжих, зүрх дэлсэх, их хөлөрөх, уур уцаартай болох, чичирхийлэл, нойргүйдэл, таталт орно; таталтыг тухайн эмийн адил үйлдэлтэй, тунг нарийн тохируулсан эмээр эмчлэх ёстой (эмгэг таталт гэнэт зогсох нь үхэлд хүргэж болно).
7. ЦНС-ийг дарангуйлагч, жишээлбэл барбитурат төрлийн эмээс гарах үед ихэвчлэн фенобарбитал эсвэл удаан үйлчлэлтэй бензодиазепинээр эмчилдэг.

B. Төв мэдрэлийн өдөөгчид

1. Төв мэдрэлийн өдөөгч бодисууд нь амфетамин, кокаин, крэк зэрэг бодисуудыг багтаана.
2. Согтууруулах (66-7-р хайрцаг)
3. Хэт тун нь амьсгалын хүндрэл, атакси, гиперпирекси, таталт, кома, тархины харвалт, зүрхний шигдээс болон үхэлд хүргэж болно.
4. Хэт тунгийн эмчилгээнд антипсихотик эмүүд болон үүсэх хажуугийн үр дагаврыг зохицуулах арга хэмжээ ашиглагддаг.
5. Таталтын шинж тэмдгүүдэд ядаргаа, депресси, сандрал, апатия, түгшүүр, нойргүйдэл, чиг баримжааг алдах, сул дорой байдал, хүсэл эрмэлзэл зэрэг орно.
6. Таталтыг антидепрессантууд, а-гаар эмчилдэг.

мин агонист эсвэл бромокриптин; таталтыг ихэвчлэн дэмжлэг үзүүлэх байдлаар эмчилдэг, ялангуяа сэргээх бодисын таталтын үед дагалддаг хүнд депрессийн үед болон амиа хорлох бодолтой үед.

C. Опиоидууд

1. Опиоид нь опиум, героин, меперидин, морфин, кодеин сульфат, метадон, гидроморфон, оксикодон, гидрокодон болон фентанил зэрэг бодисуудыг агуулдаг.
2. Согтууруулах (66-8-р хайрцаг)
3. Хэт тун нь амьсгалын депресс, цочрол, кома, таталт болон үхэлд хүргэж болно.
4. Хэт тунгийн эмчилгээнд налоксон зэрэг опиоидын антагонист эмүүдийг хэрэглэнэ.
5. Сулрах шинж тэмдгүүдэд ханиалгах,

унтаж чадахгүй байдал, уур уцаартай байдал, хамрын нусал гарах, их хөлөрөх, булчингийн агшилт, дотор муухайрах, бөөлжих, булчингийн өвдөлт, чичирхийлэл, халуур, нулимс гоожих, суулгалт.
6. Таталтыг метадоноор детоксикаци хийх эсвэл бусад опиоидуудын тунг аажмаар бууруулах аргаар эмчилдэг.
7. Клонидин нь α-адреноблокатор бөгөөд симпатик мэдрэлийн системийн хүндрэлтийг бууруулахад тусалдаг–

үүсгэсэн татгалзалтын таагүй мэдрэмжийг бууруулахад тусалдаг.

8. Шинж тэмдгийг намжаах зориулалттай тодорхой арга хэмжээнүүд, жишээлбэл суулгалт зогсоох эм болон булчингийн өвдөлт намдаах ацетаминофеныг ашиглаж болно.

D. Халлуциногенүүд

1. Халлуциногенүүдэд лизергийн хүчил диэтиламид (LSD), мескалин (пейот), псилоцибин (мөөг), фенциклидин (PCP) зэрэг бодисууд орно.
2. Согтууруулах (66-9-р хайрцаг)
3. LSD, пейоте, псилоцибиний хэт тунгийн үр дагаварт сэтгэцийн эмгэг, тархины гэмтэл, үхэл орно; PCP-ийн үр дагаварт сэтгэцийн эмгэг, гипертензив хямрал, гипертерми, таталт, амьсгалын зогсолт орно.
4. Эмчилгээ (LSD, пейоте, псилоцибин) нь орчны өдөөлтийг багасгах (удаан, тод, нам дуугаар ярих) болон түгшүүр эмчлэх эм бэлдмэл хэрэглэхээс бүрдэнэ.
5. Эмчилгээ (PCP) нь боломжтой бол ходоодны [illegible]д угаалт (ухамсартай бол); шээсийг хүчиллэг болгох эмчилгээгээр эмийг гадагшлуулах; мөн зан үйлийн доголдлыг, халууралтыг, өндөр даралт болон амьсгалын хүндрэлтэй холбоотой эмчилгээний арга хэмжээ авах.
6. Таталтын үеийн эмчилгээ нь голчлон дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд тухайлбал түгшүүр зэрэг тодорхой асуудалтай зан үйлийг чиглэсэн эм бэлдмэлүүдийг ашиглаж болно.

Флэшбэкүүд нь нөлөөллийн гэнэтийн дахин мэдрэх явдлууд юм Халлуциноген бодис хэрэглэсний дараах флэшбэкүүд анх хэрэглэсэнээс хойш удаан хугацаанд үргэлжлэх боломжтой. Флэшбэк тохиолдсон үед аюулгүй байдал хамгийн чухал.

E. Амьсгалын замаар авах бодисууд

1. Амьсгалын замаар авах бодисууд нь бутан, будаг шингэлэгч, будаг болон лав арилгагч, нисдэг тэрэгний цавуу, хумсны будаг арилгагч, азотын давхар исэл зэрэг хийн болон шингэн бодисуудыг агуулдаг.
2. Согтууруулах (66-10 дугаар хайрцаг)
3. Хэт тун нь мэдрэлийн тогтолцоонд гэмтэл учруулж, үхэлд хүргэж болно.
4. Таталтын эмчилгээ ихэвчлэн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлтэй, Үүнд гэмтсэн биеийн системүүдийн эмчилгээ багтана.

F. Марихуана (*Cannabis sativa*)

1. Ерөнхийдөө тамхилан хэрэглэдэг боловч залгиж болно; зарим мужид хууль ёсоор жор бичүүлэн олгодог бөгөөд зарим муж, мужийн хэмжээнд жороор бичигдэхгүйгээр хууль ёсны байдаг.
2. Эуфори, бодит байдлаас таслагдах мэдрэмж, тайвшрал, их ярьдаг болох, цагийн хүлээлт удаашрах, түгшүүр, паранойя үүсгэдэг.

3. Урт хугацааны хамаарал нь сул дорой байдал, amotivation синдром, анхаарал төвлөрөхөд хүндрэл, ой санамж алдагдах, мөн магадгүй архаг амьсгалын замын асуудал үүсгэж болно.
4. Таргалалтыг даван туулах эмчилгээ ихэвчлэн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлтэй.

G. Бусад чөлөөт цагийн болон клубийн мансууруулах бодисууд

Хууль бус гудамжны олон төрлийн хортой мансууруулах бодис байдаг. Сувилагч шаардлагатай Эдгээр төрөл бүрийн мансууруулах бодисын физиологийн нөлөөг сайн мэдэж, хэрэглэснээс үүдэх шинж тэмдгүүдийг таньж, яаралтай эмчилгээ үзүүлэхэд бэлэн байх ёстой.

1. Үүнд метилендиоксиметамфетамин (MDMA, экстази), γ-гидроксибутират (GHB), метамфетамин (crank, meth, crystal meth) болон кетамин (special K) орно.
2. Үр нөлөөнд эйфория, эрч хүч нэмэгдэх, өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэх, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй болох зэрэг орно.
3. Сөрөг нөлөөнд гипертерми, рабдомиолиз, бөөрний дутагдал, элэгний хордлого, депресси, паникийн дайралт, сэтгэцийн эмгэг, зүрх-судасны цочмог уналт болон үхэл орно.
4. Донтлын хөтөлбөрүүд нь никотин таслалтын шинж тэмдгийг бууруулах, хүсэл тачаалыг намжаах зорилгоор никотин наалт, никотин амьсгалагч, бупропион зэрэг эмийн болон сэтгэл засалын арга хэмжээг ашигладаг.
5. Анаболик стероидууд нь үхэл хүртэлх ноцтой гаж нөлөөнүүд нь илүү өргөнөөр мэдээлэгдэх болсон тул улам их анхаарал татаж байна.

H. Оролцоо: Тайвшрал (66-11-р хайрцаг)

1. Таталтаас сэргийлэх арга хэмжээг ав.
2. Клиентийн биед шингэн нөхөж өг.
3. Амин чухал үзүүлэлтүүдийг цаг тутамд хянах; зарим эм бэлдмэл зүрхний гэмтэл үүсгэх эрсдэлтэй тул зүрхний хяналт болон электрокардиограм, зүрхний маркер зэрэг оношилгооны шинжилгээг заавал оруулах.
4. Оролт, гаралтыг хянах.
5. Өвчтөнд байнга мэдээлэл өгч, байдлыг тайлбарлаж ойлгуул.
6. Өдөөлтийг хамгийн бага байлга.
7. Үйлчлүүлэгч рүү хүлээн зөвшөөрч, шүүмжлэлгүй хандлагаар ханд.
8. Мансууруулах бодис хэтрүүлэн хэрэглэх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүл.
9. Үйлчлүүлэгчид уур хилэнг өдөөх нөхцөл байдлыг тодорхойлоход туслах.
10. Клиенттэй сэтгэл хөдлөлөө даван туулахад нь туслах.

11. Мансууруулах бодис буруу хэрэглэх асуудлыг тайлбарлахдаа буруутгах, өөрийгөө зөвтгөхөө хязгаарлах.
12. Хэрэгцээгээ биелүүлэхийн тулд манипуляци хийхийн оронд өөрийгөө илэрхийлэх хатуу боловч шударга арга барилыг ашиглахад үйлчлүүлэгчид туслах.
13. Манипуляцийн зан үйл болон аман, бие махбодийн хүчирхийлэлд хязгаар тогтоох.
14. Шудрага, боломжийн хязгаарлалтыг бат бөх баримталж, дүрмүүдийг тогтмол бататгаж, зөрчсөн тохиолдолд зохистой үр дагаврыг тогтооно.
15. Клиентийг бүх үйлдэлдээ хариуцлага хүлээхээр тооцох.
16. Үйлчлүүлэгчийг давуу болон сул талуудаа судлахад нь туслах.
17. Хэрэв үйлчлүүлэгч хяналтаа алдаж байвал түүнийг давуу талдаа анхаарлаа төвлөрүүлэхийг урамшуул.
18. Клиентийг нэгжийн үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалах.
19. Клиентийг бүлгийн эмчилгээ болон дэмжлэгийн бүлгүүдэд оролцохыг уриалах.

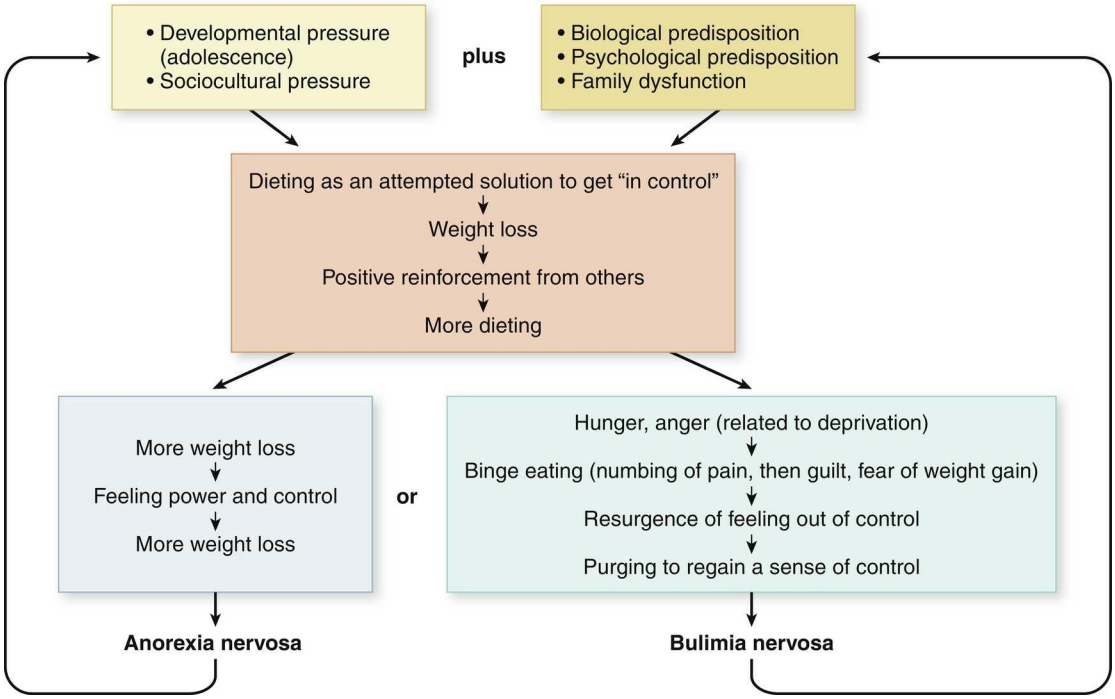
I. Хоёр давхар оношо

1. Заримдаа архи, мансууруулах бодис хэрэглэх нь дорх сэтгэцийн эмгэгийг нууж болно.
2. Сэтгэцийн эмгэг нь мөн бодис хэрэглэх, буруу ашиглахтай холбоотойгоор үүсч болно.
3. Сэтгэцийн эмгэг болон бодис хэтрүүлэн хэрэглэх байдал зэрэг илэрсэн тохиолдолд ихэвчлэн *хоёр давхар оношо* гэж нэрлэдэг.
4. Сэтгэцийн оношийг бодисын хамааралаас ялгах нь зөвхөн удаан хугацааны татгалзалтын дараа л боломжтой.

J. Эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн донтолт ба бодис буруу хэрэглээ: Сэжигтэй шинж тэмдгүүд

1. Өөр сувилагч гэрчлээгүй байхад эм бодис үрэгдсэн гэж олонтаа мэдэгддэг
2. Бусад сувилагчид хамгийн их тунг өгөөгүй байхад өөрөө үйлчлүүлэгчдэд хяналтын дорхи бодисын хамгийн их тунг өгсөн гэж мэдэгддэг
3. Өвчтөнд тун болон хэрэглэх давтамжийг өөрчлөөгүй байхад өвдөлт намдаах эмчилгээнд хэвийн хариу үзүүлэхгүй байх
4. Ажлын хэв маягт дараах зүйлс орно: Наркотик (опиоид) түлхүүр (эсвэл байгууллагын журамд заасан бусад опиоидын хандалтын төхөөрөмж) үргэлж сайн дурааараа авч явах; хяналт багатай ээлжийг сонгох; хяналтад байдаг бодисын хэрэглээ өндөр бүс, жишээлбэл эрчимт эмчилгээний тасаг, мэс заслын өрөө, мэдээ алдуулалтын тасаг болон гэмтлийн тасагт ажиллахыг сонгох
5. Сувилагч нарт ажлын чадамж алдсан хамтран ажиллагсдыг мэдээлэх мэргэжлийн болон ёс зүйн үүрэг хариуцлага ногддог.
6. Ихэнх сэтгэцийн болон бие махбодийн хувьд асуудалтай сувилагчид ажлаасаа буцаж чаддаг

Улсын сувилагчийн зөвлөлийн тусламж, хяналтын хөтөлбөрүүдийн тусламжтайгаар; эдгээр хөтөлбөрүүд нь ихэвчлэн тодорхой заасан дүрэм журмыг чанд мөрдөх, тогтмол тайлан гаргах, мансууруулах бодисын шинжилгээ өгөх шаардлагатай байдаг.



Зураг 66-1. Хоолны эмгэгийн мөчлөг ( )

66-1-р хайрцаг

CAGE-ийн шинжилгээний асуулга

C Та архи/мансууруулах бодис хэрэглээгээ багасгах шаардлагатай гэж хэзээ ч мэдэрч байсан уу?
A Та архи/мансууруулах бодис хэрэглэх талаар шүүмжлэлд уурлаж байсан уу?
G Архи ууж эсвэл мансууруулах бодис хэрэглэж байхдаа хийсэн зүйлдээ хэзээ нэгэн үед гэмшиж байсан уу?
E Өглөө сэрмэгцээ идэвхжүүлэх эсвэл таталтын шинж тэмдгээс зайлсхийхийн тулд архи ууж эсвэл мансууруулах бодис хэрэглэж байсан уу?

Хайрцаг 66-2

Архины таталтын эхний шинж тэмдгүүд

- Анорексия (дотор муухайрах, бөөлжих шинж тэмдэг илрэх боломжтой)
- Сэтгэл түгшил

- Амархан цочирдож айдаг
- Хэт сэрэмжтэй байдал
- Дээд цусны даралт ихсэлт
- Нойргүйдэл
- Уур уцаартай байдал
- Хачирхалтай, тасралтгүй хөдөлгөөн
- Магадгүй галлюцинаци, иллюзи, төөрөгдөл эсвэл тод аймшигт зүүд зэрэг үзэгдэл тохиолддог
- Магадгүй "дотор чичирх" мэдрэмжтэй гэж мэдэгддэг
- Таталт (ихэвчлэн архи хэрэглэхээ зогсоосноос хойш 7–48 цагийн дараа илэрдэг)
- Тахикарди
- Чичиргээ

Блок 66-3

Архины таталтын манийн (Delirium Tremens) илрэлүүд

- Сэтгэл хөдлөл, сандрал
- Анорексия
- Сэтгэл түгшүүр
- Делириум
- Диафорез
- Ухамсрын түвшин хэлбэлзсэн төөрөгдөл
- Халуурал (100°F [37.8°C]–103°F [39.4°C])
- Халлуцинаци ба төөрөгдөл
- Унтуулалтгүй байдал
- Таккарди ба гипертензи

Бох 66-4

Архи хэрэглээний буруу дадлагатай үйлчлүүлэгчийг удирдах

- Клиентийн анхаарлыг мансууруулах бодис буруу хэрэглэх асуудал руу чиглүүл.
- Клиенттэй хамт уур хилэнг өдөөгч нөхцөл байдлыг тодорхойл.
- Манипуляцийн зан үйл болон аман болон бие махбодийн хүчирхийлэлд хязгаар тогтоо.
- Клиентийг зохистой хязгаар дотор хатуу хариуцлагатай байлгаж, дүрмийг тогтмол бататгаж, зөрчсөн тохиолдолд зохистой үр дагавар ногдуулах.
- Клиентийг бүх зан үйлд хариуцлага хүлээлгэх.
- Үйлчлүүлэгчид давуу болон сул талуудаа судлахад нь туслахын тулд урам зоригийн ярилцлага ашигла.

- Хэрвээ үйлчлүүлэгч хяналтаа алдаж байгаа бол түүнийг давуу талдаа анхаарлаа төвлөрүүлэхийг урамшуул.
- Клиентийг бүлгийн эмчилгээ болон дэмжлэгийн бүлэгт оролцохыг уриалах.

Хаяг 66-5

Мансууруулах бодис хэтрүүлэн хэрэглэдэг үйлчлүүлэгчид болон тэдний гэр бүлд зориулсан эмчилгээнүүд

- Зан үйлийн эмчилгээ (когнитив зан үйлийн эмчилгээ [CBT] багтсан), эмийн тусламжтай татгалзах нөхцөлжүүлэлт
- Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх
- Психотерапи (хувь хүн, бүлэг, гэр бүл)
- Архины хортойдод зориулсан Alcoholics Anonymous; мансууруулах бодисын хортойдод зориулсан Narcotics Anonymous; эм тариа (Pills) хортойдод зориулсан Pills Anonymous; мөн архичин эсвэл мансууруулах бодисын донтой хүмүүсийн гэр бүлийн гишүүд, найз нөхдөд зориулсан Al-Anon, Al-a-Teen эсвэл Narc-Anon; мөн архичин эцэг эхээс төрсөн насанд хүрсэн хүүхдүүдэд зориулсан Adult Children of Alcoholics
- Шилжилтийн амьдралын хөтөлбөрүүд (хагас зам дахь байрууд)

Хаяг 66-6

Согтууруулах: Төв мэдрэлийн системийн дарангуйлагч бодисууд

- Нойрмоглолт
- Цусны даралт багасах
- Санах ой, анхаарал, дүгнэлт хийх чадвар болон нийгмийн болон мэргэжлийн үйл ажиллагаанд саатал
- Хөдөлгөөний зохицуулалт алдагдаж, алхаа тогтворгүй болох
- Уур уцаартай байдал
- Үг нь тодорхой бус яриа
- Бэлгийн сулрал

Хаяг 66-7

Согтууруулах бодис: Төв мэдрэлийн системийн сэргээш бодисууд

- Тэлэгдсэн нүдний цариг
- Эйфория
- Дээд цусны даралт
- Шүүмжлэх чадвар болон нийгмийн болон мэргэжлийн үйл ажиллагаанд саатал
- Нойргүйдэл
- Өлсгөлөн ба бөөлжис

- Паранойя, төөрөгдөл, галлюцинаци
- Хүчирхийлэл үйлдэх эрсдэл
- Таккардиа

Хаяг 66-8

Согтуурруулах бодисын хордлого: Опиоид

- Нарийссан соёо
- Амьсгалын тоо буурсан
- Нойрмоглолт
- Эйфория
- Цусны даралт буурах
- Санах ой, анхаарал, дүгнэх чадварын алдагдал
- Психомотор удаашрал
- Амны үг нь тодорхойгүй

Хавтас 66-9

Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хордлого: галзууруулагч бодис

- Тэвдүүр, дайсагнал
- Сэтгэл түгшилт ба гүн гашуудал
- Хачирхалтай зан үйл, хүүхдийнх шиг зан үйл эсвэл хүчирхийлэлтэй зан үйл
- Хоосон ширтэх
- Диафорез
- Тэлэгдсэн нүдний цариг
- Амьдралын чухал үзүүлэлтүүд, тэр дундаа цусны даралт өндөр
- Халлюцинаци
- Шүүмжлэх чадвар болон нийгмийн болон мэргэжлийн үйл ажиллагаанд саатал
- Хамралтгүй байдал
- Цул айрагшил ба архаг чичиргээ
- Паранойя
- Таталт
- Таккардиа
- Чичиргээ

Хайрцаг 66-10

Согтууруулах бодис: Амьсгалын замаар авах бодисууд

- Бэлгийн таашаалыг нэмэгдүүлэх
- Эйфория
- Сэргэлэн байдал дараа нь нойрмоглолт, толгой хөнгөхөн болох, саадгүй болох, түгшүүртэй болох
- Хахаж инээх, инээд алдах

Хаяг 66-11

Таталт: Сувилахуйн тусламж

- Хэрэглэсэн бодисын төрөл, хэмжээний талаар мэдээлэл цуглуулах.
- Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн температур зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг үнэл.
- Орчны хэрэгцээгүй зүйлсийг зайлуул.
- Шаардлагатай бол нэг-нэг хяналт тогтооно.
- Цөөн өдөөлттэй, нам гүм тайван орчныг бүрдүүлэх.
- Өвчтөнийг орчинтой нь танилцуулан чиг баримжаатай байлга.
- Таталтын үед авах хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангана.
- Шаардлагатай болон заасан тохиолдолд үйлчлүүлэгч өөрийгөө болон бусдыг гэмтээхээс сэргийлэхийн тулд аюулгүй байдлын төхөөрөмжүүдийг ашигла.
- Бие махбодийн хэрэгцээг хангах.
- Өвчтөний тэсвэрлэх чадварын хэрээр хоол хүнс болон шингэн өг.
- Таргалалтын шинж тэмдгийг бууруулахын тулд эмчийн зааврааар эм өгнө.
- Эмийн шинжилгээ хийх зорилгоор цус, шээсний дээж цуглуулах.

Даалгаврын асуултууд

817. Гэрийн эрүүл мэндийн сувилагч нь гэртээ үйлчлүүлэгчид зочилж, түүнийг мансууруулах бодисоос хамааралтай болохыг тогтоосон. Үнэлгээний явцад сувилагч зохих сувилахуйн тусламж үйлчилгээг төлөвлөхийн тулд ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?
    1. Өвчтөнөөс яагаад хууль бус мансууруулах бодис хэрэглэж эхэлснийг асуух.
    2. Өвчтөнөөс мансууруулах бодисын хэрэглээний хэмжээ болон түүний нөлөөг асуух.
    3. Өвчтөндөө хэн ч мэдэхгүйгээр хэр удаан хугацаанд мансууруулах бодис хэрэглэж чадах гэж бодож байсныг асуух.
    4. Клиент үгүйсгэж, сувилагчийг гэрээс хөөж магадгүй гэж айсандаа ямар ч асуулт бүү асуу.
818. Архины таталтад орсон үйлчлүүлэгчийг асаргахдаа аль арга хэмжээ **хамгийн тохиромжтой** вэ? **Хамаарах бүгдийг сонгоно уу.**
    - ☐ 1. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн температур зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг хянах.
    - ☐ 2. Аюулгүй орчныг бүрдүүлэх.

3. Халлюцинацийг эмчилгээний аргаар зохицуулах.

4. Орчныг сэргээх өдөөлт үзүүлэх.

5. Шаардлагатай бол бодит байдлын чиглэл өгөх.

6. NPO (амнаас юу ч өгөхгүй) статусыг хадгалах.

819. Сувилагч архины донтой үйлчлүүлэгчийн эхнэрийг Al-Anon бүлэгт оролцож байгаад ашиг тус хүртэж байгааг ямар мэдэгдэл сонссоны дараа тодорхойлно вэ?

1. "Би нөхрийнхөө надад үзүүлдэг зодуулыг дахиж ч үгүйлэхээ больсон."
2. "Хурлуудад оролцсоноор би нөхрийнхөө хүчирхийллийг өдөөдөг гэдгээ ойлгосон."
3. "Уулзалтуудад оролцох дуртай, учир нь тэд намайг гэрээс гаргаж, нөхрөөсөө холдуулдаг."
4. "Архичдын дунд ийм зан байдал түгээмэл гэдгийг одоо мэдсэн тул би нөхрийнхөө сүйтгэх зан үйлд тэсвэрлэж чадна."

820. Архи хэрэглэх зуршилтай түүхтэй эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгч сувилагчид "Би одоо явна. Явах ёстой. Би цаашид эмчилгээ авахыг хүсэхгүй байна. Надад яаралтай хийх зүйлс байна." Клиент хэвтэн эмчлүүлж байгаа ч эмнэлгээс гарах төлөвлөгөөгүй бөгөөд 1 цагийн дараа чухал оношилгооны шинжилгээ хийхээр товлогдсон байна. Сувилагч клиентийн санаа зовнилыг түүнтэй ярилцсаны дараа клиент хувцсаа өмсөж, эмнэлгийн өрөөнөөс гарахаар алхаж эхэллээ. Сувилагч ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?

1. Сувилагчийн ахлагчид залга.
2. Бүх гарах гарцыг хаахын тулд хамгаалалтын албанд залга.
3. Үндсэн эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэгч (PHCP) холбогдох хүртэл үйлчлүүлэгчийг барьж саатуулах.
4. Хэрвээ одоо гарвал дахин энэ эмнэлэгт хэвтэх боломжгүйг үйлчлүүлэгчдэд хэл.

821. Сувилагч булльимия нервоза оноштой үйлчлүүлэгчид хэвтэн эмчлүүлэх үнэлгээ хийхээр бэлтгэж байна. Сувилагч ямар үнэлгээний дүнгүүд илрэх боломжтойг урьдчилан таамаглах ёстой вэ? **Хамаарах бүгдийг сонгоно уу.**

1. Шүдний цоорол
2. Чийглэг, тослог арьс
3. Шүдний пааланг алдагдах
4. Исэлдэлтийн тэнцвэргүй байдал
5. Биеийн жин нь идеал жингийнхээсээ ихээхэн доогуур

822. Сувилагч с[illegible] анорексиа нервоза оноштой эмэгтэй үйлчлүүлэгчийг сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасагт хэвтүүлсэн. Сувилагч өрөөнд нь орж ирэхэд үйлчлүүлэгч ширүүн түлхэлт (push-up) хийж байгааг ажиглав. Аль сувилахуйн арга хэмжээ **хамгийн зохистой** вэ?

1. Өвчтөнийг тасалдуулж, даруй жинг нь хэмжих.
2. Өвчтөнийг тасалдуулж, түүнийг салхилуулахаар санал болгох.
3. Өвчтөнд дасгалын хөтөлбөрөө дуусгахыг нь зөвшөөрөх.
4. Өвчтөнд хүчтэй дасгал хийхийг хориглохыг хэл.

823. Хоол тэжээлийн дутагдалд орсон, анорексиа нервоза оноштой өвчтөн хоёр ортой өрөөнд байна. Шинээр хэвтэн эмчлүүлэх өвчтөнийг энэ өвчтөний өрөөнд хамт байрлуулах гэж байна. Анорексиа нервозатай өвчтөний өрөөний хамтрагчаар аль өвчтөн **хамгийн** тохиромжтой вэ?

1. Уушгины хатгалгаатай өвчтөн
2. Оношилгооны шинжилгээнд хамрагдаж буй үйлчлүүлэгч
3. Бусдыг удирдахад амжилттай байдаг үйлчлүүлэгч
4. Хооллох үед үйлчлүүлэгчийн тусламж авах шаардлагатай үйлчлүүлэгч 824. Сувилагч нь 24 цагийн өмнө хугарлын улмаас хэвтэн эмчлүүлсэн үйлчлүүлэгчийг үнэлж байна хумерус. Аль олдворууд сувилагчийг архины таталттай холбоотой сэтгэц самуурал үүсэх эрсдэлтэй байж болзошгүйг анхааруулах ёстой вэ?

1. Цус барах, атекси, өлсгөлөн
2. Ступор, летарги, булчингийн хатууралт
3. Цус барах, гарын томоохон чичиргээ, сул дорой байдал
4. Даралт ихсэлт, ухамсрын түвшний өөрчлөлт, галлюцинаци 825. Архины шалтгаанаар сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасагт хэвтсэн үйлчлүүлэгчийн гэр бүлийн гишүүн "Би энэ муу нөхцөл байдлаас гарах ёстой." Сувилагч **хамгийн** тустай хариу өгөх нь аль вэ?

1. "Та яагаад энэ талаар ханьдаа хэлэхгүй байгаа юм бэ?"
2. "Та энэ нөхцөл байдалд юуг хэцүү гэж үзэж байна вэ?"
3. "Энэ шийдвэр гаргахад хамгийн тохиромжтой цаг биш байна."
4. "Би чамтай санал нэг байна. Чи энэ нөхцөл байдлаас гарах хэрэгтэй."

826. Анорексиа нервозатай үйлчлүүлэгч нь эмнэлгээс гарахын өмнөх дэмжлэгийн бүлгийн гишүүн юм. Клиент шинэ хувцас авахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн ч санхүүгийн боломж нь хязгаарлагдмал байна. Бүлгийн гишүүд түүний хуучин хувцас орлуулах зорилгоор хэдэн удаа өмссөн хувцас авчирсан. Клиент шинэ хувцас нь хэтэрхий чанга гэж үзэн өдөрт 800 калори хүртэлх хоол хүнс хэрэглэж байна. Сувилагч энэ зан үйлийг хэрхэн үнэлэх вэ?

1. Энгийн зан үйл
2. Клиентын биеийн дүрс алдагдсан байдлын нотолгоо
3. Хүний нийгэм рүү шилжиж буй үед регресс илэрч байна
4. Эмнэлгээс гарах тухай үйлчлүүлэгчийн хоёрдмол сэтгэл хөдлөлийг илтгэнэ

Хариултууд

817. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Эмчлэгч сувилагч мансууруулах бодисын хамааралтай үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ хийхдээ шүүмжлэлгүй, шууд асууж мэдээлэл цуглуулах нь хамгийн тохиромжтой. 1-р сонголт буруу, учир нь шүүмжлэлтэй, анхаарал төвлөрөөгүй бөгөөд сувилагчийн талцуу байдлыг илэрхийлнэ. 3-р сонголт буруу, учир нь шүүмжлэлтэй, мэдрэмжгүй, түрэмгий бөгөөд эмчилгээний бус. 4-р сонголт буруу, учир нь сувилагчийн идэвхгүй байдлыг илэрхийлж, эмчилгээний сувилахуйн оролцооноос зайлсхийх рационализаци ашигласан байна.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдвээ** төвлөрүүлж**,** мансууруулах бодисын хамааралтай үйлчлүүлэгчийн үнэлгээнд анхаар. **Эмчилгээний харилцааны техник** ашиглах нь зөв сонголтыг олоход тусална.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Донтолт ***Гол ойлголтууд:*** Донтолт; Харилцаа ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 331-р тал.

818. ***Хариулт:*** 1, 2, 3, 5

Үндэслэл: Клиент архинаас татгалзах үед асаргааны тэргүүлэх зорилго нь өөрийгөө болон бусдыг хохироохөөс сэргийлэх явдал юм. Сувилагч амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг нягт хянаж, хэвийн бус үзэгдлийг мэдээлнэ. Сувилагч өдөөлт багатай орчныг бүрдүүлж, клиентийн тайван байдлыг аль болох хадгална. Сувилагч клиентийг бодит байдалд тогтмол эргүүлэн оруулж, галлюцинацид эмчилгээний аргаар хандана. Шаардлагатай шим тэжээл, шингэний хангамжийг хангах хэрэгтэй.

Шалгалт өгөх стратеги: *Хамгийн зохистой* **стратегийн үгсийг** тэмдэглэ. Архины таталтын үед үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг бодож, архины таталттай холбоотой шинж чанаруудыг санахад зөв хариулах боломжтой болно. Мөн зөв оролцоог сонгоход туслахын тулд **эмчилгээний харилцааны техникүүдийг** ашигла.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Гүйцэтгэл
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Донтолт ***Гол ойлголтууд:*** Донтолт; Асран халамж ***Дүгнэлт:*** Varcarolis (2017), 303-р тал.

819. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Al-Anon дэмжлэгийн бүлгүүд нь хамтрагчид болон чухал хүмүүст юу хүлээж болохыг мэдэж, амжилттай зан үйлд өөрчлөлт хийх талаар шилдэг зөвлөгөө авах хамгаалалттай, дэмжлэгтэй боломж юм. Зөв сонголт нь хамгийн эрүүл хариу үйлдэл бөгөөд энэ нь архи уудаг хамтрагч нь өөрийн үйлдэлдээ хариуцлагатай бөгөөд хяналтаа алдсаны улмаас гэр бүлийн гишүүдээ буруутгах эрхгүй гэдгийг ойлгож байгааг харуулж байна. 2-р сонголт буруу, учир нь архи уудаггүй хань хяналтаа алдсан үед хариуцлага хүлээх ёсгүй. 3-р сонголт нь бүлгийг асуудлыг шийдэх газар биш, зугтах газар гэж үзэж байгааг харуулж байна. 4-р сонголт нь эхнэр хэвээрээ хамааралтай хэвээр байгааг илтгэнэ.

Шалгалтын стратеги: Анхаарлаа **сэдэв болон** Al-Anon бүлэгт оролцохын эмчилгээний үр нөлөөнд төвлөрүүл. *Al-Anon бүлэгт оролцохын ашиг тусыг илэрхийлэх* үгсийг тэмдэглэх нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Үнэлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Донтолт ***Гол ойлголтууд:*** Донтолт; Гэр бүлийн динамик ***Эх сурвалж:*** Varcarolis (2017), 319-р тал.

820. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Ихэнх эрүүл мэндийн байгууллагууд үйлчлүүлэгч эмнэлгийн зөвлөгөөг үл тоон гарах үед түүний хариуцлагын талаар гарын үсэг зуруулах баримт бичигтэй байдаг. Үйлчлүүлэгчийг гарахынхаа өмнө анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэнтэй (PHCP) ярилцаж, "эмнэлгийн зөвлөгөөг үл тоон гарах" баримт бичигт гарын үсэг зурахыг хүсэх ёстой. Хэрэв үйлчлүүлэгч татгалзвал сувилагч үйлчлүүлэгчийг хүсэл зоригийн эсрэг барьж чадахгүй. Иймээс энэ нөхцөлд сувилагч нь сувилахуйн ахлах ажилтанд залгах ёстой. Хэрэв үйлчлүүлэгчийг эмнэлгээс гарах эрхгүй мэтээр буруу итгүүлбэл сувилагчийг хууль бусаар хорих гэмт хэрэгт буруутгаж болно. Үйлчлүүлэгчийг саатуулж, гарах гарцыг хаахын тулд хамгаалалтын алба дуудсан нь хууль бусаар хорих үйлдэл болно. Бүх үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж авах эрх бий бөгөөд тэдэнд үүнийг эсрэгээр нь хэлж болохгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: Хүнийг хууль бусаар хорих ойлголтыг санаанд барьж, 2 болон 3-р сонголтыг **адил төстэй** гэж үзэн хас**.** Бүх үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж авах эрх байдаг гэдгийг мэдэж, 4-р сонголтыг хас. Өгөгдсөн сонголтуудаас хамгийн зөв үйлдлийг харуулсан сонголтыг ол.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үзүүлэх
орчин ***Интеграцчилсан процесс:*** Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт
Агуулгын чиглэл: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Донтолт
Эрэмбэлэгдэх ойлголтууд: Клиникийн шийдвэрлэл; Эрүүл мэндийн тусламжийн хууль
Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 68-69-р хуудас.

821. ***Хариулт:*** 1, 3, 4

Үндэслэл: Булимия нервозатай үйлчлүүлэгчид эхэндээ бие махбодийн болон сэтгэл санааны хувьд өвчтэй мэт харагддаггүй. Тэд ихэвчлэн биеийн төгс жинтэй эсвэл бага зэрэг доогуур байдаг. Илүү нарийвчилсан үзлэгээр үйлчлүүлэгч бөөлжис хүргэж байсан бол шүдний цооролт, эмаль алдагдал илэрнэ. Электролитийн тэнцвэргүй байдал илэрнэ. Хуурай, хальсархаг арьс (чийглэг, тослог биш) ажиглагддаг.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт анхаарлаа** төвлөрүүлж**,** булимия нервоза өвчний үнэлгээний дүнг авч үз. Анорексия нервоза өвчний үед биеийн жин ердийнхөөсөө ихээхэн доогуур байдаг бол булимия нервоза өвчтөнүүд ихэвчлэн идеал жиндээ эсвэл түүнээс бага зэрэг доогуур байдаг гэдгийг санаарай. Мөн арьсны бүтэц хуурай, хальсархаг байхыг анхаарна уу.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хооллолтын эмгэг
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Сэтгэл түгшил; Хоол тэжээл

Дүйнз: Varcarolis (2017), 184-185-р хуудас.

822. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Анорексиа нервозатай үйлчлүүлэгчид ихэвчлэн хатуу дасгал хөдөлгөөнд хэт төвлөрч, калори зарцуулахын тулд хэвийн хязгаараа давсан дасгал хийдэг. Сувилагч нь зохистой дасгал хөдөлгөөнийг хангаж, хэт хүнд дасгалд хязгаар тогтоох ёстой. Зөв сонголт нь хортой зан үйлийг зогсоож, үйлчлүүлэгчид сэтгэл түгшүүрээ бууруулахад хоргүй үйл ажиллагаа санал болгодог. Өвчтөнийг даруй жинглэх нь түүний жингийн тухай хэт их бодох байдлыг улам бэхжүүлдэг. Өвчтөнд дасгалын хөтөлбөрөө дуусгахыг зөвшөөрөх нь түүнд хортой байж болно. Өвчтөнд дасгалын хөтөлбөрөө дуусгахыг хориглосон тухай хэлэх нь түүний түгшүүрийг нэмэгдүүлнэ.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн үгс**, *хамгийн зохистой* сонголтыг тэмдэглэж, үйлчлүүлэгчийн оношилгоонд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Мөн сувилагч аюулгүй байдлыг хангах, энэ эмгэгтэй үйлчлүүлэгчидтэй хатуу хязгаар тогтоох шаардлагад анхаарна.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Клиентын хэрэгцээ: Физиологийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хооллолтын эмгэг

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Сэтгэл түгшилт; Аюулгүй байдал

Дүгнэлт: Potter et al. (2017), 1060-р тал. 823.

Хариулт: 2

Үндэслэл: Оношилгооны шинжилгээнд хамрагдаж буй үйлчлүүлэгч нь өрөөний хамтрагч болж болохуйц. Анорексиа нервозатай үйлчлүүлэгч ихэвчлэн лейкопени зэрэг гематологийн хүндрэлтэй тулгардаг. Уушгины хатгалгаатай өрөөний хамтрагчтай байх нь анорексиа нервозатай үйлчлүүлэгчийг халдварт өртөх эрсдэлд оруулна. Анорексиа неврозатай үйлчлүүлэгчийг бусдын хоол тэжээлийн хэрэгцээнд анхаарал хандуулах эсвэл бусад хүмүүс түүнийг удирдах нөхцөлд оруулах ёсгүй, учир нь энэ нь хувийн өлсгөлөнг дарж, нуух (sublimation, suppression) явцад хүргэж болзошгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн** "*best*" гэсэн **үгийг** болон асуулгад *"starvation" буюу өлсгөлөнгийн байдал илэрхийлэх* үгсийг анхаараарай. Анрексиа нервозагийн шинж тэмдгүүд болон өвчтөн өлсгөлөнгийн улмаас дархлаа нь суларсан гэдгийг санахад таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Шинжилгээ

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа сувилгын орчин ***Нэгдмэл процесс:*** Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хооллолтын эмгэгүүд ***Эрхэмлэх ойлголтууд:*** Сувилахуйн үйлчилгээний уялдаа; Аюулгүй байдал ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 185-р тал.

824. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Архины таталтаас үүдэлтэй мөргөн будилах үед илэрдэг шинж тэмдгүүд ихэвчлэн

тэдгээрт түгшүүр, нойргүйдэл, хоолны дуршил буурах, өндөр даралт, төөрөгдөл, хуурамч дүр төрх, ухамсрын түвшин өөрчлөгдөх, сандрал, халуур, болон төөрөгдөлт итгэлүүд орно.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв болон** таталтын делириумтэй холбоотой олдворуудад анхаарлаа төвлөрүүл. Бүх сонголтыг анхааралтай хянаж, тухайн сонголтын бүх шинж тэмдэг зөв эсэхийг баталгаажуул. Хүчийн даралт буурах бус харин өндөрлөх тул эхлээд 1, 3-р сонголтыг хас. Үлдсэн сонголтуудаас манангүй байдалтай өвчтөн таталтын делириум илэрч магадгүйг санаж, зөв сонголтыг ол.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Өвчтөний хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Донтолт

Эрэмбэлэх гол ойлголтууд: Донтолт; Клиникийн шийдвэрлэл

Дүрийн ишлэл: Varcarolis (2017), 303-р тал.

825. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Хамгийн тустай хариу бол үйлчлүүлэгчийг асуудлаа шийдвэрлэхэд урамшуулдаг хариу юм. Зөвлөгөө өгөх нь сувилагч хамгийн сайн гэж үзэж, үйлчлүүлэгчийг хамааралтай болгодог. Сувилагч үйлчлүүлэгчтэй санал нийлэх ёсгүй бөгөөд тайлбар хүсэх ёсгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: *"most"* гэсэн **стратегийн үгийг** анхаар. **Эмчилгээний харилцааны техник** ашигла**.** Харилцаанд зайлсхийх ёстой "*яагаад*" гэдэг үг байгаа тул 1-р сонголтыг хас. Клиентийн мэдрэмжийг түр хойш тавьдаг тул 3-р сонголтыг хас. Сувилагч нь клиенттэй санал нийлж байгаа тул 4-р сонголтыг хас. Зөв сонголт нь зөвхөн клиентийн мэдрэмжийг авч үзсэн ганцхан сонголт юм.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Донтолт ***Гол ойлголтууд:*** Асран халамж; Харилцаа ***Дүрийн лавлагаа:*** Varcarolis (2017), 97–98, 302-р тал.

826. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Биеийн дүрсийн алдагдал нь анорексиа нервозатай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл асуудал юм. Үйлчлүүлэгч хоёрдмол сэтгэл хөдлөлтэй байж, ухралттай зан үйл гаргаж болох ч түүний зохицох арга барил нь биеийн дүрсийн алдагдалтай холбоотой үндсэн асуудалтай холбоотой байдаг. Сувилагч энэ хэрэгцээг дэмжлэгийн бүлэгт шийдвэрлэх ёстой.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв болон** биеийн дүрсийн алдагдлын шинж тэмдгүүдийг тэмдэглэ. Асуулга дахь мэдээлэл болон зөв хариултын хоорондын харилцааг тэмдэглэ.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Үнэлэх

Өвчтөний хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн нийгмийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хооллолтын эмгэгүүд
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Сэтгэл түгшилт; Даван туулах чадвар
Дорнод: Varcarolis (2017), 184-185-р хуудас.

БҮЛЭГ 67

Хямралын онол ба оролцоо

http://evolve.elsevier.com/Silvestri/comprehensiveRN/

Эрэмбэлсэн ойлголтууд

Даван туулах; Хүмүүсийн хоорондын хүчирхийлэл

I. Хямралд хөндлөнгөөс оролцох

A. Тайлбар

1. **Хямрал** гэдэг нь аюул заналхийлэл үүсгэсэн үйл явдлын улмаас үүссэн хүчтэй сэтгэл хөдлөлийн түр зуурын эмх замбараагүй байдал юм.
2. Хүн бүр хямралыг туулдаг; үр дүн нь тухайн үед ашиглаж чадах дасан зохицох механизм болон дэмжлэгийн тогтолцооноос хамаарна.
3. Шийдвэр гаргах, асуудал шийдвэрлэх чадвар хангалтгүй байдаг.
4. Эмчилгээ нь үйлчлүүлэгч болон түүний гэр бүлийг энэ стресстэй нөхцөл байдлаар даван туулахад нь туслахад чиглэнэ.

B. Хямралын үе шат

1. Шат 1: Гадаад өдөөгч үйл явдал (байдалтай, хөгжлийн, соёлын эсвэл нийгмийн шинжтэй байж болно)
2. 2-р үе шат
   a. Аюулын ухамсар
   b. Сэтгэл түгших байдал нэмэгдэх
   c. Клиент хямралыг даван туулах эсвэл шийдвэрлэх боломжтой.
3. 3-р үе шат
   a. Даван туулах чадварын алдагдал
   b. Зохион байгуулалт алдагдах
   c. Бие махбодийн шинж тэмдгүүд илрэх
   d. Харилцааны асуудлууд
4. 4-р үе шат
   a. Дотоод болон гадаад нөөцийг дайчлах
   b. Зорилго нь үйлчлүүлэгчийг хямралын өмнөх түвшиндээ буюу түүнээс доогуургүй ажиллах чадвартай болгох явдал юм.

C. Хямралын төрөл (Бох 67-1)

D. Хямралын үеийн оролцоо

1. Эмчилгээ нь яаралтай, дэмжлэгтэй, шууд хямралд хариу үйлдэл үзүүлдэг.
2. Мэргэжлийн хоорондын эрүүл мэндийн баг нь хямралд орсон хүмүүст даван туулахад нь тусалдаг; оролцоо нь зорилго чиглэсэн байдаг.
3. Клиентийн мэдрэмжийг хүлээн зөвшөөрдөг.
4. Оролцоо нь сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх, хүлээн зөвшөөрүүлэх боломжийг олгодог.
5. Тохиолдлын утга учир болон хямралын хооронд холбоо тогтоодог.
6. Клиент өөр аргаар даван туулах аргуудыг судалж, шинэ зан үйлүүдийг туршиж үздэг.

II. Гэмшил

A. Гэмшил бол алдагдлыг хүлээн зөвшөөрөх гэж оролдож буй хүмүүст зайлшгүй даван туулах ёстой байгалийн сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэл юм.

B. Гэмшил ихэвчлэн гашуудлыг шийдвэрлэхэд туслах хэд хэдэн шат эсвэл даалгаврыг даван туулахыг шаарддаг (67-2 дугаар хайрцаг).

C. Алдагдлын төрлөөс хамааран гашуудалтай холбоотой мэдрэмжүүдэд уур хилэн, бухимдал, ганцаардал, гуниг, гэмшил, харамсал, амар амгалан байдал орно.

D. Өвдөлт намдаж, хүн алдалтад дасан зохицсон үед эдгэрэлт явагддаг; хэрвээ гашуудал хайртай хүнийхээ алдагдаас үүдсэн бол хүн нас барсан хүний дурсамжийг үргэлжлүүлэн мэдэрсээр байдаг.

E. Гэмшлийн төрөл

1. Ердийн гашуудал: Бие махбодийн, сэтгэл хөдлөлийн, танин мэдэхүйн, оюун санааны эсвэл зан үйлийн хариу үйлдэл илрэх боломжтой; шийдвэрлэх үйл явц нь хэдэн сараас хэдэн жил хүртэл үргэлжилж болно.
2. Урьдчилсан гашуудал нь хайртай хүнийхээ алдагдлаас өмнө үүсч, хурц, архаг эсвэл төгсгөлгүй өвчтэй холбоотой байдаг.
3. Хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй гашуудал нь хайртай хүнийхээ алдагдлыг мэдэрсэн ч үүнийг ил тодоор хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байх үед үүсдэг (нийгмийн хэвшмэл үзэл санаа энэ алдагдлыг уламжлалт утгаар нь алдагдал гэж тодорхойлдоггүй).
4. Гэм буруутай гашуудал нь удаан хугацааны сэтгэл хөдлөлийн тогтворгүй байдал болон алдагдалд амжилттай дасан зохицох явцгүйгээр үүсдэг.
5. Хүүхдүүдийн гашуудал нь хүүхдийн хөгжлийн түвшинд суурилдаг (67-3-р хайрцаг).

III. Алдагдал

A. Алдагдал гэдэг нь хүссэн эсвэл өмнө нь боломжтой гэж үзэж байсан зүйл байхгүй болсон байдал юм.

B. Бодит хохирлыг бусад хүмүүс тодорхойлж чаддаг бөгөөд нөхцөл байдалд хариу үйлдэл болгон эсвэл урьдчилан таамаглаж үүсч болно.

C. Сэтгэлд мэдрэгдсэн хохирол нь зөвхөн нэг хүнд мэдрэгддэг бөгөөд бусад хүмүүсээр баталгаажиж чадахгүй.

D. Урьдчилсан хохирол нь хохирол тохиолдохоос өмнө мэдэрдэг.

E. Гашуудал

1. Гашуудал нь алдагдлыг гадаад, нийгмийн түвшинд илэрхийлэх хэлбэр юм.
2. Гашуудал нь соёлын, сүнслэг болон шашны итгэл үнэмшлээр тодорхойлогдож болно.

F. Гашуудал

1. Гашуудал нь хохирол амссан хүний дотоод мэдрэмж болон гадаад хариу үйлдлийг багтаана.
2. Гэмшил нь гашуудал болон гашуудлын ёслолыг багтаана.

IV. Сувилагчийн үүрэг: Гэмшил ба алдагдал (67-4 дүгээр хайрцаг)

A. Өвчтөнд итгэлцэлтэй, дэмжлэгтэй, шүүмжлэлгүй орчинд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхийг урамшуулах.

B. Бүрэн мэдээлэлд суурилсан сонголтуудыг хийх тасралтгүй боломжийг олгох.

C. Гэмшил гашуудлын үйл явцыг хөнгөвчлөх; хувь хүний гашуудлыг үнэлж, түүнд алдагдлыг нь мэдрэхэд болон гашуудлын үйл явцын даалгавруудыг биелүүлэхэд нь туслах.

D. Гэмшил нь хүний бие махбодь, сэтгэлзүйн, нийгмийн болон сүнслэг байдлаар нөлөөлдөг; гашуудал судлалын мэргэжилтэн зэрэг олон мэргэжлийн багийн арга барил нь гэмшлийн процессыг хөнгөвчилдөг.

Сувилагчийн гашуудал, алдагдлын үйл явцад гүйцэтгэх үүрэгт харилцаа холбоо тогтоох үйлчлүүлэгч, гэр бүлийн гишүүд болон чухал бусад хүмүүстэй харилцах. Сувилагч нь тухайн хүний соёл, сүнслэг байдал, шашин шүтлэг, гэр бүлийн бүтэц, амьдралын туршлага, даван туулах чадвар болон дэмжлэгийн тогтолцоог харгалзан үзэх ёстой.

V. Өөрийгөө хорлох зан үйл

A. Тайлбар

1. Өөрийгөө алах хүсэлтэй үйлчлүүлэгчид ихэвчлэн үнэ цэнэгүй, гэм буруутай, найдваргүй мэт мэдрэмжүүд нь маш хүчтэй тул амьдралаа үргэлжлүүлэх боломжгүй, амьдрахад тохиромжгүй гэж үздэг.
2. Депрессийн өвчтөнд асаргаа үзүүлж буй сувилагч үргэлж **амиа хорлох** боломжийг харгалзан үздэг.

B. Эрсдэлд өртөх хүмүүс

1. Өмнө нь амиа хорлох оролдлого хийж байсан үйлчлүүлэгчид
2. Гэр бүлийнхний **амиа хорлох оролдлогын** түүх
3. Өсвөр насныхан
4. Ахмад настнууд
5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцсийн шатандаа орсон өвчтэй үйлчлүүлэгчид
6. Зан төлөвийн эмгэгтэй үйлчлүүлэгчид
7. Органик тархины синдром эсвэл деменцтэй үйлчлүүлэгчид
8. Депрессив эсвэл психотик үйлчлүүлэгчид (65-р бүлгийг үзнэ үү

депрессийн талаарх мэдээлэл)

9. Мансууруулах бодис хэтрүүлэн хэрэглэгчид
10. Тэдгээр нь хамт насныхаа хүмүүс болон нийгмээс тогтмол дээрэлхүүлж, няцаагдсан хүмүүс
11. Хүүхэддээ хүчирхийлэл үзүүлсэн түүх
12. Өмнөх сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн түүх

C. Дохио (67-5 хайрцаг)

D. Үнэлгээ (67-6 хайрцаг)

E. Оролцоо

1. Өөрийгөө хорлох санаа болон төлөвлөгөөг үнэлж, хорлолтоос сэргийлэх арга хэмжээ авч эхлэх.
2. Клиентийн мэдэгдэл, үйлдэл, сэтгэл хөдлөл бүрийг 15 минут тутамд тэмдэглэнэ.
3. Хоруу зүйлсийг зайлуул.
4. Клиентийг ганцааранг нь бүү орхи.
5. Шүүмжлэлгүй, халамжтай хандлага баримтал.
6. Агентлагийн журам, бодлогын дагуу бичиг баримтжуулсан, огноо заасан, гарын үсэг зурсан амиа хорлохгүй байх гэрээ боловсруулж, амиа хорлох бодол төрөх үед хэрэглэх өөр зан үйлдлийг зааж, амиа хорлох бодол төрөхөд сувилагчид мэдэгдэхээ тусган бичнэ.
7. Клиентийг өөрийнхөө мэдрэмжийн талаар ярилцаж, өөрийнхөө эерэг талуудыг тодорхойлоход нь урамшуулах.
8. Өөрийн асрамжийн үйл явцад идэвхтэй оролцохыг урамшуулах.
9. Хэрэгжүүлэх боломжтой даалгавруудыг өгч үйлчлүүлэгчийг идэвхтэй байлга.
10. Зочид үйлчлүүлэгчийн өрөөнд хор хөнөөлтэй зүйлс үлдээхгүйг шалгана.
11. Дэмжлэгийн тогтолцоог тодорхойл.
12. Үйлчлүүлэгчийг ажилтны хамт явахгүй бол тасаг, хэсгээс гарахыг зөвшөөрөхгүй.
13. Клиентийн амиа хорлох эрсдлийг үнэлсээр байх.

Эрсдэлд өртөж буй үйлчлүүлэгчид бүх цаг үед нэг-нэг хяналт тавьж ажиллах өөрийгөө хорлох эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчид.

VI. Хүчирхийллийн зан үйл

A. Уур хилэн

1. Уур хилэн нь бухимдал, дургүйцлийн мэдрэмж бөгөөд үүнийг биед бус зүйл эсвэл хүнд шилжүүлж болно.
2. Уур нь түгшүүрээс зайлсхийхэд ашиглагддаг бөгөөд хүн хяналтаа алдсан мэт санагдах нөхцөлд хүчирхэг байдлын мэдрэмжийг төрүүлдэг.

B. Агресс хяналтгүй бол хор хөнөөлтэй, сүйтгэх шинжтэй байж болно.

C. Хүчирхийлэл нь өөрийн болон бусдын аюулгүй байдалд заналхийлэх бие махбодийн хүч юм.

D. Үнэлгээ

1. Хүчирхийлэл үйлдэх эсвэл өөрийгөө гэмтээх түүх
2. Өөрийн хөдөлгөөнийг хянах чадвар муутай, бухимдлыг тэсвэрлэх чадвар сул
3. Эсэргүүцэлтэй, маргаантай
4. Дуу хоолой өндөрлөх
5. Аман сүрдүүлэг хийх
6. Явж зогсох ба сандрал
7. Булчингийн хатууралт
8. Царай улайх
9. Бусдыг ширүүн ширтэх

E. Оролцоо

1. Аюулгүй, цөөн өдөөлттэй орчныг хангана.
2. Тайван хандлага баримталж, тайван, тод хоолойгоор харилцаарай (зөрүүд биш, дайсагналгүй, үгийн маргаанаас зайлсхий).
3. Өөрийн хувийн зайг их байлгаж, дайсагналгүй биеийн байрлалтай бай (жишээ нь, гар, бугуйгаа цээжин дээрээ нийлүүлэх эсвэл ташаан дээрээ тавихын оронд биеийн хажуу талд байлгах).
4. Идэвхтэй сонсож, үйлчлүүлэгчийн уурыг хүлээн зөвшөөр.
5. Клиент өөрийн хэрэгцээ гэж юуг үзэж байгааг тодорхойл.
6. Клиентийн зан байдалд хамааралтай тодорхой сонголтуудыг санал болгож, зан байдалд хязгаар тогтоож, уур хилэн болон хүчирхийллийн үр дагаврыг түүнд ойлгуул.
7. Хэрэв үйлчлүүлэгч уур хилэнгээ хянаж чадахгүй, хүчирхийлэлд хүргэж болзошгүй бол **барьж саатуулах хэрэгсэл (аюулгүйн төхөөрөмж)** эсвэл **тусгаарлах арга хэмжээ** авах талаар ярилцана.
8. Клиенттэй сонголтуудтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахад туслах.

F. Хязгаарлалтууд (аюулгүйн төхөөрөмжүүд) ба тусгаарлалт

1. Тайлбар
   a. Физик хязгаарлалт: Хүний биеийн үйлдэл, хөдөлгөөнийг чөлөөтэй хязгаарлах ямар ч физик эсвэл орчны арга хэмжээ
   b. Ганцаарчилсан тусгаарлалт: үйлчлүүлэгчийг хамгаалалт, нягт хяналт тавих зориулалттай тусгай өрөөнд хорьж, чөлөөтэй гарах боломжгүй болгодог хязгаарлалтын нэг төрөл.
   c. Химийн хязгаарлалт: тодорхой зан үйл эсвэл хөдөлгөөнийг саатуулах зорилгоор өгөгдсөн эм бэлдмэлүүд ба

энэ нь үйлчлүүлэгчийн орчинтой харилцах чадварт нөлөөлдөг

2. Хязгаарлалт ба тусгаарлалтыг ашиглах

a. Хязгаарлалт болон тусгаарлалтыг шийтгэл болгон эсвэл эрүүл мэндийн ажилтнуудын ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор хэзээ ч ашиглаж болохгүй.

b. Хязгаарлалт ба тусгаарлалт нь хэрэглэгчид эсвэл бусдад бие махбодийн хувьд хор хөнөөл учруулж болзошгүй үед, мөн хэрэглэгчид болон бусдыг хор хөнөөлөөс хамгаалахад өөр арга хэмжээ эсвэл бага хязгаарлагдмал арга хэмжээ хангалтгүй бол ашиглана.

c. Хязгаарлалт ба тусгаарлалт нь [illegible]ийн баг хяналттай орчин тустай гэж үзэж, хязгаарлах арга хэмжээ эсвэл тусгаарлахыг хүссэн тохиолдолд ашиглана.

d. Сувилагч нь хязгаарлах эсвэл тусгаарлах арга хэмжээ авах болсон зан үйлийг бичиж тэмдэглэх ёстой.

e. Ихэнх тохиолдолд хязгаарлах арга хэмжээ авахын өмнө анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийн жор шаардлагатай.

f. Яаралтай үед мэргэшсэн сувилагч үйлчлүүлэгчийг хязгаарлах эсвэл тусгаарлаж, дараа нь аль болох хурдан бичгээр эсвэл аман жор авна.

g. Улсын зааварчилгааны дагуу хязгаарлалт эсвэл тусгаарлалт эхэлснээс хойш нэг цагийн дотор сэтгэл мэдрэлийн эмч нь үйлчлүүлэгчийг нүүр тулан үнэлж, дүгнэлт хийж, хязгаарлалт эсвэл тусгаарлалтыг үргэлжлүүлэх шаардлагыг тасралтгүй дахин үнэлж байх ёстой.

h. Хязгаарлалт эсвэл тусгаарлалтад байх үед үйлчлүүлэгчийг бүх төрлийн хор хөнөөлөөс хамгаалах ёстой.

i. Хязгаарлагдсан эсвэл [illegible]арлах үед тасралтгүй нэг-нэг хяналт шаардлагатай; бие махбодийн, аюулгүй байдлын болон тав тухын хэрэгцээг 15–30 минут тутамд үнэлж, эдгээр ажиглалтыг бичиж тэмдэглэнэ

(жишээ нь хоол хүнс, шингэн зүйлс, ариун цэврийн өрөөний хэрэгцээ, хөдөлгөөний дасгал, алхах)

j. Сувилагч нь хязгаарлах хэрэгсэл ашиглахтай холбоотой байгууллагын журам, бодлогыг үргэлж дагаж мөрдөж, ахмад болон өсвөр насныханд тэдгээрийг хэрэглэх талаар мэдлэгтэй байх ёстой.

Хязгаарлах хэрэгслүүдийг ...-ийн бичгээр өгсөн жороор олгодог анхны эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс бичгээр олгосон жор шаардлагатай бөгөөд үүнийг агентлагийн бодлого, журамд зааснаар хянаж, шинэчлэх ёстой; жор нь ашиглах боолтын төрөл, боолт эсвэл тусгаарлах хугацаа, суллах шалгуурыг тодорхой заасан байх ёстой (агентлагийн бодлого, журмыг дагаж мөрдөх шаардлагатай).

VII. Дээрэлхэл

A. Дээрэлхэл гэдэг нь нэг хүн нөгөө хүнийхээ эсрэг давтан түрэмгий үйлдэл хийж эрх мэдлээ **хэтрүүлэн ашиглах** явдал юм.

B. Энэ нь ихэвчлэн хүүхдүүд болон ахлах сургууль, коллежийн орчинд тохиолддог ч ажлын байр болон бусад орчинд ч гарч болно.

C. Дээрэлхэгч нь биеийн хүч, нас бие гүйцэх байдал эсвэл найз нөхдийн дунд өндөр статустай байх, хохирогчийн сул талыг мэдэх, бусдын дэмжлэг зэрэг эх үүсвэрээс хүчээ авдаг.

D. Дээрэлхэл нь бие махбодийн хохирол, харилцааны түрэмгийлэл, тусгаарлалт ба хасалт, гүтгэлэг, цуу яриа эсвэл сүрдүүлэг зэрэг үг хэлээр хохирол учруулах хэлбэрээр илэрч болно; энэ нь зориудаар хэрцгий бөгөөд шалтгаангүй байдаг.

E. Кибер дээрэлхэл бас дээрэлхлийн нэг хэлбэр бөгөөд энэ нь нийгмийн сүлжээн дэх интернет зурвас, мессеж, цахим шуудан, зураг байршуулах болон цуу яриа хэлбэрээр илэрдэг.

F. Дээрэлхүүлсэн хүн дээрэлхэгч(дүүд)-ээс давтагдсан байдлаар сөрөг үйлдлүүдэд өртдөг.

G. Эдгээр дээрэлхлийн үйлдлүүд нь хохирогчид сэтгэл гутрал, өөртөө итгэх итгэл буурах, доромжлол, тусгаарлагдах, нийгмээс татгалзах зэрэг сөрөг үр дагавруудыг үүсгэж; зүсэх, амиа хорлох, аллага үйлдэх зэрэг өөртөө хохирол учруулах хүртэл хүргэж болно.

H. Сувилагчийн үүрэг бол дээрэлхлийн шинж тэмдгүүдийг ажиглаж, багш, сургуулийн удирдлага болон эцэг эхчүүдэд дээрэлхлийн зан үйл болон дээрэлхэл явагдаж байж болзошгүй шинж тэмдгүүдийн талаар сургах явдал юм.

VIII. Гэр бүлийн хүчирхийлэл

A. Тайлбар (Зураг 67-1)

1. Хүчирхийлэл нь заналхийллээс эсвэл аман болон бие махбодийн жижиг халдлагаас (хүчтэй байдал нэмэгдэх) эхэлж, хохирогч нь зөрчигчийн шаардлагыг биелүүлэхээр ороллдог.

2. Хүчирхийлэгч хяналтаа алдсанаар сүйтгэх үйлдэл хийдэг бөгөөд

хор хөнөөлтэй (хүчтэй цохилт), харин хохирогч өөрийгөө хамгаалахыг оролддог.

3. Хүчирхийлэл үйлдсэний дараа доромжлогч энэрэнгүй болж, тайван байдлыг сэргээх, хурцадмал байдлыг намжаах зорилгоор эвлэрэх оролдлого хийдэг; сөрөг үйлдлээ залруулахын тулд бэлэг өгч, хохирогчид эерэг анхаарал хандуулдаг.
4. Хүчирхийлэгч хүчирхийллийг хэвийн үзэгдэл гэж үздэг бөгөөд хохирогчийг хүчирхийллийн буруутан гэж буруутгадаг.
5. Гэр бүлийн гаднах хүмүүс ихэвчлэн гэр бүлийн дотор юу болж байгааг мэддэггүй.
6. Гэр бүлийн гишүүд нийгмийн хүрээнд тусгаарлагдсан, бие даасан байдал, итгэлцэлгүй; гэр бүлийн халамж, дотно харилцаа байхгүй.
7. Гэр бүлийн гишүүд бусад гишүүдээс өөрсдийн хэрэгцээг хангахыг хүлээдэг ч хэн нь ч үүнийг биелүүлж чаддаггүй.
8. Хүчирхийлэгч гэр бүлээсээ гарч явна гэж сүрдүүлдэг.

B. Хүчирхийллийн төрөл (67-7 дугаар хайрцаг)

C. Суль дорой хүн (хохирогч)

1. Эмзэг хүн гэдэг нь гэр бүлийн нэгжийн хүрээнд хүчирхийлэлд өртсөн хүн юм.
2. Хамгийн эмзэг хүмүүс нь хүүхдүүд болон ахмад настнууд юм.
3. Хүчирхийлэл үйлдэгч болон хүчирхийллийн золиос нь эрэгтэй эсвэл эмэгтэй байж болно.
4. Битүү мөргөх нь гэмт хэрэг юм.

D. Хүчирхийлэгчдийн онцлог шинжүүд

1. Өөртөө итгэх итгэл сул
2. Хүчтэй хамааралтай хэрэгцээ
3. Нарциссист ба сэжигтэй
4. Хүүхэд насны хүчирхийллийн түүх
5. Хохирогчдыг өөрийн өмч мэтээр харж, тэднийг доромжлох эрхтэй гэж үздэг

E. Хохирогчдын онцлог шинжүүд

1. Зарим нь хамааралтай зан төлөвийн эмгэгтэй байж болно
2. Багтсан, хамааралтай, тусламжгүй, эрх мэдэлгүй мэт мэдрэх
3. Хүчирхийлэгчийн эрх мэдэл, хяналтын тойрогт баригдсанаас сэтгэл гутралд орох магадлалтай (зураг 67-1-ийг үзнэ үү)
4. Үргэлжилсэн хүчирхийллийн улмаас хохирогчдын өөртөө итгэх итгэл буурч, тэд хүчирхийлэлд өөрсдийгөө буруутгаж, нөхцөл байдлаас гарах гарц олж чадахгүй болдог.

F. Оролцох арга хэмжээ

1. Хүүхэд эсвэл ахмад настны эсрэг хүчирхийллийн сэжигтэй болон бодит тохиолдлыг холбогдох байгууллагад мэдэгдээрэй

(муж болон агентлагийн зааварчилгааг дагана уу).

2. Холбогдох бэлгийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллийн (SADV) баг эсвэл бусад зохих байгууллагын багт хандуулах
3. Бие махбодийн гэмтлийн нотлох баримтыг үнэлнэ.
4. Үнэлгээний явцад нууцлал, хувийн орон зайг хангаж, шүүмжлэлгүй, өрөвч сэтгэлтэй хандлагаар итгэлийг бэхжүүл; хохирогчид буруу зүйл хийгээгүй гэдгийг нь итгүүл. 67-8 дугаар хайрцагт үнэлгээний асуулгын жишээг жагсаасан.
5. Хохирогчид өөрийгөө хамгаалах болон бусад асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэхэд нь туслах.
6. Хохирогч нөхцөл байдлаас гарах бэлэн биш байсан ч түүнийг тодорхой аюулгүй байдлын төлөвлөгөө (хэрвээ хүчирхийлэл давтагдвал хурдан зугтах) боловсруулахад урамшуулж, тусламж хаанаас авах талаарх мэдээлэл (утсаар холбогдох дугаар, аюулгүй байр, хоргодох байр) өг; хүчирхийлэлд өртсөн хүн ихэвчлэн цагдааг дууддаггүй.
7. Хохирогчийн амиа хорлох эрсдэлийг үнэл.
8. Аллагын эрсдэлийг үнэлнэ.
9. Мансууруулах болон согтууруулах ундаа хэрэглэх байдлыг үнэл.
10. Гэр бүлийн даваа туулах хэв маяг болон дэмжлэгийн тогтолцоог тодорхойлох.
11. Хууль сахиулах байгууллагатай холбогдох явцад тулгарч буй асуудлыг даван туулахад дэмжлэг, тусламж үзүүлэх.
12. Тогтоосон эмчилгээний аргаар гэр бүлийн доголдлыг шийдвэрлэхэд туслах.
13. Хохирогчид зориулсан хувь хүний эмчилгээг дэмжиж, сэтгэл зүйн цочролыг даван туулах, цаашдын сэтгэл зүйн зөрчилдөөнөөс сэргийлэхэд чиглүүлнэ.
14. Хүчирхийлэгчийн хувь хүний эмчилгээг дэмжиж, хүчирхийлэл үйлдэхээс сэргийлэх, харилцааг нөхөн сэргээхэд чиглүүлнэ.
15. Гэр бүлийн гишүүдэд даван туулах стратеги боловсруулахад нь туслахын тулд сэтгэл засал, зөвлөгөө, бүлгийн эмчилгээ болон дэмжлэгийн бүлгүүдийг дэмжихийг уриална.
16. Гэр бүлд олон нийтийн болон хувийн нөөц бололцоонд хандах боломжийг тодорхойлоход туслах.
17. Эрүүл мэндийн нарийвчилсан, бүрэн гүйцэтгэсэн эмнэлгийн бүртгэлийг хөтлөх.

IX. Хүүхэд хулгайлах

A. Тайлбар

1. Хүүхэд хулгайлах гэдэг нь насанд хүрсэн хүн хүүхдийг (эсвэл нярайг) хулгайлах явдал юм.
2. Тохиолдол
    a. Танихгүй хүн хүүхдийг гэмт хэрэгт ашиглах эсвэл хорон санаатай зорилгоор хулгайлах тохиолдол гардаг.
    b. Танихгүй хүн хүүхдийг (эсвэл

нярай) хүүхдийг өөрийн хүүхэд мэт өсгөх зорилгоор хулгайлах.

c. Эцэг эсвэл эх нь хүүхдийг нөгөө эцэг эсвэл эхийн асран хамгаалалтаас авч эсвэл үлдээдэг (ихэвчлэн салалтын явцад эсвэл дараа).

3. ...-ээс үүдсэн нэмэгдсэн бие даасан байдлын улмаас

д цэцэрлэгийн насны үед бие даах чадвар нэмэгддэг тул эцэг д өмнө нь үзүүлдэг байсан тасралтгүй хамгаалалтыг үзүүлэх боломжгүй болдог; хамгаалалтыг хангах (хүүхдэд заахыг оролцуулан) арга хэмжээ зайлшгүй шаардлагатай.

4. Хүчирхийллийн эрсдэлийг илрүүлэхэд туслах асуултууд: "Чи хамгийн их хэнтэйгээ тоглодог вэ? Чи хэнтэй тоглох дургүй вэ? Чи ямар тоглоом тоглох дургүй вэ?"

B. Оролцоо

1. Эцэг эхэд дараах зүйлсийг агуулсан хувийн аюулгүй байдлын үндсэн зааврууудыг хүүхдэд зааж өгөхийг зааварла:
   a. Ганцаараа хаашаа ч битгий яв.
   b. Хаашаа яваа болон хэзээ буцахыг үргэлж насанд хүрсэн хүнд хэлж бай.
   c. Хэрвээ ямар нэг нөхцөл байдал танд таалагдахгүй, эвгүй санагдвал "*үгүй*" гэж хэл.
   d. Хэрвээ ямар нэг насанд хүрсэн хүн эцэг/эхийн тань зөвшөөрөлгүйгээр танд ямар нэгэн зүйл санал болговол холдож, үгүй гэж хэлж, хэн нэгэнд хэлээрэй.
   e. Хэрвээ ямар нэг насанд хүрсэн хүн эцэг эхийн тань зөвшөөрөлгүйгээр тусламж хүсвэл холдож, үгүй гэж хэлж, хэн нэгэнд хэлээрэй.
   f. Хэрвээ ямар нэг насанд хүрсэн хүн чамаас нууцлахыг хүсвэл үгүй гэж хэлээд холдож, дахин үгүй гэж хэлээд хэн нэгэнд хэлээрэй.
   g. Алдагдсан нохой эсвэл муур хайхад хэнд ч туслаж болохгүй, танихгүй хүнээс чихэр эсвэл бэлэг бүү хүлээн аваарай.
   h. Хэрвээ дэлгүүрт төөрвөл эцэг эхийгээ хайж тойрон гүйхгүй, шууд ажилтанд эсвэл харуулд хандаарай.
2. Хүүхдүүд өөрийн бүрэн нэр, хаяг, эцэг эхийнхээ нэр, утасны дугаарыг мэдэж байх хэрэгтэй.
3. Хүний хулгайд өртсөн ямар ч хүүхдэд сэтгэл зүйн хүнд цочролын дараах сэтгэл зүйн хямралын шинж тэмдгүүд илэрч байгааг анхааараарай.

X. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл

A. Тайлбар

1. Хүчирхийлэл гэдэг нь эцэг эх эсвэл хүүхдийн асран хамгаалагчийн санаатайгаар бие махбодийн гэмтэл учруулах эсвэл асран халамжлах үүргээ санаатайгаар үл биелүүлэх үйлдэл бөгөөд хүчирхийлэлд орхигдуулалт, бие махбодийн, бэлгийн болон сэтгэл зүйн хүчирхийлэл орно.
2. Халамжгүй байдал нь бие махбодийн эсвэл сэтгэл зүйн халамжгүй байдлын хэлбэрээр илэрч, хүүхдийн үндсэн хэрэгцээг хангах, хяналт тавих, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх, боловсрол олгох болон анхаарал, хайр халамжийн хэрэгцээг хангахад дутагдалтай байдаг.
3. Бэлгийн хүчирхийлэлд ойр дотны хүний бэлгийн харьцаа (инцест), бэлгийн дарамт (molestation), үзүүлбэр үзүүлэх (exhibitionism), порнографи, биеэ үнэлэлт, педофили зэрэг орно; бэлгийн хүчирхийллийн улмаас үүссэн шинж тэмдгүүд хүүхдэд амархан илэрдэггүй.
4. Чичирхийлсэн нярайн хам шинж нь нярайг хүчтэй чичирхийлснээс үүдэлтэй тархины доторх (ихэвчлэн судрал цус алдалт) гэмтэл бөгөөд энэ нь тархины хавагналт үүсгэж, үхэлд хүргэж болно.

B. Үнэлгээ (67-9-р хайрцаг)

C. Оролцоо

1. Хүүхдийг нарийвчилсан биеийн үзлэгийн явцад дэмжлэг үзүүлэх үнэлгээ.
2. Гэмтлийг үнэл.
3. Хэрэв сэгсэрсэн нярайны хам шинж сэжиглэгдвэл ухамсарын түвшин буурахыг хянах; энэ нь тархины дотоод даралт (ICP) нэмэгдсэнийг илтгэж болно.
4. Эрүүл мэндийн ажилтнууд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн сэжигтэй бүх тохиолдлыг холбогдох орон нутгийн эсвэл улсын байгууллагад хууль ёсоор мэдээлэх үүрэгтэй.
5. Хүүхдийг аюулгүй орчинд байрлуулж, цаашдын гэмтлээс сэргийл.
6. Сэжиглэгдсэн хүчирхийллийн талаархи мэдээллийг бодитой, хөндлөнгийн байдлаар баримтжуулна.
7. Эцэг эхийн давуу болон сул тал, хэвийн давахад ашигладаг арга механизм, дэмжлэгийн тогтолцоо байгаа эсэхийг үнэл.
8. Гэр бүлд стресстэй хүчин зүйлс, дэмжлэгийн тогтолцоо болон нөөц бололцоог тодорхойлоход туслах.
9. Гэр бүлийг зохих дэмжлэгийн бүлгүүдэд чиглүүлнэ.

Сувилагч нар нь сэжиглэгдсэн бүх тохиолдлыг хууль ёсоор мэдээлэх үүрэгтэй хүүхэд эсвэл ахмад настны эсрэг хүчирхийллийн бүх сэжигтэй тохиолдлыг холбогдох орон нутгийн эсвэл улсын агентлагт хууль ёсоор мэдээлэх үүрэгтэй; улсын хууль, журам харилцан адилгүй байж болох бөгөөд тэдгээрийг үргэлж дагаж мөрддөг.

XI. Гэртээ ганцаараа үлддэг хүүхдүүд

A. Тайлбар

1. Сургууль эхлэхээс өмнө эсвэл сургууль тарахад насанд хүрэгчийн хараа хяналтгүй үлддэг хүүхдүүд; энэ хугацаанд тэд өөрсдийгөө асран хариуцдаг.
2. Энэ нь хүүхдүүд ганц эцэг/эхтэй гэр бүлийн гишүүн байх эсвэл хоёр эцэг/эх нь хоёулаа ажиллаж, хүүхдүүдээ сургууль руу хүргэхээс өмнө эсвэл сургууль тараад гэртээ ирэхээс өмнө гэрээс явах шаардлагатай үед тохиолддог.
3. Энэ нөхцөл байдал нь хүүхдүүдэд стресстэй орчныг бүрдүүлж, тэднийг аюултай нөхцөл байдал, гэмтэл бэртэл болон зөрчилтэй зан үйлд өртөх эрсдэлд оруулдаг.

B. Хөндлөнгийн арга хэмжээ

1. Гэрийн түлхүүртэй хүүхдийг тодорхойл.
2. Эцэг эхэд хүүхдэдээ өөрийгөө асрах, туслах чадварыг зааж сургахыг уриалах.
3. Эцэг/эхэд хүүхдийг ганцааранг нь орхих бусад боломжит хувилбаруудыг тодорхойлоход туслах.
4. Эцэг эхэд хүүхдэд зориулсан сургууль дараах хөтөлбөрүүд зэрэг орон нутгийн боломжит нөөцийн талаар мэдээлэх.

XII. Ахмад настны эсрэг хүчирхийлэл

A. Тайлбар

1. Ахмад настны эсрэг хүчирхийлэл нь бие махбодийн, сэтгэлзүйн эсвэл бэлгийн хүчирхийлэл; халамжгүй орхигдуулалт; болон эдийн засгийн мөлжлөгийг агуулна.
2. Хамгийн их эрсдэлд өртөх нь өвчин, хөдөлгөөний бэрхшээл эсвэл оюун ухааны өөрчлөлтөөс шалтгаалан бусдаас хамааралтай болсон хүмүүс юм.

3. Хүчирхийлэл, халамжгүй байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлс

[illegible]удаан хугацааны гэр бүлийн хүчирхийлэл, асрагчийн стресс, ахмад настны бусдаас улам бүр хамааралтай болж буй байдал орно.
4. Хохирогчид гэмтлээ санамсаргүй мэтээр няцаахыг оролдох ба, хүчирхийлэгчид илчлэгдэхээс сэргийлэхийн тулд хохирогчдод зохих эмнэлгийн тусламж авахаас нь сэргийлдэг.
5. Хохирогчдыг ихэвчлэн доромжлогч нь нийгмээс тусгаарладаг.

B. Үнэлгээ

1. Бие махбодийн хүчирхийлэл
   a. Уналт, үе мөчний гажилт эсвэл ясны хугарал
   b. Абрази, хөхрөлт эсвэл зүсэлтүүд
   c. Хэвтээ дарамтын шарх
   d. Нүхлэгдсэн шарх
   e. Шарх
   f. Арьсны урагдал
2. Бэлгийн хүчирхийлэл
   a. Тасарсан эсвэл толботой дотуур хувцас
   b. Бэлгийн эрхтний хэсэгт таагүй мэдрэмж эсвэл цус алдалт

хэсэгт

c. Явах эсвэл суухад хүндрэлтэй

d. Тайлбарлагдашгүй бэлгийн замын халдвар эсвэл өвчин

3. Сэтгэл зүйн хүчирхийлэл

a. Төөрөлдөх байдал

b. Айж сандрах

c. Өлсгөлөн ба жингийн өөрчлөлт

d. Өөртөө болон нийгмийн үйл ажиллагаанд татгалзах, сонирхолгүй болох

4. Анхааралгүй орхих

a. Цэгцгүй төрх

b. Хангалтгүй эсвэл зохисгүй хувцаслалт

c. Ус дуталт ба хоол тэжээлийн дутагдал

d. Нүдний шил, сонсголын аппарат, хиймэл шүд зэрэг бие махбодийн хэрэгцээ хангагдаагүй байх

5. Эмийн хэт тунгийн шинж тэмдэг

6. Эдийн засгийн мөлжлөг

a. Төлбөр төлөх чадваргүй байж, санхүүгийн талаар ярилцахад айдастай байдаг

b. Санхүүгийн талаар төөрөгдөх, буруу ойлголттой эсвэл мэдлэггүй байх

C. Оролцох арга хэмжээ

1. Бие махбодийн гэмтлийг үнэлж, эмчилнэ.
2. Хэрвээ ямар нэгэн гэмтэл нь хэн нэгний халдлагаас үүдсэн эсэхийг асуух.
3. Эргэлзээтэй хүчирхийллийн тохиолдлыг холбогдох байгууллагад мэдээл (муж, агентлагийн зааварчилгааг дагана уу).
4. Хэрэв боломжтой бол ахмад настныг хүчирхийллийн орчноос тусгаарлан, мөрдөн шалгалт явагдаж байх хугацаанд байршуулахад тусламж авахын тулд насанд хүрэгчдийг хамгаалах албанд хандана.
5. Хохирогчид хамгийн бага хязгаарлалттай, хамгийн бага саад тотгор учруулах өөр оршин суух зохицуулалтуудыг судалж үзээрэй.
6. Хүчирхийлэлд өртсөн ахмад настан нь санхүү болон эрх зүйн асуудлаар тусламж хэрэгтэй байж болно.
7. Яаралтай нийгмийн нөөцөд хандуулах заавар өгөх.
8. Хамгаалагчидтай ажиллахдаа тэдний стресстэй тэмцэхийн тулд түр амралт эсвэл зөвлөгөө авах шаардлагыг үнэлнэ (Эрүүл мэндийн тэргүүлэх үйл ажиллагаанууд хэсгийг үзнэ үү).

Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх арга хэмжээ

Ахмад үйлчлүүлэгчийн бие махбодийн хүчирхийлэл

1. Шуухирлыг үнэлж, эмчилнэ.
2. Хохирогчийг аюултай орчноос гаргаж, аюулгүй байдлыг хангана.

3. Аль ч тохиолдолд хүчирхийллийн талаар заавал мэдээлэх хуулийг чанд мөрдөнө.
4. Хэргийн ажилтан (case worker)-д нөхцөл байдлын талаар мэдэгдэх.
5. Тохиолдол, илэрсэн үр дүн, авсан арга хэмжээ болон хохирогчийн хариу үйлдлийг баримтжуул.

Дүгнэлт

Varcarolis (2017), 344-345-р хуудас.

XIII. Хүчирхийлэл болон бэлгийн халдлага

A. Тайлбар

1. Хүчиндэлт гэдэг нь хүч хэрэглэх эсвэл шахалт үзүүлж, бэлгийн түншийн зөвшөөрөлгүйгээр түүнийг бэлгийн харьцаанд оруулах үйлдэл юм.
2. Хохирогчид хүчирхийлэл болон довтолгоог хууль ёсоор мэдээлэх шаардлагагүй.
3. Ихэвчлэн хохирогчийг бусад хүмүүс буруутгадаг бөгөөд ойр дотны хүмүүсээсээ ямар ч дэмжлэг авдаггүй.
4. Танилын хүчирхийлэл нь хохирогчийн таньдаг хүнтэй холбоотой байдаг.
5. Хууль ёсны зөрчилтэй бэлгийн харьцаа гэдэг нь хууль ёсны зөвшөөрлийн насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох үйлдэл бөгөөд бага насны хүн зөвшөөрсөн ч гэсэн гэмт хэрэгт тооцогдоно.
6. Ижил хүйстэн хүний хүчирхийлэл
   a. Эмэгтэйчүүд: бэлгийн эрхтэнтэй хүрэлцэх, амаар бэлгийн харьцаанд орох, хуруу эсвэл бусад ямар нэгэн зүйлээр нэвтрэх зэрэг орно
   b. Эрэгтэйчүүд: эмэгтэйчүүдийнхтэй адил; тусламж хүсэх үед ихэвчлэн ялгаварлан гадуурхалттай тулгардаг
   c. Үзнэ үү https://www.cdc.gov/violencepreventio дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл байна.
7. Гэр бүлийн хүчирхийлэл
   a. Гэрлэлт нь хүссэн үедээ, хамтрагчийн зөвшөөрөлгүйгээр бэлгийн харьцаанд орох эрх олгодог гэсэн итгэл нь гэр бүлийн доторх хүчирхийллийн тохиолдолд хүргэдэг.
   b. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид хүсээгүй үйлдлийг хийхэд шахагдсан, бэлгийн харьцааны явцад бие махбодийн хүчирхийлэлд өртсөн гэж өгүүлдэг.

B. Үнэлгээ

1. Эмэгтэй үйлчлүүлэгч
   a. Сүүлийн сарын тэмдэгийн эхэлсэн огноог тогтооно.
   b. Хэрэглэсэн жирэмслэлтээс хамгаалах аргыг тодорхойлж, хүчирхийлэл үйлдэгдсэнээс өмнөх сүүлчийн бэлгийн харьцааны үйлдлийг тогтооно.

c. Харилцааны үргэлжлэх хугацаа, зөрчигдсөн нүхнүүд болон эр бэлгийн эрхтний нэвтрэлт болсон эсэхийг тогтоох.

d. Гэмт хэрэгтэн презерватив ашигласан эсэхийг тогтоох.

C. Ичгүүр, зовнил, доромжлол

D. Уур хилэн ба өш хонзон

E. Итгэгдэхгүй байх вий гэж айсаны улмаас бусдад хэлэхээс эмээдэг

F. Эрэгтэйчүүд хүүхэд байхдаа болон насанд хүрсэн хойно бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж болно, педофилуудын ердийн золиос болдог; тэд хүчирхийллийнхээ талаар илчилэхэд илүү хэцүү байж болно.

G. Хүчирхийллийн дараах сэтгэл зүйн цочролын хам шинж

1. Унтах явцад үүсэх хүндрэл, аймшигт зүүд
2. Хоолны дуршил буурах
3. Аймшиг, түгшүүр, фоби, сэжиг
4. Үйл ажиллагаа болон урам зоригийн бууралт
5. Харилцагч, гэр бүл, найз нөхөдтэй харилцаанд алдаа, зөрчил гарах
6. Өөрийгөө буруутгах, гэмших, ичих
7. Өөртөө итгэх итгэл буурах, үнэ цэнэгүй мэт санагдах
8. Бие махбодийн гомдол
9. Посттравматик стрессийн эмгэгийн талаарх мэдээллийг 65-р бүлэгт үзнэ үү.

H. Оролцох арга хэмжээ

1. Үнэлгээг чимээгүй, хувийн нууцлаг орчинд явуул.
2. Шаардлагатай бол SADV сувилагчид хандуулах
3. Хохирогчийн дэргэд байж, түүний аюулгүй байдлыг хангана.
4. Үйлчлүүлэгчийн бие махбодийн гэмтлийг үнэл. Шаардлагатай бол эмчил.
5. Эмчилгээ, процедур хийхээс өмнө хохирогчийн стрессийн түвшинг үнэл.
6. Шалгалт хийгдэх хүртэл хохирогч нь шүршүүрт орох, ваннд орох, эмэгтэйчүүд даашинз угаах эсвэл хувцаа сольж болохгүй.
7. Шалгалт, гэрэл зураг авах, лабораторийн шинжилгээ хийх, мэдээлэл дамжуулах болон лабораторийн дээж авах тухай бичгээр зөвшөөрөл аваарай.
8. Эмэгтэйгийн бэлхүүсний үзлэгт тусалж, үрийн шингэнийг илрүүлэх дээж цуглуулах (бэлхүүсний үзлэг нь халдлагын дурсамжийг сэргээж болно); үзлэгийн дараа үйлчлүүлэгчид шүршүүр болон цэвэр хувцас олгох ёстой.
9. Аливаа нотлох баримтыг хамгаал.
10. Бие махбодийн гэмтлийг эмчилж, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах.
11. Жороор бичигдсэн эмийг олгох.
12. Хохирогчийг асран хамгаалсан бүх үйл явдлыг баримтжуул.
13. Хүчирхийлэлд өртсөндөө амьд үлдэх нь хамгийн чухал гэдгийг хохирогчид ойлгуулах; хэрвээ хүчирхийлэлд өртсөндөө амьд үлдсэн бол тэр эсвэл

тэр амьд үлдэхийн тулд яг шаардлагатай бүхнийг хийсэн.

14. Хохирогчийг хямралын үеийн тусламж, дэмжлэгийн бүлэгт холбох.

Бохь 67-1

Төрөлүүд хямралын төрөл

Хөгжлийн

- Хөгжлийн шат болон түүнтэй холбоотой үүргийн өөрчлөлтүүдтэй холбоотой; жишээ нь гэрлэлт, хүүхэд төрөх, тэтгэвэрт гарах

Нөхцөл байдлын

- Гадаад эх үүсвэрээс үүдэлтэй, ихэвчлэн урьдчилан таамаглашгүй бөгөөд хувь хүн эсвэл бүлгийн сэтгэлзүйн тэнцвэрийг алдагдуулсан амьдралын үйл явдлуудтай холбоотой; жишээ нь ажлаасаа халагдах эсвэл ажлын байранд өөрчлөлт орох, санхүүгийн байдал өөрчлөгдөх, хайртай хүнийхээ нас барах, салалт, үр хөндөлт, гэр бүлийн шинэ гишүүд нэмэгдэх, жирэмслэлт, хүнд бие махбодийн эсвэл сэтгэлзүйн өвчин

Гэнэтийн

- Аймшигт гамшгийн хямралтай холбоотой бөгөөд өдөр тутмын амьдралын хэсэг биш; төлөвлөгдөөгүй, санамсаргүй. Гэнэтийн хямрал нь байгалийн гамшиг (жишээ нь үер, гал түймэр, салхины шуурга, газар хөдлөлт), үндэсний гамшиг (жишээ нь дайн, үймээн самуун, онгоцны осол) эсвэл хүчирхийллийн гэмт хэрэг (жишээ нь хүчингийн хэрэг, бие махбодийн халдлага, ажлын байр эсвэл сургууль дээрх аллага, бөмбөгдөлт, эсвэл гэр бүлийн гишүүн эсвэл хүүхдэд үзүүлэх хүчирхийлэл) зэргээс үүдэж болно.

Варкаролис Э: *Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйн үндэс*, шинэчилсэн дахин хэвлэл, 2 дахь хэвлэл, Филадельфиа, 2013, Saunders.

Бохь 67-2

Гэмшил хариу үйлдэл

Шат 1: Цочрол ба итгэлгүй байдал

- Хүн мэдээгүйжсэн мэдрэмж, шийдвэр гаргахад хүндрэл, сэтгэл хөдлөлийн дэлбэрэлт, үгүйсгэх, тусгаарлагдах мэдрэмжтэй байж болно.

2-р үе шат: Хохирлыг мэдрэх

- Хэрвээ гашуудлын хариу хайртай хүнийхээ алдагдалтай холбоотой бол тухайн хүн мэдрэх боломжтой

үхсэн хайртай хүндээ уурлах эсвэл түүний үхлийнхээ төлөө гэмших мэдрэмж төрж болно.

- Энэ шатанд найдлага тавих, сэтгэл гутрал эсвэл аль аль нь илрэх боломжтой.

3-р үе шат: Дахин нэгдэх

- Хүн амьдралаа дахин зохион байгуулж, хохирлын бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг.

67-3 дугаар хайрцаг

Хүүхдүүдийн гашуудал

Төрөлтөөс 1 нас хүртэл

- Нярай үхлийн талаар ойлголтгүй.
- Нярай эх эсвэл асрагчийнхаа алдагдсанд хариу үйлдэл үзүүлдэг.

1 2 хүртэлх нас

- Ягаан насны хүүхэд үхлийг буцааж болдог гэж үзэж болно.
- Хүүхэд орилж, тусгаарлагддаг эсвэл орчныг үл тоомсорлодог.
- Гомдол мэдрэмж нь нярай хүүхдийн амьдралд чухал хүн нас барсан тохиолдолд л үүсдэг.

2 5 хүртэлх нас

- Хүүхэд үхлийг буцааж болдог гэж үзэж болно.
- Рэгрэссив эсвэл түрэмгий зан авир илрэх боломжтой.
- Хүүхэд алдсан мэдрэмжтэй болж, хэн асрах бол гэж санаа зовдог.

5-9 Нас

- Хүүхэд анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хүндрэлтэй болдог.
- Хүүхэд үхлийг байнгын гэж үзэж эхэлдэг.
- Хүүхэд энэ явдалд өөрийгөө буруутай гэж мэдрэх магадлалтай.

Өсвөр насны өмнөх үеэс өсвөр нас хүртэл

- Өсвөр насны хүүхэд ухралт үзүүлж болно.
- Өсвөр насны хүүхэд үхлийг байнгын гэж үздэг.
- Өсвөр насны хүүхэд хүчтэй сэтгэл хөдлөл мэдэрдэг.

Хаяг 67-4

Гэмшил, алдалтын үед харилцаа холбоо

- Клиент болон түүний гэр бүл энэ нөхцөл байдлын талаар хэр их мэдэхийг хүсч байгааг тодорхойл.
- Гэр бүлийн төлөөлөгч байгаа эсэхийг тодорхойл.
- Соёлын, сүнслэг болон шашны итгэл үнэмшил харилцааны явцад хэрхэн нөлөөлж болохыг анхаарах; хувийн зай, нүдний холбоо, хүрэлцэх зэрэг асуудлыг харгалзан үзэх.
- Хэрэв шаардлагатай бол орчуулагч авчирна.
- Мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргах боломжийг олго.
- Хэрэв хүсвэл шийдвэр гаргах үйл явцад туслах; шийдвэр гаргахад асуудал шийдвэрлэх аргыг ашиглаж, хувийн үзэл бодол, байр сууриа оруулахгүй байх.
- Үйлчлүүлэгчтэй итгэлцлийг бий болгож, итгэл даахуйц, дэмжлэгтэй, шүүмжлэлгүй орчинд тэдний мэдрэмж, санаа зовнил, айдсыг илэрхийлэхийг нь урамшуул.
- Шударга байж, үйлчлүүлэгч болон түүний гэр бүлд та тэднийг орхиж явахгүй гэдгийг мэдэгд.
- Клиент болон түүний гэр бүлээс тэдний хүлээлтийн талаар болон хэрэгцээний талаар асуу.
- Эмзэг сонсогч бай; шаардлагатай, зохистой үед чимээгүй суу.
- Хэрвээ зохистой бол үйлчлүүлэгч эсвэл түүний гэр бүлийн гишүүний гарыг барьж, илэрхийлэх.
- Өнгөрснөө дурсахад нь урам өг.
- Хэрвээ та тодорхой нөхцөл байдалд юу хийхээ мэдэхгүй бол тусламж хүс.
- Хэрвээ үхэл эсвэл өөр ямар нэгэн хохирол, алдагдлын талаар ярьж буй үйлчлүүлэгч эсвэл түүний гэр бүлд юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байвал анхааралтай сонсож, нээлттэй асуулт тавих, тусгаж харуулах зэрэг эмчилгээний харилцааны аргуудыг ашигла.
- Өөрийнхөө мэдрэмжийг хүлээн зөвшөөр; ярилцах сэдэв хэцүү гэдгийг үйлчлүүлэгч болон түүний гэр бүлд мэдэгдэж, юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байгаагаа илэрхийл.
- Гомдол гунигийн явцад үйлчлүүлэгч болон тэдний гэр бүлтэй хамт уйлах нь хэвийн зүйл гэдгийг ойлго.

Хаяг 67-5

Өөрийгөө хорлох дохио

- Хувийн, онцгой, үнэ цэнэтэй эд зүйлсээ бусдад өгөх
- Нийгмийн арга хэмжээг цуцлах
- Өвлүүлэх бичиг баримт боловсруулах эсвэл өөрчлөх
- Даатгалын гэрээг цуцлах эсвэл өөрчлөх
- Зан үйлдлийн эерэг эсвэл сөрөг өөрчлөлтүүд
- Хоолны дуршил буурах
- Унтах хүндрэл
- Найдваргүйдлийн мэдрэмж
- Анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хүндрэлтэй
- Хобби, сонирхолтой үйл ажиллагаанд сонирхолгүй болох

- Өөрийгөө хорлох оролдлого хийх санаатай байгаагаа илэрхийлсэн үйлчлүүлэгчийн мэдэгдлүүд
- Гэнэт тайвширсан эсвэл гутранги байдал сайжирсан
- Үйлчлүүлэгчийн хор, буу эсвэл бусад амь насанд аюултай зүйлс, обьектүүдийн талаарх лавлагаа
- Сургууль эсвэл ажлын гүйцэтгэл гэнэт муудах

Бохь 67-6

Өөрийгөө хорлох эрсдэлтэй үйлчлүүлэгч: үнэлгээ

Төлөвлөгөө

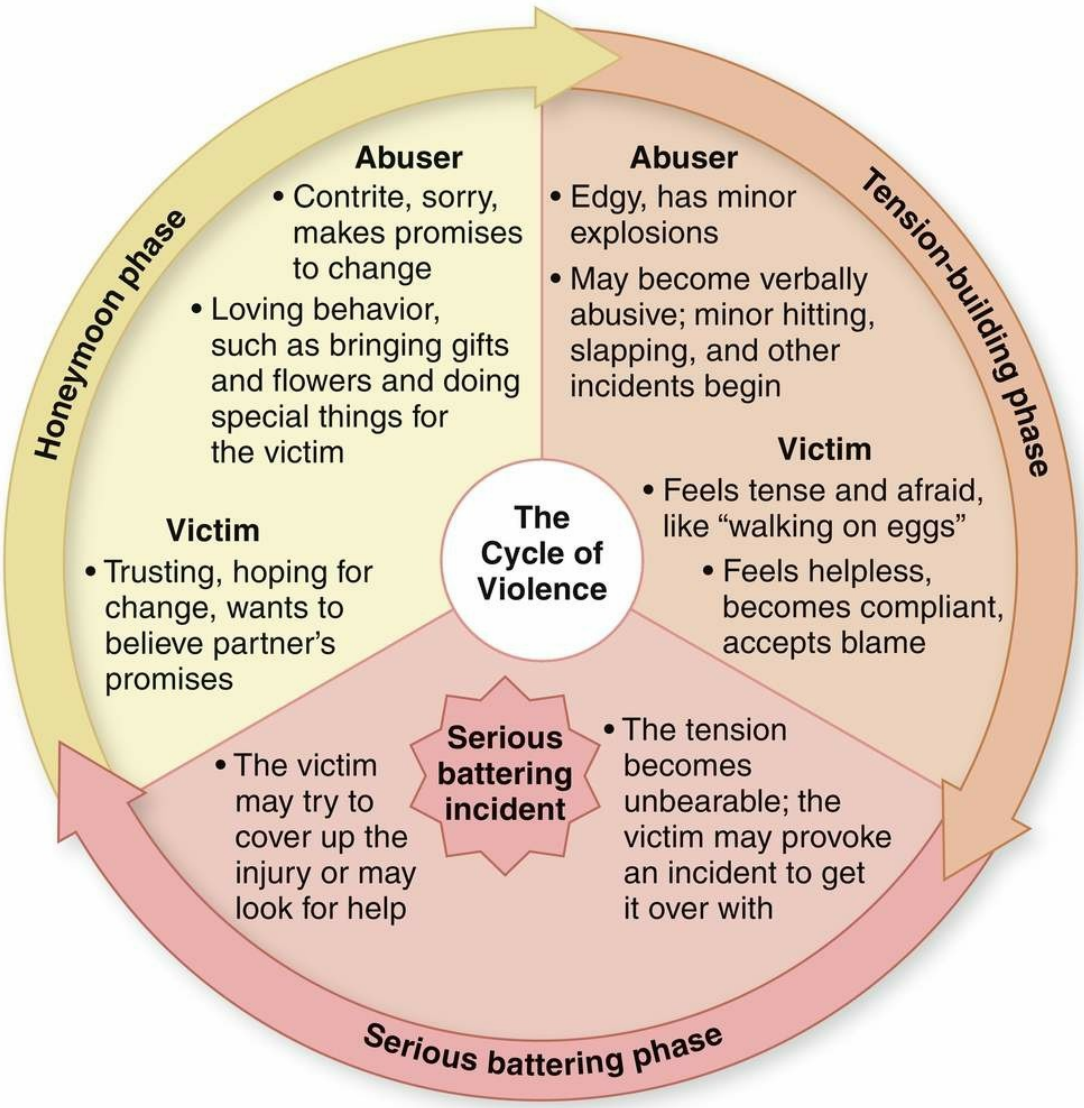
- Клиент төлөвлөгөөтэй юу?
- Клиент төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх боломжтой юу?
- Клиент төлөвлөгөөгөө хэзээ хэрэгжүүлэхээ шийдсэн үү?

Клиентийн оролдлогын түүх

- Өмнө нь ямар амиа хорлох оролдлогууд гарч, ямар хор хөнөөл учирсан бэ?
- Клиентийг санамсаргүйгээр аварсан уу?
- Өмнөх оролдлого, арга барил ижил байсан уу, эсвэл аргууд илүү аюултай болсон уу?

Сэтгэлзүйн болон нийгмийн хүчин зүйлс

- Клиент ганцаардсан эсвэл бусдаас тусгаарлагдсан байна уу?
- Эсвэл дайсагнал эсвэл гутрал илэрч байна уу?
- Клиент галлюцинацид өртөж байна уу? Галлюцинацийн төрөл (сонсголын/тушаалын, харааны)?
- Мансууруулах бодис хэрэглэх асуудал байгаа юу?
- Клиент саяхан ямар нэгэн хохирол амссан эсвэл бие махбодийн өвчин туссан уу?
- Клиент орчны эсвэл амьдралын хэв маягт ямар нэгэн өөрчлөлт орсон уу?



Зураг 67-1 Хүчирхийллийн мөчлөг.

67-7-р хайрцаг

Хүчирхийллийн төрөл

Бие махбодийн хүчирхийлэл: бие махбодийн өвдөлт эсвэл бие махбодийн гэмтэл учруулах
Бэлгийн хүчирхийлэл: Зөвшөөрөлгүй ямар ч төрлийн бэлгийн харилцаа
Сэтгэлзүйн хүчирхийлэл: Сэтгэлзүйн зовлон учруулах
Бие махбодийн халамжгүй байдал: Бие махбодийн болон сэтгэлзүйн өвчнийг урьдчилан сэргийлэх эсвэл эмчлэхэд шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх
Хөгжлийн орхигдуулалт: Хөгжлийн хомсдлыг урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай бие махбодийн болон танин мэдэхүйн өдөөлтийг хангахгүй байх
Боловсролын орхигдуулалт: Хүүхдийг боловсрол эзэмших эрхээс нь хасах
Эдийн засгийн мөлжлөг: хувийн ашиг хонжоо олох зорилгоор мөнгө, санхүүгийн эх үүсвэр болон бусад нөөцийг хууль бусаар эсвэл зохисгүйгээр ашиглах

Хаяг 67-8

Хүчирхийлэл, мөлжлөгийн үнэлгээний асуултууд

- "Хэн нэгэн таныг таагүй мэдрэмж төрүүлэх байдлаар хүрч байсан уу?"
- "Эдгээр гэмтлүүд нь хэн нэгэн таныг хохироосон үр дүн мөн үү?"
- "Одоогоор хэн нэгэн чамайг зовоож байна уу?"
- "Та болон таны хамтрагч уур бухимдал (эсвэл санал зөрөлдөөн)-г хэрхэн шийддэг вэ?"
- "Таны хамтрагч танд хэзээ нэгэн удаа цохиж байсан уу?"
- "Та хэзээ нэгэнт ...-аас заналхийлүүлж байсан уу? __?"
- "Таны хамтрагч танд гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ уулзахыг саад болдог уу?"
- Таны хамтрагч хэзээ нэгэн үед хүүхдүүдийг ашиглан таныг удирдаж байсан уу?
- Таны гэр бүлийн хэн нэгэн уур хилэнгээ цохиж илэрхийлдэг байсан (эсвэл одоо ч цохидог) уу?

Хаяг 67-9

Хүүхдийн орхигдуулалт ба хүчирхийлэл: Үнэлгээний дүгнэлтүүд

Анхаарал халамжийн дутагдал

- Хангалтгүй жин нэмэлт
- Хувийн ариун цэврийн дутагдал
- Тогтмол өлсгөлөн
- Сургалтад тогтмол оролцдоггүй
- Тасралтгүй ядаргаа
- Хүүхдийн хараа хяналтгүй байдлын тухай мэдээлэл
- Гэмт хэрэгт өртөх

Бие махбодийн хүчирхийлэл

- Тайлбарлагдашгүй хөхрөлт, түлэгдэлт эсвэл хугаралт
- Толгойн арьсан дээр үсгүй толбо
- Айсан хүүхэд
- Хэтэрхий довтолгоотой зан (ихэвчлэн хөвгүүдэд) эсвэл тусгаарлагдах хандлага (ихэвчлэн охидод)
- Эцэг эхийн айдас
- Танихгүй хүн ойртсон үед (том нярай, алхаж эхэлсэн хүүхэд эсвэл бага цэцэрлэгийн насны хүүхэд) уйлахгүй байх
- Спортын гэмтлээс үүдсэн бэртлийн түүхгүй спираль хугаралууд
- Сургуульд сурлагын амжилт муутай байх

Сэтгэл зүйн хүчирхийлэл

- Ярианы эмгэгүүд
- Сорох, хазах, савлах зэрэг зуршлын эмгэгүүд
- Психонейротик урвал
- Суралцах чадварын эмгэгүүд
- Өөрийгөө хорлох оролдлого

Бэлгийн хүчирхийлэл

- Явах эсвэл суухад хүндрэлтэй
- Хугарсан, толботой эсвэл цусанд будагдсан дотуур хувцас
- Бэлэг эрхтний өвдөлт, хавдар эсвэл загатнал
- Бэлэг эрхтний болон анусны эргэн тойрон дахь гажиг, хөхрөлт, цус алдалт эсвэл цууралт
- Өмсгөлөө солих эсвэл биеийн тамирын дасгалд оролцох хүсэлгүй байх
- Найз нөхөдтэй харилцаа муутай
- Сургуульд сурлагын амжилт муутай байх

Чирхийлсэн нярайны хам шинж

- Гадны гэмтлийн шинж тэмдэг ихэвчлэн илэрдэггүй
- Офтальмоскопийн шинжилгээ нь торлог бүрхэвчийн цус алдалтыг илрүүлнэ
- Толгойн хөндлөн хэсэг бүрэн хавдсан, толгойн тойрог нь хүлээгдсэн хэмжээнээс их

Даалгаврын асуултууд

827. Сувилагч хүчирхийлэл үйлдэх эрсдэлтэй үйлчлүүлэгч сэтгэл түгшсэн, коридороор явж зогсохгүй, бусад үйлчлүүлэгчдэд дайсагнасан, довтолгоотой дохио зангаа гаргаж байгааг ажиглав. Энэ үйлчлүүлэгчтэй харилцахдаа **хамгийн зохистой** өгүүлэх зүйл аль вэ?
    1. "Чи яг одоо энэ зангаа зогсоох хэрэгтэй."
    2. Чамайг тусгаарлах шаардлагатай болно.
    3. "Чи тайвангүй харагдаж байна; юу болж байгааг хэлээч."
    4. "Хэрвээ чи зан авираа өөрчлөхгүй бол чамайг барьж саатуулах шаардлагатай болно."
828. Сувилагч нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасагт хэвтэн орсон үйлчлүүлэгчийн үнэлгээний өгөгдлийг хянаж байна. Сувилагч нь хүлээн авах сувилагч нь үйлчлүүлэгч нөхцөл байдлын хямралын улмаас түгшүүртэй байгааг тэмдэглэсэн байгааг анзаарчээ. Сувилагч үйлчлүүлэгчийн асаргааг төлөвлөж, энэ төрлийн хямрал ямар үйл явдлаас үүдэлтэй байж болохыг тодорхойлж байна?
    1. Аллагын гэрч болох
    2. Хайртай хүний үхэл
    3. Клиентын гэрийг сүйтгэсэн гал түймэр
    4. Клиент саяхан хүчирхийлэлд өртсөн явдал
829. Сувилагч нь хямралд орсон үйлчлүүлэгчийн анхны үнэлгээг хийж байна. Үйлчлүүлэгчийн тухайн нөхцөл байдлыг үүсгэсэн шалтгаан болсон үйл явдлыг хэрхэн хүлээн авч байгааг үнэлэх үед

хямралд хүргэсэн шалтгаан болсон үйл явдлыг хэрхэн хүлээн авч байгааг үнэлэхэд **хамгийн тохиромжтой** асуулт аль вэ?

1. "Та хэнтэй хамт амьдардаг вэ?"
2. "Танд туслах боломжтой хүн хэн бэ?"
3. "Яагаад яг одоо тусламж хүсэхээр шийдлээ вэ?"
4. "Та ихэвчлэн өөрийгөө дээр мэдрэхийн тулд юу хийдэг вэ?"

830. Сувилагч сэтгэл зүйн хямралын байдалтай үйлчлүүлэгчийн асрах төлөвлөгөөг боловсруулж байна. Төлөвлөгөө боловсруулахдаа сувилагч ямар хүчин зүйлийг харгалзан үзэх ёстой вэ?

1. Кризис байдал нь үйлчлүүлэгч сэтгэцийн өвчтэй гэдгийг илтгэнэ.
2. Хямралын байдал нь үйлчлүүлэгчид сэтгэл хөдлөлийн өвчин туссан гэдгийг илтгэнэ.
3. Хямралын үед илэрдэг шинж тэмдгүүд нь хямралтай тулгарч буй бүх үйлчлүүлэгчдэд адил байдаг.
4. Клиентийн хямралд үзүүлэх хариу үйлдэл нь хувь хүний онцлогоос хамаарч өөр байдаг бөгөөд нэгэнд хямрал гэж тооцогдох нөхцөл байдал нь өөр нэгэнд хямрал гэж тооцогдохгүй байж болно.

831. Яаралтай тусламжийн тасгийн сувилагч бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болсон залуу эмэгтэйг асарч байна. Өвчтөний биеийн үзлэг бүрэн хийгдэж, бие махбодийн нотлох баримтыг цуглуулсан байна. Сувилагч өвчтөн заримдаа дотогшоо татагдаж, анхаарал сарниж, чичирч, төөрөлдөж байгааг анзаарсан. Эдгээр зан үйлийг сувилагч хэрхэн тайлбарлах вэ?

1. Депрессийн шинж тэмдгүүд
2. Сүйрлийн үйл явдалд үзүүлэх хариу үйлдэл
3. Өвчтөнд өндөр амиа хорлох эрсдэлтэй байгааг харуулсан нотолгоо
4. Эмнэлэгт хэвтэх шаардлагын илрүүлэгч шинжүүд

832. Онош тавигдсан хэвтэн эмчлүүлэх тасагт хэвтсэн сэтгэл гутралтай үйлчлүүлэгч сувилагчид "Манай гэр бүл надаас ангид илүү сайн байх байсан" гэж хэлэв. Сувилагчийн **хамгийн тохиромжтой** хариулт аль вэ?

1. "Та энэ талаар гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцаж үзсэн үү?"
2. "Сэтгэл гутралтай үед хүн бүр иймэрхүү мэдрэмж төрдөг."
3. "Эмчилгээ чинь эхэлмэгц чи сайхан мэдрэх болно."
4. "Та маш их сандарч байгаа бололтой. Өөрийгөө гэмтээх талаар бодож байна уу?"

833. Сувилагч нь илэрхийлж байсан үйлчлүүлэгчийг нягт ажиглаж байв иррационал ааш авир гаргаж байгааг нягт ажиглаж байв. Сувилагч өвчтөний ааш авир улам ширүүсч байгааг ажиглав. Энэ үед тухайн өвчтөнд **хамгийн их** туслах сувилахуйн арга хэмжээ юу вэ? **Хамаарах бүхнийг сонгоно уу.**

1. Хүнийг тусгаарлах арга хэмжээг эхлүүлэх.
2. Клиентийн зан үйлийг хүлээн зөвшөөрөх.
3. Клиентийг чимээгүй газар руу дагуулан явах.
4. Клиентээс аюулгүй зай барьж байх.
5. Клиентд нөхцөл байдлыг өөрөө хянах боломж олго.

834. Сувилагчи[illegible]игласан аль зан үйл нь сэтгэл гутралтай өсвөр насны үйлчлүүлэгч амиа хорлох магадлалтайг илтгэнэ вэ?

1. Өсвөр насны хүүхэд DVD болон дуртай уран бүтээлчийн гарын үсэгтэй үнэ цэнэтэй зургийг бусдад өгч байна.
2. Өсвөр насны хүүхэд эмчилгээний бүлгээс гүйн гарч, бүлгийн ахлагчийг харааж, өрөөндөө явдаг.
3. Өсвөр насны хүүхэд утсаар ярьж байхдаа уурлана

мөн утсаа ширээн дээр хүчтэй цохиж тавьдаг.

4. Өсвөр насны охин өрөөний хамтрагч нь түүний хувцсыг асууж зөвшөөрөлгүй зээлсэнд уурлана.

835. Цагдаа нар хоёр бугуйгаа зүссэн өвчтөнийг яаралтай тусламжийн тасагт авчирлаа. **Эхний** сувилагчийн үйлдэл юу байх вэ?

1. Сэтгэл түгшүүр намжаах эм өгөх.
2. Гэмтсэн хэсгүүдийг үнэлж, эмчилнэ.
3. Нарийвчилсан анамнезийг авч, бүртгэнэ.
4. Өвчтөнд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд нь урамшуулж, дэмжлэг үзүүлэх.

836. Хоёр хоногийн өмнө эмнэлэгт хэвтсэн дунд зэргийн депрессийн шинжтэй өвчтөн гэнэт инээмсэглэн, хямрал дуусан гэж мэдэгдэв. Өвчтөн сувилагчид "Би эцэст нь эдгэрлээ" гэж хэлэв. Өвчтөний зан үйл, мэдэгдэлд үндэслэн сувилагч төлөвлөгөөндөө ямар арга хэмжээ оруулах ёстой вэ?

1. Эмчилгээний эмүүдийг бууруулахыг санал болгох
2. Өрөөнд хийх үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх
3. Өөрийгөө хорлохоос сэргийлэх арга хэмжээг чангатгах
4. Шаардлагатай үед үйлчлүүлэгчийг тасаг дотор болон гадуур явах эрх олгох

837. Сувилагч нь амиа хорлох оролдлого хийсэн өвчтөнийг сувилахуйн тасагт хүлээн авах үедээ асаргааны төлөвлөгөөндөө ямар **тэргүүлэх ач холбогдолтой** сувилахуйн арга хэмжээг оруулах ёстой вэ?

1. Нэг-нэгээр үзэх амиа хорлолтоос сэргийлэх арга хэмжээ
2. 30 минутын зайтай шалгалттай амиа хорлолтоос сэргийлэх арга хэмжээ
3. Клиентийн байршлыг 15 минут тутамд шалгах
4. Өвчтөндөө амиа хорлох бодлыг даруй мэдээлэхийг хүсэх

838. Яаралтай тусламжийн тасгийн сувилагч нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон насанд хүрсэн үйлчлүүлэгчийг асарч байна. Гарах зааварчилгаанд ямар **тэргүүлэх ач холбогдолтой** мэдээллийг оруулах ёстой вэ?

1. Орогнолын газруудын талаарх мэдээлэл
2. Цагдааг дуудах заавар
3. Өөрийгөө хамгаалах сургалтын талаархи заавар
4. Хүчирхийллийн нөхцөл байдлаас гарахын ач холбогдлыг тайлбарлах 839.

Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч эмэгтэйг хямралын төвд үзэж байна.

үйлчлүүлэгч "хүчирхийлэл яг л өчигдөр болсон юм шиг" санагддаг гэж хэлж байна, үйл явдал болсноос хэдэн сарын дараа ч. Сувилагчийн **хамгийн зохистой** хариу үйлдэл аль нь вэ?

1. "Та бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хүчирхийлэл зүгээр л саяхан болсонгүй."
2. "Чамайг хүчирхийлсэн явдлын талаархи эдгээр мэдрэмжээс ангижрахын тулд тодорхой хугацаа шаардагдана."
3. "Танд хүчирхийлэл яг одоо л болсон мэт санагдуулах тэр явдлын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгнө үү."
4. "Дахин хүчирхийлэлд өртөх вий гэсэн айдсаа багасгахын тулд та юу хийж чадах гэж бодож байна вэ?"

840. Өөрийгөө өлгөж амиа хорлох оролдлого хийсний дараа үйлчлүүлэгчийг сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасагт хүлээн авсан. Сувилагч үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг **хамгийн сайн** хангахын тулд ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Тус үйлчлүүлэгчийн дэргэд бүх цаг үед хамт байх хамтрагчаар хүсэлт гаргах.
2. Клиентийн хувцсыг тайлан, эмнэлгийн халаад өмсүүлэх.
3. Үйлчлүүлэгчид бүх цаг үед хамт байх ажилтныг томилох.

4. Боломжит аюултай бүх зүйлсийг авч хаясан тусгаарлах өрөөнд үйлчлүүлэгчийг хэвтүүлэх.

841. Гэр рүү нь халдлага үйлдэж, дээрэмдсэн явдлын дараа сүүлийн үед хүнд түгшүүртэй болсон үйлчлүүлэгчийг хүлээн авлаа. Эхний үнэлгээний ярилцлагын явцад үйлчлүүлэгчийн аль мэдэгдэл нь сувилагчид посттравматик стрессийн эмгэгийн боломжит оношийг зааж өгөх ёстой вэ? **Хамаарах бүхнийг сонгоно уу.**

- ☐ 1. "Би аалзны айдастай."
- ☐ 2. "Би дээрэм тохиолдсон явдлыг байнга дахин дахин туулж байна."
- ☐ 3. "Би хаа явсан газар бүртээ түүний царайг хардаг."
- ☐ 4. "Одоо би юу ч идэхыг хүсэхгүй байна."
- ☐ 5. "Хэдхэн долларын төлөө би үхэж ч мэдэх байсан."
- ☐ 6. "Би гараа олон удаа, дахин дахин угаах хэрэгтэй болдог."

Хариултууд

827. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Хамгийн зохистой өгүүлбэр нь үйлчлүүлэгчээс түүний түгшүүрийн шалтгааныг асуух явдал юм. Энэ нь үйлчлүүлэгчид өөрийн зан үйлээ ухамсарлахад тусалж, сувилагчид түүнд тохирсон арга хэмжээг төлөвлөхөд дэмжлэг үзүүлнэ. 1-р сонголт нь үйлчлүүлэгчийн түгшүүрийг нэмэгдүүлэх боломжтой шаардлагатай зан үйл юм. 2-р болон 4-р сонголтууд нь үйлчлүүлэгчид заналхийлэх тул зохимжгүй.

Шалгалт өгөх стратеги: *хамгийн тохиромжтой* **стратегийн үгсийг** тэмдэглэ. 1-р сонголтыг хасаарай, учир нь энэ нь үйлчлүүлэгчдэд ихээхэн ачаалал үүсгэнэ. 2 ба 4-р сонголтуудыг хасаарай, учир нь тэд үйлчлүүлэгчдэд заналхийлэл үүсгэнэ.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хүчирхийллийн зан үйл ***Гол ойлголтууд:*** Сэтгэл түгшилт; Харилцаа ***Дүрийн лавлагаа:*** Varcarolis (2017), 140, 143-р хуудас.

828. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Нөхцөл байдлын хямрал нь дотоод бус, харин гадаад эх үүсвэрээс үүсдэг. Хямрал үүсгэж болзошгүй гадаад нөхцөлд ажлаасаа халагдах эсвэл ажлын байранд өөрчлөлт гарах, хайртай хүнийхээ нас баралт, үр хөндөлт, санхүүгийн байдалд өөрчлөлт гарах, салалт, гэр бүлийн шинэ гишүүд нэмэгдэх, жирэмслэлт болон хүнд өвчин зэрэг орно. 1, 3, 4 дүгээр сонголтууд нь гэнэтийн хямралуудыг зааж байна. Гэнэтийн хямрал нь аюулт үзэгдлийн хямрал бөгөөд өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг биш, төлөвлөгдөөгүй, санамсаргүй тохиолддог. Гэнэтийн хямрал нь байгалийн гамшиг (жишээ нь үер, гал түймэр, салхины шуурга, газар хөдлөлт), үндэсний гамшиг (жишээ нь дайн, үймээн самуун, онгоцны осол) эсвэл хүчирхийллийн гэмт хэрэг (жишээ нь хүчингийн хэрэг, зодоон, аллага) зэргээс үүдэж болно.

ажилтын байр эсвэл сургууль, бөмбөгдөлт, эсвэл гэр бүлийн гишүүн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл).

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв** болон нөхцөл байдлын хямралыг анхаар. Энэ төрлийн хямрал нь гадаад эх үүсвэрээс үүдэлтэй, ихэвчлэн урьдчилан таамаглашгүй бөгөөд хувь хүн эсвэл бүлгийн сэтгэлзүйн тэнцвэрийг алдагдуулсан амьдралын үйл явдалтай холбоотойг сана. Энэ нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Төвөгшөөлт эмгэг

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Сэтгэл түгшил; Даван туулах чадвар

Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 325-326-р тал.

829. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Хямралд орсон үйлчлүүлэгчийг үнэлэхэд сувилагчийн эхний даалгавар нь тухайн хүн эсвэл гэр бүл болон асуудлыг үнэлэх явдал юм. Асуудлыг хэр тодорхой тогтооно, шийдэл олох магадлал төдий чинээ өндөр байдаг. Зөв сонголт нь хямралыг үүсгэсэн шалтгаантай холбоотой мэдээллийг тодорхойлоход тусална. 1, 2-р сонголтууд нөхцөл байдлын дэмжлэгийг үнэлнэ. 4-р сонголт хувь хүний даван туулах чадварыг үнэлнэ.

Шалгалт өгөх стратеги: *Хамгийн зохистой* **стратегийн үгсийг** тэмдэглэ. Мөн **сэдэв**, хямралд орсон үйлчлүүлэгчийн үнэлгээний аргуудыг тэмдэглэж, *хямралыг үүсгэсэн үйл явдал* болон *хямралд хүргэсэн* үгсийг тэмдэглэ. 1, 2-р сонголтыг хас, учир нь эдгээр өгөгдөл нь дэмжлэгийн тогтолцоог тодорхойлно. 4-р сонголтыг хас, учир нь энэ асуултыг даван гарах чадварыг тодорхойлох үед асуудаг.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэцийн нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд:

Хямралын ***тэргүүлэх ойлголтууд:*** Сэтгэл түгшилт;

Даван гарах чадвар ***Лавлагаа:*** Varcarolis (2017), 327-329-р хуудас.

830. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Хэдийгээр хямралд үзүүлэх хариу үйлдлийг илэрхийлэх шинж тэмдгүүдийн хувьд адил хэлбэрээр тодорхойлж болох ч нэг үйлчлүүлэгчийн хувьд хямрал гэж тооцогдох зүйл нь өөр үйлчлүүлэгчийн хувьд хямрал биш байж болно, учир нь хүн бүр өвөрмөц байдаг. Хямралын байдалд байгаа нь үйлчлүүлэгчид сэтгэлзүйн эсвэл сэтгэл хөдлөлийн өвчин оношлогдсон гэсэн үг биш юм.

Шалгалт өгөх стратеги: "бүх" гэсэн **хаалттай үгний** улмаас 3-р сонголтыг хасах. Дараа нь 1, 2-р сонголтыг хасах, учир нь хямрал нь "өвчин" гэдгийг илэрхийлэхгүй.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Бүтээлч

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хямрал

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: асаргаа халамж; даван туулах чадвар

Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 329-р тал.

831. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Хүчирхийллийн хямралын хурц үед үйлчлүүлэгч нь сэтгэл хөдлөл болон бие махбодийн олон төрлийн хариу үйлдэл үзүүлж болно. Дээр дурдсан шинж тэмдгүүд нь хүлээгдэж болох ердийн хариу үйлдлийг илтгэнэ. 1, 3, 4 дүгээр сонголтууд нь буруу тайлбар юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв** болон үйлчлүүлэгчийн хямралд үзүүлсэн хариу үйлдлийг анхаарах. Гэмт хэрэгт өртөх зэрэг сүйрлийн үйл явдлуудад үйлчлүүлэгчийн үзүүлэх хариу үйлдлийн талаарх мэдлэгээ ашиглан асуулгад дурдсан шинж тэмдгүүдэд төвлөрч зөв сонголтыг тодорхойлох.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Шинжилэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд:

Хямралын ***тэргүүлэх ойлголтууд:*** Асран халамжлах;

Даван туулах***. Лавлагаа:*** Varcarolis (2017), 354–355-р тал.

832. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Сэтгэл гутралтай үйлчлүүлэгчид амиа хорлох эрсдэлд өртөж болно. Сувилагч нь амиа хорлох бодол, төлөвлөгөөг үнэлж, төлөвлөгөө гаргах нь чухал. Сувилагч нь үйлчлүүлэгчээсээ өөрийгөө гэмтээх төлөвлөгөө байгаа эсэхийг шууд асуух ёстой. 1, 2, 3 дугаар сонголтууд нь үйлчлүүлэгчийн сэтгэл хөдлөлтэй шууд холбоогүй.

Шалгалт өгөх стратеги: "*best"* гэсэн **стратегийн үгийг** анхаар. **Эмчилгээний харилцааны техникүүдийг** санахад зөв сонголтыг олоход тусална. 4-р сонголт нь үйлчлүүлэгчийн мэдрэмжтэй шууд хамааралтай цорын ганц сонголт юм. Мөн амиа хорлох эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчдээс өөрийгөө гэмтээх боломжийн талаар шууд асуулт асуух шаардлагатай.

Оюуны чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал

Нэгтгэсэн процесс: Харилцаа холбоо ба баримтжуулалт

Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Өөрийгөө алах ***Эхний ээлжийн ойлголтууд:*** Клиникийн шийдвэрлэл;

Аюулгүй байдал ***Ишлэл:*** Varcarolis (2017), 207, 367–368-р тал.

833. ***Хариулт:*** 2, 3, 4

Үндэслэл: Хурдацлах үед үйлчлүүлэгчийн зан байдал хяналтаа алдах чиглэл рүү шилжиж байна. Сувилагчийн арга хэмжээ нь хяналтыг гартаа авах, аюулгүй зай барих, зан байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, үйлчлүүлэгчийг нам гүм газар шилжүүлэх, шаардлагатай бол эмчилгээ хийх зэргийг багтаана. Энэ үед тусгаарлах арга хэмжээг эхлүүлэх нь зохимжгүй. Хэрэв тусгаарлах арга хэмжээ шаардлагатай бол хямралын үед эхлүүлэх нь хамгийн зохистой.

Шалгалтын стратеги: "**стратегийн**" гэдэг **үг** болон *"хамгийн" гэдэг үг*, мөн "хамгийн тустай сувилахуйн арга хэмжээ" гэсэн сэдвэд анхаарлаа төвлөрүүл. Мөн *"агрессив зан үйл*" ба *"хурдацтай нэмэгдэж буй*" гэсэн үгсийг анхаар. Хурдацтай нэмэгдэж буй үед үйлчлүүлэгчийн зан үйл ...

хяналтаа алдах чиглэл рүү хөдөлж байгааг, хамгийн бага хязгаарлалттай арга хэмжээг ашиглах ёстойг санахад тань зөв сонголтыг хийхэд тусална.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд:
Хүчирхийлэл ***Гол ойлголтууд:*** Клиникийн шийдвэрлэл;
Аюулгүй байдал ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 379–
380-р тал.

834. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Сэтгэл гутралтай, амиа хорлох эрсдэлтэй үйлчлүүлэгч салах ёс хийх, дурсагдахыг хүссэн байдлаар үнэ цэнэтэй зүйлсээ ихэвчлэн тарааж өгдөг. 2, 3, 4 дүгээр сонголтууд нь ихэвчлэн өсвөр насныханд нийтлэг уур хилэн, гадаад илэрхийлэлтэй зан үйлтэй холбоотой.

Шалгалт өгөх стратеги: 2, 3, 4 дүгээр сонголтуудыг **адилтгаж** хасах. Зөв сонголт нь өөр бөгөөд үйлдэл нь үйлчлүүлэгч "салах ёс гүйцэтгэж" байж магадгүйг илтгэнэ.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх
Клиентийн хэрэгцээ: Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд:
Өөрийгөө алах оролдлого ***Гол ойлголтууд:*** Сэтгэл
хөдлөл ба илэрхийлэл; Аюулгүй байдал ***Дүрийн ишлэл:***
Varcarolis (2017), 366-р тал.

835. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Эхний сувилагчийн үйлдэл нь өөрөө учруулсан гэмтлийг үнэлж, эмчлэх явдал юм. Гарын бугуй хэрчигдсэнээс үүссэн шарх нь амь насанд аюултай нөхцөл үүсгэж болно. Бусад арга хэмжээ, жишээлбэл 1, 3, 4 дүгээр сонголтууд нь үйлчлүүлэгчийг эмнэлгийн тусламж авсны дараа авч хэрэгжүүлж болно.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн үг** бол "*initial*" (эртний). Эрэмбэлэхдээ **Маслоугийн хэрэгцээний иерархийн онолыг** ашигла. Физиологийн хэрэгцээ эхэнд ирдэг. Зөв хариулт нь физиологийн хэрэгцээг хангана.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Клиентийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Гүйцэтгэл
Агуулгын салбар: Нарийн төвөгтэй асаргаа: Яаралтай нөхцөл байдал: Удирдлага
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд—
Өөрийгөө хорлох ***Эрэмбэлэх гол ойлголтууд:*** Асран
халамж; Аюулгүй байдал ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis
(2017), 367-р тал.

836. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Дунд зэргийн депрессийн байдалтай, эмнэлэгт ердөө хоёр хоног хэвтсэн үйлчлүүлэгч ийм эрс эдгэрэх магадлал багатай. Депрессийн байдал гэнэт арилбал, энэ нь

клиент өөрийгөө гэмтээх шийдвэр гаргасан байж болзошгүй. Клиентийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд амиа хорлолтоос сэргийлэх арга хэмжээ зайлшгүй шаардлагатай. Үлдсэн сонголтууд нь буруу тайлбар юм.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт**, амиа хорлолтоос сэргийлэхэд анхаар. 1, 4 дүгээр сонголтууд нь өвчтөнд эдгэрэлтийн үзэгдэл тохиолдсон гэсэн ойлголтыг дэмжиж байна. 2 дугаар сонголт нь өвчтөнд өөрийгөө тусгаарлах байдлыг нэмэгдүүлэх боломж олгож, түүний аюулгүй байдалд заналхийлнэ. Аюулгүй байдал хамгийн чухал гэдгийг мэдэх нь таныг зөв сонголтыг хийхэд чиглүүлнэ.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үзүүлэх

орчин ***Интеграцчилсан процесс:*** Асаргаа үйлчилгээний

процесс—Төлөвлөлт ***Агуулгын салбар:*** Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд

Эрэмбэлэх ойлголтууд: Асран халамж; Аюулгүй байдал

Эшлэл: Varcarolis (2017), 369-370-р талууд.

837. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Амиа хорлох оролдлого хийсэн үйлчлүүлэгчид нэг-нэг хараа хяналт шаардлагатай. 2 болон 3-р сонголтууд тохиромжтой байж болох ч нөхцөл байдлыг харгалзан одоогоор тохиромжгүй. 4-р сонголт мөн сувилахуйн оролцоо байж болох ч тэргүүлэх ач холбогдол нь зөв сонголтод заагдсан. Хамгийн тохиромжтой арга хэмжээ нь тасралтгүй хяналт бөгөөд ингэснээр үйлчлүүлэгч өөрийгөө гэмтээх оролдлого хийх үед сувилагч шаардлагатай үед оролцох боломжтой.

Шалгалт өгөх стратеги: **стратегийн үг**, *тэргүүлэх ач* холбогдолд анхаарч, үгсийг тэмдэглэх *өөрийгөө хорлох оролдлого*. Зөв сонголт нь аюулгүй орчинг бүрдүүлэх цорын ганц сонголт юм.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа сувилгын орчин

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт

Агуулгын салбар: Нарийн төвөгтэй асаргаа: Яаралтай нөхцөл байдал: Удирдлага

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Өөрийгөө

хорлох Эрүүл мэндийн ***тусламжийн тэргүүлэх***

ойлголтууд: Асран халамж; Аюулгүй байдал

Лавлагаа: Varcarolis (2017), 369-р тал.

838. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Гэр бүлийн хүчирхийллийн гуравдугаар шатны урьдчилан сэргийлэлт нь хүчирхийлэл үйлдэгдсэний дараа хохирогчид туслахыг багтаана. Сувилагч нь хохирогчид хаана тусламж авах, хүчирхийлэгчээс хэрхэн зай барих, зугтах, халуун шугам болон хоргодох байрны байршлын талаар тодорхой төлөвлөгөө, мэдээлэл өгөх ёстой. Хүчирхийлэлд өртсөн хүн ихэвчлэн цагдааг дууддаггүй. Хүчирхийлэл үйлдэгчтэй тулгарах үед хохирогчийг эсэргүүцэн тэмцэх арга зааж өгөх нь зохистой арга биш юм. Хүчирхийллийн нөхцөл байдлаас гарахын ач холбогдлыг тайлбарлах нь чухал боловч тодорхой төлөвлөгөө зайлшгүй шаардлагатай.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн үг** болох "*приоритет*"-ийг анхаар. Асуулгын гол **сэдэв** нь үйлчлүүлэгчид аюулгүй орчин бүрдүүлэхтэй холбоотой тул түүнд анхаарлаа төвлөрүүл. Зөв хариулт нь аюулгүй байдлыг хангах тодорхой төлөвлөгөөг санал болгодог.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргааны орчин
Нэгтгэсэн процесс: Сувилахуйн процесс—хэрэгжилт ***Сэдэв:***
Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Хүчирхийлэл
Гол ойлголтууд: Хүмүүсийн хоорондын хүчирхийлэл;
Аюулгүй байдал ***Эх сурвалж:*** Varcarolis (2017), 330–331,
343-р тал.

839. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Зөв сонголт нь үйлчлүүлэгчид санаа бодол, мэдрэмжээ илүү бүрэн илэрхийлэх боломж олгож, сувилагчийн яаруугүй, шүүмжлэлгүй, дэмжлэгтэй хандлагыг харуулдаг. Үйлчлүүлэгчдэд тэдний мэдрэмж хэвийн гэдгийг баталгаажуулж, аюулгүй, халамжтай орчинд санаа зовнилоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтойг мэдрүүлэх шаардлагатай. 1-р сонголт харилцааг шууд тасалдаг. 2-р сонголт үйлчлүүлэгчийн мэдрэмжийг түр хойш тавьдаг.
4-р сонголт асуудлыг шийдэх бүх хариуцлагыг үйлчлүүлэгчид бүрэн шилжүүлдэг.
Шалгалт өгөх стратеги: *Хамгийн зохистой* **стратегийн үгсийг** анхаараарай. Мөн үйлчлүүлэгч хүчирхийлэл яг л өчигдөр болсон мэт мэдэрч байгааг **сэдэв** болгон төвлөр. **Эмчилгээний харилцааны техникүүдийг** ашигла. Зөв сонголт нь үйлчлүүлэгчийн сэтгэл хөдлөлийг цорын ганц харгалзан үзсэн сонголт юм. Үргэлж эхлээд үйлчлүүлэгчийн сэтгэл хөдлөлийг анхаарах хэрэгтэй.
Танин мэдэхүйн чадварын түвшин:
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг хэрэгжүүлэх***:***
Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүтэн байдал***:***
Интеграцчилсан процесс: Халамж
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Эмчилгээний харилцаа
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Харилцаа; Даван туулах чадвар
Эх сурвалж: Varcarolis (2017), 355-р тал.

840. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Өөрийгөө өлгөж амиа хорлох оролдлого нь ноцтой амиа хорлох оролдлого юм. Эмчилгээний төлөвлөгөө нь үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг тусгах ёстой. Ажилтны нэгтэй нэг харьцаатай тасралтгүй ажиглалт хийх нь хамгийн сайн сонголт юм. Үйлчлүүлэгчийг эмнэлгийн халаад өмсүүлэх, хамтрагчтай нь хамт үлдэхийг хүсэх нь аюулгүй орчныг бүрдүүлэхгүй. Тусгаарлах нь эхний арга хэмжээ байж болохгүй бөгөөд хамгийн бага хязгаарлагдмал арга хэмжээг ашиглах ёстой.
Шалгалтын стратеги: **Стратегийн үг** бол *"хамгийн сайн"* юм. Анхаарлаа **сэдэв** дээр төвлөрүүл: амиа хорлох эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчийн асаргаа. 4-р сонголтыг хас, учир нь тусгаарлах нь эхний арга хэмжээ байж болохгүй. Дараа нь 1-р сонголтыг хас, учир нь үйлчлүүлэгчийг хамгаалах нь хамтрагчийн үүрэг биш. 2-р сонголтыг хас, учир нь хувцсаа тайлах нь бүх боломжит аюулгүй байдлын стратегийг хамгийн ихээр хангахгүй.
Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх
Клиентийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үйлчилгээний
орчин ***Интеграцчилсан процесс:*** Сувилахуйн процесс—хэрэгжилт
Агуулгын салбар: Сэтгэцийн эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Өөрийгөө
хорлох ***Эрхэмлэх ойлголтууд:*** Асран халамжлах;
Аюулгүй байдал ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), p.
367.

841. ***Хариулт:*** 2, 3, 5

Үндэслэл: Үйл явдлыг дахин дахин давтан амсах, сэтгэл хөдлөлөө мэдрэхгүй болох (үхэлтэй нүүр тулах), үйл явдлын дурсамж гэнэт сэргэх (хаа сайгүй нэгэн царайг харах) зэрэг нь бүгд посттравматик стрессийн эмгэгийн үед нийтлэг тохиолддог. "Би аалзны айдастай" гэх нь илүү ихээр фобитой холбоотой. "Гараа олон удаа, дахин дахин угаах хэрэгтэй" гэсэн өгүүлбэр нь обсессив-компульсив эмгэгтэй хүний түгшүүрийг бууруулах зорилготой ритуал маягийн албадлагын зан үйлүүдийг илэрхийлнэ. "Одоо юу ч идэхгүй" гэж хэлэх нь тодорхойгүй бөгөөд олон янзын нөхцөл байдлуудтай холбоотой байж болно.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт** төвлөр, посттравматик стрессийн эмгэг. Ажлын асуудалд аалзны айдас нь асуудлын нэг хэсэг гэдгийг харуулах ямар ч мэдээлэл байхгүй. Асуулгад үйлчлүүлэгчид ритуал зан үйл байгаа гэдгийг батлах мэдээлэл байхгүй. Үйлчлүүлэгч тухайн үед юу ч идэхгүй гэж мэдэгдсэн нь энэ тохиолдолд холбогдолгүй. 2, 3, 5 дугаар хариултууд нь үйлчлүүлэгч саяхан гэрт халдлага, дээрэм тохиолдсон явдлаас үүдэн сэтгэл зүйн дараах дарамтын эмгэгтэй байгааг илтгэнэ.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа үзүүлэх

орчин ***Интеграцчилсан процесс:*** Сувилахуйн процесс—

Үнэлгээний ***агуулгын салбар:*** Сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл зүйн хүнд цочролын дараах эмгэг

Эрэмбэлэх ойлголтууд: Сэтгэл түгшилт; Даван гарах чадвар

Дүгнэлт: Varcarolis (2017), 123-р тал.

БҮЛЭГ 68

Сэтгэцийн эмүүд

http://evolve.elsevier.com/Silvestri/comprehensiveRN/

Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд

Сэтгэл түгшил; Сэтгэл хөдлөл ба илэрхийлэл

I. Сайтоот серотонины дахин шимэгдэлтийг сааруулагч эмүүд (SSRIs) (68-1-р хайрцаг)

A. Тайлбар

1. Серотониний шимтгэлийг саатуулж, антидепрессант хариу үйлдэл үүсгэдэг
2. Сэтгэл түгшүүрийн шинж тэмдэгтэй депрессийн болон психомотор догдлолтой депрессийн эмчилгээнд үр дүнтэй
3. Хуучин антидепрессантууд (трициклик)тай харьцуулахад гаж нөлөө харьцангуй бага
4. Антихолинэрг нөлөө, ам хуурайших, хараа бүдгэрэх эсвэл шээс тогтох үр дагавар үүсгэдэггүй
5. Бусад эмүүдтэй (жишээ нь дигоксин, варфарин) харилцан үйлчлэл үзүүлж болно.
6. Эмийн харилцан үйлчлэлийн эрсдэл хамгийн их нь моноамин оксидазын ингибитор (MAOI) зэрэг хоёр дахь серотонин нэмэгдүүлэгч бодис хамт хэрэглэвэл үүсдэг. Эмийн бүрэн мэдээллийг цуглуулан үнэлэх шаардлагатай; ялангуяа St. John's wort зэрэг ургамлын гаралтай эмчилгээг хэрэглэсэн эсэхийг лавлах.

B. Сөрөг болон гаж нөлөө

1. Амны хуурайшилт
2. Цусны даралтын өөрчлөлт
3. Унтуулалт, нойрмоглолт (унтаатай, нойрмоглосон), апатия
4. Сэтгэл түгшилт
5. Жин хасах эсвэл нэмэгдэх
6. Ирээдүйн бэлгийн хүсэл буурах
7. Апатия
8. Чичиргээ
9. Таталт үүсэх
10. Боломжит хортой нөлөө (хэт өндөр тун эсвэл бусад эмүүдтэй харилцан үйлчлэл)
    a. Хэвлийн өвдөлт, суулгалт
    b. Хөлс их гарах, халуур
    c. Таксикарди, цусны даралт ихсэх
    d. Оюун ухааны өөрчлөлт (мунгина)

е. Миоклонус (булчингийн агшилт), хөдөлгөөний идэвхижил нэмэгдэх

С. Хэмжээ авах арга хэмжээ

1. Амин чухал үзүүлэлтүүдийг хянах, учир нь SSRI эмүүд даралт бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх боломжтой.
2. Бэлгийн үйл ажиллагааны доголдлол эсвэл бэлгийн хүсэл эрмэлзэл буурах шалтгаан болж болно. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол эрүүл мэндийн мэргэжилтнээ мэдэгдээрэй.
3. Толгой эргэх шинж илэрвэл аюулгүй байдлын арга хэмжээ авч, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэнтэй холбогдоно.
4. Клиентээс архи хэрэглэхгүй байхыг зааварлах.
5. Толгой эргэх, толгой хөнгөх шинж тэмдгийг бууруулахын тулд хөнгөн зууш эсвэл хоолтой хамт өг.
6. Өөрийгөө алах бодолтой үйлчлүүлэгчийг, ялангуяа сэтгэл санаа сайжирч, эрч хүч нэмэгдсэн үед нь хянаарай.
7. Клиентдээ ибупрофеныг SSRI-үүдтэй хамт хэрэглэх нь дээд хоол боловсруулах замын цус алдалтын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг гэж зааж өг.
8. Урт хугацааны эмчилгээнд байгаа үйлчлүүлэгчийн хувьд элэг, бөөрний үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг хянах; үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөж, тунг тохируулах шаардлага гарч болно.
9. Цагаан эс болон нейтрофилийн тоог хянаж, түвшин хэвийн доод хязгаараас доогуур буурвал эмчилгээг зогсоож болно.
10. Хэрэв даралт буурах шинж илэрвэл байрлалаа аажмаар солихыг зааварла.
11. Эмийг гэнэт зогсоохгүй байхыг үйлчлүүлэгчид зааж сургах. Гэнэт зогсоох нь хоол боловсруулах замын таагүй байдал, хөдөлгөөний эмгэг, нойргүйдэл, мэдрэхүйн алдагдал зэрэг шинж тэмдэгтэй серотонин таталтад хүргэж болно.
12. Серотонин синдромын эрсдэлд анхааралтай бай: энэ нь ихэвчлэн гиперактив эсвэл тайвангүй байдал, тахикарди, халуур, цусны даралт ихсэх, сэтгэлзүйн байдал өөрчлөгдөх (мөдриум), сэтгэл хөдлөл тогтворгүй болох, таталт, булчингийн хатууралт, хэвлийн өвдөлт зэрэг шинж тэмдэгтэй; SSRI болон MAOI-үүдийг хамт хэрэглэвэл энэ эрсдэл эрс нэмэгддэг тул эмийн хослолыг зайлсхийх шаардлагатай.
13. Рецептгүй (OTC) ханиадны эмүүд серотонин синдромын эрсдэлийг нэмэгдүүлж болзошгүйг анхааруул.
14. Жирэмсэн үед эдгээр эмүүдийг хэрэглэх талаар төрөх эмчтэй зөвлөлдөх нь зүйтэй.
15. Хүүхэд, өсвөр насныхан болон ахмад настнуудад эмийн хариу үйлдлийг нарийн ажиглах хэрэгтэй, учир нь хариу үйлдэл насанд хүрэгчийнхээс ялгаатай байж болно.
16. Сэтгэл засалын эмчилгээг дэмжинэ.
17. Серотонин-норэпинефриний дахин шимэгдэлтийг сааруулагч эмүүд (SNRI) нь SSRI-үүдтэй төстэй боловч серотонинийн нөлөөг сааруулахын зэрэгцээ норэпинефриний нөлөөг ч хаадаг.

Анхаарах зүйлс нь SSRI-үүдийнхтэй адил.

II. Гурвалсан циклийн антидепрессантууд (68-2-р хайрцаг)

A. Тайлбар

1. Пресинапсын холболтод норэпинефрин ба серотонины дахин шимэгдэлтийг хаадаг; депрессийн эмчилгээнд хэрэглэгддэг
2. Мөн бусад нейротрансмиттерүүдэд нөлөөлж, олон төрлийн гаж нөлөө үүсгэдэг
3. Таталтын босгыг бууруулж болно
4. Цусны даралт бууруулах эмийн үр нөлөөг бууруулж болно
5. Архи болон антигистамин эмүүдтэй зэрэг хэрэглэвэл төв мэдрэлийн системд дарамт үүсгэж болно.
6. MAOIs-тэй зэрэг хэрэглэвэл гипертензив криз үүсгэж болно.
7. Зүрхний хордлого үүсч болно, бүх өвчтөнүүд

лгээ эхлэхийн өмнө болон цаашид тогтмол ЭКГ-ээр хяналт тавих шаардлагатай.

8. Хэт тун нь амь насанд аюултай тул яаралтай эмчилгээ шаарддаг (хамгийн чухал сувилагчийн үйлдлүүдийг үзнэ үү).

Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх арга хэмжээ

Трицикликаар антидепрессантын хэт тун

1. Амьсгалын замыг шалгаж, нээлттэй байлга.
2. Шаардлагатай бол хүчилтөрөгч өгч, амьсгалыг дэмжих.
3. Амьсгал, зүрхний чухал үзүүлэлтүүдийг шалгаж, зүрхний хяналтыг тогтмол явуулна.
4. Электрокардиограмм ав.
5. Хэрэв залгиснаас хойш 2 цагийн дотор бол идэвхжүүлсэн нүүрстөрөгчийн хар нүүрс ашиглан ходоод угаахад бэлтгэх.
6. Зааврын дагуу судсаар шингэн эмчилгээ хийх.
7. Трициклийн антидепрессантын нөлөөг буцаахын тулд эмчийн зааврааар эм бэлдмэл хэрэглэхэд бэлтгэх.
8. Үйл явдал, авсан арга хэмжээ болон үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдлийг баримтжуул.

Дүгнэлт

Varcarolis (2017), 303-р тал.

9. Трициклик антидепрессант кломипрамин нь обсессив-компульсив эмгэгийг эмчлэхэд ашиглагдаж болно.

B. Хэлц болон гаж нөлөө

1. Антихолинэрг нөлөө: Ам хуурайших, шээхэд хүндрэлтэй болох, нүдний цөмийн тэлэгдэл, хараа бүдгэрэх, хоол боловсруулах замын хөдөлгөөн буурах, өтгөн хаталт
2. Шээс тогтолт
3. Зүрх судасны эмгэгүүд, жишээлбэл тахикардиа эсвэл ритмийн эмгэг; ортостатик гипотензи
4. Тамхилтыг мэдрүүлэх
5. Бүх биеийн таталт (бупропионтой хамт)

6. Жин нэмэх эсвэл жин хасах
7. Сэтгэл түгшил, тайвангүй байдал, уур уцаар, төөрөгдөл
8. Импульс гаргалт болон босох чадварын алдагдалтай хамт бэлгийн хүсэл буурах эсвэл нэмэгдэх
9. Трициклийн антидепрессантын (TCA) хордлогын шинж тэмдгүүд
    a. Тардиве дискинези: нүүр, эрүүний сайн дурааараа бус хөдөлгөөн
    b. Акинези: сайн дурааараа булчингийн хөдөлгөөн алдагдах
    c. Акацизия: сандрал, зовнил, тайвангүй байдлын төлөв
    d. Псевдопаркинсонизм

C. Оролцоо

1. Өөрийгөө алах бодолтой үйлчлүүлэгчийг, ялангуяа сэтгэл санаа сайжирч, эрч хүч нэмэгдсэн үед нь хянаарай.
2. Цусны даралт буурах үр нөлөөнөөс сэргийлэхийн тулд үйлчлүүлэгчид байрлалаа аажмаар солихыг зааж өг.
3. Өдөр тутмын гэдэс хөдөлгөөний хэв маягийг хянана.
4. Шээс хавхлага үүссэн эсэхийг үнэл.
5. Урт хугацааны эмчилгээнд байгаа үйлчлүүлэгчийн элэг, бөөрний үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг хянана.
6. Хоол боловсруулах замын таагүй шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд хоол эсвэл сүүтэй хамт өг.
7. Нойрсуулах нөлөөтэй тул өдөрт олгох бүх аман тунг илүүд нь орондоо орохын өмнө өг. Тунг хуваж, жишээлбэл талыг нь өглөө, талыг нь орой авахгүй.
8. Сөрөг эмийн харилцан үйлчлэлээс сэргийлэхийн тулд үйлчлүүлэгчид архи болон жороор олгодоггүй эм хэрэглэхээс зайлсхийхийг зааварла.
9. Өвчтөнд хариу тодорхойгүй байх хүртэл машин жолоодох болон сэргэлэн байдлыг шаардсан бусад үйл ажиллагаанаас зайлсхийхийг зааварлах; эмчилгээний эхэнд тайвшрал илрэх бөгөөд цаг хугацаа өнгөрөх тусам сулрах боломжтой.
10. Эмчилгээг анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэгч (PHCP) зогсоох үед тунг аажмаар бууруулан зогсоох ёстой.
11. Эмийн сангийн жоргүй ханиадны эмүүдтэй эмийн харилцан үйлчлэлийн эрсдэл байдаг.
12. Амны ариун цэврийн дэглэм баримтлах, хатуу чихэр болон ам зайлагч бодис хэрэглэхийг дэмжинэ.
13. Сэтгэл засалын эмчилгээнд уриал.

Клиентд антидепрессант эм нь хүссэн үр дүнг үзүүлэхийн тулд хэдэн долоо хоног

й байж болохыг мэдэгд (клиентийн хариу үйлдэл илрэхгүй байж магадгүй

III. Моноамины оксидазын ингибитор (MAOIs) (68-3-р хайрцаг)

A. Тайлбар

1. Тархи, цусны бүлэгнэлтийн эс, элэг, цулцаг, бөөрөнд агуулагддаг моноамин оксидаз ферментийг сааруулна
2. Моноамин оксидаза нь аминүүд (допамин, тирамин), норэпинефрин болон серотониныг задлан шингээдэг тул MAOIs хэрэглэснээр эдгээр аминүүдийн концентраци нэмэгддэг.
3. Депрессийн эмчилгээнд бусад антидепрессант эмчилгээ, тэр дундаа цахилгаан таталт эмчилгээнд хариу өгөөгүй өвчтөнд МАОИ-үүдийг заримдаа хэрэглэдэг. Гэхдээ боломжит ноцтой гаж нөлөө болон бусад эм бэлдмэлүүдийн боломжийн хувилбаруудын улмаас эдгээр эмүүд анхны сонголт биш юм.
4. Амфетамин, антидепрессант, допамин, эпинефрин, леводопа/карбидопа, хамрын суулгагч эсрэг эм, норэпинефрин, тирамин агуулсан хүнс эсвэл судас агчигч эмүүдтэй зэрэг хэрэглэвэл гипертензив хямрал үүсгэж болно.
5. Опиоид төрлийн өвчин намдаах эмүүдтэй зэрэг хэрэглэвэл гипертензи эсвэл гипотензи, кома эсвэл таталт үүсгэж болно.

B. Гаж болон сөрөг үр нөлөө

1. Ортостатик гипотензи
2. Зүрхний цохилтын давтамж ба хэмнэлд өөрчлөлт
3. Тайвангүй байдал
4. Нойргүйдэл
5. Толгой эргэх, хуйхлалт
6. Сул дорой, ядаргаа
7. Хоол боловсруулах замын таталт эсвэл өтгөн хаталт
8. Шээхэд саатал
9. Амны хуурайшилт
10. Жин нэмэгдэх
11. Периферийн хаван
12. Антихолинэрг нөлөө
13. Төв мэдрэлийн системд өдөөлт (сандрал, догдлол, маниа)
14. Бэлгийн үйл ажиллагааны доголдло

C. Гипертензив хямрал

1. Дээд цусны даралт
2. Толгойн хойд хэсгийн өвдөлт урд тийш тархана
3. Хатуурах, өвдөлт
4. Дотор муухайрах ба бөөлжих
5. Хөлөрөх
6. Халууралт ба чичирхийлэл
7. Арьс чийглэг, хөлөрсөн
8. Нүдний соёо томрох
9. Зүрх дэлсэх, тахикарди эсвэл брадикарди

10. Хэвлийг шахах мэт цээжний өвдөлт
11. Дээд даралттай хямралын эсрэг эмчилгээ: фентоламин судсанд тарьж

D. Эмчилгээний арга хэмжээ

1. Удаан хугацааны даралт ихсэлттэй үед цусны даралтаа тогтмол хянах.
2. Гипертензив хямралын шинж тэмдгүүдийг хянах.
3. Хэрэв зүрх дэлсэх эсвэл давтамжтай толгой өвдөлт илэрвэл эмчилгээг зогсоож, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP)-д мэдэгдэнэ.
4. Хоол боловсруулах замын таагүй байдал илэрвэл хоолтой хамт уулгана.
5. Эмийн үр нөлөө эмчилгээний эхний долоо хоногт илрэх боловч хамгийн их үр дүнд хүрэхийн тулд 3 долоо хоног шаардлагатай байж болохыг үйлчлүүлэгчид зааж өг.
6. Өвчтөнд толгой өвдөх, хүзүү хатуурч эсвэл хүзүү өвдөх шинж илэрвэл даруй мэдээлэхийг зааварла.
7. Ортостатик гипотензи үүсэхээс сэргийлэхийн тулд өвчтөнд байрлалаа аажмаар өөрчлөхийг зааварлах.
8. Клиентд кофеин болон жин хасах шахмал эм, халуун ногоо эсвэл томуу, харшилны эсрэг жоргүй бэлдмэл хэрэглэхээс зайлсхийхийг зааж өг.
9. Эм уух зааврыг мөрдөж буй эсэхийг хянах.
10. Эмийн дараагийн тунг товлосон цагаас 3 цагийн дотор мартагдсан тунг ууж болно; эс бөгөөс мартагдсан тунг орхиж, дараагийн тунг товлосон цагт нь уухыг зааварла.
11. Өвчтөнд MAOI эм ууж байгаагаа илтгэх MedicAlert карт авч явахыг зааж өг.
12. Эмийг оройн цагаар өгөхөөс зайлсхий, учир нь нойргүйдэл үүсч болно.
13. Эмийн хэрэглээг анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP) зогсоох тохиолдолд эмийг аажмаар зогсоох ёстой.
14. Клиентд бэлтгэх эсвэл хадгалахад бактери эсвэл мөөгөнцөр шаарддаг хүнс болон тирамин агуулсан хүнснээс зайлсхийхийг зааж өг (Зураг 68-1; Хайрцаг 68-4).

Клиентд тирамин агуулсан хоол хүнсний талаар зааж сургах. Хэрэглэх МАО ингибитор (MAOI) ууж байх үед тирамин агуулсан хоол хүнс нь гипертензив хямрал үүсгэж болно.

IV. Сэтгэл хөдлөлийг тогтворжуулагч эмүүд (68-5 дугаар хайрцаг)

A. Тайлбар: Эсийн тээвэрлэлтийн механизмийг нөлөөлж, сэргэлт эсвэл γ-аминобутир хүчил (ГАБА)-ийн үйл ажиллагааг, эсвэл аль алиныг нь нэмэгдүүлдэг бөгөөд эдгээр нь сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой

B. Лити

1. Диуретикууд, флуоксетин эсвэл стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүдтэй зэрэг хэрэглэвэл нэмэгддэг

бөөрний литийн дахин шингээлт буюу литийн ялгаралтыг хориглосноор аль нь ч литийн хордлогын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

2. Ацетазоламид, теофиллин, фенотиазинууд эсвэл натрийн бикарбонат нь бөөрөөр литийн ялгаралтыг нэмэгдүүлж, үр дүнг бууруулж болно.
3. Эмчилгээний тун нь хордлого үүсгэх тунгаас ердөө бага зэрэг доогуур байдаг.
4. Эмчилгээний тунгийн үед сийвэнгийн түвшин литийн хэмжээ 0.6–1.2 mEq/L (0.6–1.2 mmol/L) байдаг; эмчилгээний үр нөлөө үзүүлэх бодит тун болон хордлого үүсэх түвшин нь тус бүрийн өвчтөнд ихээхэн хэлбэлздэг.
5. Литийн түвшин нэмэгдэх шалтгаанд натрийн хэрэглээ буурах; хэт их хөлөрөх, шингэн дутагдал, суулгалт эсвэл диуретик эмчилгээтэй холбоотой шингэн ба электролитийн алдагдал; мөн өвчин эсвэл эм хэт тун хэрэглэх зэрэг орно.
6. Эмчилгээг эхэлсний дараа серумын литийн хэмжээг тогтмол шалгаж, дараа нь сар бүр эсвэл хоёр сар тутамд, эсвэл зан байдалд ямар нэгэн өөрчлөлт илэрсэн үед хэмжиж байх хэрэгтэй.
7. Цусны дээжийг серумын литийн хэмжээг шалгахын тулд өглөө, сүүлийн тунг авснаас хойш 12 цагийн дараа авна.
8. Литийг жирэмсний D ангилалд багтаадаг; энэ нь плацентын саадыг чөлөөтэй давж, урагийн хордлогын эрсдэлтэй холбоотой.

C. Сөрөг болон гаж нөлөө

1. Полиури
2. Полидипси
3. Хавадалт
4. Ритмийн эмгэг
5. Хоолны дуршил буурах, бөөлжих
6. Ам хуурай, хөнгөн цангалга
7. Хэвлийн хавагнал
8. Зөөлөн өт эсвэл суулгалт
9. Гарын нарийн чичиргээ
10. Анхаарал төвлөрөх чадвар алдагдах
11. Цээжний булчин сулрах
12. Толгой өвдөх
13. Гипотиреоз ба гойтер

D.

Оролцоо

1. Өөрийгөө алах эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчийг, ялангуяа ... үед хянаарай сэтгэл санаа сайжирч, эрч хүч нэмэгдсэн.
2. Эмийг хоолтой хамт өгөх замаар хоруу урвалыг багасгах

хоол боловсруулах замын цочрол.

3. Клиентд диуретик нөлөөтэй тул кофе, цай эсвэл кола хэт их хэрэглэхээс зайлсхийхийг зааж өг.
4. Клиент литийн эмчилгээнд байх үед шээс хөөх эм бэлдмэл хэрэглэхгүй.
5. Клиентд архи хэрэглэхгүй байхыг зааварла.
6. Өвчтөнд жоргүй эмийн хэрэглээг хязгаарлахыг зааж өг.
7. Өвчтөнд товлосон цагаас хойш 2 цагийн дотор мартагдсан тунг ууж болно; эс бөгөөс мартагдсан тунг орхиж, дараагийн тунг товлосон цагт нь уухыг зааж өг.
8. Литийн тунг гэнэт зогсоохгүйгээр аажмаар бууруулах шаардлагатай тул үйлчлүүлэгчид PHCP-тэй зөвлөлдөхгүйгээр тунгаа өөрчлөх эсвэл эмээ зогсоохгүй байхыг зааж өг.
9. Клиентд литийн хордлогын шинж тэмдгүүдийн талаар зааварлах.
10. Клиентээс их шээх, удаан хугацааны бөөлжих, суулгалт эсвэл халуурсан тохиолдолд анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэнд мэдэгдэхийг зааварлах.
11. Эмийн эмчилгээний хариу 1–3 долоо хоногийн дараа илэрдэгийг үйлчлүүлэгчид зааж өг.
12. ЭКГ, бөөрний үйл ажиллагааны болон бамбай булчирхайн шинжилгээг хянах (энэ шинжилгээг эмчилгээ эхлэхээс өмнө хийлгэсэн байх ёстой).
13. Жингийн хяналт тавих.

Литийн эмчилгээнд байгаа үйлчлүүлэгчид шингэн хэрэглээг 6-аас Өдөрт 8 аяга ус ууж, литийн хордлогыг сэргийлэхийн тулд хангалттай хэмжээний давс хэрэглэх.

Е. Литийн хордлого

1. Тайлбар
    a. Литийн хордлого нь биед шингэсэн литийг бөөрөөр цэвэршүүлж, ялгаруулж чадахгүй үед үүсдэг
    b. Цусны серум дахь литийн хэмжээ 1.5 mEq/L (1.5 mmol/L) хүрэхэд хордлогын шинж тэмдгүүд илэрч эхэлнэ.
2. Хөнгөн хордлого
    a. Сийвэнгийн литийн түвшин 1.5 mEq/L (1.5 mmol/L)
    b. Апатия
    c. Сул дорой байдал
    d. Анхаарал төвлөрөл буурах
    e. Хөнгөн атакси
    f. Гарааны томоохон чичиргээ
    g. Булчингийн бага зэрэг сулрал
3. Дунд зэргийн хордлого

a. Сэрийн литийн хэмжээ 1.5–2.0 mEq/L (1.5–2.0 ммол/л)
b. Дотор муухайрах, бөөлжих
c. Хүнд суулгалт
d. Хөнгөн болон дунд зэргийн атаксиа ба зохицуулалтгүй байдал
e. Үг нь тодорхой бус яриа
f. Чих шуугиан
g. Хараа бүдгэрэх
h. Цэнгэг булчингийн чичиргээ
i. Тогтворгүй чичиргээ

4. Хүнд хордлого

a. Сийвэнгийн литийн хэмжээ 2.0 mEq/L (2.0 mmol/L)-ээс их
b. Нистагмус
c. Цул айдас
d. Гүн булчингийн хэтэрхий их рефлекс
e. Хараа болон мэдрэхүйн хуурамч мэдрэмж
f. Олигури эсвэл анури
g. Ухамсрын түвшин бууралт
h. Тоник-клоник таталт эсвэл кома, үхэлд хүргэдэг

5. Литийн хордлогыг эмчлэх арга хэмжээ

a. Литийн хэрэглээг зогсоож, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP)-д мэдэгдэнэ.
b. Амьсгал, зүрхний үйл ажиллагаа болон ухамсарын түвшинг хянах.
c. Зүрхний үйл ажиллагааг хянах.
d. Литийн, электролитийн, цусны шээсний давсны азот болон креатинины түвшинг хянах дээж цуглуулах, мөн цусны ерөнхий тооллого хийхэд бэлтгэх.
e. Өөрийгөө алах хандлагыг хянаж, **амиа хорлохоос** сэргийлэх арга хэмжээ ав.

V. Сэтгэл түгшүүр бууруулах эсвэл анксиолитик эм бэлдмэлүүд

A. Тайлбар

1. Сэтгэл түгшүүр намжаах эмүүд нь төв мэдрэлийн системийг дарангуйлж, GABA-ийн үйлчлэлийг нэмэгдүүлдэг; энэ нь тайвшрал үүсгэж, лимбийн системийг дарангуйлах боломжтой.
2. Бензодиазепинууд нь сэтгэл түгшүүр бууруулах (анксиолитик), нойрсуулах-хипнотик, булчин сулруулах болон таталт эсэргүүцэх үйлдэлтэй (68-6-р хайрцаг).
3. Бензодиазепиныг хурц нарийн өнцөгт глаукоматай өвчтөнд хэрэглэхийг хориглох ба хүүхэд болон ахмад настнуудад болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай.
4. Бензодиазепинууд нь төв мэдрэлийн системийн бусад эмүүдтэй харилцан нэмэлт нөлөө үзүүлдэг тул зөвхөн богино хугацааны хэрэглээнд ашиглахыг зөвлөдөг.

5. Бензодиазепиныг гэнэт зогсоох нь амь насанд аюултай байж болох тул эмнэлгийн хяналт дор л зогсоох ёстой.

B. Гаж болон сөрөг үр нөлөө

1. Өдрийн нойрмоглолт
2. Толгой эргэх
3. Толгой өвдөх
4. Тодорхой бус эсвэл давхар хараа
5. Цусны даралт буурах
6. Чичиргээ
7. Амнези
8. Уруудаж яриа
9. Шарх эсвэл суулгалт
10. Сул дорой байдал
11. Завсрын өөрчлөлт

C. Хурц хордлого

1. Нойрмоглолт
2. Төөрөлдөх байдал
3. Рефлекс сулрах ба кома
4. Флумазенил нь венийн шугамаар тарьдаг бензодиазепин антагонист бөгөөд 5 минутын дотор бензодиазепины хордлогыг буцаадаг.
5. Бензодиазепины хэт тунгийн эмчилгээнд байгаа өвчтөн сэтгэл түгшүүр, тайвангүй байдал, таагүй мэдрэмж, сэтгэл зовнил мэдрэх боломжтой.

D. Арга хэмжээ

1. Сэршүүрэл, чичиргээ, булчингийн таталт зэрэг хөдөлгөөний хариу үйлдлийг хянаарай.
2. Хүйтэн, чийглэг гар ба хөлс гаргах зэрэг автоном мэдрэлийн хариу үйлдлийг хянаарай.
3. Эмчилгээний эхний үед, ялангуяа ахмад настнууд болон сул дорой өвчтөнүүдэд төв мэдрэлийн системийн парадоксаль сэргэлтийг хянаарай.
4. Эмийн эмчилгээ нь глаукомыг хүндрүүлэх боломжтой тул харааны алдагдалд анхаарал хандуулах.
5. Элэг, бөөрний үйл ажиллагааны үзүүлэлт болон иж бүрэн цусны тоог хянах.
6. Ахмад настай болон элэгний үйл ажиллагаа муудсан үйлчлүүлэгчийн эмчилгээний тунг заасан ёсоор бууруулна.
7. Аюулгүй байдлын арга хэмжээг авч эхлэх шаардлагатай, учир нь ахмад настнууд нойр эсвэл түгшүүрийн эм уух үед унах эрсдэлтэй.
8. Хэрэв нойрмоглолт эсвэл толгой эргэх шинж илэрвэл алхахад туслах.

9. Эмчилгээг үргэлжлүүлэх явцад нойрмоглолт ихэвчлэн арилдаг гэж үйлчлүүлэгчид зааж өг.
10. Эмийн хариу тогтоогдох хүртэл сэргэлэн байдлыг шаарддаг ажлуудыг хийхээс зайлсхийхийг үйлчлүүлэгчид зааж өг.
11. Клиентэд архин уухгүй байхыг зааварлах.
12. Үйлчлүүлэгчид анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгчтэйгээ зөвлөлдөхгүйгээр бусад эм бэлдмэл хэрэглэхгүй байхыг зааж өг.
13. Эмийг гэнэт зогсоохгүй байхыг үйлчлүүлэгчид зааж өг (таталт үүсэх эрсдэлтэй).

E. Тайвшруулах эмчилгээг зогсоох

1. Таталтын шинж тэмдгийг бууруулахын тулд бензодиазепины тунг 2–6 долоо хоногийн турш аажмаар бууруулах ёстой.
2. Гэнэт эсвэл хэт хурдан татгалзах нь дараах үр дагаврыудыг үүсгэнэ:
    a. Тайвангүй байдал
    b. Уур уцаартай байдал
    c. Унтуулах эмэнд дурлах
    d. Гараа чичирхийлэх
    e. Хэвлий эсвэл булчингийн агшилт
    f. Хөлс их гарах
    g. Бүлтрэлт
    h. Таталт

VI. Барбитур болон тайвшруулагч-хипнотик эмүүд (68-7 дугаар хайрцаг)

A. Тайлбар

1. GABA нейротрансмиттерийн хориглох синапсын үйлдлийг дэмжиж, ретикуляр идэвхжүүлэх системийг дарангуйлах
2. Нойргүйдлийг түргэн хугацаанд эмчлэх эсвэл түгшүүр, булцайсан байдал, айдсыг намжаах зорилгоор тайвшруулах зориулалттай

B. Сөрөг болон гаж нөлөө

1. Толгой эргэх, нойрмоглох
2. Төөрөгдөл
3. Уур уцаартай байдал
4. Харшилтын урвал
5. Агранулоцитоз
6. Тромбоцитопенийн пурпура
7. Мегалобласт цус багадалт

C. Хэт тун

1. Таккардиа
2. Цусны даралт багасах
3. Хүйтэн, чийглэг арьс
4. Тэлэгдсэн сормуус
5. Сул, хурдтай цохилт
6. Шокын шинж тэмдэг
7. Амьсгал сул
8. Рефлексүүд алга

9. Амьсгал болон зүрх судасны систем уналт нь кома болон үхэлд хүргэж болно.

D. Хасалтын шинж тэмдэг

1. Хүнд эмэнд донтох байдалтай хүнд эм уухыг зогсоосны дараах 24 цагийн дотор хүнд таталтын шинж тэмдгүүд илэрдэг.
2. Хамааралтай үйлчлүүлэгчийг хорт бодисоос цэвэрлэхэд эмийн хэрэглээг аажмаар зогсоох аргыг ашигладаг.
3. Сэтгэл түгшил
4. Зан үйлийн өөрчлөлтүүд
5. Унтуулах эмэнд донтох үед эмчилгээг зогсоосны дараах 24 цагийн дотор хүнд таталтны
6. Зүүд зэрэмдэглэх
7. Өдрийн сэтгэл түгшүүр
8. Чичиргээ
9. Мэдрэлийн төөрөгдөл
10. Таталт

E. Оролцоо

1. Ахмад настнуудад заасан бага тунг олгох өвчтөн.
2. Өөрийгөө хорлох хандлагатай эсвэл мансууруулах бодисын **донтолттой** түүхтэй өвчтөнд эмийг болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай.
3. Явган алхах үед хянаж, шаардлагатай үед шөнийн цагаар орны хажуугийн хашлага ашиглан аюулгүй байдлыг хангана.
4. Клиентээс эмийг зааврaар нь уухыг зааж өг.
5. Хэрэв нойрмоглолт, толгой эргэлт эсвэл тэнцвэргүй байдал илэрвэл үйлчлүүлэгчид машин жолоодох болон аюултай тоног төхөөрөмж ажиллуулахгүй байхыг зааварла.
6. Клиентэд архи хэрэглэхгүй байхыг зааварла, учир нь энэ нь эмийн илүү их хэмжээг тархинд нэвтрүүлж, сэтгэл гутрал, нойрмоглолт, толгой эргэлт, амьсгал удаашрах, хүндрэлтэй амьсгал, төөрөгдөл болон кома үүсгэдэг.
7. Нойргүйдэлтэй өвчтөнд эмийг унтахынхаа өмнө 30 минутын өмнө ууж, шингээлтийг сайжруулахын тулд их хэмжээний хоол хүнстэй хамт уухаас зайлсхийхийг зааварла.
8. Өглөө согтуурруулах ундааны дараах шинж тэмдэг илрэх боломжтойг үйлчлүүлэгчид зааж өг.
9. Эмийг гэнэт зогсоохгүй байхыг үйлчлүүлэгчид зааж өг.
10. Хлорал гидрат ууж буй өвчтөнд хоол болон нэг аяга дүүрэн ус, жимсний шүүс эсвэл имбирийн сода уухыг зааж өгөх ба ингэснээр ходоодны цочролоос сэргийлнэ.

VII. Антипсихотик эмүүд (68-8-р хайрцаг)

A. Тайлбар

1. Психозын шинж тэмдэгтэй үйлчлүүлэгчийн бодлын үйл явц, зан үйлийг сайжруулах, ялангуяа шизофренитэй үйлчлүүлэгчдэд

2. Тархины допамин рецепторуудад нөлөөлж, психозын шинж тэмдгүүдийг бууруулна
3. Энгийн антипсихотик эмүүд шизофренийн эерэг шинж тэмдгүүд, тухайлбал галлюцинаци, довтолгоо, төөрөгдөлд илүү үр дүнтэй; мөн эдгээр эмүүд тархины химийн рецепторын өдөөгч бүс болон бөөлжих төвийг хааж, бөөлхийн эсрэг үйлчлэл үзүүлдэг.
4. Атипик антипсихотик эмүүд шизофренийн сөрөг шинжүүд, тухайлбал аволици, апати, алогиад илүү үр дүнтэй байдаг.
5. Антипсихотик эмүүдийн нөлөө нь төв мэдрэлийн системд үйлчилдэг бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэвэл нэмэгддэг.

B. Сөрөг болон гаж нөлөөнүүд (68-9-р хайрцаг)

C. Экстрапирамид синдром: Паркинсонизм, дистони, акацизия эсвэл тардиве дискинезийг агуулж болно (68-9-р хайрцгийг үзнэ үү)

D. Эмчилгээний арга хэмжээ

1. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг хянах.
2. Нейролептик хорт хам шинжийн шинж тэмдгүүдийг хянах (антипсихотик эмүүд хэрэглэснээр үүсч болно); VIII хэсгийг үзнэ үү.
3. Шээсний гаралтыг хянах.
4. Цусны глюкозын түвшинг хянах.
5. Хоол эсвэл сүүтэй хамт эм уулгаснаар ходоодны цочролыг бууруулна.
6. Амны аргаар хэрэглэхэд шингэн хэлбэр илүү тохиромжтой байж болно, учир нь зарим үйлчлүүлэгчид шахмалыг залгихаас зайлсхийхийн тулд амандаа нууж үлдээдэг.
7. Амны хөндийд хэрэглэх шингэн хэлбэрийн эм нь шимэгдэх хурд нь илүү өндөр.
8. Концентрат шингэнтэй арьс нь холбогдохоос сэргийлэхийн тулд арьстай холбоотой харшлагаас зайлсхий.
9. Шилэн концентратыг гэрлээс хамгаалаарай.
10. Шингэн концентратыг жимсний шүүсээр шингэл.
11. Эмийн зааврыг мөрдөхөд хүндрэлтэй үйлчлүүлэгчдэд Риспердал Конста-гийн тарьдаг хэлбэрийг хоёр долоо хоног тутамд тарьж өгдөг.
12. Эмийн бүрэн эмчилгээний үр нөлөө эмчилгээг эхэлснээс хойш 3–6 долоо хоногийн дараа илрэхгүй байж болохыг үйлчлүүлэгчдэд мэдэгд; гэвч 7–10 хоногийн дараа ажиглагдах эмчилгээний хариу илрэх боломжтой.
13. Эмийн зарим төрөл нь шээсний өнгөнд хоргүйгээр ягаан, улаан-бор өнгөтэй болгох өөрчлөлт үүсгэж болдгийг үйлчлүүлэгчдэд мэдэгдээрэй.
14. Гадаа байх үед нарны тос, малгай, хамгаалалтын хувцас хэрэглэхийг зааварлах.

15. Клиентээс архи болон төв мэдрэлийн системийн бусад депрессант бодис хэрэглэхээс зайлсхийхийг зааварла, учир нь эдгээр бодисууд эмний илүү их хэмжээг тархинд нэвтрүүлж, депрессийн мэдрэмж, нойрмоглолт, толгой эргэлт, амьсгал удаашрах, хүндрэлтэй амьсгал, төөрөгдөл болон комын байдал үүсгэдэг.
16. Ортостатик гипотензи үүсэхээс сэргийлэхийн тулд өвчтөнд байрлалаа аажмаар өөрчлөхийг зааварла.
17. Клиентээс агранулоцитозын шинж тэмдгүүд болох хоолой өвдөх, халуурал, ерөнхий сулралыг мэдээлэхийг зааварлах.
18. Өвчтөнд элэгний үйл ажиллагааны алдагдалын шинж тэмдгүүд болох арьс, нүдний шарлалт, ерөнхий сулралт, халуурсан байдал, баруун дээд хэвлийн өвдөлтийг мэдээлэхийг зааж өг.
19. Антипсихотик эмчилгээг зогсоох үед тунг гэнэт сэргэхээс сэргийлэхийн тулд аажмаар бууруулах шаардлагатай.

Антипсихотик эм ууж буй үйлчлүүлэгчид экстрапирамид болон бусад сөрөг нөлөөг хянах.

VIII. Нейролептингийн хорт хам шинж

A. Тайлбар

1. Нейролептик (антипсихотик) эмчилгээ (ихэвчлэн эхний үеийн антипсихотикууд) явцад эмчилгээний аль ч үед үүсч болох, амь насанд аюултай хам шинж.
2. Ховор боловч нейролептик хорт хам шинж ихэвчлэн эмчилгээг эхлэх үед, өвчтөнийг нэг эмээс нөгөө эм рүү шилжүүлсний дараа, тунг нэмсний дараа эсвэл эмүүдийн хослолыг хэрэглэх үед илүү түгээмэл тохиолддог.

B. Үнэлгээ

1. Амьсгал давчдах буюу амьсгалын хурдассан байдал
2. Тахикарди эсвэл тогтворгүй зүрхний цохилт
3. Автоном мэдрэлийн үйл ажиллагааны доголдло
    a. Хэт халуурлын хам шинж
    b. Дээд цусны даралт
    c. Тахикарди
    d. Хурдассан амьсгал
    e. Диафорез
    f. Шүлс гоожих
4. Дээд эсвэл доод цусны даралт
5. Хэт сулралт эсвэл ядаргаа
6. Ухамсарын түвшин өөрчлөгдөх
7. Таталт
8. Хүнд экстрапирамидаль гаж нөлөө ба сөрөг үр дагаврууд
9. Скелетийн булчингийн хатуурал

10. Залгихад хүндрэл
11. Окулогирик криз
12. Цагаан эсүүдийн тоо өндөр, элэгний үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон креатинфосфокиназын түвшин

C. Арга хэмжээ

1. PHCP-д мэдэгдээрэй.
2. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралтыг хянах.
3. Аюулгүй байдлын болон таталтын эсрэг арга хэмжээг авч эхлүүлнэ.
4. Эмийн хэрэглээг зогсоох бэлтгэл хийх.
5. Ухамсарын түвшинг хянах.
6. Жороор заасан дагуу халуун цацруулдаг эм өг.
7. Биеийн температурыг бууруулахын тулд хөргөлтийн хөнжил ашигла.
8. Электролитийн түвшинг хянах ба зааврын дагуу судсаар шингэн эмчилгээ хийх.
9. Гүн судасны тромбоз (DVT) болон рабдомиолизис зэрэг хүндрэлүүдийг хянах.

IX. Анхаарал дутагдал/илүүдэл хөдөлгөөний эмгэгт зориулсан эмүүд (68-10-р хайрцаг)

A. Анхаарал дутуу болон хэт идэвхитэй зан авирыг бууруулах, анхаарал төвлөрөх хугацааг уртасгахын тулд эмчилгээ шаардлагатай байж болно.

B. Энэхүү эмгэгийг хянах хамгийн үр дүнтэй эмүүд нь төв мэдрэлийн системийн сэргээгч эмүүд юм.

C. Төв мэдрэлийн системийн сэргээгч эмүүд нь насанд хүрэгчдэд сэтгэл хөдлөл, идэвхийг нэмэгдүүлдэг бол анхаарал дутагдал/илүүдэл хөдөлгөөний эмгэгтэй хүүхдүүдэд тайвшруулах нөлөө үзүүлж, сэрэмжтэй байдал болон өдөөлтөд мэдрэг байдлыг нэмэгдүүлдэг.

D. Сөрөг болон гаж нөлөө

1. Тахикарди
2. Анорексиа ба жин алдалт
3. Цусны даралт ихсэх
4. Толгой эргэх
5. Тэвдүүр

E. Хөндлөнгийн арга хэмжээ

1. Төв мэдрэлийн системийн болон гаж нөлөөг хянах.
2. Эхний ЭКГ-ийг ав.
3. Цусны даралтыг хянах.
4. Хүүхэд болон эцэг эхэд нь жоргүй эмийн хэрэглээг зайлсхийхийг зааж өг.
5. Хүүхэд болон эцэг эхэд өдрийн сүүлийн тунг унтахынхаа өмнө дор хаяж 6 цагийн өмнө (удаан хугацааны үйлчлэлтэй хэлбэрүүдийн хувьд 14 цагийн өмнө) уухыг зааж өгөх ба ингэснээр нойргүйдэл үүсэхээс сэргийлнэ.
6. Өндөр, жинг хянах (ялангуяа хүүхдэд).
7. Эмчилгээний үр нөлөө илрэхийн тулд хэдэн долоо хоногийн эмчилгээ шаардлагатай байж болохыг онцлон сануулах.
8. Эмчилгээгүй хугацаа зааж өгөх боломжтойг үйлчлүүлэгч болон эцэг эхэд нь тайлбарлаж, энэ нь

эмчилгээг үргэлжлүүлэх шаардлага, мөн эмийн гаж нөлөөг түр зуур арилгах зорилгоор эмийн завсарлага өгөх боломжтойг тайлбарлана; эмийн гаж нөлөөнд ихэвчлэн нойр хойшлуулах, өлсгөлөнг бууруулах, эмчилгээнд дасал үүсэх зэрэг ордог.

X. Альцгеймерийн өвчнийг эмчлэх эм бэлдмэлүүд (68-11-р хайрцаг)

A. Ацетилхолинэстераз хориглогч эмүүдийг Альцгеймерийн өвчтэй хүмүүст эхний шатанд когнитив үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ашиглаж болно.

B. Донепезил

1. Ацетилхолинэстеразын хориглогч нь Альцгеймерийн өвчний хөнгөн болон дунд зэргийн деменцийг эмчлэхэд ашиглагддаг
2. Сөрөг болон гаж нөлөөнд бөөлжис хүрэх, суулгалт орно.
3. Донепезил нь ваготоник нөлөөгөөр зүрхний цохилтыг удаашруулж чадна.

C. Галатамин

1. Альцгеймерийн өвчний хөнгөн болон дунд зэргийн деменцийг эмчлэхэд ашиглагддаг холинэстеразын ингибитор
2. Сөрөг болон гаж нөлөөнд дотор муухайрах, бөөлжих, суулгалт, хоолны дуршил буурах, жин алдах зэрэг орно.
3. Галатамин бронхыг агшаах үйлдэл үзүүлж болох тул астма болон архаг обструктив уушгины өвчтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай.

D. Мемантин

1. N-метил-$_d$-аспарт (NMDA) рецепторын антагонист нь Альцгеймерийн өвчний дунд зэргийн болон хүнд зэргийн деменцийг эмчлэхэд зааварлагддаг
2. Сөрөг болон гаж нөлөөнд толгой эргэх, толгой өвдөх, төөрөгдөх, өтгөн хаталт орно.
3. Мемантинийг амантадин эсвэл кетамин зэрэг бусад NMDA рецепторын антагонистуудтай хамт хэрэглэж болохгүй; ийм хослолууд нь хүсээгүй нэмэлт нөлөө үүсгэдэг.
4. Натрийн бикарбонат болон шээсийг шүлтлэг болгодог бусад эмүүд нь мемантинийн бөөрөөр ялгартыг бууруулж, биед хортой хэмжээгээр хуримтлагдах эрсдэл үүсгэдэг.
5. Бөөрний үйл ажиллагаа муудсанаар клиренс буурдаг тул болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай.

E. Ривастигмин

1. Колинэстераз хориглогч нь Альцгеймерийн өвчний хөнгөн болон дунд зэргийн деменцийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг
2. Сөрөг болон гаж нөлөөнд бөөлжис, бөөлжих, суулгалт, хоолны дуршил буурах, биеийн жин буурах зэрэг орно.
3. Хоолтой хамт уух нь хоол боловсруулах замын гаж нөлөөг бууруулна.
4. Ривастигминийг ходоодны шархлаа, брадикарди, синусын өвчний синдром, шээс хаагдах, уушгины өвчтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй

учир нь холинергик дамжуулалтыг нэмэгдүүлж, эдгээр эмгэгийн шинж тэмдгүүдийг улам хурцруулдаг.

68-1-р хайрцаг

Дахин авахын хориглогчид

Сэлэктив серотонин дахин шингээх дарангуйлагчид

- Циталопрам
- Эциталопрам
- Флуоксетин
- Флувоксамин
- Пароксетин
- Сертралин
- Вилазодон

Серотонин-норэпинефриний дахин шимэгдэлтийг сааруулагчид

- Десвенлафаксин
- Дулоксетин
- Левомилнаципран
- Венафаксин

Атипик антидепрессантууд

- Бупропион
- Миртазапин
- Нефазодон
- Тразодон
- Вортиоксетин

Хаяг 68-2

Гурванцикл антидепрессантууд

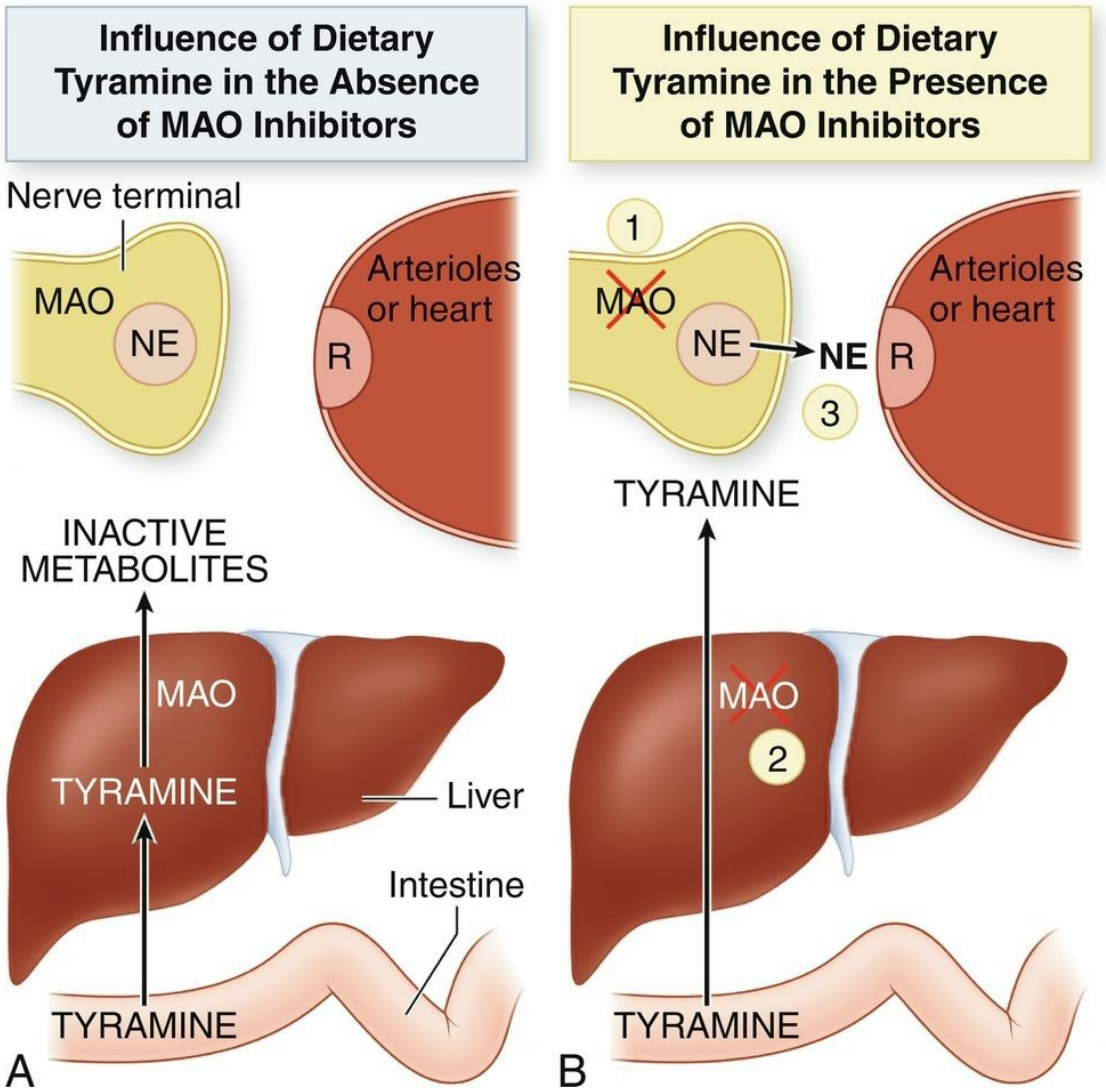
- Амитриптилин
- Амоксапин
- Кломипрамин
- Дезипрамин
- Доксепин

- Имипрамин
- Нортриптилин
- Протриптилин
- Тримипрамин

Хаяг 68-3

Моноамины оксидазын саатуулагчид (MAOIs)

- Изокарбоксазид
- Фенелзин (Канад улсад хэрэглэхэд зөвшөөрөгдөөгүй)
- Селегилин
- Транилципромин



Зураг 68-1 Хоол хүнсэнд агуулагдах тирамин ба моноамин оксидаза ингибиторууд (MAOIs)-ийн харилцан үйлчлэл. **A,** MAOIs байхгүй үед холлосон тирамин ихэнх нь идэвхгүйждэг

энтерогийн хана дахь MAO (зурагт үзүүлээгүй). Энтерогийн хана дахь MAO-ээр метаболизмд ороогүй хоол хүнсний тирамин шууд элгэнд дамжин, тэнд элэгний MAO-ээр даруй идэвхгүйждэг. Тирамин ерөнхий эргэлтэд орохгүй. **Б,** MAOIs-ийн орчинд гурван үйл явц явагддаг: (1) нейроны MAO-ийг саатуулах нь симпатик мэдрэлийн терминал дахь норэпинефрин (NE)-ийн түвшинг нэмэгдүүлдэг; (2) гэдэс болон элэгний MAO-г саатуулах нь хоол хүнсээр орсон тираминыг гэдэсний хана болон элэгнээс дамжин гэмтэлгүйгээр ерөнхий эргэлтэд орох боломжийг олгодог; (3) периферийн симпатик мэдрэлийн төгсгөлд хүрэхэд тирамин хуримтлагдсан норэпинефриний нөөцийг чөлөөлж, их хэмжээний судас агшилт болон зүрхний хэт их өдөөлтийг үүсгэдэг. *R* – норэпинефриний рецептор.

Бох 68-4

Тирамин агуулсан хүнс

- Авокадо
- Гавайн самрыг
- Үхрийн эсвэл тахианы элэг
- Шар айрагны мөөгөнцөр
- Өргөн шош
- Кофеин, жишээлбэл кофе, цай эсвэл шоколад
- Бяслаг, ялангуяа боловсорсон, коттеж бяслаг үл хамаарах
- Барбарис
- Инжир
- Махны экстракт болон зөөлрүүлэгч бодисууд
- Хэт боловсорсон жимс
- Папайя
- Хиамдсан халим
- Хуурайсан усан үзэм
- Улаан дарс, шар айраг, шери
- Хиамт байцаа
- Утсан мах, болонья, пепперони, саламя
- Сүүн цөцгий
- Сояны соус
- Йогурт

Анхаар: MAO ингибитор (MAOI) эм ууж буй өвчтөн эдгээр хоол хүнснээс зайлсхийх шаардлагатай. Цөөн хэмжээний тирамин ч цусны даралт болон зүрхний агшилтын хүч ба/эсвэл давтамжийг нэмэгдүүлж болно.

Хаяг: 68-5 дугаар хайрцаг

Сэтгэл хөдлөлийг тогтворжуулагч эмүүд

Литийн бэлдмэл

- Литийн карбонат

Бусад сэтгэл хөдлөлийг тогтворжуулагч эмүүд

- Арипипразол
- Брекспипразол
- Карбамазепин
- Клозапин
- Габапентин
- Ламотрижин
- Оланзапин
- Оланзапин/флуоксетин
- Окскарбазепин
- Палиперидон
- Кветиапин
- Рисперидон
- Вальпроат
- Зипрасидон

Хаяг 68-6

Бензодиазепинууд

- Альпразолам
- Хлордиазепоксид
- Клоназепам
- Клоразепат
- Диазепам
- Лоразепам
- Мидазолам
- Темезепам
- Триазолам

Бензодиазепин бус сэтгэл тогтоох эм

- Буспирон

Хаяг 68-7

Барбитурат ба тайвшруулагч-унтааруулагч эмүүд

Барбитурат

- Фенобарбитал
- Секобарбитал

Тайвшруулагч-унтаах эмүүд

- Хлорал гидрат
- Эзопиклон
- Мепробамат
- Рамелтеон
- Суворексант
- Тасимелтон
- Залеплон
- Золпидем

Хаяг 68-8

Антипсихотик эмүүд

Уламжлалт антипсихотик эмүүд

- Хлорпромазин
- Флуфеназин деканоат
- Галоперидол
- Перфеназин
- Трифлуоперазин

Атипик антипсихотик эмүүд

- Арипипразол
- Асенапин
- Брекспипразол
- Карипразин
- Клозапин
- Лурасидон
- Оланзапин
- Палиперидон
- Пимавансерин
- Кветиапин
- Рисперидон
- Зипрасидон

Хаяг 68-9

Антипсихотик эмийн гаж болон сөрөг нөлөөллүүд

Антихолинэрг нөлөөлөл

- Ам хуурайших
- Зүрхний цохилт хурдасгах
- Шээс тогтох
- Хатуулаг
- Цусны даралт буурах

Экстрапирамид үр нөлөө

- Паркинсонизм
- Чичиргээ
- Маск маягийн царай
- Хатуурал
- Ялзмаг алхалт
- Залгилах хүндрэл
- Шүлс гоожих

Дистониа

- Хэвийн бус эсвэл хүсээгүй нүдний хөдөлгөөнүүд, түүний дотор окулогойрик хямрал
- Нүүрний муухайрах
- Бүдүүн бие эсвэл бусад булчингийн бүлгийн мурийлт

Акатезиа

- Тайвангүй байдал
- Тасралтгүй хөдөлж байх

Тардив дискинези

- Хатуу булчирхайн булчирхайлаг ялгаралт
- Зажлах хөдөлгөөн
- Бие болон гар хөлний сайн дурааараа бус хөдөлгөөнүүд

Бусад болон сөрөг нөлөөллүүд

- Нойрмоглолт
- Цусны эмгэгүүд
- Сарьсалзуур
- Гэрэлд мэдрэгшил
- Цусан дахь глюкозын хэмжээ өндөр
- Жин нэмэгдэх
- Биеийн температурын зохицуулалт алдагдах
- Гинекомасти
- Хөхний сүүний ялгаралт

Хайрцаг 68-10

Анхаарал дутуу болон хэт идэвхитэй байдлын эмгэгт зориулсан эм бэлдмэлүүд

- Амфетамин
- Атомокситин
- Дексметилфенидат
- Декстроамфетамин
- Декстроамфетамин ба амфетамин
- Гванфацин
- Лиздексамфетамин
- Метилфенидат

Хаяг 68-11

Альцгеймерийн өвчнийг эмчлэх эм бэлдмэлүүд

- Донепезил
- Галатамин
- Мемантин
- Ривастигмин

Давтлагын асуултууд

842. Клиентийн эмийн хуудас сертралин эм бичигдсэн байна. Эмийг аюулгүйгээр олгохын тулд сувилагч тунг хэрхэн олгох ёстой вэ?
    1. Хоосон ходоодонд
    2. Оройн цагаар тогтмол цагт

3. Өдөрт тэнцүү зайтай
4. Клиент сэтгэл гутралтай гэж гомдоллосон үед шаардлагатай үед

843. Шизофренитэй өвчтөнд клозапин эмчилгээг эхлүүлсэн. Сувилагч нь энэ эмийн гаж нөлөөг хянахын тулд ямар лабораторийн шинжилгээний үр дүнг үнэлэх ёстой вэ?
1. Плателет эсийн тоо
2. Цусан дахь глюкозын хэмжээ
3. Элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ
4. Цагаан эсүүдийн тоо

844. Өвчтөнийг эмнэлгээс гарах төлөвлөгөөтэй бөгөөд удаан хугацаагаар фенобарбитал уух болно. Сувилагч өвчтөнд заахдаа өвчтөний аюулгүй байдлыг шууд хамаарах агуулгыг **хамгийн өндөр ач холбогдол**той гэж үзэх ёстой.
1. Эмийг зөвхөн хоолны үед уух.
2. Эмийг өдөр бүр тогтмол цагт уух.
3. Эм уухыг мартсанаас сэргийлэхийн тулд тусгай хэмжээст сав ашигла.
4. Энэ эм ууж байх үед архи уухгүй байх.

845. Сувилагч амитриптилин ууж буй үйлчлүүлэгчдээ эмийн гаж болон сөрөг үр нөлөөг тайлбарлаж байна. Сувилагч хэлэлцүүлэгтээ ямар мэдээллийг оруулах ёстой вэ?
1. Өндөр ширхэглэгтэй хоол хүнс хэрэглэхгүй.
2. Хоол хүнсэнд шингэн болон эслэгийн хэмжээг нэмэгдүүл.
3. Зүрх хурдан цохилох үед амрах.
4. Шээхэд хүндрэлтэй бол алхаарай, учир нь энэ нь хэвийн гаж нөлөө юм.

846. Сувилагч шизофренитэй, эмнэлгээс гарах товтой үйлчлүүлэгчид рисперидон өгч байна. Гарахаас өмнө сувилагч үйлчлүүлэгчид ямар заавар өгөх ёстой вэ?
1. Хангалттай нарны гэрэл ав.
2. Энгийн үедээ адил жолоо барьсаар бай.
3. Калийн агууламж өндөр хоол хүнснээс зайлсхий.
4. Байрлалаа өөрчлөхдөө аажмаар босох.

847. Сувилагч имипрамин эмчилгээг эхлэх гэж буй үйлчлүүлэгчид эмийн талаар зааварчилгаа өгч байна. Эмчилгээг эхэлснээс хойш хэдэн хугацаанд хамгийн их хүссэн үр нөлөөг хүлээж байхыг үйлчлүүлэгчид мэдээлэх ёстой вэ?
1. 2 сарын дараа
2. 2–3 долоо хоногийн дотор
3. Эхний долоо хоногт
4. Эмчилгээний зургаа дахь долоо хоногт

848. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөнд сэтгэл гутралыг эмчлэх зорилгоор моноамин оксидазын ингибитор (MAOI) эмчилгээг эхлүүлжээ. Сувилагч нь энэ эмийг ууж байх үед аль хүнснүүдийг хэрэглэх нь зохистойг өвчтөнд зааж өгөх ёстой вэ? **Хамаарах бүхнийг сонгоно уу.**
1. Жизжиг
2. Йогурт
3. Крэкерс
4. Хуучирсан бяслаг

5. Шарсан салат

6. Оатмилийн сам хорхойтой жигнэмэг

849. Сувилагч шизофренитэй, антипсихотик эмчилгээ авч буй үйлчлүүлэгч телевиз үзэхдээ ам хөдөлгөж, хэлээ гаргаж, нүүрний булчинг чангалж байгааг анзаарлаа. Сувилагч үйлчлүүлэгч ямар эмийн хүндрэлтэй тулгарч байгааг тодорхойлох вэ?

1. Паркинсонизм
2. Тардив дискинези
3. Гипертензив хямрал
4. Нейролептик хорт хам шинж

850. Сувилагч нэг сарын өмнө эмнэлгээс гарсан үйлчлүүлэгчтэй дагалдах сургалтын хичээл явуулж байна. Үйлчлүүлэгч флуоксетин ууж байна. Энэ айлчлалын үеэр сувилагчид эмийн гаж болон сөрөг үр дагаварын талаар ямар мэдээлэл авах нь чухал вэ?

1. Зүрх-судасны шинж тэмдгүүд
2. Хоол боловсруулах замын үйл ажиллагааны доголдлууд
3. Амны хуурайшилттай холбоотой асуудал
4. Их хөлрөхтэй холбоотой асуудал

851. Буспироныг нэг сарын турш ууж байсан өвчтөн дагалдах үнэлгээндээ клиникэд эргэн ирэв. Сувилагч эм **үр дүнтэй** гэж дүгнэхдээ ямар илрэх шинж тэмдэг байхгүй байх ёстой вэ?

1. Параноидын бодлын процесс
2. Зүрхний цохилт хурдасгах эсвэл түгшүүр
3. Архины таталтны шинж тэмдэг
4. Бодол цацагдах эсвэл төөрөгдөл

852. Литийн бэлдмэл хэрэглэж буй өвчтөн бөөлжис, хэвлийн өвдөлт, суулгалт, хараа бүдгэрэх, чих шуугих, чичиргээн мэдрэгдэж байна гэж мэдэгдэв. Литийн түвшин 2.5 mEq/L (2.5 mmol/L) байна. Сувилагч энэ түвшинг ямар үзүүлэлтээр үндэслэн асаргаа төлөвлөх вэ?

1. Хоруу
2. Энгийн
3. Нормаас бага зэрэг өндөр
4. Хэвийн хэмжээнээс хэт доогуур

853. Клиент гэрийн эрүүл мэндийн сувилагчид кломипрамины нэг шил өгдөг. Сувилагч тус эмийг клиент хоёр сарын турш хэрэглээгүйг тэмдэглэв. Энэ эмийн зааврыг дагаагүйг батлах клиентийн ямар зан үйл ажиглагдсан бэ?

1. Унтаж чадахгүй тухай гомдол
2. Өлсгөлөн ба ядаргааны гомдол
3. Минутанд 60 цохилтоос бага зүрхний цохилт
4. Гарын арьсыг халуун, савантай усаар олон удаа угаах

854. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгч сэтгэл гутрал эмчлэх эм болгон бупропион ууж эхэлсэн.
Сувилагч нь үйлчлүүлэгч хэт их эм хэрэглэж байгааг илтгэх гаж нөлөөг тодорхойлно уу?

1. Шархла
2. Таталт үүсэх үйл ажиллагаа
3. Жин нэмэгдэх
4. Босох үед толгой эргэх

855. Трицикликаар антидепрессант эмчилгээ авч буй үйлчлүүлэгч сэтгэцийн эрүүл мэндийн клиникэд ирлээ. Ямар ажиглалт нь үйлчлүүлэгч эмийн төлөвлөгөөг зөв дагаж мөрдөж байгааг харуулах вэ?

1. Клиент сүүлийн долоо хоногт ажилдаа яваагүй гэж мэдэгдэв.
2. Клиент "юу ч хийж чадахгүй" болсон гэж гомдоллож байна.
3. Клиент эмнэлэгт цэвэрхэн, зохистой төрхтэй ирсэн.
4. Клиент шөнөд 12 цаг, өдөрт 3–4 цаг унтдаг гэж мэдэгдэв.

Хариултууд

842. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Сертралин нь антидепрессант ангилалд багтдаг. Сертралиныг ерөнхийдөө 24 цаг тутамд нэг удаа өгдөг. Эмийг өглөө эсвэл орой өгөх боломжтой ч нойрмоглох нь гаж нөлөө тул оройн цагаар өгөх нь илүү тохиромжтой. Хоол боловсруулах замын таагүй байдал үүсвэл хоолтой эсвэл хоолгүй өгөх боломжтой. Сертралиныг хэрэгцээ гарсан үед хэрэглэх зориулалтаар бичиж өгдөггүй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт,** сертралин хэрэглэхэд анхаарлаа төвлөрүүл. Энэ эм нь өдөр бүр уух антидепрессант гэдгийг санахад зөв сонголтыг хийхэд тусална.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал

Нэгтгэсэн процесс: Сувилахуйн процесс—Хэрэгжилт

Агуулгын салбар: Фармакологи: Психотерапевтик эмчилгээ: Сэлэктив серотонин дахин шингээх хориглогчид (SSRIs)

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд ***Гол ойлголтууд:*** Сэтгэл хөдлөл ба илэрхийлэл; Аюулгүй байдал ***Дүгнэлт:*** Burchum, Rosenthal (2016), 346–347-р тал.

843. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Клозапин хэрэглэж буй өвчтөнд агранулоцитоз үүсч болох бөгөөд үүнийг цагаан эсүүдийн тоог шалгах замаар хянадаг. Хэрэв цагаан эсийн тоо 3000 мм^3(3 × 10^9/л)-ээс бага бол эмчилгээг зогсоодог. Агранулоцитоз илрээгүй, эмчилгээ хийгдээгүй тохиолдолд амь насанд аюултай. Бусад лабораторийн шинжилгээ нь энэ эмийн хэрэглээтэй шууд холбоогүй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Энэхүү эмийн** хэрэглээтэй холбоотой хүндрэл болох клозапины агранулоцитозыг анхаарах. Энэ эм агранулоцитоз үүсгэдгийг санаарай; энэ нь таныг зөв хариулт руу хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал: Антипсихотик эмүүд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Скизофрени

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Эсийн зохицуулалт; Психоз

Эшлэл: Varcarolis (2017), 48, 264-р хуудас.

844. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Фенобарбитал нь таталт эсэргүүцэгч ба нойрсуулах эм юм. Энэ эмийг хэрэглэж байх үед архи зэрэг төв мэдрэлийн системийн дарамтлагч бодисыг хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Эмийг хоол хүнснээс үл хамааран өгч болно. Эмийг өдөр бүр тогтмол цагт уух нь эмчийн зааврыг чандлан биелүүлэхэд болон цусан дахь эмийн тогтвортой түвшинг хадгалахад тустай. Тундаа сав буюу "pillbox" ашиглах нь зарим үйлчлүүлэгчдэд тустай байж болно.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэвт** анхаарлаа төвлөрүүлж**,** үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангаж, **стратегийн үгс болон** *хамгийн өндөр ач холбогдлыг* тэмдэглэнэ. 1-р сонголтыг **хаалттай**, *зөвхөн үгтэй* тул хасна. 2, 3-р сонголтууд нь зөв заавар боловч өгөгдсөн сонголтуудаас хамгийн өндөр ач холбогдолгүй тул хасна. Унтах эм ууж байх үед архи уухгүй байх ёстойг санаарай, учир нь архи нь сөрөг нөлөөтэй.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Хэрэгжүүлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа сувиллын орчин

Интеграцчилсан процесс: Заах ба суралцах

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал эмчилгээний эм: Барбитур болон тайвшруулах-хипнотик эмүүд

Эрүүл мэндийн асуудал: Хамааралгүй

Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд: Үйлчлүүлэгчийн боловсрол; Аюулгүй байдал

Дүйнз: Hodgson, Kizior (2018), 932-933-р хуудас

845. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Амитриптилин нь өтгөн хаталт үүсгэдэг тул үйлчлүүлэгчид шингэн хэрэглээ болон өндөр ширхэглэгтэй хоол хүнсээр хоолны хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зааварласан. Хэрэв зүрх хурдан цохилох бол эхний ээлжийн эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP)-д мэдэгдэнэ, учир нь энэ нь сөрөг нөлөө байж болно. Шээхэд хүндрэлтэй байх нь сөрөг нөлөө бөгөөд шээх боломжгүй байдал (urinary retention)-ийг илтгэнэ; үүнийг мөн мэдээлэх ёстой.

Шалгалт өгөх стратеги: Амитриптилиний **сэдэв,** гаж болон таагүй үр дагаварт анхаарлаа төвлөрүүл. Энэхүү эмийн гаж нөлөө нь өтгөнд хатах явдал гэдгийг санахад таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин:

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг хэрэгжүүлэх***:***

Физиологийн бүрэн бүтэн байдлын ***нэгдмэл процесс:***

Заах ба сурах

Агуулгын салбар: Фармакологи: Психотерапевтик эмчилгээ: Трицикликаль антидепрессантууд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд. ***Эрхэмлэх ойлголтууд:*** Үйлчлүүлэгчийн боловсрол; Аюулгүй ***байдал. Лавлагаа:*** Burchum, Rosenthal (2016), 263-р тал.

846. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Рисперидон ортостатик гипотензи үүсгэж болно. Энэ эм ууж буй өвчтөн нарны шууд туяанаас зайлсхийх ёстой. Ямар ч сэтгэц нөлөөлөх эм хэрэглэх үед (жишээлбэл жолоо барих эсвэл анхаарал шаардсан бусад үйл ажиллагаанд) болгоомжтой хандах шаардлагатай

сэрэмжтэй байдал) хүртэл тухайн хүн сэрэмжтэй байдлын түвшин нь нөлөөлөгдсөн эсэхийг тодорхойлж чадах хүртэл болгоомжтой байх шаардлагатай. Хоол хүнстэй харилцан үйлчлэл нь санаа зовох зүйл биш юм.

Шалгалт өгөх стратеги: Рисперидон хэрэглэж буй үйлчлүүлэгчийн хувьд ажиглах **үзүүлэлт,** параметрүүдэд анхаарлаа төвлөрүүл. Рисперидоныг өгөхтэй холбоотой сувилахуйн анхаарах зүйлс болон энэ эм ортостатик гипотензи үүсгэж болдог гэдгийг мэдэх шаардлагатай. Мөн **ABC (агаар дамжуулах зам, амьсгал, цусны эргэлт**) зарчмыг ашигласнаар зөв сонголтыг олоход тусална.

Когнитив чадварын түвшин: Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг хэрэгжүүлэх***:*** Физиологийн бүрэн бүтэн байдал ***Интеграцчилсан процесс:*** Заах ба сурах

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал судлал: Антипсихотик эмүүд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Скизофрениіа

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Үйлчлүүлэгчийн боловсрол; Аюулгүй байдал ***Дүрийн лавлагаа:*** Varcarolis (2017), 48, 264-р тал.

847. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Имипраминий эмчилгээний хамгийн их үр дүн антидепрессант эмчилгээг эхлүүлснээс хойш 2–3 долоо хоногийн дараа илэрч болно. 1, 3, 4 дүгээр сонголтууд нь буруу хугацааны интервалтай байна.

Шалгалт өгөх стратеги: Эмийн **нэр,** энэ эмийн хүссэн үр нөлөөг тэмдэглээд *"хамгийн их" гэсэн* үгэнд анхаарлаа төвлөрүүл. Ихэнх антидепрессантууд хамгийн их эмчилгээний үр дүнд хүрэхийн тулд 2–3 долоо хоног шаарддаг гэдгийг санахад таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин:

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг хэрэгжүүлэх***:***

Физиологийн бүрэн бүтэн байдал ***Интеграцчилсан процесс:*** Заах ба сурах

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал судлал: Трициклик антидепрессантууд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд ***Эрхэмлэх ойлголтууд:*** Сэтгэл түгшилт; Үйлчлүүлэгчийн боловсрол ***Дүрийн ишлэл:*** Hodgson, Kizior (2018), 583–584-р тал.

848. ***Хариулт:*** 3, 5

Үндэслэл: МАО ингибитор (MAOI) хэрэглэж буй өвчтөнд тирамин их агуулагдсан хүнс хэрэглэхээс зайлсхийх шаардлагатай. Эдгээр хүнс нь амь насанд аюултай гипертензив хямралыг үүсгэж болзошгүй. Хэрэглэхгүй байх хүнсэнд йогурт, боловсорсон бяслаг, тамхилуулсан эсвэл боловсруулсан мах, улаан дарс, авокадо, улаан лооль, интоор зэрэг жимс орно.

Шалгалт өгөх стратеги: MAOIs-ийг хэрэглэж байх үед **сэдэв болон** зөвшөөрөгдөх хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд анхаарлаа төвлөрүүл. Фенелзин нь MAOI гэдгийг санаж, тирамин их агуулсан хүнснээс зайлсхийх шаардлагатайг санаарай. Дараа нь асуултад жагсаасан хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээс тирамин агуулаагүйг нь тодорхойл.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин:

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг шинжлэх*:* Физиологийн бүрэн бүтэн байдлын ***интеграцчилсан процесс:*** Заах ба сурах

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал эмчилгээний эм: Моноамин оксидазын хориглогчид (MAOIs)

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд
Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Хоол тэжээл; Аюулгүй байдал
Дүйнз: Varcarolis (2017), 215, 218-р хуудас.

849. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Тардиве дискинезиа нь антипсихотик эмчилгээний улмаас үүсч болох урвал юм. Энэ нь бие болон гар хөлний, ялангуяа хэлний хяналтгүй, сайн дурааараа бус хөдөлгөөнөөр илэрдэг. Паркинсонизм нь чичиргээ, маск маягийн царай, хатуурал, гулсмал алхалттай илэрдэг. Гипертензив криз нь моноамин оксидазын ингибаторуудаар эмчлэгдэх үед үүсч болох бөгөөд өндөр даралт, хойшоо хэсгээс урд хэсэг рүү тархдаг толгой өвдөлт, хүзүүний хатуурал ба өвдөлт, дотор муухайрах, бөөлжих зэрэг шинж тэмдэгтэй.
Нейролептик хорт хам шинж нь нейролептик (антипсихотик) эмчилгээний явцад хэзээ ч илрэх аюултай хам шинж юм. Энэ нь амьсгал давчдах эсвэл хурдасгах, зүрхний цохилт хурдасгах эсвэл тогтворгүй болох, халууралт, цусны даралт өөрчлөгдөх, хөлс их гарах, шээс алдагдах, булчингийн хатууралт зэрэг шинж тэмдэгээр илэрдэг.
Шалгалт өгөх стратеги: Антипсихотик эмийн гаж нөлөө болох **сэдэвт** анхаарлаа төвлөрүүл. Зөв сонголтыг олоход туслахын тулд тардиве дискинези нь бие болон мөчдийн, ялангуяа хэлний хяналтгүй, санамсаргүй хөдөлгөөнөөр илэрдэг гэдгийг санаарай.
Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ
Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал судлал: Антипсихотик эмүүд
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл
хөдлөлийн эмгэг ***Гол ойлголтууд:*** Клиникийн шийдвэрлэл;
Психоз ***Дүйнж:*** Varcarolis (2017), 268-р тал.

850. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Флуоксетинтэй холбоотой хамгийн түгээмэл гаж болон сөрөг нөлөөлөлд төв мэдрэлийн болон хоол боловсруулах замын үйл ажиллагааны доголдлууд орно. Флуоксетин хоол боловсруулах замыг дотор муухайрах, бөөлжих, агших болон суулгалт үүсгэх замаар нөлөөлдөг. Зүрх-судасны шинж тэмдэг, ам хуурайших, хэт их хөлөрөх нь энэ эмийн гаж болон сөрөг нөлөөлөлд хамаарахгүй.
Шалгалт өгөх стратеги: Флуоксетиний ерөнхий гаж болон сөрөг нөлөөнд анхаарлаа төвлөрүүл. Энэ эм хоол боловсруулах замын асуудал үүсгэдгийг санах хэрэгтэй. Энэ нь таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.
Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх
Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал
Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ
Агуулгын салбар: Фармакологи: Психотерапевтик эмчилгээ: Сэлэктив серотонин дахин шимэгдэхээс сэргийлэгч эмүүд (SSRI)
Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд
Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд: Клиникийн шийдвэрлэл; Аюулгүй байдал
Дүгнэлт: Burchum, Rosenthal (2016), 360-361-р тал; Skidmore (2017), 519-521-р тал.

851. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Буспирон нь параноидын бодлын эмгэг, мансууруулах бодис эсвэл архины таталт, эсвэл шизофренийн эмчилгээнд тохиромжгүй. Буспирон ихэвчлэн түгшүүрийн эмчилгээнд зааварлагддаг.

Шалгалт өгөх стратеги: **Стратегийн үг болох "***үр дүнтэй***"-г** тэмдэглэ. Асуулгад энэ үг *байхгүй байгаагийн илрэл болсон* үгсийг тэмдэглэ. Буспироныг сэтгэл түгшүүрийн эсрэг эм гэдгийг санахад таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Үнэлгээний

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал судлал: Сэтгэл түгшүүр бууруулах эм/Ансиолитик

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл түгшүүрийн эмгэг

Эрэмбэлсэн ойлголтууд: Сэтгэл түгшил; Баталгаа

Далав: Varcarolis (2017), 46-р тал.

852. ***Хариулт:*** 1

Үндэслэл: Литийн арчилгааны серумын түвшин 0.6–1.2 mEq/L (0.6–1.2 mmol/L) байдаг. Хордлогын шинж тэмдгүүд 1.5 mEq/L (1.5 mmol/L) түвшинд илэрч эхэлдэг. Литийн хордлого нь яаралтай эмнэлгийн тусламж шаарддаг бөгөөд хордлогын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд анхны эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгчид мэдэгддэг.

Шалгалт өгөх стратеги: Литийн эмчилгээний серумын түвшин **сэдэвт** анхаарлаа төвлөрүүл. Хэмнэлтийн түвшний дээд хязгаар 1.2 mEq/L (1.2 mmol/L) гэдгийг санахад таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Төлөвлөлт

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал судлалын эм: Сэтгэл хөдлөлийг тогтворжуулагч эмүүд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэг ***Эрхэмлэх ойлголтууд:*** Клиникийн шийдвэр гаргалт; Аюулгүй байдал ***Дүрийн ишлэл:*** Varcarolis (2017), 46-р тал, 236-237-р тал.

853. ***Хариулт:*** 4

Үндэслэл: Кломипрамин нь обсессив-компульсив эмгэгийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг трициклик антидепрессант эм юм. Заримдаа тайвшрал илэрч болно. Нойргүйдэл нь ховор тохиолддог гаж нөлөө юм. Жин нэмэгдэлт болон тахикарди нь энэ эмийн гаж болон сөрөг нөлөөлөлд тооцогдоно.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв**т төвлөрч**,** кломипрамины зааврыг зөрчих. Энэ эм нь обсессив-компульсив эмгэгийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг трицикликаль антидепрессант гэдгийг санахад таныг зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Үнэлгээ

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал судлал: Гурванцикл антидепрессантууд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: ХОК

Эрэмбэлэгдсэн ойлголтууд: Эмчилгээний зааварчилгааг дагаж мөрдөх; Баримт нотолгоо

Дүгнэлт: Hodgson, Kizior (2018), 262-264-р тал.

854. ***Хариулт:*** 2

Үндэслэл: Бупропионы өдөрт 450 мг-аас их тун хэрэглэж буй өвчтөнүүдэд таталт үүсч болно. Жин нэмэгдэх нь хааяа тохиолддог гаж нөлөө бол хатуурал нь энэ эмийн нийтлэг гаж нөлөө юм. Энэ эм нь босох үед даралт ихсэх ортостатик өөрчлөлтөд онцгой нөлөөлдөггүй.

Шалгалт өгөх стратеги: **Сэдэв болон** бупропионтой холбоотой хордлогын шинж тэмдгүүдэд анхаарлаа төвлөрүүл. *"Их хэмжээний"* гэсэн үгсийг тэмдэглэ. Эдгээр үгс таныг хамгийн ноцтой асуудлыг заасан зөв сонголтод хөтлөх болно.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Дүн шинжилгээ хийх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал судлал: Атипийн антидепрессант

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэг ***Гол ойлголтууд:*** Клиникийн шийдвэр; Аюулгүй байдал ***Дүгнэлт:*** Hodgson, Kizior (2018), 162–164-р тал.

855. ***Хариулт:*** 3

Үндэслэл: Сэтгэл гутралтай хүмүүс удаан хугацаагаар унтдаг, ажилдаа явж чаддаггүй, "юу ч хийж чадахгүй" мэт мэдэрдэг. Эдгээр үйлчлүүлэгчид эмчилгээний эмийн нөлөөг авсны дараа эдгээр олон гомдлууд шийдэгдэж, гадаад төрх нь сайжирсан гэж мэдэгддэг. 1, 2, 4 дүгээр сонголтууд нь сэтгэл гутрал үргэлжилж байгааг зааж байна.

Шалгалт өгөх стратеги: 1, 2, 4 дүгээр сонголтуудад дурдсан үйлчлүүлэгчийн зан үйл эсвэл мэдээллүүд нь **ижил төстэй** бөгөөд депрессийн шинж тэмдэг юм. Гадна төрх сайжирсан нь эмчилгээний хариу үйлдэл сайтай байгааг, эм уух дэглэмд мөрдөж байгааг харуулж байна.

Танин мэдэхүйн чадварын түвшин: Үнэлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ: Физиологийн бүрэн бүтэн байдал

Интеграцчилсан процесс: Сувилахуйн процесс—Үнэлгээ

Агуулгын салбар: Фармакологи: Сэтгэл засал эмчилгээний эм: Трицикликаль антидепрессантууд

Эрүүл мэндийн асуудал: Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Сэтгэл хөдлөлийн эмгэгүүд ***Гол ойлголтууд:*** Эмчилгээний зааврыг дагах; Баталгаатай ***эх сурвалж:*** Varcarolis (2017), 44, 213-р тал.

XIX ДЭХ ХЭСЭГ

Нарийн төвөгтэй асаргаа

Танилцуулга

Амжилтад хүрэх пирамид

Пирамидын цэгүүд нь судсаар (IV) эмчилгээ, тэр дундаа судсаар шингэн болон эмийн тэжээл, цусны бүтээгдэхүүн хэрэглэх, хоолойтой үйлчлүүлэгчийн асаргаа, мөн арьс салст, цус судлал, хавдар судлал, булчирхайн, хоол боловсруулах, амьсгалын, зүрх судас, бөөр ба шээсний, мэдрэлийн болон дархлааны тогтолцоотой холбоотой нарийн төвөгтэй асуудлуудад төвлөрдөг. Шокын төрөл бүрийг авч үзэхдээ сепсис, системийн үрэвсэлт хариу урвалын хам шинж, олон эрхтний дутагдлын хам шинж, септик шок болон гемодинамик удирдлагад онцгойлон анхаарна. Тайвшрал, сандрал, төөрөгдөл зэрэг үзэгдлүүдийг авч үздэг. Эдгээр ойлголтууд нь NCLEX® шалгалтад гарч болох сэдвүүд юм. Судаснаас дотоод эмчилгээ (IV терапи) эхлэхийн өмнө өвчтөний харшил, тэр дундаа латекс мэдрэг байдлыг үнэлж, хүндрэлүүдийг хянах нь сувилагчийн чухал үүрэг юм. Мөн цусны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шилжүүлэх журам, шилжүүлэлтийн урвалын шинж тэмдэг, урвал илэрсэн тохиолдолд яаралтай үзүүлэх тусламж зэрэг нь голлон авч үзэгддэг. Хоол боловсруулах замын хошуур эсвэл цээжний хошуур зэрэг хошуур ашиглан эмчилгээ явуулж буй өвчтөнд үзүүлэх сувилахуйн тусламж нь өөр өөр заалт, арга хэмжээтэй байдаг. Нарийн төвөгтэй нөхцөлд өндөр түвшний сувилахуйн тусламж шаарддаг тодорхой асуудлуудыг холбогдох үнэлгээний дүнгүүд болон сувилахуйн арга хэмжээнүүдийн хамт нарийвчлан авч үзсэн.

Өвчтөний хэрэгцээ: Суралцах зорилтууд

Аюулгүй, үр дүнтэй асаргаа сувиллын орчин

Халдвараас сэргийлэх зарчмуудыг хэрэгжүүлэх
Нарийн төвөгтэй нөхцөлтэй үйлчлүүлэгчийн асаргаанд мэргэжлийн хоорондын эрүүл мэндийн тусламжийн багийн гишүүдтэй хамтран ажиллах
Нэвтрэх мэс ажилбар болон цусны бүтээгдэхүүн хэрэглэхэд мэдээлэлд суурилсан зөвшөөрөл авсан эсэхийг баталгаажуулах
Үнэлгээ, оролцооны тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, нэвтрэх
төхөөрөмжүүдийг ашиглахтай холбоотой удирдамжийг дагах
Эрүүл мэндийн ажилтан болон бусад хүмүүсийг гэмтлээс хамгаалахын тулд аюултай, халдварт материалыг дамжуулах
Цусны бүтээгдэхүүн хэрэглэхийн өмнө үйлчлүүлэгчийг дор хаяж хоёр төрлийн таних баримт бичгээр (жишээ нь нэр, төрсөн огноо) тодорхойлох
Нууцлалыг хадгалах
Алдаа, осол, гэмтэл гаргуулахгүйн тулд болгоомжлолын арга хэмжээг баримтлах Эм хэрэглэж буй үйлчлүүлэгчийг гэмтлээс хамгаалах

Тоног төхөөрөмжийг аюулгүйгээр ашиглах
Стандарт болон дамжуулалтад суурилсан болгоомжлолын арга хэмжээ, асепсийн журам ашиглах

Эрүүл мэндийг дэмжих ба хадгалах

Өвчтөний өөрөө асрах чадварыг үнэлэх
IV шугамын гэрийн асаргаатай холбоотой амьдралын хэв маягийн сонголтыг
харгалзан үзэх Цус шилжүүлэхтэй холбоотой амьдралын хэв маягийн сонголтыг
тодорхойлох Эмийн хэрэглээний талаар үйлчлүүлэгч болон түүний гэр бүлд сургалт
явуулах
гэрийн парарентераль хооллолт
Үр дагаврыг урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн эрүүл мэнд, сайн сайхны сургалт
явуулахӨвчтөнд заасан эм болон судсаар эмчилгээ хийх талаар заахӨвчтөн болон
түүний гэр бүлд судсаар эмчилгээний шугамыг арчлах талаар заах
Үндсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчдэд мэдэгдэх шаардлагатай шинж тэмдгүүдийг
хянах талаар үйлчлүүлэгчид заах

Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал

Клиент болон түүний гэр бүлийн эмчилгээнд үзүүлэх сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдлийг үнэлэх
Клиентийн судсаар эмчилгээ (IV терапи) эсвэл эмийн тарилгаар хооллолт (парентераль хооллолт)
авах шаардлагатай холбоотой үүрэг, амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт, шилжилтийг хэлэлцэх
Клиент болон түүний гэр бүлийн тэсвэр
тэвчээрийг дэмжих Дэмжлэгийн тогтолцоог
тодорхойлох
Эрүүл мэндэд нөлөөлөх соёлын, шашны болон сүнслэг хүчин зүйлсийг тодорхойлох
Гэр бүлийг үйлчлүүлэгчийн явцын талаар мэдээллээр хангах
Чухал хүмүүст сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх
Клиент санаа зовнилоо илэрхийлэх боломжтой орчныг бүрдүүлэх

Физиологийн бүтэн байдал

Цусны бүтээгдэхүүнийг аюулгүйгээр хэрэглэх Эм болон
судсаар эмчилгээг аюулгүйгээр хийх
Төв венийн хандалтын төхөөрөмжүүдийг үнэлж, арчлах
Оролцооны урьдчилсан болон гэнэтийн үр нөлөөг үнэлж, илрүүлсэн зүйлийг баримтжуулах
Клиентийн хөдөлгөөн болон хөдөлгөөнгүй байдлын түвшинг үнэлэх, өдөр
тутмын амьдралын үйл ажиллагаанд туслах
Клиентийн төвөгтэй асаргааны арга хэмжээнд үзүүлсэн хариу үйлдлийг баримтжуулах
Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх
Үйлчлүүлэгчийн харшил болон мэдрэгшилтийг тодорхойлох
Эм болон судсаар (IV) эмчилгээний гаж нөлөө, хориглох заалтуудыг тодорхойлох
Эмнэлзүйн эсвэл мэс заслын хүндрэл үүсэх үед сувилахуйн арга хэмжээг эхлүүлэх Гал түлэгдэлт
эсвэл амьсгал замын гэмтэлтэй үйлчлүүлэгчийг удирдах
Зүрх-судасны асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах Хоол
боловсруулах замын асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах

Хемологийн эсвэл онкологийн асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах Амьсгалын асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах
Эндокрин системийн асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах
Бөөрний болон шээс ялгаруулах замын асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах.
Сепсис, системийн үрэвсэлт хариу урвалын хамшинж, олон эрхтний дутагдлын хамшинж, септик шоктой өвчтөнийг удирдах
Неврологийн асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах Иммун системийн асуудалтай үйлчлүүлэгчийг удирдах Тайвшруулах, сандрал болон төөрөгдлийг аюулгүйгээр удирдах
Хүнд өвчтэй үйлчлүүлэгчийн гемодинамикийн өөрчлөлтийг удирдах
Цус шилжүүлэлтийн урвал эсвэл бусад хүндрэл гарсан тохиолдолд эмийн яаралтай тусламж үзүүлэх
Биеийн системүүдийн өөрчлөлтийг хянах
Энтераль хооллолтыг болон өвчтөний хооллолтыг тэсвэрлэх чадварыг хянах, мөн цээжний хоолой зэрэг инвазив төхөөрөмжтэй өвчтөнийг хянах
Шаардлагатай үед өвчтөний биеийн байдлын өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх
Хоолойн нарийвчлалтай байрлалыг баталгаажуулахын тулд оношилгооны шинжилгээнд бэлтгэх.
Үйлчлүүлэгчийн нас, соёл, шашны итгэл үнэмшилтэй нийцсэн арга хэмжээг авах, сүнслэг болон эрүүл мэндийн тусламжийн итгэл үнэмшил, боловсролын түвшин, хэл. Үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалд гарч буй өөрчлөлтүүдийг таньж, боломжит эрсдэлийг зааварчилгаагаар хангах бэрхшээл үүсч байгааг илрүүлж, зохих арга хэмжээ авах тусгай болон нэвтрэх хяналтын тоног төхөөрөмж ашиглан

БҮЛЭГ 69

Нарийн төвөгтэй асаргаа

http://evolve.elsevier.com/Silvestri/comprehensiveRN/

Эрэмбэлсэн ойлголтууд

Клиник шийдвэр, Перфузи

I. Судаснаас (IV) шингэн эмчилгээ хийх

A. Венийн эмчилгээ

1. Амнаас бодис ууж чадахгүй өвчтөнүүдийг тэжээхэд ашиглагддаг
2. Амны аргаар өгөхтэй харьцуулахад ус, электролит болон **шим тэжээлийг** илүү хурдан нөхдөг
3. Хоол боловсруулах замд шимэгдэхэд шаардлагатай хугацааг хэмнэж, тодорхой шингэнийг хурдан хүргэх зорилгоор судасны системд шууд хандах боломжийг олгодог
4. Эм бэлдмэл эсвэл цусны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг судсаар түгээх замыг хангана

B. Шингэний төрөл (69-1-р хүснэгт)

Лактатын Рингер шингэн нь кали агуулдаг тул архаг бөөрний гэмтэл эсвэл архаг бөөрний өвчтэй өвчтөнд хэрэглэж болохгүй.

1. Изотоник шингэнүүд
   a. Биеийн шингэнүүдтэй ижил осмоляршилттай
   b. Эсийн гаднах шингэний хэмжээг нэмэгдүүлэх
   c. Шингэнийг эс рүү оруулдаггүй, учир нь осмосын хүч байхгүй
2. Гипотоник шингэнүүд
   a. Илүү шингэрүүлсэн уусмал бөгөөд биеийн шингэний осмолярлаас бага осмолярлатай
   b. Оссмосын нөлөөгөөр ус эсийн дотор шилжинэ
   c. Эсийн хаван үүсэхээс сэргийлэхийн тулд удаан хурдтай тарьж хэрэглэнэ
3. Гипертоник уусмалууд
   a. Илүү концентрацитай шингэн бөгөөд биеийн шингэнээс осмоляр байдлаараа өндөр

b. Осмосын үйлчлэлээр эсийн доторх усыг эс хоорондын шингэнд шилжүүлэх шалтгаан үүсгэх

4. Коллоид

a. Мөн плазмын эзлэхүүнийг нэмэгч гэж нэрлэдэг

b. Эс хоорондын хэсгээс судасны хэсэг рүү шингэнийг татдаг

c. Цус алдалт эсвэл хүнд гиповолемийн үед судсаны эзлэхийг хурдан нэмэгдүүлэхэд ашиглагддаг

Венийн (IV)

шингэн эсвэл эмийг судсаар өгөх нь судсанд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог. Энэ нь уг аргаар шингэн эсвэл эм өгөх давуу талтай ч эрсдэлтэй байж болно. Тиймээс анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийн (PHCP) жор зааврыг анхааралтай шалгаж, зөв шингэн эсвэл эмийг зааврын дагуу өгөх нь чухал. Эмийн хэрэглээний дүрмийг үргэлж дагаж мөрдөнө.

C. Судасны доторх төхөөрөмжүүд

1. Баттерфляй сувгууд

a. Энэхүү иж бүрдэл нь металл канюла, хуванцар эсвэл резинэн далавч, хуванцар катетер эсвэл холхтой далавчтай үзүүртэй зүү юм.

b. Тус зүү нь 0.5–1.5 инч урттай, зүүний хэмжигч нь 16–26 хүртэл байдаг.

c. **Шилжэлт** илүү түгээмэл

Эдгээр төхөөрөмжүүдтэй.

d. Ширэнхүүний (butterfly) инфузийн иж бүрдлийг ихэвчлэн судас нь нарийн эсвэл эмзэг байдаг хүүхэд болон ахмад настай хүмүүст ашигладаг.

2. Пластик канюла: голчлон богино хугацааны эмчилгээнд ашиглагддаг.

D. IV хэмжигчид

1. Гаж нь зүү эсвэл канюлийн сувгийн диаметрийг заадаг.

2. Гажийн дугаар бага байх тусам нүхний диаметр том, гажийн дугаар их байх тусам нүхний диаметр жижиг байдаг.

3. Ашиглах канюлийн хэмжээ нь тарих шингэн болон боломжит судсны диаметрээс хамаарна.

4. Их диаметртэй лумен (бага хэмжээтэй gauge тоонууд нь жижиг диаметртэй лументэй харьцуулахад илүү их шингэн урсгалын хурдыг боломжтой болгож, өндөр концентрацитай шингэнүүдийг тарилга хийх боломжийг олгодог.
5. Яаралтай шингэн орлуулах, цусны бүтээгдэхүүн эсвэл наркоз өгөх, мэс заслын өмнөх болон дараах өвчтөнд 18 эсвэл 19 хэмжээтэй том диаметртэй лумен ашиглагддаг.
6. Периферийн **өөхний эмульс (липид)** тарилга хийхэд 20 эсвэл 21 хэмжээтэй люмен эсвэл канюла ашиглана.
7. Стандарт IV шингэн болон тунгалаг шингэн IV эмийн хувьд 22 эсвэл 24 хэмжээтэй люмен эсвэл канюла ашиглагддаг.
8. Хэрэв үйлчлүүлэгчийн судсууд маш нарийн бол 24–25 хэмжээтэй люмен эсвэл канюла ашиглана.

Чихрийн шижинтэй өвчтөн ихэвчлэн хүлээн авдаггүй декстрозын (глюкозын) уусмал нь цусны глюкозын хэмжээг нэмэгдүүлэх тул ихэвчлэн өгдөггүй.

E. IV сав

1. Сав ихэвчлэн хуванцар байдаг; зарим шингэн шилэн саванд хадгалагддаг.
2. Байрлуулахын өмнө хуванцар уутыг шахаж гэмтэлгүйг шалгаж, шилэн лонхыг хагарал, цууралт байгаа эсэхээр шалгана.
3. Ихэнх байгууллагуудад эмийн алба эм агуулсан уусмал бэлтгэдэг; зарим нөхцөлд сувилагч эмийг дахин уусгах шаардлагатай болдог. Агентлагийн протокол болон эмийн сангийн зааврыг үргэлж дагах ёстой.

IV-ийн хуванцар уутанд маркер үзгээр битгий бич, учир нь бэх нь хуванцараар дамжин шингэнд шингэж болно. Бичиглэлд шошго ашиглаж, бөмбөгний үзэгээр шошго дээр биччиж, шошгыг уутанд нааж байрлуулна.

F. IV хоолой (Зураг 69-1)

1. IV хоолой нь уут эсвэл лонхтой холбох зориулалттай шпик үзүүр, дусал цуглуулах камер, роллер хавчаар, Y холболтын цэг, үйлчлүүлэгчийн судсанд оруулсан канюлад холбох адаптер үзүүрээс бүрдэнэ.
2. Богино, хоёрдогч хоолойг пиггибэк шингэнүүдэд ашиглаж, тэдгээрийг дусалны камерын хамгийн ойр тарьж буй цэгүүдтэй холбодог (Зураг 69-2).
3. Пластик материалд шингэх эм бэлдмэлд зориулсан тусгай хоолойг ашиглана (эмчилгээ хийх тусгай зааврыг шалгана уу).

IV эмчилгээний удирдамж).

4. Агаар нэвтрэх болон агаар нэвтрэхгүй хоолой ашиглагддаг.
   a. Агааржуулагч нь шингэн гарах үед IV саванд агаар орох боломжийг олгодог.
   b. Агааржуулалттай адаптер нь агааржуулалтгүй IV хоолойн системд агааржуулалтын нүх нэмэхэд ашиглагддаг.
   c. Уян саванд агаар нэвтрэхгүй хоолой ашигла.
   d. Шилэн эсвэл хатуу хуванцар саванд агаар орж, шингэнийг гарах үед шахаж гаргах боломж олгохын тулд агаар нэвтрэх нүхтэй хоолойг ашиглана; хатуу IV савнаас шингэн агаар нэвтрэх нүхгүй бол урсахгүй.

IV-д сунгалтын хоолойг нэмж болно

хоолойн иж бүрдэлд хоолойг илүү урт болгох зориулалттай. Хүүхдүүдэд, тайван бус үйлчлүүлэгчдэд эсвэл хөдөлгөөний тусгай хэрэгцээтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан IV хоолойн иж бүрдэлд сунгалтын хоолойг нэмж болно.

G. Туршилтын камер (зураг 69-3)

1. Macrodrip камер
   a. Камер нь хэрэв шингэн өтгөн эсвэл хурдан тарьж өгөх шаардлагатай үед ашиглана.
   b. Дусалны коэффициент нь үйлдвэрлэгчээс хамааран 10–20 дусал (gtt)/мл-ийн хооронд хэлбэлздэг.
   c. Хоолойн савлагааг уншиж, нэг миллилитр тутамд хэдэн дусал нийлүүлэгддэгийг (дусалтын коэффициент) тодорхойлно.

2. Микродусалны камер
   a. Ерөнхийдөө камерт дусал үүсэх богино босоо металл хэсэг (стилет) байдаг.
   b. Камер нь ойролцоогоор /mL.
   c. Дусал гаргах коэффициент (gtt/mL)-ийг тодорхойлохын тулд хоолойн савлагааг на уу.
   d. Микродусалны камеруудыг ашиглана хэрэв шингэнийг удаан хурдтай (цагт 50 mL-ээс бага) тарилга хийх эсвэл уусмалд хүчтэй эмийн найрлага орсон тохиолдолд

титрлэх шаардлагатай үед, жишээлбэл эрчимт эмчилгээний тасаг эсвэл хүүхдийн өвчтөнүүдэд.

H. Шүүлтүүрүүд

1. Шүүлтүүрүүд нь тоосонцруудыг өвчтөний судсанд орохоос сэргийлж хамгаалалт үзүүлдэг.
2. Эдгээр нь IV шугаманд уусгаагүй бодис болон уусмалд тунасан эмийн үлдэгдэл зэрэг жижиг хэсгүүдийг барьж авах зориулалттай.
3. Ашиглахтай холбоотой агентлагийн бодлогыг шалгана уу

рын ашиглалтын талаар байгууллагын бодлогыг шалгана уу.

4. Ихэнх шингэнд 0.22 мкм-ийн шүүлтүүр, липид эсвэл альбумин агуулсан шингэнд 1.2 мкм-ийн шүүлтүүр, цусны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тусгай шүүлтүүр ашиглана.
5. Шүүлтүүрүүдийг 24–72 цаг тутамд (хамааран) сольж байх

уллагын бодлогын дагуу) бактерийн өсөлтийг зогсоохын тулд.

I. Торгуулагчг

н тарилга төхөөрөмжүүд

1. Торгуулагчгүй тарилга төхөөрөмжүүдэд далд суусан зүү, хуванцар канюла, нэг чигт хавхлага ордог; эдгээр систем нь бохирдсон зүүнд өртөх эрсдэлийг бууруулдаг.
2. Нэг чиглэлтэй хавхлагаар эмийн савны хоол тэжээл болон цусны бүтээгдэхүүн тарихыг хориглоно.

J. Хуваагдах (интермиттент) инфузийн төхөөрөмжүүд

1. Эмийн таталт эсвэл IV piggyback аргаар эмийг завсрын зайтай өгөх шаардлагатай үед судсанд нэвтрэх боломжтой байх үед завсрын зайтай инфузийн төхөөрөмжүүдийг ашиглана.
2. Нэвтрэх чадварыг хэвийн давсны уусмалаар (*натри хлорид* болон *хэвийн давсны уусмал* нь хоёул адил утгатай нэр томъёо) тогтмол зайтай зайлж хадгалдаг.
3. Агентлагийн бодлогын дагуу, үед

лгээ хийхдээ IV канюлагийн байрлалыг баталгаажуулахын тулд 1–2 мл хэвийн давсны уусмалаар зайлуулж, заасан эмийг тарьсны дараа канюлагийн сувгийг нээлттэй байлгахын тулд дахин 1–2 мл хэвийн давсны уусмалаар зайлуулна.

K. Цахилгаан IV тарилга төхөөрөмжүүд

1. IV дусалжуулагч насосууд шингэний хэмжээг хянадаг

Төв венийн болон артерийн шугам, эмийн найрлагатай шингэн, эцэг талын тэжээлийн шингэнтэй хамт хэрэглэнэ. Ихэнх байгууллагууд ямар ч судсанд тарьж буй шингэнийг IV шахуургаар тарьдаг.

2. Жижиг хэмжээний шингэнийг шахах зориулалттай сиринж шахуургыг ашигладаг

эм бэлдмэл бага хэмжээгээр өгөх үед; эмийг болон шингэнийг агуулсан шприц насос төхөөрөмжид сууж, эмийг хяналттай хурдтайгаар өгөхөөр тохируулдаг.

3. Өвчтөн хяналттай өвчин намдаах эмчилгээ (PCA)

   a. Өвчтөнд өөрөө судсаар эм (жишээлбэл өвчин намдаах эм) тарьж өгөх боломж олгодог төхөөрөмж; өвчтөн тогтмол зайтай тун тарьж, насосыг урьдчилан тогтоосон хугацаанаас гадуурх тунг хаах байдлаар тохируулж болдог тул хэт тунгийн эрсдлийг бууруулна.

   b. PCA эмчилгээний горимд суурь урсгалын хурд ба шаардлагатай тундаар хослуулсан, зөвхөн суурь урсгалын хурдтай, эсвэл зөвхөн шаардлагатай тундаар тохируулсан байж болно.

   c. Болосууд тунг тохиргоонуудын аль алинд нь өгөхөөс өмнө өгч болох ба үүнийг PHCP-ийн жор дагуу тохируулах ёстой.

   d. PCA төхөөрөмжүүд үргэлж түгжигдсэн байдаг бөгөөд тохиргоо хийхэд өөр бүртгэлтэй сувилагчийн (RN) гэрч шаардлагатай.

Цахим IV тарилга төхөөрөмжүүдийг шалгах ихэвчлэн. Эдгээр төхөөрөмжүүд электрон боловч энэ нь шингэн болон эмийн найрлагыг нарийвчлалтай тарьж байгааг баталгаажуулдаггүй.

L. Латексийн харшил

1. Өвчтөнд латекс харшлага байгаа эсэхийг үнэл.
2. IV хангамжийн хэрэгслүүд, тухайлбал IV катетер, IV хоолой, IV порт (ялангуяа резинэн тарилга хийх порт), олон тундааны савны резинэн таг болон наалдамхай тууз нь латекс агуулж болно.
3. Латекс-аюулгүй судсанд тарьж өгөх хэрэгсэл латексын харшилтай үйлчлүүлэгчдэд ашиглагдах ёстой; ихэнх байгууллагууд ийм төрлийн хэрэгсэлтэй байдаг ч үүнийг дахин шалгах шаардлагатай.
4. Латекс харшлын талаархи нэмэлт мэдээллийг 62-р бүлгээс үзнэ үү.

M. Периферийн судсанд катетер суулгах байршил сонгох

1. Гарааны, бугуй болон тохойн нугасны урд хэсгийн судсууд тохиромжтой газрууд юм (Зураг 69-4).

2. Доод мөч (хөл, хөлийн доод хэсэг) дахь судсууд насанд хүрэгчдэд зориулагдаагүй, учир нь тромб үүсэх эрсдэлтэй, мөн венийн цусны урсгал султай хэсгүүдэд эм хуримтлагдах боломжтой (Box

69-1).

3. Толгойн арьсны болон хөлний судаснууд нярайд тохиромжтой байрлал байж болно.
4. Газрыг сонгохоос өмнө хоёр гарны судсыг анхааралтай үнэл.
5. Венийн суваг таслагдах эсвэл шингэн нэвтрэх тохиолдолд гар эсвэл хөлний доод хэсгээс эхлэн тарилга хийх бөгөөд ингэснээр судсыг дээш нь дагуулан нэвтрэх боломжтой; хэрэв тохойн дотор талын судсаас шингэн нэвтэрсэн бол тухайн гарын доод судсыг дахин нэвтрэхэд ашиглахгүй байх нь зүйтэй.
6. Өвчтөний давамгайлах талыг тодорхойлж, **веноз** зүсэлт хийх байрлалд эсрэг талыг сонго.
7. IV тавьсан гарын тохойг нугалах нь шингэний урсгалыг амархан хааж, нэвчилт үүсгэн тромбофлебит үүсгэх эрсдэлтэй.
8. Хэрвээ боломжтой бол IV шингээн суулгалт авч буй гарын цусны даралт хэмжихийг зайлсхий.
9. Венпунктурын газарт боолт бүү хийх.
10. Веноз судсанд зүү оруулах газар нугаралттай хэсэгт байрлавал шаардлагатай үед гарны тулгуур хавтан (armboard) ашигла.

Насанд хүрэгчид судсанд катетер оруулахад хамгийн их ашиглагддаг газрууд канюла эсвэл зүү оруулах хамгийн түгээмэл газар нь бугуйн судсууд бөгөөд учир нь бугуйн яс нь байгалийн дэмжлэг, шийрэгч болдог.

N. Судас доторх шингэн эмчилгээг эхлүүлэх ба хэрэглэх

1. IV шингэнийг PHCP-ийн жортой төрөл, хэмжээ, шингэний хувь болон урсгалын хурдны дагуу харьцуулан шалгаж, эмийн хэрэглээний эрхийн зарчмыг дагаж мөрдөнө.
2. Клиентийн эрүүл мэндийн байдал, эмгэгүүдийг үнэлж, тухайн IV шингэн эсвэл IV тоног төхөөрөмжийн хэрэглээнд харшилсан нөхцөл (жишээлбэл цэвэрлэх шингэнд, наалдамхай материалд эсвэл латексэд харшил) байгаа эсэхийг тодорхойл. Шаардлагатай бол IV шингэний нийцлийг шалга.
3. Өвчтөнийг хоёр таних баримтаар шалгаж, процедурыг тайлбарлах; өвчтөний өмнөх судсаар эмчилгээ хийлгэх туршлага болон судсыг оруулах байрлалын сонголтыг үнэлэх.
4. IV шугам оруулах болон түүнтэй ажиллахын өмнө гараа сайтар угааж, бээлий зүүгээрэй.
5. IV шугам тавих болон IV талбай дээрх боолтыг сольж байх үед ариутгалын техник ашигла.
6. Венпунктурын газрыг өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэх төвийн (CDC) зөвлөмжийн дагуу 72–96 цаг тутамд солих

Урьдчилан сэргийлэлт (CDC)-ийн зөвлөмжүүд болон байгууллагын бодлого.

7. IV боолтыг боолт норсон эсвэл бохирдсон үед, эсвэл байгууллагын бодлогоор заасан хугацаанд сольж байх.
8. IV хоолойг CDC-ийн зөвлөмж, агентлагийн бодлого эсвэл венопунктурын газрыг солих бүрт 96 цаг тутамд сольж байх.

9. IV уусмалын уутыг эсвэл лонхыг өлгөж бүү үлдээ гаас илүү хугацаагаар өлгөхгүй, бактерийн бохирдол болон сийн эрсдэлийг бууруулахын тулд.
10. IV хоолойг шаланд хүрэхээс сэргийлэхийн тулд шалан дээр хүрэхэд бүү зөвшөөр.
11. IV суулгах зааврыг Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд хэсгээс үзнэ үү.
12. IV-ийг салгах зааврыг авахын тулд Эрчимт сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд хэсгийг үзнэ үү.

Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд

Периферийн судсанд катетер суулгах

1. Анхны эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн (PHCP) жор бичгийг шалгаж, инфузийн төхөөрөмжийн төрөл, хэмжээг тодорхойлж, дотоод судсанд (IV) холболтын хоолой эсвэл өргөтгөлийн иж бүрдэл болон шингэнийг бэлдэнэ; системээс агаарыг гаргахын тулд IV хоолой эсвэл өргөтгөлийг урьдчилан шалгаж, үйл явцыг үйлчлүүлэгчдэд тайлбарлана.
2. Суулгах судсыг судсны чанар, үйлчлүүлэгчийн биеийн хэмжээ, IV эмчилгээний заалтад үндэслэн сонго; турникет тавьж, судсыг уян хатан байдлаар нь илрүүлнэ (зураг 69-4-ийг үзнэ үү).
3. Арьсыг антимикроб шингэнээр дотроос нь гадагш тойрог хэлбэрээр цэвэрлэ, эсвэл АНУ-ын Өвчин хяналт, урьдчилан сэргийлэх төв (CDC)-ийн заавар, агентлагийн бодлогод зааснаар.
4. Оруулах цэгийн доорх судсыг тогтворжуулж, арьс болон судсыг нэвтрүүлэн флашбэк камерт цус цугларсныг ажигла; хэрэв цус цугларсан бол катетерыг арьсны түвшинд тэгшилж, судсанд ахиулна (амжилттүй бол дараагийн оролдлогод шинэ ариутгасан төхөөрөмж ашиглана).
5. Турникетыг ав. Оруулах газрын дээр давамгайлдаггүй гарынхаа дунд хуруугаар даралт үзүүлж, катетерт суурилсан стилетээ татан гарга; IV хоолой эсвэл өргөтгөлийн иж бүрдлийн үзүүрийг катетерийн хоолойд холбож, бэхэлж, IV урсгалыг эхлүүл. Клиентээс оруулах газарт хэр тав тухтай байгааг асууж, урсгал хангалттай байгааг шалга.
6. Агентлагийн журамд зааснаар нэвтрүүлсэн газрыг тунгалаг боолтоор нааж бэхэл; хоолой, боолт болон шингэний уутыг товч тодорхой шошголж, огноо, цагийг заавал тэмдэглэ.
7. Журмын тусгай нарийвчилсан мэдээллийг баримтжуулна: оруулгах оролдлогын тоо; оруулсан газар; төхөөрөмжийн төрөл, хэмжээ; шингэний шийдэл, урсгалын хурд болон хугацаа; мөн үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдэл. Мөн журмын баримтжуулалтыг агентлагийн журамд зааснаар гүйцэтгэнэ.

Дүгнэлт

Potter et al. (2017), 957, 967–969-р хуудас.

Эрүүл мэндийн сувилахуйн тэргүүлэх үйл ажиллагаа

Периферийн судсанд катетер суулгах (катэтер салгах)

1. Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийн (PHCP) жор бичгийг шалгаж, үйл явцыг үйлчлүүлэгчид тайлбарла; канюла эсвэл зүү салгах үед тухайн хэсгийг хөдөлгөөнгүй барьж байхыг үйлчлүүлэгчээс хүс.
2. Судасны доторх (IV) хоолойн хавчаарыг унтрааж, катетерыг тогтвортой барьж байх үед тус газрыг бүрхсэн боолт, наалтыг ав.
3. Агентлагийн журамд заасан стериль марль эсвэл бусад материал ашиглан тухайн газарт хөнгөн даралт өгч, катетерыг арьсны тэгш өнцөгтэй байлгаж, удаан тогтвортой хөдөлгөөнөөр сугал.
4. Хуурай стериль марли ашиглан 2–3 минут даралт өг (хамгийн ихдээ 5 минут хүртэл); хэрэв үйлчлүүлэгч цус алдалтын эмгэгтэй эсвэл антикоагулянт эм хэрэглэж байгаа бол илүү удаан даралт өг.
5. Гаднаас нь улайлт, ялгаралт эсвэл хавдар байгаа эсэхийг шалгаж, катетерийн бүтэн байдлыг шалгана.
6. Агентлагийн журамд зааснаар шаардлагатай бол боолт хийнэ.
7. Журмыг болон үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдлийг баримтжуул.

Дүгнэлт

Perry et al. (2018), 794-р тал.

О. Судасны доторх шугамын болгоомжлол

1. Суулгах үед IV шугам нь үйлчлүүлэгчид эхний үед өвдөлт, таагүй мэдрэмж үүсгэж болно.
2. IV-ийн нэвчилт нь бие рүү бичил биет орж ирэх зам болдог.
3. IV замаар өгөгдсөн эмнэлгийн бэлдмэлүүд цусанд шууд орж, ямар ч сөрөг урвал эсвэл харшил даруй илрэх боломжтой.
4. Цусны эргэлтийн шингэний хэт их ачаалал эсвэл электролитын тэнцвэргүй байдал нь IV шингэнийг хэт их эсвэл хэт хурдан тарьснаас үүдэн үүсч болно.
5. Зарим шингэн болон эмийн хооронд нийцэлгүй байдал үүсч болно.

Амьсгалын, зүрхний, бөөрний эсвэл элэгний өвчтэй; ахмад өвчтөнүүд; мөн маш залуу хүмүүс нь цусны эргэлтийн ачаалал хэтрэх эрсдэлтэй бөгөөд хэт их шингэний хэмжээг тэсвэрлэж чадахгүй. Мөн зүрхний дутагдал эсвэл бөөрний дутагдалтай өвчтөнд ихэвчлэн давсны уусмал агуулсан шингэн өгөхгүй, учир нь энэ төрлийн шингэн нь биед ус хураах үйлдэлтэй тул шингэний ачаллыг нэмэгдүүлж, зүрхний болон бөөрний дутагдлыг улам хүндрүүлдэг.

P. Судас доторх эмчилгээний хүндрэлүүд (69-2-р хүснэгт)

Агентлагийн бодлогын дагуу хүндрэл үүссэн тохиолдол бүрийг, үнэлгээний дүнг, авсан арга хэмжээг болон үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдлийг үргэлж бичиж тэмдэглэ.

Q. Төв венийн катетерууд

1. Тайлбар
    a. Төв венийн катетерууд (Зураг 69-5) нь гиперосмоляр шингэн бэлдмэл, төвийн венийн даралт хэмжилт хийх, эмийн гаднах тэжээл (parenteral nutrition) эсвэл олон төрлийн IV шингэн бэлдмэл, эм тариа дусаах зориулалттай.
    b. Катетерийн байрлалыг тогтоодог

        асны дараа рентген зураг авалтаар хойлно.
    c. Катетер нь нэг, хоёр эсвэл гурван лументэй байж болно.
    d. Катетерийг периферийн судсанд (базилик эсвэл цефалик) суулгаж, дээд ховд руу дамжуулан оруулж, эсвэл дотоод жүүгулар эсвэл субклавиан судсаар төвөөр суулгаж, эсвэл мэс заслын аргаар арьсны доорх эдийг туулан суулгаж болно.
    e. Олон сувагтай катетерт эмийн холимог таарахгүй асуудалгүйгээр нэгэн зэрэг хэд хэдэн эм өгөх боломжтой бөгөөд зөвхөн нэг удаагийн суулгах цэг шаардлагатай.

Төв шугам тавих, хоолой солих үед,

мөн шугам салгах үед өвчтөнийг эсрэг заалтгүй бол Тренделенбургийн байрлалд эсвэл хэвтээ байрлалд байрлуулж, IV систем нээлттэй үед төв судаснуудад даралт нэмэгдүүлэх зорилгоор Вальсальва арга хэмжээг хийхийг зааж өг.

2. Туннельт төв венийн катетерууд
    a. Илүү тогтвортой төрлийн катетер, жишээлбэл Хикман, Бровиак эсвэл Грошонг катетер, нь урт хугацааны судсаар эмчилгээ хийхэд ашиглагддаг.
    b. Катетер нь ганц сувагтай эсвэл олон сувагтай байж болно.
    c. Катетерийг мэс заслын өрөөнд оруулна

операцийн өрөөнд катетерийг баруун дээд ховдгийн үүдэнд (орох цэг) суулгаж, арьсны доор хонгил үүсгэн цээжний хэсэгт гарах цэг хүртэл чиглүүлдэг; гарах цэг дээр катетерийг арьсны доорх "манжет"-ээр бэхэлдэг.

d. Катетерийг шаардлагатай үед хандах боломж олгох, системийг хаалттай, гэмтэлгүй байлгах зорилгоор завсрын инфузийн төхөөрөмжөөр тоноглодог.

e. Гадны нэвтрэх чадварыг ...-аар хадгалдаг.

ерийн төрлөөс хамааран агентлагийн бодлогын дагуу шингэрүүлсэн гепарин эсвэл физиологийн давсны уусмалаар зайлуулна.

3. Судасны хандалтын порт (суулгагддаг порт)

a. Хирургийн аргаар арьсны доор суулгасан Port-a-Cath, Mediport эсвэл Infusaport зэрэг портыг удаан хугацааны давтагдсан судсанд эмчилгээ хийхэд ашигладаг.

b. Хүрэхэд портыг арьсаар дамжин өөрөө битүүрдэг Huber цэгийн зүү гэх мэт зүү ашиглан портын доторх хэсэгт шприцээр шахаж, зүүгээр хатган олж авдаг.

c. Гадны заалтаар болон агентлагийн бодлогын дагуу шингэрүүлсэн гепарин уусмалаар тогтмол зайлуулан урсгаж нэвтрэх чадварыг хадгалдаг.

4. Хувьдралын төв венийн катетер (PICC) шугам

a. Энэхүү катетерыг удаан хугацааны IV эмчилгээнд, ихэвчлэн гэртээ ашигладаг.

b. Ихэвчлэн базилик венийг ашигладаг боловч тохойн урд хэсгийн дунд кубитал болон толгойн венийг ч мөн ашиглаж болно.

c. Катетерт утас оруулан, катетерийн үзүүрийг субклавиан вена эсвэл дээд вена кавад байрлуулах байдлаар суулгадаг.

d. Суулгах үед бага зэргийн цус алдалт үүсч, 24 цагийн турш үргэлжлэх боломжтой, гэхдээ түүнээс хойш цус алдалт тохиолдохгүй.

e. Флебит нь түгээмэл хүндрэл юм.

R. Эпидурал катетер (Зураг 69-6)

1. Каттетер эпидуралын орон зайд өвдөлт намдаах эмчилгээ хийх зорилгоор байрлуулдаг; энэ арга нь

эмчилгээ нь өвдөлтийг хянахын тулд шаардлагатай эмийн тунг бууруулдаг тул үйлчлүүлэгч гаж нөлөөг бага мэдэрдэг.

2. Өвчтөний амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн температур зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүд, ухамсарын түвшин, доод мөчүүдийн хөдөлгөөн ба мэдрэхүйн үйл ажиллагааг үнэл.
3. Суулт хийсэн газрыг халдварын шинж тэмдэг илрэх эсэхээр хянаж, катетер нь өвчтөний арьсанд бат бэх тогтсон, бүх холболтыг салгагдахаас сэргийлж скочтой наасан байхыг баталгаажуул.
4. Шилжүүлэн тарилга болон эмийн хэрэглээний талаар PHCP-ийн жор зааврыг шалгана.
5. Тасралтгүй дусалжуулалт хийх үед урсгалын хурдыг зөв тохируулсан эсэхийг электрон дусалжуулагч төхөөрөмжөөр хянана.
6. Болос тунг катетерээр өгөхдөө агентлагийн журам, катетерээр болюс тунг өгөх зааврыг дагаж мөрдөнө.
7. Эмийн тарилга хийхийн өмнө аспираци хийдэг;

з 1 мл-ээс их тунгалаг шингэн эсвэл цус буцаж ирвэл эмийг гүй бөгөөд PHCP эсвэл мэдээ суулгагч эмчид даруй мэдэгдэнэ (катетер субарахноидын хөндий эсвэл цусны судсанд шилжсэн байж болно).

Эпидурал катетер тавих болон эмчилгээ хийхэд харшилтай нөхцөлүүд

эпидурал өвдөлт намдаахын эсрэг заалтууд нь яс-булчингийн болон нугасны гажиг, цус алдалтын эмгэг, антикоагулянт хэрэглэх, олон давхар абсцесс үүссэн түүх, сепсис зэрэг орно.

II. Параэнтераль тэжээл өгөх

A. **Параэнтераль тэжээл (ПТ)**

1. Тайлбар

a. Параэнтераль тэжээл нь тэжээллэг бодисыг судсаар дамжуулан нийлүүлдэг.

b. PN нь **хэсэгчилсэн венийн тэжээл** (PPN) болон **бүрэн венийн тэжээл** (TPN)-ээс бүрдэнэ. Ямар төрлийг хэрэглэх нь үйлчлүүлэгчийн тэжээлийн хэрэгцээнээс хамаарна.

c. PN нь декстрозын хэлбэрээр нүүрс ус, эмульжлагдсан хэлбэрээр өөх тос, амин хүчлийн хэлбэрээр ууараг, витамин, эрдэс бодис, электролит болон усыг нийлүүлдэг.

d. PN нь арьсны доорх өөхний элэгдлийг зогсоодог

булчингийн уургыг эрчим хүч болгон задлагдахаас сэргийлдэг.

e. PN-ийн шингэнүүд нь глюкозын өндөр концентраци болон амины хүчлийн нэмэлтээс болж гипертоник байдаг.

2. Заалтууд

a. Хоол тэжээлийг боловсруулах чадваргүй эсвэл хоол боловсруулах зам нь хүнд хэлбэрээр гэмтсэн, үйл ажиллагаа нь зогссон өвчтөнүүд PN-аас ашиг хүртэж болно.

b. Амны хооллолтоор тодорхой хэмжээгээр хооллож чаддаг ч тэжээлийн хэрэгцээгээ хангахад хүрэлцэхгүй тохиолдолд PN-аас ашиг тус хүртэж болно.

c. Олон удаагийн хоол боловсруулах замын мэс засал хийлгэсэн, хоол боловсруулах замын гэмтэл авсан, энтераль хооллолтыг хүндээр тэсвэргүй эсвэл гэдэсний бөглөрөлтэй, эсвэл гэдсээ эдгээх үүднээс амраах шаардлагатай үйлчлүүлэгчид PN-аас ашиг хүртэж болно.

d. Олдмол дархлал сулрал (AIDS), хавдар, түлэгдэлт, **хоол тэжээлийн дутагдал** зэрэг хоол тэжээлийн ноцтой дутагдалтай нөхцөлтэй эсвэл хими эмчилгээнд орж буй өвчтөнүүд PN-аас ашиг хүртэж болно.

PN нь тэжээлийн нэг хэлбэр бөгөөд дараах үед хэрэглэгддэг өөр хоол тэжээлийн сонголт байхгүй үед. Хоол тэжээлийг аман замаар эсвэл назогастраль хоолойгоор өгөх аргыг ихэвчлэн эхлээд хэрэглэдэг, дараа нь PN-ийг эхлүүлдэг.

3. PN-ийг хэрэглэх (Зураг 69-7).

4. PPN

a. Ихэвчлэн гарны доод хэсгийн том судсанд стандарт периферийн IV катетер, мидлайн эсвэл PICC-ээр хийдэг. Мидлайн катетерийг дээд гарны брахиаль эсвэл цефалик судсанд суулгаж, үзүүрийг нь хөхний шугамаас доош байрлуулах ёстой.

b. Хэрэв PICC суурилуулах боломжгүй бол PPN-д субклавиан болон дотоод эсвэл гадаад жюгуляр венийг ашиглаж болно.

5. TPN

a. Төв судаснаас өгдөг; PICC ашиглах нь хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Мөн ашиглаж болох бусад газрууд нь субклавиан судсанд болон дотоод эсвэл

гаднах жугулаар судсууд.

b. Хэрэв судсанд тарьдаг шингэний уут (TPN) хоосорч, сувилагч шинэ шингэний уутыг эмийн сангаас ирэхийг хүлээж байгаа бол гипогликемиас сэргийлэхийн тулд 10% глюкозын уусмалыг заасан хурдаар тарьж, заасан шингэнийг аль болох хурдан авч байх ёстой.

Гипертоник шингэнийг судсанд тарьж өгөхөд гадаад судсууд склероз, флебит эсвэл хавдар үүсгэж болно. Эдгээр хүндрэлүүдийг анхааралтай хянаарай.

6. Параэнтераль тэжээлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

a. Нүүрс ус: Дестрин шингэний концентраци нь үйлчлүүлэгчийн тэжээлийн хэрэгцээ, өгөх зам (төв эсвэл периферийн), байгууллагын протоколд хамаарна; нүүрс ус ихэвчлэн калори (энергийн) хэрэгцээний 60–70%-ийг хангадаг.

b. Амин хүчлүүд (уураг): концентраци нь 3.5%-аас 20% хүртэл хэлбэлздэг. Илүү бага концентрацийг ихэвчлэн периферийн судсаар, өндөр концентрацийг ихэвчлэн төв судсаар өгдөг; нийт эрчим хүчний хэрэгцээний ойролцоогоор 15–20%-ийг уураг хангах ёстой.

7. **Тосны эмульс (липидүүд)**

a. Липидүүд калори (энергийн) хэрэгцээний 30%-ийг хүртэл хангадаг.

b. Липидүүд нь уураг бус калори хангаж, өөхний хүчилийн дутагдлыг урьдчилан сэргийлэх эсвэл засах үүрэгтэй.

c. Липидийн уусмалууд изотон тул периферийн эсвэл төвийн венийн замаар өгөгдөж болно; уусмалыг Y-холбогчийн тусламжтайгаар гол IV өгөх иж бүрдлийн шүүлтүүрийн доор тусдаа IV шугамаар эсвэл PN уусмалд (декстроз, амины хүчил,

болон липидүүд).

d. Ихэнх өөхний эмульс нь шар буурцаг эсвэл саффлорын тосоор бэлтгэгддэг бөгөөд эмульсжилт үүсгэхийн тулд өндөгний шар нэмдэг; гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь линолейн, олейн, пальмитин, линоленик болон стеарийн хүчилүүд юм (клиентээс харшлын урвал илрүүлэх).

e. Глюкозын тэсвэргүй эсвэл чихрийн шижинтэй үйлчлүүлэгчид нийт калорийнх нь илүү их хувийг өөх тосоос авснаар цусан дахь глюкозын хэмжээг хянаж, тарилгаар өгсөн декстрозоос үүдэлтэй инсулины хэрэгцээг бууруулахад тустай байж болно.

f. Савыг эмульс давхарга болон өөхний бөмбөлөгөөр тусгаарлагдсан эсэх, эсвэл хөө хуримтлагдсан эсэхийг шалга; хэрэв ажиглагдвал бэлдмэлийг хэрэглэхгүй, эмийн сан руу буцаана.

g. Өөхний эмульс шингэнд нэмэлт бодис оруулах ёсгүй.

h. Ашиглах шүүлтүүрийн хэмжээг агентлагийн бодлого, зааврын дагуу мөрдөнө; ихэвчлэн 1.2 мкм эсвэл түүнээс том шүүлтүүр ашиглах шаардлагатай, учир нь липидийн хэсгүүд 0.22 мкм шүүлтүүрээр дамжихгүй.

i. Эмчилгээний шингэнийг заасан урсгалын хурдаар—ихэвчлэн аажмаар
Эхэндээ минутанд 1 мл-ээр—инфузийн эхний 30 минутанд амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн температур зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг 10 минут тутамд хянаж, гаж нөлөө илрүүлэхгүй бол урсгалын хурдыг заасан хэмжээнд тохируулна. Хэрэв гаж нөлөө илэрвэл инфузийг зогсоож, анхны эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэгч (PHCP)-д мэдэгдэнэ (69-2-р хайрцаг).

j. Хэрэв сөрөг урвал илрээгүй бол урсгалын хурдыг заасан хэмжээнд тохируулна.

k. Инфузийг зогсоосны дараа 4 цагийн дараа серумын липидийг хянах.

Өөхний эмульс (липид) нь өндөгний шар агуулдаг фосфолипид агуулдаг тул өндөгний харшилтай өвчтөнд өгөхгүй байх ёстой.

8. Бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүд

a. PN шингэн бэлдмэлүүд ихэвчлэн ихэнх витамины хэрэгцээг хангах, хомсдлоос сэргийлэх зорилгоор стандарт олон витаминтай бэлдмэл агуулдаг

дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор.

b. Шаардлагатай болон эмчийн зааврaар тусдаа витамины бэлдмэлүүдийг нэмж болно.

c. Эрдэс бодис ба мөгөөрс элемэнтүүд: Хэвийн **бодисын солилцоог** дэмжих зориулалттай худалдааны эрдэс бодис ба мөгөөрс элемэнтийн бэлдмэлүүд янз бүрийн концентрацаар байдаг.

d. Электролитууд: PN эмчилгээ авч буй хүмүүсийн электролитийн хэрэгцээ нь биеийн жин, хоол тэжээлийн дутагдал эсвэл катаболизмын байдал, электролитийн дутагдлын зэрэг, эрхтний үйл ажиллагааны өөрчлөлт, электролитийн тасралтгүй алдагдал болон өвчний явц зэргээс хамааран өөр өөр байдаг.

e. Ус: PN шингэнд шаардлагатай усны хэмжээг электролитийн тэнцвэр болон шингэний хэрэгцээгээр тодорхойлдог.

f. Ердийн инсулин: Нэмж болно

ингэнд глюкозын өндөр концентрациас гаалан цусны глюкозын түвшинг хянах зорилгоор.

g. Гепарин: Нэмж болно

ерийн үзүүрт фибриний бүлэгнэл үүсэхийг бууруулах.

B. Өгөлт ба зогсоох

1. Тасралтгүй PN

a. 24 цагийн турш тасралтгүй тарьсан

b. Эмнэлгийн орчинд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг

2. Хуваатай эсвэл мөчлөгт PN

a. Ерөнхийдөө шим тэжээлийн шингэний тарилга схем нь янз бүрийн бөгөөд ихэвчлэн шөнийн цагаар хийдэг.

b. Урт хугацааны тэжээлийн дэмжлэг шаардлагатай өвчтөнүүдэд өдөрт нь IV уут, насосны иж бүрдлийн төвөггүйгээр өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагаанд оролцох боломж олгодог.

c. Глюкозын түвшинг нарийвчлан хянах

озын дутагдалтай үед гипогликеми үүсэх лтэй тул

инфузийн бус үед глюкозын дутагдал үүсэх эрсдэлтэй тул глюкозын түвшинг нарийвчлан хянах шаардлагатай.

3. PN эмчилгээг зогсоох

a. PN-ийг зогсоохоос өмнө хоол тэжээлийн мэргэжилтэн хоол тэжээлийн байдлыг үнэлдэг.
b. Эмчилгээг зогсоох заавар өгөгдсөн тохиолдолд амны хоолны хэмжээг нэмэгдүүлэн, урсгалын хурдыг 1–2 цагийн турш аажмаар бууруулна (энэ нь гипогликеми үүсэхээс сэргийлнэ).
c. IV катетерийг авсны дараа оруулах газар эдгэрэх хүртэл өдөр бүр боолтыг сольж байх. Төв судасны катетеруудыг халдварын эрсдлээс болж шаардлагагүйгээр удаан хугацаагаар үлдээхгүй байх ёстой, гэхдээ зарим тохиолдолд (судасны хангамж, эм тариа хийх) шаардлагатай үед үлдээж ашиглаж болно.
d. Амны хооллолтыг дэмжинэ.
e. Амны хооллолтын хэмжээг, биеийн жинг, цусны электролит болон глюкозын түвшний лабораторийн дүнг тэмдэглэнэ.

PN шингэнийг гэнэт таслах нь цуглуулагдсан шингэнийг гэнэт зогсоох нь гипогликеми үүсгэж болно. PN-ийг зогсоох үед урсгалын хурдыг аажмаар бууруулах шаардлагатай.

С. Гэмтлүүд (69-3-р хүснэгт)

1. Пневмоторакс ба **агаарын эмболи** нь төвийн шугам тавиулалттай холбоотой; агаарын эмболи нь мөн хоолой солихтой холбоотой.
2. Бусад хүндрэлүүдэд катетертэй холбоотой халдвар, гиперволеми, мөн гипергликеми ба гипогликеми зэрэг метаболик өөрчлөлтүүд орно; эдгээр хүндрэлүүд ихэвчлэн PN шингэний шийдвэрлээс үүдэлтэй байдаг (Приоритет сувилахуйн арга хэмжээг үзнэ үү).

Эмнэлгийн сувилагчийн тэргүүлэх үйл ажиллагаа

Төв венийн катетерийн халдвар сэжиглэгдсэн талбай

1. Анхны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид (PHCP) мэдэгдээрэй.
2. Катетерийг салгах болон өөр байршилд дахин суулгах боломжийн бэлтгэл хийх.
3. Катетерийн үзүүрийг авч, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн үзүүлэгчийн заавраар лабораторид суулгацын шинжилгээнд илгээх.

4. Цусны соёлд шинжилгээ өгөхөд үйлчлүүлэгчийг бэлтгэх.
5. Антибиотик өгөхөд бэлтгэх.
6. Тохиолдлыг, авсан арга хэмжээг болон үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдлийг баримтжуул.

Дүрийн ишлэл

Ignatavicius, Workman, Rebar (2018), 221-р хуудас.

D. Нэмэлт сувилахуйн анхаарах зүйлс

1. PN шингэнийг PHCP-ийн жортой харьцуулан шалгаж, заасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд шингэнд байгаа эсэхийг баталгаажуулна; зарим эрүүл мэндийн байгууллагууд жор батлахын тулд хоёр бүртгэлтэй сувилагчийн баталгаажуулалт шаарддаг.
2. Халдвар болон шингэний нийцэлгүй байдлаас сэргийлэхийн тулд PN шугамаар тарьсан эм болон цус өгөхгүй.
3. Шинжилгээнд зориулсан цусыг төв венийн хандалтын цэгээс авч болно; PN-ийг хэдэн минут зогсоосны дараа (байгууллагын журамд зааснаар) PN-ийн шингэнийг оруулдаг порт биш өөр портоор цус авна, учир нь PN-ийн шингэн дээжийн үр дүнг өөрчилж болзошгүй. Төв венийн хандалтын цэгтэй, PN авч байгаа үйлчлүүлэгчид венийн зүү оруулах цэг байх ёстой.
4. Антикоагулянт хэрэглэж буй өвчтөнүүдэд хэсэгчилсэн тромбопластин цаг (APTT) болон протромбины цагийг хянах.
5. Электролит болон альбумины түвшин, элэг ба бөөрний үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон бусад заасан лабораторийн шинжилгээг хянана. PN эмчилгээ авч байгаа үед цусны химийн шинжилгээг ихэвчлэн хоёр өдөр тутам эсвэл долоо хоногт 3 удаа (байгууллагын журамд зааснаар) хийдэг; үр дүнг нь PHCP нь PN шингэний найрлага эсвэл хурдыг үргэлжлүүлэх эсвэл өөрчлөх шийдвэр гаргахад үндэслэл болгодог.
6. PN шингэний найрлагаас үүдэлтэй гипергликемийн эрсдэлтэй тул зааврааp (ихэвчлэн 4 цаг тутамд) цусны глюкозын хэмжээг хянах.
7. Хүнд шингэн дутагдсан өвчтөнүүдэд PN эхлүүлснээр эмчилгээ шингэнийг нөхөж эхлэх тул эхэндээ альбумины түвшин буурах боломжтой.
8. Хүнд хоол тэжээлийн дутагдалтай өвчтөнүүдэд "дахин тэжээх хам шинж" (**калийн, магнийн** болон фосфатын сийвэнгийн түвшин хурдан буурах) илрэх эсэхийг хянаарай.
9. "Дахин хооллох хам шинжийн" үед үүсэх электролитийн шилжилт нь зүрх-судас, амьсгал болон мэдрэлийн хүндрэл үүсгэж болзошгүй; амьсгал хөнгөн, төөрөгдөл, сулралт, цус алдалт зэрэгт анхаарал хандуулах

хандлага, болон таталт. Ийм шинж тэмдэг илэрвэл эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP)-д даруй мэдэгдэнэ.

10. Элэгний үйл ажиллагааны үзүүлэлт хэвийн бус байх нь өөхний эмульс тэсвэргүй эсвэл хэт их хэрэглээ, эсвэл нүүрс ус, уураг шингээх, боловсруулах үйл ажиллагааны хүндрэлтэй байгааг илтгэнэ.
11. Бөөрний үйл ажиллагааны сорилын хэвийн бус үр дүн нь амин хүчлийн хэт их хэмжээг илтгэж болно.
12. PN шингэнүүдийг хөргөгчинд хадгалах ба бэлтгэсэн цагаас хойш 24 цагийн дотор хэрэглэх ёстой (хэрэглэхээс 0.5–1 цагийн өмнө хөргөгчнөөс гаргах).
13. Мөндөршиж эсвэл бараан өнгөтэй болсон PN шингэнийг хэрэглэж болохгүй бөгөөд эмийн сан руу буцаах ёстой.
14. PN шингэнд шим тэжээл зэрэг бодис нэмэх ажлыг сувилахуйн тасагт биш, эмийн сангийн нөхцөлд хийх ёстой.
15. Хоол тэжээлийн мэргэжилтэнтэй зөвлөлдөхийг тогтмол (эмчийн зааврааp эсвэл байгууллагын протоколын дагуу) хийх ёстой.

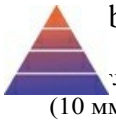
Е. Гэрийн асаргааны заавар (Бохь 69-3)

III. Цусны бүтээгдэхүүн хэрэглэх

A. Цусны бүтээгдэхүүнүүд

1. **Багцлагдсан улаан эсийн бэлдмэл (PRBC)**

a. PBRC-үүд нь эритроцитыг орлуулах зориулалттай цусны бүтээгдэхүүн бөгөөд 1 нэгжийн инфузийн хугацаа ихэвчлэн 2–4 цагийн хооронд байдаг.



b. Нэгж бүр нэмэгдүүлнэ

лобины түвшинг 1 г/дл-ээр нэмэгдүүлнэ (10 ммоль/л) болон гематокрит 3 %-иар (0.03); лабораторийн үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт цус шилжүүлсний дараа 4–6 цагийн дараа илэрнэ.

c. Үр дүнтэй хариу үйлдлийг анемийн шинж тэмдгүүд арилсан болон эритроцит, гемоглобин, гематокритийн тоо нэмэгдсэнээр үнэлдэг.

d. Лейкоцит багатай эсвэл лейкоцит арилгасан нэгжүүд нь лейкоцит, уураг болон плазмын агууламжийг бууруулсан нэгжүүд юм. Эдгээрийг цусны хүчилтөрөгч тээвэрлэх чадвар болон судасны доторх эзлэхүүнийг нөхөн сэргээхэд ашигладаг.

Угаасан улаан эсийг (leukocyte-poor буюу лейкоцит багатай) нь лейкоцит, уураг болон плазмын агууламжийг бууруулсан нэгжүүд юм. Эдгээрийг цусны хүчилтөрөгч тээвэрлэх чадамж болон судасны до

плазма, тромбоцит, лейкоцит) нь харшилтай цус шилжүүлэлтийн урвал үүссэн түүхтэй эсвэл гемопоэтик үндсэн эсийн шилжүүлэгт орсон өвчтөнд зааж өгөгдөж болно. Лейкоцитын ялгаралт (лейкоредукци) нь шүүлт, угаалт эсвэл хөлдөөлийн аргаар цусны бөөгнөрсөн эсийн нэгж дэх цагаан эсийн тоог бууруулах үйл явц юм.

2. **Тромбоцит шилжүүлэн шингээх**

a. Тромбоцитыг тромбоцитопени болон тромбоцитын үйл ажиллагааны доголдлыг эмчлэхэд ашигладаг.

b. Олон удаагийн тромбоцит шилжүүлэн сэлбүүлсэн өвчтөнүүд янз бүрийн тромбоцитын эсрэг бие үүсгэж, "аллоиммунчлогдож" болно. Ийм өвчтөнүүдэд тэдний хүний лейкоцитын антиген (HLA)-ийн тодорхой төрөлтэй нь таарсан тромбоцит шилжүүлэн сэлбүүлэх нь үр дүнтэй байж болно.

c. **Харилцан тохиргоо** хийх шаардлагагүй ч ихэвчлэн хийгддэг (тромбоцитын концентрат нь цөөн улаан эсийг [RBCs] агуулдаг).

d. Плазмийн нэгж дэх эзлэхүүн харилцан адилгүй байж болно; уутыг шалгахдаа цусны бүрэлдэхүүний эзлэхүүн (мл-ээр) заавал шалгана.

e. Плакетыг цусны банкнаас хүлээн авмагц яаралтай, ихэвчлэн 15–30 минутын дотор хурдан хурдаар тариулна.

f. Үр дүнтэй үнэлгээ

уг тромбоцитын тоог сайжруулахад лэн үнэлдэг бөгөөд тромбоцитын тоог ихэвчлэн шилжүүлсний дараа 1 цаг болон 18–24 цагийн дараа үнэлдэг; шилжүүлсэн тромбоцитын нэгж бүрийн хувьд, 5000–10000 мм^3 (5–10 × 10^9/л) өсөлт ажиглагдана.

3. Шинэхэн хөлдөөсөн плазма

a. Шинэхэн хөлдөөсөн плазм нь бүлэн үүсгэх хүчин зүйлсээр хангах эсвэл эзлэхүүнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэгддэг; энэ нь тромбоцит агуулдаггүй.

b. Шинэхэн хөлдөөсөн плазмыг хайлах явцад, коагуляцийн хүчин зүйлс идэвхтэй байх үед 2 цагийн дотор 15–30 минутын турш тарилга хийнэ.

c. **Плазмын** бүтээгдэхүүн шилжүүлэхэд Rh болон **ABO** нийцтэй байдал шаардлагатай.

d. Үр дүнтэй үнэлгээ

Хариу урвалыг коагуляцийн шинжилгээ, ялангуяа протромбины хугацаа болон хэсэгчилсэн тромбопластины хугацааг хянах, гиповолемийн шинж тэмдгүүд арилж буйгаар үнэлдэг.

4. Криопреципитатууд

a. Шинэхэн хөлдөөсөн плазмаас бэлтгэсэн криопреципитатыг 1 жил хадгална. Нэг удаа хайлуулсны дараа бүтээгдэхүүнийг заавал хэрэглэх ёстой; 1 нэгжийг 15–30 минутын турш тариулна.

b. Цусны бүлэгнэлтийн хүчин зүйлс, ялангуяа VIII хүчин зүйл болон фибриногеныг нөхөн олгохад ашиглана.

c. Үр дүнтэй

Үр дүнтэй хариу урвалыг бүлэгнэлтийн шинжилгээ болон фибриногенийн түвшинг хянах замаар үнэлдэг.

5. Гранулоцитууд

a. Сепсистэй эсвэл антибиотикт хариу өгөхгүй халдвар авсан нейтропенитэй өвчтөнд эмчилгээнд хэрэглэж болно

b. Үр дүнтэй хариу үйлдлийг үнэлэхийн тулд цагаан эсүүд болон тэдгээрийн ялгаварлалтын тоог хянана.

Шаардлагатай мэдээллийг тухайн талаар баримтжуулна

өвчтөний эмнэлгийн түүхэнд цус шилжүүлсэн тухай шаардлагатай мэдээллийг (байгууллагын удирдамжийг дагаж) баримтжуулна. Мөн өвчтөний шилжүүлэлтэд тэсвэрлэх чадвар, хариу үйлдэл болон шилжүүлэлтийн үр нөлөөг тусгана.

B. **Цусны** хандивын төрөл

1. Өөрийн

a. Төлөвлөгдсөн процедурын өмнө үйлчлүүлэгчийн өөрийн цусыг өгөх нь автолог хандив гэж нэрлэгддэг; энэ нь өвчин дамжих эрсдэл болон шилжүүлэн цус тэжээхтэй холбоотой хүндрэл үүсэх эрсдэлийг бууруулдаг.

b. Леүкеми эсвэл бактериемитэй өвчтөнд автолог хандив өгөх боломжгүй.

c. Хэмоglobin нь тогтмол хязгаар дотор байвал хандив 3 хоног тутамд өгөх боломжтой.

аюулгүй хүрээнд.

d. Цусны хандив нь цус шилжүүлсний дараах 5 долоо хоногийн дотор эхэлж, шилжүүлэх өдрөөс дор хаяж 3 хоногийн өмнө дуусах ёстой.

2. Цусны нөөцлөлт

a. Цусны нөөцлөлт нь биеийн хөндий, үений зай эсвэл бусад хаалттай биеийн хэсгүүдээс цус соруулан авч, өөрийн биедээ буцаан шилжүүлэх автолог хандив юм.

b. Цэнг буцааж сэлбэхээс өмнө эд эсийн үлдэгдлийг арилгах тусгай процесс болох "угаах" шаардлагатай байж болно.

3. Тодорхойлогдсон донор

a. Тодорхойлогдсон хандив нь хүлээн авагчид өөрсдөө тохирох донороо сонгох үед явагддаг.

b. Цус хандивлах нь цусаар дамжих халдварын эрсдэлийг бууруулдаггүй; гэвч хүлээн авагчид хандивлагчдаа өөрсдөө тодорхойлохдоо илүү тав тухтай байдаг.

C. Тохирох байдал (69-4-р хүснэгт)

1. Хүлээн авагчийн цусны дээж авна

мөн цусны дээж авах үед үйлчлүүлэгчийн орны хажууд шошго нааж тэмдэглэдэг; үйлчлүүлэгчээс нэрийг нь хэлэхийг хүсэж, үүнийг түүний таних бүслүүр эсвэл бугуйвчны нэртэй харьцуулдаг.

2. Хүлээн авагчийн ABO болон **Rh** төрлийг тодорхойлно.

3. Анти-A болон анти-B-ээс бусад эсрэг биеийн байдлыг тодорхойлохын тулд эсрэг биеийн шинжилгээ хийдэг.

4. Тохирлыг тодорхойлохын тулд кросс-матч хийдэг бөгөөд үүнд донорын улаан эсийг хүлээн авагчийн **серум** болон Кумбсын серумтай хольдог; улаан эсийн наалдалт үүсэхгүй бол кросс-матч тохирсон гэж үздэг.

5. Ерөнхий улаан эсийн донор нь O (-) бүлгийн, ерөнхий н авагч нь AB (+) бүлгийн байдаг.

6. Rh-эерэг цустай хүмүүс дараахыг хүлээн авч болно

Хэрэв шаардлагатай бол Rh-сөрөг донорын улаан эсийн шилжүүлэлт хийх; гэвч Rh-сөрөг хүлээн авагч нь Rh-эерэг цус авч болохгүй.

Донорын болон хүлээн авагчийн цусыг ...-ийн хувьд шинжлэх шаардлагатай.

холбоцтой байдлыг шалгах. Хэрэв цус нийцэхгүй бол амь насанд аюултай шилжүүлгийн урвал үүсч болно.

D. Инфузийн насосууд

1. Инфузийн насосыг тунгалаг бус шингэнтэй ажиллах зориулалттай бол цусны бүтээгдэхүүн тарихад ашиглаж болно; улаан эсийн гемолизыг сэргийлэхийн тулд цусны бүтээгдэхүүнд зориулсан тусгай шүүлтүүртэй IV хоолойг ашиглана.
2. Пумпыг хэрхэн ашиглах болон цус шилжүүлэхтэй нийцтэй байдлын талаарх зааврыг үргэлж үйлдвэрлэгчийн заавартай зөвлөлдөөрэй.
3. Цусны бүтээгдэхүүн шингээх зориулалттай тусгай гар барьцтай даралтны манжетыг урсгалын хурдыг нэмэгдүүлэхэд ашиглаж болох ч 300 ммHg-ээс ихгүй байх ёстой.
4. Стандарт сфигмоманометрийн манжетнууд ашиглах ёсгүй ... лын хурдыг нэмэгдүүлэхэд ашиглаж болохгүй, учир нь тэд уутыг бүх хэсэгт жигд шахалт үзүүлдэггүй.

E. Цус халаагч

1. Цусны халаагчийг хэд хэдэн нэгж цус шингээх үед гипотерми болон сөрөг урвалуудаас сэргийлэхэд ашиглаж болно.
2. Энэ зориулалтаар тусгай халаагчийг боловсруулсан бөгөөд зөвхөн энэ зориулалтаар батлагдсан төхөөрөмжүүдийг ашиглах ёстой.

Хэрэв цус халаах шаардлагатай бол зөвхөн халаах төхөөрөмжүүдийг ашиглана

Цусны бүтээгдэхүүнийг халаахад зориулан тусгайлан бүтээгдэж, батлагдсан. Цусны бүтээгдэхүүнийг микродолгионы зуух эсвэл халуун усанд бүү халаа.

F. Амралтын арга хэмжээ ба сувилагчийн үүрэг (69-4-р хайрцаг)

Өвчтөнийг таних (2 таних шинж тэмдэг) өөр лицензтэй сувилагчтай хамт шалгана уу

цусны бүтээгдэхүүн тарьж өгөх. PHCP-ийн жор, өвчтөнд венийн хангамжийн зохистой газар байгаа эсэх, хөндлөн хослолын шинжилгээ хийгдсэн эсэх, мэдээлэлд суурилсан зөвшөөрөл авсан эсэх, мөн зөв өвчтөнд зөв төрлийн цус өгөгдөж байгаа эсэхийг заавал шалга. Өвчтөний аюулгүй байдлыг хангахын тулд агентлагийн бодлогын дагуу баркод сканнерын систем ашигла.

G. **Цус шилжүүлэлтийн урвал** (69-5 дугаар хайрцаг)

1. Тайлбар
   a. Гемотрансфузийн урвал нь цус шилжүүлэн сэлбэх явцад үүсдэг сөрөг урвал юм.

b. Цус шилжүүлэлтийн урвалын төрөлд гемолитик, харшил, халуурал эсвэл бактерийн урвал (**септицеми**), мөн цус шилжүүлэлтийн дараах шилжүүлсэн эс-хост өвчин (GVHD) орно.

2. Шуурхай шилжүүлэлтийн урвалын шинж тэмдгүүд

a. Халууралт ба их хөлөрөх
b. Цээжний булчин өвдөх, нуруу өвдөх эсвэл цээжний хэсэгт өвдөлт
c. Булцай, тууралт, загатнал, хавагдалт
d. Хурдан, нарийн зүрхний цохилт
e. Амьсгал давчдах, ханиалгах эсвэл хяхтнах
f. Цайвар царай ба цианоз
g. Сэтгэл түгших
h. Мэдрэхүйн зөрүү, мэдрэмжгүй болох
i. Толгой өвдөх
j. Өлсгөлөн, бөөлжис, хэвлийн таталт, суулгалт

3. Ухаан алдсан өвчтөнд гарсан цус шилжүүлэлтийн урвалын шинж тэмдгүүд

a. Сул цохилт
b. Халуурал
c. Тахикардиа эсвэл брадикардиа
d. Цусны даралт буурах
e. Харагдах гемоглобинури
f. Олигури эсвэл анури

4. Хожуу илэрдэг шилжүүлэлтийн урвалууд

a. Гэмт урвал нь цус шилжүүлснээс хойш хэд хоногоос хэдэн жилийн дараа илрэх боломжтой.
b. Шинж тэмдгүүдэд халуур, хөнгөн шаргал өнгөтэй арьс, цусны гематокритийн түвшин буурах зэрэг орно.

Эхний 15 минутын турш үйлчлүүлэгчийн хажууд байцус шингээх явцад эхний 15 минутанд өвчтөний хажууд байж, шилжүүлэлтийн урвалын шинж тэмдгүүдийг хяна; шилжүүлэлтийн эхний 15 минут хамгийн чухал тул сувилагч өвчтөний хажууд байх ёстой. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн температур зэрэг амьдралын чухал үзүүлэлтүүдийг байгууллагын протоколд заасан хугацаагаар (30 минут тутамгаас 1 цаг тутам) хянана.

5. Оролцоо (Эрчимт сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд хэсгийг үзнэ үү)

Цус шилжүүлэлтийн урвал сэжиглэгдвэл шилжүүлэлтийг яаралтай зогсооно.

Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд

Цус шилжүүлэлтийн урвал

1. Цус шилжүүлэлтийг зогсоо.
2. IV шугамын хоолойг цусны төвлөрсөн газарт (IV site) хүртэл сольж, IV шугамыг физиологийн уусмалаар нээлттэй байлга.
3. Эхний ээлжийн эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгч (PHCP) болон цусны банканд мэдэгдэнэ.
4. Клиенттэй хамт байж, тэмдэг, шинж тэмдгүүдийг ажиглаж, амин чухал үзүүлэлтүүдийг 5 минут тутамд хянана.
5. Жороор заасан яаралтай эмийн тунг өгөхөд бэлд.
6. Шээсний дээж авч лабораторийн шинжилгээнд илгээх (бусад лабораторийн шинжилгээг зааврын дагуу хийх).
7. Цусны уут, хоолой, наалттай шошгууд болон цус шилжүүлэлтийн бүртгэлийг цусны банк руу буцааж өг.
8. Тохиолддлыг, авсан арга хэмжээг болон үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдлийг баримтжуулна.

Дүгнэлт

Perry et al. (2018), 803-805-р хуудас.

H. **Цусны эргэлтийн хэт ачаалал**

1. Тайлбар: Өвчтөнд тэсвэрлэх чадвар нь хүрэлцэхгүй хурдтайгаар цус шингэлснээс үүсдэг
2. Үнэлгээ
   a. Хоолой ханиалгах, амьсгал давчдах, цээжний өвдөлт, уушги сонсоход шуугиан
   b. Толгой өвдөх
   c. Дээд цусны даралт
   d. Таккардиа ба хүчтэй цохилттой пульс
   e. Хавирган хүзүүний судсууд

3. Эмчилгээний арга хэмжээ
   a. Тусгалын хурдыг удаашруул.
   b. Клиентийг босоо байрлалд, хөлөө доош чиглэсэн байрлалд байлга.
   c. Анхны тусламжийн эмч (PHCP)-д мэдэгдэнэ.
   d. Заасан тунгаар хүчилтөрөгч, диуретик болон морфин сульфатыг өг.
   e. Ритм алдааг хянах.
   f. Флеботоми нь хүнд тохиолдолд эмчийн зааврааp явуулдаг эмчилгээний арга байж болно.

I. Септицеми

1. Тайлбар: Микробийн бохирдолтой цус шилжүүлэхэд тохиолддог
2. Үнэлгээ
   a. Хурдан эхлэх чичрэх ба өндөр халуур
   b. Бүлтрэлт
   c. Халууралт
   d. Цусны даралт буурах
   e. Шок

3. Оролцоо

a. PHCP-д мэдэгдээрэй.
b. Цус болон цусны уутыг соёлд илгээх.
c. Зааврын дагуу хүчилтөрөгч, судсаар шингэн, антибиотик, вазопрессор болон кортикостероидыг хэрэглэнэ.

J. Төмрийн илүүдэл

1. Тайлбар: Хожуу дамжуулалтын хүндрэл нь олон удаа цус шингээх шаардлагатай болсон өвчтөнүүдэд, жишээлбэл цус багадалт эсвэл тромбоцитопениатай өвчтөнүүдэд үүсдэг.
2. Үнэлгээ
   a. Бүлтрэлт
   b. Халууралт
   c. Цусны даралт буурах
   d. Цусны үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөх

3. Оролцоо

a. Дефероксамин судсаар эсвэл арьсан доор тарьснаар бөөгнөрсөн төмрийг бөөрөөр дамжуулан гадагшлуулдаг.
b. Дефероксамин өгсний дараа төмөр ялгарах үед шээс улаан болдог; серум дахь төмрийн хэмжээ хэвийн болсон үед эмчилгээг зогсоодог.

Хэрэв a бол PHCP-тэй яаралтай холбогдоно уу цус шилжүүлэлтийн урвал эсвэл цус шилжүүлсний хүндрэл үүссэн тохиолдолд.

K. Өвчин дамжих

1. Хамгийн түгээмэл дамждаг өвчин нь С вирусний гепатит бөгөөд энэ нь хоолны дуршил буурах, дотор муухайрах, бөөлжих, шээс харлаж, арьс, салст бүрхэвч шарлах зэргээр илэрдэг; шинж тэмдгүүд ихэвчлэн цус шилжүүлсний дараах 4–6 долоо хоногийн хооронд илэрдэг.
2. Цус шилжүүлснээр дамжих бусад халдварт агент, өвчнүүдэд В гепатийн вирус, хүний дархлал хомсдлын вирус (HIV), хүний герпес вирусийн 6-р төрөл, Эпштейн-Барр вирус, хүний Т-эсийн лейкеми, цитомегаловирус болон маляри зэрэг орно.
3. Донорын шалгалт нь халдварт бодисын дамжих эрсдэлийг ихээхэн бууруулсан; түүнчлэн донорууд ХДХВ-ийн эсрэг эсрэгбиеийн шинжилгээ хийх нь дамжих эрсдэлийг ихээхэн бууруулсан.

L. Гипокальцеми

1. Гэмжүүлсэн цусны цитрат нь **кальцитай** холбогдож, биеэс ялгардаг.
2. Цус шилжүүлснээс өмнө болон дараа серум кальцийн түвшинг үнэлнэ.
3. Гипокальцемийн шинж тэмдгүүдийг хянах (гиперактив рефлексүүд, парастези, тетани, булчингийн агшилт, эерэг Труссогийн шинж, эерэг Хвостекийн шинж).
4. Цус шилжүүлэлтийг удаашруулж, гипокальцемийн шинж тэмдэг илэрвэл анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP)-д мэдэгдэнэ.

M. Гиперкалиеми

1. Хадгалагдсан цус гемолизийн явцад кали чөлөөлдөг.
2. Цус хөгширөх тусам гиперкалиемийн эрсдэл нэмэгддэг; тиймээс бөөрний дутагдал эсвэл бөөрний үйл ажиллагаа зогссон зэрэг гиперкалиемийн эрсдэлтэй өвчтөнүүдэд шинэ цус шилжүүлэх хэрэгтэй.
3. Цусны хадгалах хугацаа болон шилжүүлсний өмнөх, дараах серумын калийн хэмжээг шалгана.
4. Калийн түвшин болон шинж тэмдгүүдийг хянах ба гиперкалиемийн шинж тэмдгүүд (парестези, сулрал, хэвлийн булчингийн агшилт, суулгалт, ритмийн эмгэг).
5. Цус шилжүүлэлтийг удаашруулж, гиперкалиемийн шинж тэмдэг илэрвэл анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP)-д мэдэгдээрэй.

N. Цитратын хордлого

1. Цитрат нь цусны бүтээгдэхүүнд ашиглагддаг цус бүлэгнэлтийн эсрэг бодис бөгөөд элэгний үйл ажиллагаагаар задлагддаг.
2. Хадгалагдсан цусны олон нэгжийг хурдан шингээхэд цитрат кальци, магнитай холбогдож кальци, магнийн дутагдал үүсгэж болно; энэ нь цитратын хордлого үүсгэн миокардийн сулрал, коагулопати үүсгэдэг.
3. Хамгийн их эрсдэлд өртөх хүмүүс нь элэгний үйл ажиллагаа доголдсон болон элэгний үйл ажиллагаа бүрэлдэн тогтоогүй нярайнууд юм.
4. Эмчилгээнд цитратыг боловсруулах боломж олгохын тулд цус шилжүүлэлтийг удаашруулах эсвэл зогсоох; кальцийн болон магнийн дутагдлыг нөхөн сэлбэх эмчилгээгээр эмчилдэг.

IV. Хоолойн арчилгаа

A. Хамрын ходоодны (NG) хоолой

1. Эдгээр нь ходоодонд интубаци хийхэд ашиглагддаг хоолойнууд юм.
2. Хоолойг хамраас ходоод руу оруулдаг.

B. Зорилго

1. Ходоодонд хуримтлагдсан шингэн эсвэл хийг гадагшлуулан даралтыг бууруулах

ходоодны тав тухыг дэмжих

2. Мэс заслын анастомозыг суналтгүйгээр эдгэрүүлэх

3. Асприрацийн эрсдэлийг бууруулах

к чадахгүй үйлчлүүлэгчдэд эм тариа өгөх

5. Тэжээл өгөх түр хоол тэжээлийн хоолойн үүрэг гүйцэтгэх замаар тэжээл өгөх

6. Ходоодонд угаалга хийж хордлогын үед үүссэн хортой бодисыг гадагшлуулах

C. Хоолойн төрөл

1. Левин хоолой (зураг 69-8)

a. Нэг сувагтай хоолойн хоолой

b. Хоол боловсруулах замын агууламжийг завсрын соролт ашиглан гаргах эсвэл хоолойг ашиглан хоол тэжээл өгөхөд ашиглагддаг

2. Сэйлэмийн сумп хоолой: Сэйлэмийн сумп нь хоёр сувагтай, агаар гаргах хоолой (pigtail) бүхий назогастраль хоолой бөгөөд тасралтгүй, завсрын соруулалттайгаар даралт бууруулахад ашиглагддаг (зураг 69-8-ыг үзнэ үү).

Сэйлэмийн сумп хоолойн агаарын гаргагч хоолойг хавчих ёсгүй бөгөөд ходоодны түвшнээс дээш байлгах ёстой. Хэрэв агаарын гаралтын нүхээр гоожилт гарвал агаарын гаралтын нүх рүү 30 мл агаар шахаж, гол сувгийг физиологийн давсны уусмалаар угаана.

D. Интубацийн аргачлал (69-6 дугаар хайрцаг)

E. Угаалга

1. Услахаас өмнө байрлалыг үнэлнэ (69-6-р хайрцгийг үзнэ үү).

2. Хоолойн нээлттэй байдлыг шалгах, хадгалахын тулд 4 цаг тутамд усалгаа хийнэ.

3. Усалгааны шприцээр 30–50 мл ус эсвэл натрийн хлоридын 0.9 %-ийн уусмал (байгууллагын бодлогоос хамаарч) зөөлөн дусааж оруулна.

4. Сирэнжийн поршийг ухрааж шингэнийг сорж, сувгийн нээлттэй байдлыг шалгана; хоолойн урсгал удаашралтай бол давтан хийнэ.

F. Насогастраль хоолойг салгах: Клиентээс авахыг хүс

гүнзгий амьсгаа авч барь; хоолойг 3–6 секундын турш аажмаар, жигд татаж гаргана (гаргах явцад хоолойг гарынхаа эргэн тойронд ороож болно).

G. Хоол боловсруулах замын хоолойгоор хооллох

1. Хоолойн төрөл болон анатомийн байрлал

a. Насогастраль: Хамраас ходоод руу

b. Назодуоденаль-назожежуналь: Хамраас 12-р хоолой эсвэл жежум хүртэл

c. Гастростоми: Хэвлий

d. Жеюностоми: Жеюнум

2. Оруулах аргууд

a. Болюс: Болюс нь хэвийн хооллолтын хэв маягтай төстэй; холимогийг 3–6 цаг тутамд 30–60 минутын хугацаанд өгдөг; холимогийн хэмжээ, давтамжийг хоол тэжээлийн мэргэжилтэн зөвлөж, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгч (PHCP) бичгээр зааварчилдаг.

b. Тасралтгүй: Хооллолтыг 24 цагийн турш тасралтгүй өгдөг; урсгалыг инфузийн хооллолтын насос зохицуулна.

c. Цикльчилсэн: Хооллолтыг өдөр эсвэл шөнийн цагаар ойролцоогоор 8–16 цагийн турш явуулна (шөнийн хооллолт нь өдрийн цагаар илүү эрх чөлөө олгодог).

d. Инфузийн хооллолтын насос урсгалыг зохицуулна.

3. Хоол тэжээл өгөх аргачлал

a. Үлдэгдлийн хэмжээг тогтоох талаар PHCP-ийн жор болон байгууллагын бодлогыг шалгана; ихэвчлэн үлдэгдэл 100 мл-ээс бага байвал хооллолтыг үргэлжлүүлнэ; их хэмжээний аспираци нь ходоодны хоол гарах явц удааширч байгааг илтгэн, үйлчлүүлэгчийг аспирацийн эрсдэлд оруулна.

b. Гутлын чимээг үнэл; гутлын чимээ байхгүй бол хооллолтыг түр зогсоож, PHCP-д мэдэгд.

c. Өвчтөнийг өндөр Фоулер байрлалд байрлуул; комототой бол өндөр Фоулер байрлалд баруун хажуугаар нь хэвтүүл.

d. Хоол боловсруулах сувгийн агууламжийг соруулан pH-ийг (3.5 эсвэл түүнээс бага байх ёстой) эсвэл байгууллагын журамд зааснаар хэмжиж хоолойн байрлалыг үнэлнэ.

e. Ходоодны үлдэгдэл бүхэл агууламжийг соруулан хэмжиж, электролитийн тэнцвэргүй байдлаас сэргийлэхийн тулд ходоодонд буцааж хийнэ (хэрэв үлдэгдлийн өнгө эсвэл шинж чанар хэвийн бус эсвэл хэмжээ нь 250 мл-ээс их бол буцаахгүй).

f. Хоолны температурыг өрөөн температурт хүртэл халааж, суулгалт болон булчингийн агшилтыг сэргийлнэ.

g. Тасралтгүй эсвэл мөчлөгт хооллолтод инфузийн хооллолтын насос ашиглана.

h. Болос хооллолтын дараа хооллолтыг 30 минут турш өндөр Фоулер байрлалд хадгална. Инфузийн насос ашиглах эсвэл хооллолтыг хүч таталтаар урсгахыг зөвшөөрнө. Хооллолтыг ходоодонд шууд шахж оруулахгүй.

i. Тасралтгүй хооллолт хийх үед өвчтөнийг үргэлж хагас Фаулер байрлалд байлга.

4. Аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ

Хоол тэжээлийн хоолойг байрлуулахын өмнө хоол боловсруулах замын хоолойн байрлалыг үргэлж үнэлж байх

хоолны шингэн, эм эсвэл бусад ямар ч шингэн тарьж оруулна. Хэрэв хоолой буруу байрласан бол өвчтөн амьсгалын замд шингэн орж, амьсгалын замын хагарал үүсэх эрсдэлтэй.

a. Хоолны сав болон хоолойг 24 цаг тутамд эсвэл байгууллагын журамд заасан хугацаанд сольж байх.

b. 4 цагийн хугацаанд шаардлагатайгаас илүү шингэн бэлдмэл өлгөж болохгүй; энэ нь бактерийн өсөлтийг зогсоодог.

c. Хоолны найрлагыг хэрэглэхийн өмнө хугацаа дуусах огноог шалгана.

d. Формулыг сав (хооллох уут) руу асгахаас өмнө сайтар сэгсрээрэй. Зарим хооллолт нь формулыг уут руу хийх эсвэл хооллох хоолойг шууд холбож болдог лонх ашиглахыг шаарддаг. Хоолой заримдаа Y-холболттой байдаг тул поршен сиринг ашиглахгүйгээр насосоор тогтмол угаалт хийх боломжтой.

e. Бөөрний дуу чимээг үргэлж шалга; хэрэв бөөрний дуу чимээ байхгүй бол хооллолт хийхгүй.

f. Хоолыг заасан хурдаар эсвэл гравитацийн урсгалаар (урсгалтай болюс хооллолт) 50–60 мл-ийн поршеныг нь салгасан шприцээр өгнө.

g. Хооллолтын дараа усалгааны шприцээр 30–50 мл ус эсвэл физиологийн шингэн (NS) (байгууллагын бодлогоос хамаарч) зөөлөн зайлуулна.

5. Хооллолтын хүндрэлүүдэд аспираци,

хоол боловсруулах замын эмгэг, бөөлжих, хоолой бөглөрөх.

6. Аспираци

a. Хоолойн байрлалыг шалгана.

b. Хэрэв үлдэгдэл 100 мл-ээс их байвал хооллолт өгөхгүй (PHCP-ийн жор болон агентлагийн бодлогыг шалгана уу).

c. Орны толгойн хэсгийг өргөсөн байлга.

d. Хэрэв аспираци тохиолдвол шаардлагатай үед соруулалт хийж, амьсгалын давтамжийг үнэлж, уушгины чимээг сонсож, аспирацийн уушгины хатгалгааны үед температурыг хянаж, цээжний рентген зураг авах бэлтгэл хийх.

7. Халууралт

a. Клиентийн лактоз тэсвэргүй байдлыг үнэлнэ.

b. Эслэг агуулсан хооллолтыг хэрэглэ.

c. Хоолыг өрөөний температурт удаан өг.

8. Бүлтрэлт

a. Хоолыг удаан өг, нэг удаагийн их хэмжээний хоол өгөх үед хооллолтыг дор хаяж 30 минут үргэлжлүүл.

b. Хэвлийн тойргийг хэмжинэ.

c. Хоолны уутыг хоосорч болохгүй.

d. Хоолойн дотор агаар орохоос сэргийл.

e. Хоолыг өрөөний температурт өг.

f. Орны толгойн хэсгийг өргө.

g. Жороор заасан ёсоор бөөлжис баригч эм өг.

9. Хорголсон хоолой

a. Хэрэв боломжтой бол эмийн шингэн хэлбэрийг хэрэглэ.

b. Эмийн хэрэглээний өмнө болон дараа, мөн болюс хооллолтын өмнө болон дараа хоолойн доторхыг 30–50 мл усаар эсвэл натрийн хлоридын изотоник шингэнээр (байгууллагын бодлогод үндэслэн) зайлж цэвэрлэ.

c. Тасралтгүй хооллохын тулд 4 цаг тутамд усаар зайлуулна.

Хэрэв үйлчлүүлэгч бөөлжиж байвал хоолойн хооллолтыг зогсооно

мөн өвчтөнийг хажуу тийш хэвтээ байрлалд байрлуулж, шаардлагатай үед сурфаксант соруулах.

H. Эм бэлдмэл олгох (Эхний ээлжийн сувилахуйн үйл ажиллагааг үзнэ үү)

Эмнэлгийн үйлчилгээний тэргүүлэх арга хэмжээ

Хамрын ходоод (NG), ходоодны гастростоми эсвэл jejunostomy хоолойгоор эм бэлдмэл өгөх

1. Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийн (PHCP) жор бичгийг шалгах.
2. Эмийг хэрэглэхэд бэлд.
3. Заасан эм шахаж бутаргаж болох эсвэл нээж болох капсул эсэхийг шалга; боломжтой бол эликсир хэлбэрийн эмийг ашигла.
4. Бүтээгдэхүүнийг бутласан эм эсвэл капсулын агуулгыг 15–30 мл усанд уусгана.
5. Клиентийн таних мэдээллийг (2 таних тэмдэг) баталгаажуулж, үйл явцыг клиентд тайлбарлана.
6. Бээлий өмс; эмийг дусаахаас өмнө хоолойн байрлал, үлдэгдлийг шалгаж, гэдэсний чимээг сонсох.
7. Агентлагийн бодлогын дагуу 30–50 мл ус эсвэл нормаль давсны уусмалаар зайлуулна.
8. Хоолойг хавчин, назогастраль хоолойд усалгааны шприц холбож, эмийг шприц рүү хийнэ. Хоолойг хавчсан газраа даруй суллаж, эмийг хүчний нөлөөгөөр урсгах боломж олгоно.
9. Агентлагийн бодлогын дагуу 30–50 мл ус эсвэл физиологийн уусмалаар зайлуулна.
10. Эмийн төрөл болон байгууллагын бодлогоос хамааран хоолойг 30–60 минут хавчуурах.
11. Эмчилгээг олгосон болон бусад холбогдох мэдээллийг баримтжуулна.

Дүгнэлт

Potter et al. (2017), 636-637-р хуудас.

I. Бөөрөнхий гэдэсний хоолой

1. Тайлбар

a. Энэхүү гэдэсний хоолойг хамраар дамжуулан жижиг гэдэс рүү оруулна.

b. Энэ нь гэдэсний даралтыг бууруулах эсвэл бусад арга хэмжээ үр дүнгүй үед цугларсан гэдэсний ялгаралтыг зайлуулахад ашиглагддаг.

c. Энэхүү хоолой нь үзүүртээ вольфрам агуулсан жижиг уутын жингийн нөлөөгөөр пилорын сфинктерийг дамжин жижиг гэдэс рүү ордог.

d. Хоолойн төрөлд Канторын хоолой (нэг сувагтай) болон Миллер-Абботтын хоолой (хоёр сувагтай) орно (зураг 69-8-ыг үзнэ үү).

2. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. PHCP-ийн жор болон ахиц дэвшил, ...-ийн агентлагийн бодлогыг үнэлнэ

хоолой болон вольфрамыг гаргах.

b. Өвчтөнийг баруун хажуугаараа хэвтүүлж, жинтэй уутыг ходоодны пилорус дамжин жижиг гэдэс рүү ороход хялбар болгоно.

c. Журмын явцад хоолойн гаралтыг болон хэвлийн тойргийг хянаж, хэвлийг үнэлнэ.

d. Хоолойг гэдсэнд эцсийн байрлалд нь (хэдэн цаг зарцуулах боломжтой) хүрэх хүртэл нүүрэнд нь наалтаар бэхлэж болохгүй.

e. Хэрэв хоолой бөглөрвөл РНСР-д мэдэгдэнэ.

f. Хоолойг авахын тулд тунгустенийг баллон хэсгээс шприцээр сорж авна; хоолойг РНСР-ийн зааврааар цаг тутамд 6 инч (15 см)-ээр аажмаар гаргана.

J. Хоолойн болон ходоодны хоолой

1. Тайлбар

a. Бусад арга хэмжээ үр дүнгүй эсвэл хэрэглэж болохгүй үед цус алдаж буй хоолойн судаснуудад даралт үзүүлж цус алдалтыг хянах зорилгоор ашиглаж болно.

b. Өвчтөнд хоолойн шархлалт эсвэл некроз байгаа эсвэл өмнө нь хоолойн мэс засалд орсон бол хагарах эрсдлээс болж ашиглахгүй.

2. Сэнгстакен-Блэкмор хоолой ба Миннесота хоолой (зураг 69-8-ыг үзнэ үү)

a. Сенгстакен-Блэкмор хоолой нь зөвхөн заримдаа хэрэглэгддэг, гурван сувагтай ходоодны хоолой бөгөөд уушигны судасны варикозыг шахах зориулалттай үл хөөрөх уушигны бөмбөлөг (compresses esophageal varices), ходоод-уушигны залгаа хэсэгт даралт үзүүлэх үл хөөрөх ходоодны бөмбөлөг, мөн ходоодны шингэн сорох сувагтай. Эзофагийн бөмбөлөгийн дээр хуримтлагдсан ялгаралтыг цуглуулахын тулд эсрэг хамар нүх рүү назогастраль хоолой оруулдаг.

b. Илүү түгээмэл хэрэглэгддэг нь Миннесота хоолой бөгөөд энэ нь нэмэлт

lumen (4-лументэй ходоодны сонда) хоолойн-хоолойн булчирхайн ялгаралтыг сорох зориулалттай.

c. Дээд хэвлий ба цээжний рентген зураг байрлалыг баталгаажуулна.

3. Оролцоо

a. Оруулахын өмнө бүх бөмбөлөгийн нэвтрэх чадвар болон гэмтэлгүй байдлыг шалгана.

b. Лүмен бүрт шошго наах.

c. Суулгахын өмнө үйлчлүүлэгчийг босоо эсвэл Фоулерын байрлалд байрлуул.

d. Шууд суулгасны дараа байрлалыг баталгаажуулахын тулд рентген зураг авах бэлтгэл хийх.

e. Хоолой байрласаны дараа толгойг өргөсөн байдлаар хадгална.

f. Агаарын алдагдлыг зогсоохын тулд бөмбөлөгийн портуудыг хоёр хавчаараар ...улах.

g. Хажуугийн ширээн дээр хайч байлга бүх үед; амьсгалын хүндрэл үүсэхийг хянах ба хэрэв үүссэн тохиолдолд хоолойг тайрч бөмбөлгүүдийг сулруулах.

h. Хоол боловсруулах хоолойн шарх үүсэх эсвэл некроз болохоос сэргийлэхийн тулд заасан хугацаанд болон байгууллагын журмын дагуу хоол боловсруулах хоолойн даралтыг суллана.

i. Илүү их хэмжээний цусархаг ялгадас гарч байгааг хянаж, энэ нь тогтмол цус алдалт болон варикозын судсууд хагарсны шинж байж болно.

j. Хоол боловсруулах хоолойн хана цуурах шинж тэмдгүүд болох цусны даралт буурах, зүрхний цохилт түргэсэх, нуруу болон дээд хэвлийн өвдөлтийг ажигла. Хоол боловсруулах хоолойн хана цуурах нь яаралтай тусламж шаарддаг тул эдгээр шинж тэмдгүүдийг илрүүлсэн даруйд РНСР-д даруй мэдээл.

К. Ляжагийн хоолойнууд

1. Ходоодонд агуулагдах хортой бодисыг гадагшлуулахад ашиглагддаг
2. Хоолойн төрөл

a. Лавакуатор: Лавакуатор нь том сорох хөндий, бага угаалгын-вентиляцийн хөндийтэй орогастрак хоолой бөгөөд тасралтгүй сорох үйлдлийг хангадаг; угаалгын шингэн угаалгын хөндий рүү орж, ходоодны агууламжийг сорох хөндийгээр гадагшлуулдаг

лумен (зураг 69-9-ийг үзнэ үү).

b. Эвальдын хоолой: Нэг сувагтай, том диаметртэй хоолой бөгөөд түргэн нэг удаагийн угаалт, зайлуулалтад ашиглагддаг

L. Шээс болон бөөрний хоолойнууд

1. Шээх катетерийн төрөлүүд
   a. Нэг лументэй: Ихэвчлэн шулуун катетеризацид, өвчтөний давсагыг хоослох, стериль шээсний дээж авах эсвэл өвчтөн шээсний дараа үлдэгдэл шээсний хэмжээг шалгахад ашиглагддаг
   b. Хоёр сувагтай: Тасралтгүй давсагны дренаж хийх шаардлагатай үед ашиглагддаг; нэг сувag нь дренажийн, нөгөө нь бөмбөлөгийг үлээлгэх зориулалттай.
   c. Гурван сувагтай: Шууд давсаг угаах, зайлуулах шаардлагатай үед ашиглагддаг; нэг сувag нь давсаг угаах уусмал хийх, нэг сувag нь тасралтгүй давсаг зайлуулах, нэг сувag нь бөмбөлөг үлээхэд зориулагдсан.
   d. Катетер суулгах болон арчилгаанд хатуу асептик техник шаардлагатай.
2. Шээх катетерийн ерөнхий арчилгаа
   a. Бээлий зүүж, перинэйн хэсгийг бүлээн савантай усаар угаана.
   b. Зонхилохгүй гараараа лабиа эсвэл урд арьсыг ухарган татаж, шээх нүхийг ил гаргана (насанд хүрсэн эрэгтэйд урд арьсыг хэвийн байрлалд нь буцаана).
   c. Катетерийн дагуух хэсгийг саван, усаар цэвэрлэ.
   d. Катетерыг гуянд бэхлэх.
   e. Катетерийн уутыг давсагны түвшнээс доогуур байлга.

3. Шээсний хоолой болон нефростомын хоолой (69-9-р зураг)
   a. Хоолойг хэзээ ч хавчуулахгүй.
   b. Гадны бөглөрөлгүй байдлыг хадгалах.
   c. PHCP-ээр заасан тохиолдолд л хатуу асепсийн техник баримтлан угаах; хамгийн ихдээ 5 мл стериль физиологийн уусмалыг удаан, зөөлөн дусааж оруулна.
   d. Хэрэв заасан угаалтаар сувгийн нэвтрэх чадварыг тогтоож чадахгүй бол PHCP-д даруй мэдэгдэнэ.
4. Катетер суулгах ба салгах (69-7-р хайрцаг)

Хэрэв үйлчлүүлэгчид шээсний хоолой эсвэл нефростомын хоолой суурилуулсан бол гаралтыг хянаарай

нарийвчлан хянаж; шээсний ялгаралт цагт 30 мл-ээс бага эсвэл 15 минутаас дээш хугацаанд ялгаралт байхгүй бол энэ талаар PHCP-д даруй мэдэгдэх ёстой.

М. Амьсгалын замын хоолойнууд

1. Эндотрахеал хоолой (Зураг 69-10)
    a. Эндотрахеал хоолойг амьсгалын замыг нээлттэй байлгахад ашиглана.
    b. Эндотрахеал хоолойг өвчтөнд механик амьсгалын дэмжлэг шаардлагатай үед ашиглана.
    c. Хэрэв үйлчлүүлэгч 10–14 хоногоос илүү хугацаагаар хиймэл амьсгалын зам шаардвал, хоолойн болон хоолойн булчирхайн гэмтлийг сэргийлэхийн тулд трахеостоми хийж болно.
    d. Хоолойн төгсгөлд байрлах манжетыг үлээхэд трахеа болон манжетын хооронд битүүмж үүсч, аспирациас сэргийлж, механик амьсгалын аппаратыг ашиглах үед тогтоосон амьсгалын эзлэхүүнийг хүргэх нөхцлийг хангадаг; үлээсэн манжет бас агаарыг хоолойн утас, хамар эсвэл ам руу нэвтрэхээс хамгаалдаг.
    e. Пилот бөмбөлөг нь манжетанд агаар оруулах, агаар алдагдахаас сэргийлэх бөгөөд манжетанд агаар байгаа эсэх, эс байгааг тодорхойлох заавар болгон ашиглагддаг.
    f. Универсал адаптер нь хоолойг механик амьсгалын аппаратын хоолой эсвэл бусад төрлийн хүчилтөрөгч дамжуулах системд холбох боломжийг олгодог.
    g. Хоолойн төрөл: оротрахеал болон назотрахеал
2. Оротрахеал хоолой
    a. Амны замаар оруулдаг; илүү том диаметртэй хоолой ашиглах боломж олгож, амьсгалын ачааллыг бууруулдаг
    b. Хамар битүүрэлтэй эсвэл хамар цус алдахад өртөмтгий үед зааварлагддаг
    c. Таагүй мэдрэмж төрүүлж, хэлээр хөдөлгөж болдог тул амьсгалын замыг бөглөх эрсдэлтэй; өвчтөнд хоолойг хазахаас сэргийлэхийн тулд амны агаар дамжуулах хоолой хэрэгтэй байж болно.
3. Хамтрах трахеал хоолой

a. Нэг хамарны нүхээр оруулдаг; энэ жижиг хоолой эсэргүүцлийг нэмэгдүүлж, өвчтөний амьсгалын ажлыг нэмэгдүүлдэг.

b. Цус алдалтын эмгэгтэй өвчтөнд хэрэглэхээс зайлсхийдэг.

c. Энэ нь өвчтөнд илүү тав тухтай бөгөөд өвчтөн хоолойг хэлээр хөдөлгөж чадахгүй.

4. Оролцоо

a. Хэлбэрийн байрлалыг цээжний рентген зургаар баталгаажуулдаг (зөв байрлал нь хоолойн салааны зангилаагаас 1–2 см дээш байрлана).

b. Хэвлэгийн хоёр талд чих тавин сонсож, амьсгалын аппарат (Ambu уут) ашиглан гараар амьсгалыг нөхөж байх үед байрлалыг үнэлнэ (хэрэв зүүн талд амьсгалын чимээ болон хэвлийн хананы хөдөлгөөн алга бол хоолой баруун гол бронхус руу орсон байж болно).

c. Ходоод руу сонсголт хийж хоолойн хоолой ходоодонд ороогүйг баталгаажуул.

d. Хэрвээ хоолой ходоодонд орсон бол ходоодны дээгүүр хөхнийхөөс илүү чанга амьсгалын чимээ сонсогдож, ходоод томорсон байна.

e. Интубаци хийсний дараа шууд наалдамхай туузаар хоолойг бэхлээрэй.

f. Хоолойн байрлалыг уруул эсвэл хамар дээр хянаарай.

g. Арьс болон салст бүрхүүлийг хяна.

h. Шаардлагатай үед л хоолойг соруулаарай.

i. Амны хоолойг уруулын болон амны хэсэгт даралт, некроз үүсэхээс сэргийлж, мэдрэлийн гэмтлийг зогсоох, амны хөндийг үзлэг, цэвэрлэгээ хийхэд хялбар болгох үүднээс өдөр бүр амны нөгөө тал руу шилжүүлэх шаардлагатай; хоолойг амны нөгөө тал руу шилжүүлэх ажлыг хоёр эрүүл мэндийн ажилтан гүйцэтгэнэ.

j. Хоолойг хөдлөх, татагдах, чирэгдэхээс сэргийл; өвчтөний соруулах, ханиалгах, ярих оролдлого нь хоолойнд нэмэлт ачаалал өгч, хөдлөхөд хүргэж болно.

k. Пилот бөмбөлгийг шалгаж, манжет хэвийн дүүрсэн эсэхийг баталгаажуулах; манжетыг тогтмол дүүрсэн байлгах

хэмжээнд нь дүүргэх нь битүүмж үүсгэж, амьсгалыг бүрэн механик хяналтанд оруулах боломж олгодог.

l. Коллетийн даралтыг агентлагийн журамд зааснаар дор хаяж 8 цаг тутамд хянах ба 20 ммHg-ээс хэтрэхгүй байх ёстой (коллетийн даралтыг хэмжихийн тулд анероид даралт хэмжигч ашиглана); коллетийн даралтыг шалгахдаа бага алдагдалтай болон битүүмжилсэн аргуудыг ашиглан дүүргэнэ.

Амбу уутыг бэлэн байлгах шаардлагатай энгийн амьсгалын хоолой эсвэл трахеотомийн хоолойтой өвчтөний орны хажууд үргэлж байлгах шаардлагатай.

5. Хамгийн бага алдагдлын техник

a. Энэ нь даралтын буулгах хавхлагагүй манжетыг үлээлгэх, манжетны даралтыг шалгах зориулалттай.

b. Манжетыг битүүмж тогтох хүртэл үлээнэ; өвчтөн амьсгаа авахад трахейн дээр тавьсан стетоскопээр ямар ч ширүүн авиа сонсогдохгүй, гэхдээ амьсгаа хамгийн их гүнзгий авсан үед бага зэрэг агаарын алдагдал гарч, сонсогдоно.

c. Өвчтөн аман дуу гаргаж чадахгүй бөгөөд түүний амнаас агаар гарах мэдрэгдэхгүй.

6. Хаалттай арга

a. Энэ нь даралтын хэт их нэмэгдлийг хязгаарлах хавхлагатай манжетыг үлээх, даралтыг шалгахад ашиглагддаг.

b. Манафын хамгийн бага шахалтын даралтаар хоолойд хангалттай битүүмжлэл үүсгэнэ.

c. Агаарын алдагдалгүйгээр хамгийн бага алдагдлын аргыг ашигладаг.

7. Экстубаци

a. Өвчтөнд их хэмжээний хүчилтөрөгч өгч, хоолойн хоолой болон амны хөндийг соруулагчаар цэвэрлэ.

b. Өвчтөнийг хагас Фоулер байрлалд байрлуулна.

c. Күүфийг суллаж, өвчтөнд амьсгаа аваалгаж, амьсгал дээд цэгтээ хүрэхэд хоолойг гаргаж, амьсгалын замыг соруулагчаар цэвэрлэнэ.

хоолойг гаргах явцад агаар дамжуулах замыг соруулан авах.

d. Хоолойг гаргасны дараа өвчтөнд хоолойнд хуримтлагдсан ялгаралтыг гаргахад туслахын тулд ханиалгах, гүн амьсгал авахыг зааж өг.

e. Зааврын дагуу хүчилтөрөгчийн эмчилгээ хийх.

f. Амьсгалын хүндрэл гарч байгаа эсэхийг хянах; амьсгалын хүндрэл гарвал анхан шатны эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэнтэй холбогдох.

g. Өвчтөнд хоолой задрах эсвэл хоолой өвдөх нь хэвийн үзэгдэл бөгөөд ийм үед яриагаа хязгаарлахыг зөвлөх.

N. Трахеостоми

1. Трахеотоми нь амьсгалын замыг хангах зорилгоор мэс заслын аргаар шууд трахеад үүсгэсэн нүх бөгөөд трахеотомийн хоолойг энэ нүх рүү оруулж, механик амьсгалын аппарат эсвэл өөр төрлийн хүчилтөрөгч нийлүүлэх төхөөрөмжид холбодог (Зураг 69-11).

2. Төрөл: Трахеотоми түр зуурын эсвэл байнгын байж болно (69-8-р хайрцаг).

3. Оролцоо

a. Амьсгалын давтамж, хоёр талын амьсгалын чимээг үнэлнэ.

b. Артерийн цусны хий болон пульс оксиметрийн үзүүлэлтүүдийг хянах.

c. Хоолой авах болон гүнзгий амьсгалахыг урамшуулах.

d. Хагас Фоулерээс өндөр Фоулер байрлалд байлга.

e. Цус алдалт, амьсгалахад хүндрэл, амьсгалын чимээгүй байдал, крепитаци (арьсны доорх эмфисема)-г хянаж, эдгээр нь цус алдалт эсвэл пневмотораксын шинж тэмдэг юм.

f. Заасан ёсоор амьсгалын эмчилгээг хийх.

g. Шаардлагатай үед шингэнийг соруулаарай; соруулахын өмнө өвчтөнийг их хэмжээний хүчилтөрөгчөөр хангана (Эхлээд хийх сувилахуйн үйлдлүүд хэсгийг үзнэ үү).

h. Хэрэв өвчтөнд хооллох зөвшөөрөл өгсөн бол хооллох үед болон хооллосноос хойш 1 цагийн турш өвчтөнийг суугаа байрлалд байлгаж, хоолойн бөглөөг (хэрэв хоолой битүүмжилээгүй бол) бүрэн дүүргэсэн байхыг хангана.

i. Бөгжний даралтыг зааврааp хянах.

j. Стома болон ялгаралтыг үнэлнэ

цус эсвэл мөгөөрсөн ялгадас.

k. Трахеостомийн нүх болон дотор катетерыг цэвэрлэхдээ PHCP-ийн жор, байгууллагын дүрмийг дагаж мөрдөнө (ихэнх дотор катетер нэг удаагийнх); ихэвчлэн 0.5% хүчилтөрөгчийн уусмал ашиглана.

l. Зааврын дагуу чийгшүүлсэн хүчилтөрөгч өгөх, учир нь трахеотоми хийлгэсэн өвчтөнд хэвийн чийгшүүлэх процесс алдагддаг.

m. Трахеостомийн боолтыг солиход тусламж аваарай; шинэ боолтыг байрлуулсны дараа трахеостомыг тогтоож байсан хуучин боолтыг тайрч авна (зарим тогтоох төхөөрөмж нь зөөлөн, хоолойг тогтоох зориулалттай велкротой байдаг).

n. Орон дор амь сэргээх (Ambu) уут, обтуратор, хавчаар болон ижил хэмжээтэй нөөц трахеостомын хоолойг байлга.

4. Трахеотомийн хүндрэлүүд (69-5-р хүснэгт)

Хавтан (cuff) бүрэн суугаагүй байхад трахеостомийн хоолой руу бөглөө (cap) хэзээ ч битгий хийх

хавчаар нь сулруулж, дотор канюльг авсан тохиолдолд л бөглөө (cap) оруулах ёстой; эс бөгөөс агаарын урсгалыг өвчтөнд хаяж хор учруулна.

Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд

Амьсгалын хоолойн соруулалт

1. Өвчтөнийг үнэлж, процедурыг тайлбарлана.
2. Өвчтөнийг босоо байрлалд шилжүүлэхэд туслах.
3. Гараа ариутгаж, хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл зүүнэ.
4. Шингэн соруулах тоног төхөөрөмжийг бэлдэж, сорох үйлдлийг асаа.
5. Өвчтөнийг их хэмжээний хүчилтөрөгчөөр хангах.
6. Соруулагч холбоогүйгээр катетерыг оруул.
7. Оруулаад катетерыг эргүүлж, гаргах явцад тасралтгүй соруулалт хийнэ.
8. Өвчтөнийг их хэмжээний хүчилтөрөгчөөр хангах.
9. Амьсгалын чимээг сонсож, хүчилтөрөгчийн ханыгдлыг дахин үнэл.
10. Журмыг, үйлчлүүлэгчийн хариу үйлдэл болон үр дүнг бичиж тэмдэглэ.

Дүгнэлт

Льюис нар (2017), 488-р тал.

О. Хөхний хоолойн дренажийн систем

1. Хөхний хоолойн дренажийн систем нь плеврагийн хоосон зайд сөрөг даралт үүсгэдэг.
2. Энэхүү систем нь плеврагийн хөндийд хэт их хуримтлагдсан агаар болон шингэнийг зайлуулахад ашиглагддаг (Зураг 69-12).
3. Шингэн цуглуулах камер (Зураг 69-13)
    a. Шингэн цуглуулах камер нь өвчтөний цээжний хоолой системд холбогдсон газарт байрлана.
    b. Энэхүү камерт хоолойгоор дамжин гарах дренаж нь хэмжигдсэн өндөртэй дараалсан баганууд урсан цуглардаг.
4. Усны битүүмжлэх камер (69-13-р зураг үзнэ үү)
    a. Хоолойн үзүүр нь усны доор байрласнаар плевралын хөндийгөөс шингэн ба агаар гадагшилж, агаар хөндий рүү орохоос сэргийлнэ.
    b. Ус хэлбэлздэг (өвчтөн амьсгаа авахад дээш хөдөлж, амьсгаа гаргахад доош хөдөлдөг).
    c. Хэт их бөмбөлөг үүсэх нь цээжний хоолойн системд агаар алдагдал байгааг илтгэнэ.
5. Шингэн сорох хяналтын камер (зураг 69-13-ыг үзнэ үү)
    a. Сорох хяналтын камер нь сорох хүчийг үүсгэж, үүнийг хянах замаар цээжинд сөрөг даралт үүсгэх боломжтой.
    b. Энэ камер нь шаардлагатай сорох түвшинг хангахын тулд янз бүрийн хэмжээний усаар дүүргэгддэг; хяналтгүй бол уушгины эд эрхтэн цээжний хоолой руу сорогдож болно.
    c. Энэ камерт зөөлөн бөмбөлөг үүсэх нь соролт байгаагийн шинж бөгөөд плевралын хөндийөөс агаар алдагдаж байгааг илтгэхгүй.
6. Хуурай соруулах систем (69-13-р зураг үзнэ үү)
    a. Энэ нь цээжний дренажийн өөр төрлийн систем юм. Учир нь энэ нь хуурай соруулах систем тул соруулах хяналтын камерт хөөс үүсэхгүй.
    b. Цуглуулах төхөөрөмжийн товчлуурыг заасан сорох хүчийг тохируулахад ашиглаж, дараа нь ханы сорох эх үүсвэрийн тохируулагчийг төхөөрөмжийн цонхонд жижиг улбар шар хөвөгч хавхлага харагдах хүртэл эргүүлнэ (улбар шар хөвөгч хавхлага цонхонд харагдах үед, зөв

соруулах хүчийг тогтооно).

7. Зөөврийн цээжний дренажийн систем: Жижиг, зөөврийн цээжний дренажийн системүүд бас байдаг бөгөөд эдгээр нь харилцагчийн уушги руу агаар буцаж орохоос сэргийлэх хяналтын флютер хавхлага ашигладаг хуурай систем юм. Бүх төрлийн системд ашиглагддаг зарчим, даралт, хүч татах үзүүлэлт болон сувилахуйн арчилгаа нь адилхан бөгөөд эдгээр систем нь илүү их хөдөлгөөний эрх чөлөөг олгож, харилцагч цээжний хоолойтойгоо гэртээ харьж болох боломжийг олгодог.

8. Цуглуулах камер: Оролцоо

a. Шингэн гаралтыг хянаж, гаралтыг 70–100 мл/цаг-аас их байвал эсвэл гялалзсан улаан болж, гэнэт нэмэгдвэл анхан шатны тусламжийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн (PHCP)-д мэдэгдээрэй.

b. Цээжний хоолойн гаралтыг цуглуулах камерт 1–4 цагийн зайтай наалт ашиглан тэмдэглэ.

9. Усны битүүмжлэх камер: Арга хэмжээ

a. Усны битүүмжлэх камер дахь шингэний түвшний хэлбэлзлийг хянаарай.

b. Усны битүүмжлэх камер дахь шингэний түвшний хэлбэлзэл хоолой бөглөрсөн, доош унжсан холбоос үүссэн, соруулагч хэвийн ажиллахгүй эсвэл уушги дахин дэлгэрсэн тохиолдолд зогсдог.

c. Хэрэв өвчтөнд тодорхой пневмоторакс илэрсэн бол цээжээс агаар гадагшилж байх үед усны битүүмжлэх камерт завсрын хөөсрөлт гарна, харин тасралтгүй хөөсрөлт нь системд агаар алдагдаж байгааг илтгэнэ.

d. Усны битүүмжлэх камерт тасралтгүй бөмбөлөг үүсвэл PHCP-д мэдэгдээрэй.

10. Шарнирын хяналтын камер: Арга хэмжээ: Нимгэн (хүчтэй биш) бөмбөлөг үүсэх нь чийглэг соруулах системийн шарнирын хяналтын камерт ажиглагдах ёстой.

11. Нэмэлт арга хэмжээ

a. Орц хийсэн газарт хаалттай стериль боолтыг хадгална.

b. Хөхний рентген зураг нь хоолойн байрлалыг үнэлж, уушги дахин дэлгэгдсэн эсэхийг тодорхойлно.

c. Амьсгалын байдлыг үнэлж, уушгины чимээг сонсох. Хөхний хоолойн боолтыг шээс болон шингэн гаралтыг шалгаж, эргэн тойрон дахь эдийг крепити байдлаар илж мэдрэх.

d. Урт хугацааны хүндрэл үүсэх шинж тэмдгүүдийг хянах

пневмоторакс эсвэл гемоторакс.

e. Дренажийн системийг цээжний түвшнээс доогуур байлгаж, хоолойнуудыг муруйралт, унжилт эсвэл бусад бөглөрөлтөөс ангид байлга.

f. Бүх холболтууд найдвартай байгааг баталгаажуул.

g. Хөхцөл гаргах, гүнзгий амьсгалахыг урамшуул.

h. Шингэн зайлуулах болон агааржуулалтыг сайжруулахын тулд өвчтөний байрлалыг байнга сольж өг.

i. Хөхний хоолойг PHCP-ээс тодорхой заавар авсан, байгууллагын бодлого зөвшөөрсөн тохиолдолд л цэвэрлэх буюу шүүсийг нь гаргах.

j. Орны хажууд үргэлж хавхлагыг (системийг солих шаардлагатай бол хэрэгтэй) болон стериль битүүмжилсэн боолтыг байлга.

k. PHCP-ийн бичгээр өгсөн жороор заавал баталгаажуулахгүй бол хөхний хоолойг хааж болохгүй; мөн хөхний хоолойг хаах талаар байгууллагын бодлогыг тодорхойл.

l. Хэрэв дренажийн систем хагарч эсвэл хугарвал цээжний хоолойг стериль усаар дүүргэсэн лонхонд хийгээд хагарсан эсвэл хугарсан системийг авч, шинэ системээр соль.

m. PHCP-ийн сонголтоос хамааран, цээжний хоолойг салгах үед үйлчлүүлэгчээс гүн амьсгаа авч барихыг хүсэж, хоолойг салгаж болно. Эсвэл үйлчлүүлэгчээс гүн амьсгаа авч, гаргаж, доош шахах (Вальсальва арга) хөдөлгөөн хийхийг хүсэж болно. Хөхний хоолойг авсны дараа PHCP-ийн сонголтоос хамааран хуурай стериль боолт, петролеум цаасны боолт эсвэл Telfa боолтыг туузаар тогтооно.

Хэрвээ цээжний хоолойг цээжээс гаргасан бол санамсаргүйгээр уушгины хоолойг цээжээс татаж гаргасан тохиолдолд арьсны нүхийг хоёр талаас нь хавчууран нийлүүлж, агаар нэвтрүүлдэггүй стериль боолт тавьж, боолтыг 2 инч (5 см) өргөнтэй туузан наалтаар давхарлан нааж, яаралтай эрүүл мэндийн тусламжийн мэргэжилтэн (PHCP)-ийг дуудах.

V. Арьс болон салстын төвөгтэй асуудлууд

A. Гал түймрийн шарх (Эрэн тусламжийн тэргүүлэх үйлдлүүд хэсгийг үзнэ үү)

Эмнэлгийн үйлчилгээний тэргүүлэх арга хэмжээ

Шатаах гэмтэл: Яаралтай тусламжийн тасагт үзүүлэх анхан шатны тусламж

1. Амьсгалын замыг нээлттэй эсэхийг үнэл.
2. Зааврын дагуу хүчилтөрөгч өг.
3. Амьсгал, зүрх судасны чухал үзүүлэлтүүдийг ав.
4. Судас дотор (IV) шугам тавьж, зааврын дагуу шингэн нөхөлт эхлүүлэх.
5. Хэрэв илэрхий ясны хугаралгүй бол зүүн, баруун гар, хөлний хэсгийг өргөн барих.
6. Өвчтөнийг дулаахан байлгаж, амнаас юу ч өгөхгүй (NPO) статустай болгоно.

Дүгнэлт

Ignatavicius, Workman, Rebar (2018), 489-р тал.

1. Тайлбар: Халуун, үрэлт, цахилгаан, цацраг эсвэл химийн бодисын улмаас арьсны давхаргуудын эсүүд устдаг.
2. Жижиг түлэгдэлт: Биеийн гэмтэлд үзүүлэх хариу үйлдэл гэмтсэн хэсэгт төвлөрдөг.
3. Том эсвэл өргөн цар хүрээтэй түлэгдэлтүүд:
    a. Том буюу өргөн цар хүрээтэй түлэгдэлт нь насанд хүрэгчийн биеийн гадаргуугийн талбайн 25% буюу түүнээс дээш, хүүхдийн биеийн гадаргуугийн талбайн 10% буюу түүнээс дээш хувийг эзэлдэг.
    b. Горхиол гэмтэлд биеийн хариу үйлдэл нь системтэй байдаг.
    c. Шархлалт нь биеийн бүх гол системийг хамардаг.
    d. Цахилгаан түлэгдэлт ихэвчлэн гадаргуугийн гэмтэл багатай боловч дотоод гэмтэл өргөн цар хүрээтэй байж болно.
4. Гортлын цар хүрээг тооцоолох (Зураг 69-14)

B. Шатаах гүн

1. **Гадаргуугийн зузаан түлэгдэлт**
    a. Эпидермисийн гэмтэл ордог; дермисийн цусны хангамж хэвээрээ байдаг.
    b. Хөнгөнөөс хүртэл хүнд зэргийн эритема (ягаан–улаан) илэрнэ, боловч хөөс үүсдэггүй.
    c. Арьс даралт өгөхөд цайрч, дараа нь эргэн өнгө орно.
    d. Шарх өвдөлттэй, зөөлөн чичрэх мэдрэмжтэй бөгөөд хөргөхөд өвдөлт намддаг.
    e. Таагүй мэдрэмж ойролцоогоор 48 цаг үргэлжилнэ; эдгэрэлт ойролцоогоор 3–6 хоногт явагддаг.
    f. Сорилт үлддэггүй бөгөөд арьсны шилжүүлэг хийх шаардлагагүй.

2. **Гадаргуугийн хэсэгчилсэн зузаан түлэгдэлт** (Зураг 69-15)

a. Дермагийн илүү гүн хэсэгт гэмтэл үүсдэг; цусны хангамж буурдаг.

b. Том хөөс өргөн талбайг хамарч болно.

c. Хавагдалт илэрнэ.

d. Суурь нь ягаан-улаан толботой, эпидермис нь хугарч, гадаргуу нь чийглэг, гялалзсан, шингэн гоождог нь онцлог.

e. Шарх өвдөлттэй бөгөөд хүйтэн агаарт мэдрэг.

f. 10–21 хоногийн дотор сорви үлдээгүйгээр эдгэрдэг, гэхдээ бага зэргийн пигментийн өөрчлөлт гарч болно.

g. Эдгэрэлт удааширвал арьсны шилжүүлэг хийж болно.

3. **Гүн хэсэгчлэн зузаан түлэгдэлт** (Зураг 69-16)

a. Арьсны дермисийн гүн рүү илүү гүн нэвтэрнэ

b. Булчирхай үүсэх нь ихэвчлэн тохиолддоггүй, учир нь үхсэн эд эсийн давхарга зузаан бөгөөд амьд үлдсэн дермагийн давхаргад наалддаг.

c. Шуухийн гадаргуу улаан, хуурай бөгөөд гүн хэсэгт нь цагаан хэсгүүд байна.

d. Цайвар өнгөтэй эсэх нь тодорхойгүй, хаван дунд зэрэг байна.

e. Хэрэв халдвар, гипокси эсвэл ишемийн улмаас эд эсийн гэмтэл нэмэгдвэл бүрэн зузаан түвшний түлэгдэл болж хувирч болно.

f. Ерөнхийдөө 3–6 долоо хоногт эдгэрдэг боловч сорвижилт үүсч, арьсны шилжүүлэн суулгалт шаардлагатай байж болно.

4. **Бүтэн зузаан түлэгдэлт** (Зураг 69-17)

a. Эпидермис болон дермисийн гэмтэл, устгалтай; шарх дахин эпителиар бүрхэгдэх замаар эдгэрэхгүй бөгөөд арьс шилжүүлэн суулгах шаардлага гарч болно.

b. Хуурай, хатуу, арьс шиг хатуу хавсарсан шарх (шатаах шархны хатуу хальс буюу үхсэн эд нь эдгэрэхийн өмнө салж унах эсвэл шархнаас арилгах шаардлагатай).

c. Лавлагч цагаан, гүн улаан, шар, бор эсвэл хар өнгөтэй харагддаг.

d. Гэмтсэн гадаргуу хуурай харагддаг.

e. Эсчарын доор хаван үүссэн байна.

f. Нервийн төгсгөлүүд устсанаас болж мэдрэхүй буурсан эсвэл алга болсон байдаг.

g. Эдгэрэлт нь хэдэн долоо хоногоос хэдэн сар хүртэл үргэлжилж, хангалттай цусны хангамжийг тогтоохоос хамаарна.

h. Шаталт нь эшарыг арилгах, арьсны нимгэн эсвэл бүхэл зузаантай шилжүүлэн суулгах мэс засал шаарддаг.

i. Сорилт үүсэх, шархны агшилт үүсэх магадлалтай.

5. **Гүн, бүх зузаан шаталсан түлэгдэлт** (Зураг 69-18)

a. Гэмтэл нь арьсаар хязгаарлагдахгүйгээр доорх фасци, эдүүдэд хүртэл тархан, булчин, яс, шөрмөс гэмтдэг.

b. Гэмтсэн хэсэг хар өнгөтэй харагдаж, мэдрэхүй бүрэн алга болсон байна.

c. Эшар хатуу, уян хатан бус.

d. Өвдөлт мэдрэгдэхгүй нь мэдрэлийн төгсгөлүүд устсантай холбоотой.

e. Эдгэрэлт хэдэн сар үргэлжилж, арьсны шилжүүлэг хийх шаардлагатай.

C. Шархны байрлал

1. Толгой, хүзүү, цээжний түлэгдэлт нь уушгины хүндрэлүүдтэй холбоотой.
2. Нүүрний түлэгдэлт нь нүдний буйлны зураас үүсэхтэй холбоотой.
3. Чихний түлэгдэлт нь чихний хальсны хондриттай холбоотой.
4. Гараа болон үе мөчнүүдэд хөгжлийн бэрхшээлээс сэргийлэхийн тулд эрчимжүүлсэн эмчилгээ шаардлагатай.
5. Перинеалын хэсэг нь шээс, ялгадасаар автобохирдоход өртөмтгий.
6. Гар, хөлний эргэн тойрон дахь түлэгдэлт нь туронкет маягийн нөлөө үзүүлж, судасны даралтын бууралт (компартмент синдром) үүсгэдэг.
7. Хөхний эргэн тойрон дахь түлэгдэлт нь цээжний хана хангалттай тэлэхгүй болон уушгины дутагдалд хүргэдэг.

D. Нас ба ерөнхий эрүүл мэнд

1. 4 хүртэлх насны хүүхдүүдэд, ялангуяа төрөлтийн дараах 1 нас хүртэлх хүүхдүүдэд болон 65-аас дээш насныханд нас баралтын түвшин өндөр байдаг.
2. Зүрх, амьсгал, булчирхай, бөөрний хүндрэлтэй эмгэгүүд нь гэмтэл болон эмчилгээнд өгөх хариу үйлдлийг сөргөөр нөлөөлдөг.
3. Гал түймрийн шарх авах үед үйлчлүүлэгчид урьдчилан тогтсон эмгэгтэй бол нас баралтын түвшин өндөр байдаг.

E. Амьсгал замын гэмтэл

1. **Утаагаар амьсгал авах үед үүсэх гэмтэл**

a. Гал түймрийн үед шатаж буй бүтээгдэхүүнийг амьсгалах үед үүсэх амьсгалын замын гэмтэл.

Амьсгалын зам нь ...-д тэргүүлэх анхаарал юм.

амьсгал дамжуулах замын гэмтэл.

b. Үнэлгээ (69-9-р хайрцаг)

2. **Нүүрстөрөгчийн моноксидийн хордлого**

a. Нүүрстөрөгчийн монооксид нь өнгөгүй, үнэргүй, амтгүй хий бөгөөд хүчилтөрөгчөөс 200 дахин их хемоглобинд холбогдох чадвартай.

b. Оксигений молекулууд шахагдаж, нүүрстөрөгчийн монооксид эргэцүүлэн холбогдон карбоксигемоглобин үүсгэнэ.

c. Эд эсийн гипокси үүснэ.

d. Үнэлгээ (69-6-р хүснэгт)

3. Шууд дулааны гэмтэл

a. Дулааны халуун гэмтэл нь уур, дэлбэрэх хий амьсгалах эсвэл халуун шингэн амьсгалын замд орсноос доод амьсгалын замд үүсч болно.

b. Дээд амьсгалын зам гэмтэж, улайж, хавагнасан, салстын хөөсрөлт ба шархла үүсдэг.

c. Шилэнгийн хавагналт нь ялангуяа эхний 24–48 цагийн дотор дээд амьсгалын замыг бөглөрүүлэх аюултай.

d. Толгой эсвэл хүзүүнд түлэгдэлт авсан бүх өвчтөнийг амьсгалын замын бөглөрөл үүсэхээс сэргийлэн нягт хяналт тавьж, бөглөрөл илэрсэн тохиолдолд яаралтай трахеа руу интубаци хийх шаардлагатай.

e. Үнэлгээ: дээд амьсгалын зам улайж, хавагнасан, салстын хөөсрөлт ба шархла үүссэн

F. Шархны патофизиологи

1. Шаталтаас хойш гэмтсэн эдээс вазоактив бодисууд ялгарч, эдгээр бодисууд капиллярын нэвчилт нэмэгдүүлж, плазмийг эргэн тойрон дахь эд рүү шингэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

2. Судаснууд дахь шууд гэмтэл нь капиллярын нэвчилт дамжуулалтыг нэмэгдүүлдэг (гэмтлийн дараа 18–26 цагийн хооронд капиллярын нэвчилт буурдаг ч гэмтлийн дараах 2–3 долоо хоногийн дараа хэвийн түвшиндээ буцдаггүй).

3. Өргөн цар хүрээтэй түлэгдэлт нь биеийн ерөнхий

Ерөнхий биеийн хавагдал үүсч, судсанд эргэлдэж буй цусны эзлэхүүн буурдаг.

4. Шингэний алдагдал нь эрхтнүүдийн

цусны хангамж буурна.

5. Зүрхний цохилт түргэсч, зүрхний гарал буурч, цусны даралт буурна.
6. Эхэндээ гипонатриеми ба гиперкалиеми илэрнэ.
7. Плазмын алдагдлын улмаас гематокритийн түвшин нэмэгддэг; гэхдээ гэмтлийн үед улаан эсийн гэмтэл, алдагдлын улмаас энэ анхны өсөлт түлэгдлийн дараах гурав дахь–дөрөв дэх өдрүүдэд хэвийн түвшнээс доогуур буурдаг.
8. Эхэндээ бие нь бөөрнөөс цусыг чиглүүлж, олигури үүсгэдэг; дараа нь бие шингэнийг дахин шимшиж эхэлж, илүүдэл шингэн дараагийн хэдэн хоног, долоо хоногийн турш шээх замаар гадагшилна.
9. Хоол боловсруулах замын цусны урсгал буурснаар гэдэсний илеус болон хоол боловсруулах замын үйл ажиллагааны доголдлолд хүргэдэг.
10. Иммун тогтолцооны үйл ажиллагаа суларснаар дархлаа дарангуйлагдаж, халдвар, сепсисийн эрсдэл нэмэгддэг.
11. Уушгины артерийн даралт ихсэх (пульмональ гипертензи) үүсч, артерийн хүчилтөрөгчийн түвшин буурч, уушгины эластик чанар буурдаг.
12. Шатаах шархны арьснээс ууршиж шингэний алдагдал хэвийн хэмжээнээс их бөгөөд шарх бүрэн хаагдтал үргэлжилдэг.
13. Хэрэв судсанд шингэн нөхөж өгөхгүй бол цусны эргэлтийн шингэний дутагдал үүсч, эцэст нь гиповолемийн шок болон үхэлд хүргэнэ.

G. Шархны эмчилгээ: Амь сэргээх/яаралтай

тусламжийн үе (69-7-р хүснэгт)

1. Эмнэлэгт хүргэхээс өмнөх тусламж
   a. Осол гарсан газарт эхэлж, яаралтай тусламж авсан үед дуусдаг
   b. Гал түймрийн эх үүсвэрээс хохирогчийг нүүлгэн гарга.
   c. ABC-г үнэлнэ: амьсгалын зам, амьсгал, цусны эргэлт.
   d. Амьсгал дамжин орсон гэмтэл зэрэг холбогдох гэмтлийг үнэл.
   e. Биеийн дулааныг хадгалах.
   f. Шархыг ариутгасан эсвэл цэвэр даавуугаар тагла.

g. Шахалт үүсгэж буй гоёл чимэглэл, хувцсыг тайлах.

h. Тусгаарлагдсан судсанд катетер оруулах.

i. Яаралтай тусламжийн тасаг руу тээвэрлэх.

2. Яаралтай тусламжийн тасгийн эмчилгээ нь гэмтлийн газарт үзүүлсэн тусламжийн үргэлжлэл юм.

3. Хүнд түлэгдэлт

a. Шатаалын зэрэг, цар хүрээг үнэлж, амь насанд аюултай нөхцлийг эмчлэх.

b. Амьсгалын замыг нээлттэй байлгаж, зааврын дагуу 100% хүчилтөрөгч өг.

c. Амьсгалын хүндрэл үүсч байгааг хянах ба интубаци хийх шаардлагыг үнэлэх.

d. Орофаринксыг бөмбөлөг, улайлттай эсэхийг үнэл; хоолойн чанарыг үнэлж, хамрын үс шатаж хайлсан эсэхийг шалгаж, уушгины авиа сонсох.

e. Артерийн цусны хий болон карбоксигемоглобины түвшинг хянах.

f. Амьсгал дамжин хордсон тохиолдолд карбоксигемоглобины түвшин 15%-аас доош буух хүртэл зааврын дагуу нягт таарсан дахин амьсгалахгүй нүүрний маск ашиглан 100% хүчилтөрөгч өг.

g. Гар, хөлний түлэгдэлтээс дээш байрлах түлэгдээгүй арьсанд периферийн судсанд зүү оруулах эсвэл зааврын дагуу төв венийн шугам тавих бэлтгэл хийх.

h. Гиповолемийн шинж тэмдгийг үнэлж, шингэний тэнцвэрийг хадгалахын тулд судсаар шингэн тарилга хийхэд бэлтгэх.

i. Амьсгал, зүрх-судасны чухал үзүүлэлтүүдийг нягт хяна.

j. Жороор заасан ёсоор Фолейн катетер суулгаж, шингэний сэргээх эмчилгээг шээсний гаралтыг 30-д барих зорилгоор зохицуулах 50 мл/цаг.

k. NPO (амнаас юу ч өгөхгүй) статустай байлга.

l. Ходоодны шүүрэл гаргаж, аспирациас сэргийлэхийн тулд зааврaар назогастраль хоолой суулгана.

m. Тетанусын эсрэг урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг зааврaар олгоно.

n. IV замаар зааврын дагуу өвдөлтийн эмчилгээг хийх.

o. Шуухийн арчилгаа хийж, бэлтгэх

клиентийг зааврын дагуу эшаротоми эсвэл фасциотоми хийхэд бэлтгэх.

4. Хөнгөн түлэгдэлт

a. Өвдөлт намдаах эмийг зааврааp олгоно.

b. Өвчтөнд заасан дагуу аман өвчин намдаах эм хэрэглэхийг зааж зааварлах.

c. Тетанусын эсрэг урьдчилан сэргийлэлтийг зааврын дагуу хийх.

d. Шалган заасан ёсоор шарх арчилгаа хийх ба энэ нь цэвэрлэх, сул эдээс салгах, хортой бодисыг арилгах, дараа нь антимикробийн тос түрхэж, ариутгасан боолт тавихыг багтааж болно.

e. Өвчтөнд дагалдах арчилгаа, үүнд идэвхтэй хөдөлгөөний дасгал болон шарх арчилгааны эмчилгээ хийх талаар зааварлах.

H. Шархны гэмтлийг удирдах: Асрамжийн үе шат (69-7-р хүснэгтийг үзнэ үү)

1. Шингэн нөхөн сэргээх (69-8-р хүснэгт)

a. Шингэн олгох хэмжээ нь шээсний гаралтыг цагт 30–50 мл байлгахад шаардлагатай судсаар цагт олгох шингэний хэмжээнээс хамаарна.

b. Шингэн нөхөн сэргээлт амжилттай болсон эсэхийг амьсгал, зүрх судасны тогтвортой үзүүлэлт, хангалттай шээсний гарц, гарын судас баригдах, ухаан санаа болон сэтгэлгээ хэвийн байдлаар үнэлдэг.

c. IV шингэн нөхөн сэргээх эмчилгээг түлэгдэлтэй өвчтөний перфузийн хэрэгцээг хангах үүднээс шээсний гарц болон цусны серум дахь электролитийн түвшинг харгалзан тун тааруулан өөрчилж болно.

d. Хэрэв гемоглобин болон гематокритийн түвшин буурсан эсвэл шээсний гарц цагт 50 мл-ээс их болбол судсаар шингэн өгөх хурдыг бууруулж болно.

Шээсний гарц нь хамгийн найдвартай бөгөөд зүрхний гарал ба эд эсийн цусны хангамжийг үнэлэх хамгийн мэдрэг, нэвтрэхгүй хэмжилтийн параметр юм.

2. Оролцоо

a. Трахей эсвэл ларинксийн хаванг хянаж, заасан ёсоор амьсгалын эмчилгээг хийх; шаардлагатай бол хүндрэл үүсэхээс өмнө амьсгалын түлэмжийн үед интубаци хийж, механик амьсгалын аппаратаар амьсгалыг дэмжинэ.

b. Пульс оксиметрийн үзүүлэлтийг хянаж, амьсгал залгиулах гэмтэл сэжиглэгдсэн тохиолдолд артерийн цусны хий болон карбоксигемоглобины түвшинг тодорхойлоход бэлтгэнэ.

c. Нүүр, толгойн түлэгдэлттэй үед орны толгойг 30° эсвэл түүнээс дээш өнцгөөр өргөнө.

d. Шингэн хэт их хуримтлагдалт болон уушгины хаван үүсэх эсэхийг хянах.

e. Электрокардиографийн (ЭКГ) хяналтыг эхлүүлнэ.

f. Хүний температурыг хянаж, халдварыг илрүүлэх.

g. Хамгаалалтын тусгаарлах арга хэмжээг эхлүүл; гараа хатуу угаах; үйлчлүүлэгчийг асарч сувилахдаа стериль хөнжөл, даавуу ашиглах; мөн бээлий, малгай, маск, гутлын бүрхүүл, эмчийн хувцас болон хуванцар хантааз зүүж ажиллах.

h. Соривны ирмэгийн эргэн тойрон дахь биеийн үсийг хайчлана.

i. Эхний 72 цагт 6–9 кг (15–20 фунт) жин нэмэгдэх боломжтой гэж тооцож, өдөр тутмын жинг хяна.

j. Ходоодны гаралтыг болон pH-ийн түвшинг хянах, ходоодны таагүй мэдрэмж, цус алдалтыг илрүүлэх; эдгээр нь стрессийн шарх үүсч байгааг илтгэнэ.

k. Стрессийн шарх үүсэхээс сэргийлэхийн тулд эмчийн зааврааар антацид, H2 рецепторын антагонист болон шархны эсрэг эмүүдийг өг.

l. Илеус илрүүлэх зорилгоор гэдэсний чимээг сонсож, хэвлийн хавагналт болон хоол боловсруулах замын үйл ажиллагааны доголдлыг хянана.

m. Цээжний ялгадас дахь нуугдсан цусыг шалгах.

n. Миоглобин ба гемоглобины түвшинг тодорхойлохын тулд шээсний дээж ав.

o. Шугамд тарьсан шингэн болон цаг тутамд орж, гарах шингэний хэмжээг хянаж, шингэн нөхөх эмчилгээний хангалттай байдлыг тодорхойлно; шээсний гарал 30 мл/цаг-аас бага эсвэл 50 мл/цаг-аас их бол анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид мэдэгдэнэ. Цусны серумын лабораторийн үзүүлэлтүүд, тэр дундаа электролит болон иж бүрэн цусны тоог хянана.

p. Хэрэв илэрхий ясны хугаралгүй бол эцэг сүүлний эргэн тойрон түлэгдлийг зүрхний түвшнээс дээш дэрэн дээр өргөж байгаарай; диуретик (шээс хөөх эм) нь гиповолемийн эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг тул хавдрыг бууруулах зорилгоор ерөнхийдөө хэрэглэдэггүй.

q. Галдсан эргэн тойрон дахь эцсийн хэсгийн пульс, капиллярын нөхөлтийг хянаж, цусны хангамжийг үнэлнэ.

r. Яс хугарсан эсэх болон холбогдох гэмтлийг илрүүлэх зорилгоор цээжний рентген зураг болон бусад рентген шинжилгээ хийхэд бэлтгэх.

s. Өрөөний температурыг дулаан байлга.

t. Өвчтөнийг агааржуулдаг ор эсвэл тусгай матрас дээр хэвтүүлж, орны хүрээ ашиглан хөнжлийг арьсанд нь хүрэхгүй байлга.

3. Өвдөлт намдаах

a. IV замаар эмчийн зааврааp опиоид төрлийн өвдөлт намдаах эмчилгээг хийх.

b. Хоол боловсруулах замын үйл ажиллагааны доголдлын эрсдэлтэй тул эм бэлдмэлийг аман замаар өгөхөөс зайлсхий.

c. Өвчтөнд эмчилгээг зааврааp болон өвдөлттэй процедуруудаас өмнө хийх.

Интрамускулаар эсвэл арьсан доорхыг зайлсхийх эмчилгээний замыг ашиглахгүй байх, учир нь гиповолеми болон их хэмжээний шингэний шилжилттэй үед зөөлөн эдээр шимэгдэлт найдвартай биш.

4. Хоол тэжээл

a. Зохистой хооллолт нь шарх эдгэрэлтийг дэмжиж, халдвараас сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой.

b. Гал түймрийн шарханд суурь бодисын солилцооны хурд хэвийн үедээ 40–100 дахин их байдаг.

c. Гарцны чимээ сонсогдох хүртэл NPO (хоол, шингэн, эмийн бүх төрлийн хэрэглээг хориглох) статустай байлгаж, дараа нь зааврын дагуу тунгалаг шингэн рүү шилжинэ.

d. Хоол тэжээлийн зөвлөгөөг зааж өгөх боломжтой. Хоол тэжээлийг энтераль хоолойн аргаар эсвэл төв судасны шугамаар параэнтераль аргаар өгөх боломжтой.

e. Ууараг, нүүрс ус, өөх тос, витамин ихтэй хоол хүнсээр хангах ба томоохон түлэгдэлттэй үед өдөрт 5000-аас дээш калори шаардлагатай.

f. Каллорийн хэрэглээ болон өдөр тутмын жинг хянах.

I. Шархны гэмтлийг удирдах: Хурц үе (69-р хүснэгтийг үзнэ үү)

1. Хамгаалалтын тусгаарлах аргуудыг үргэлжлүүл.
2. Өвдөлт намдаах эмчилгээг зааврын дагуу хийж, шархыг хаахад бэлтгэх.
3. Өвдөлт намдаах эмчилгээг хийх.
4. Заасан ёсоор хангалттай тэжээллэг хооллолтыг хангах.
5. Клиентийг сэргээн засах бэлтгэлд бэлтгэх.

J. Цусны эргэлтийн хүндрэлтэй нөхцөлд үзүүлэх эмчилгээ

1. Эшаротоми
   a. Гал түймрийн шархны хатуу хальсыг дагуу урт зүсэлт хийж, шахалт, даралтыг багасгаж, цусны эргэлтийг сайжруулна.
   b. Эсхаротоми нь тойрог маягийн түлэгдлээс үүдсэн цусны эргэлтийн алдагдлыг эмчлэх зорилгоор хийгддэг.
   c. Эшаротоми нь өвчтөний ор дээр мэдээгүйжүүлэлтгүйгээр хийгдэж болно, учир нь түлэгдэлтийн шарх нь мэдрэлийн төгсгөлүүдийг устгасан байдаг.
   d. Амьсгалын үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд цээжний хэсэгт эсхаротоми хийх шаардлага гарч болно.
   e. Эшаротомийн дараа гэмтсэн хөл гарны цохилт, өнгө, хөдөлгөөн, мэдрэмжийг үнэлж, цус алдалтыг даралтаар зогсооно.
   f. Эшаротоми хийсний дараа зааврын дагуу зөөлөн торлогт марлигаар зүсэлтийг бөглөнө.
   g. Зааврын дагуу тус хэсэгт гадаргуугийн антимикробийн эмчилгээг хэрэглэ.
2. Фассиотоми
   a. Арьсны доорх өөхний эд болон фасцийн давхаргыг дамнан зүсэлт хийнэ.
   b. Эсхаротоми хийлгэсний дараа хангалттай эд эсийн цусны хангамж сэргээгдээгүй тохиолдолд энэхүү процедурыг хийдэг.
   c. Фассиотомийг операцийн өрөөнд өвчтөнийг

ерөнхий мэдээгүйжүүлэг дор.

d. Үйлдэл дуусаны дараа гэмтсэн хөл/гарын цусны урсгал, өнгө, хөдөлгөөн, мэдрэмжийг үнэлж, шахалтаар цус алдалтыг зогсооно.

e. Заасан дагуу тухайн хэсэгт гадаргуугийн антимикробийн эм бэлдмэл болон боолтыг хэрэглэ.

K. Шуухны арчилгаа

1. Тайлбар: Шархны сорвиг цэвэрлэх, бохирдлыг арилгах, боолт хийх
2. Ус эмчилгээ
   - a. Шархыг тусгай ширээнд шүршүүрт оруулж эсвэл орны хажууд шархны жижиг хэсгүүдийг угааж цэвэрлэдэг.
   - b. Гидротерапи нь түлэгдлийн шархнаас натрийн алдагдлыг нэмэгдүүлэх, дулаан алдагдах, өвдөлт, стрессээс сэргийлэхийн тулд 30 минут эсвэл түүнээс бага хугацаанд явагдана.
   - c. Журмын өмнө үйлчлүүлэгчид урьдчилсан эмчилгээ хийх ёстой.
   - d. Гемодинамик тогтворгүй эсвэл шинэ арьсны шилжүүлэг хийлгэсэн өвчтөнд гидротерапийг хэрэглэдэггүй.
   - e. Жорлонгийн явцад цус алдалтыг багасгах, биеийн температурыг тогтвортой барих тал дээр анхаарал хандуулна.
   - f. Ус эмчилгээний дараа эмчийн зааж өгсөн антимикробийн эмүүдийг түрхэнэ.
3. Эсцэр цэвэрлэх
   - a. Дэбридмент нь шархны гадаргуу дээрх хатаж үхсэн эд (эшар)-ыг арилгах үйл явц бөгөөд энэ нь бактерийн үржилтийг сааруулж, шарх эдгэрэлтийг дэмжих зорилготой.
   - b. Эд эсийн цэвэрлэгээ механик, ферментэд суурилсан эсвэл мэс заслын аргаар хийгдэж болно.
   - c. Гүн хэсэгчилсэн зузаан шаталсан түлэгдэлт эсвэл гүн бүрэн зузаан шаталсан түлэгдэлт: шархыг цэвэрлэж, үхсэн эдээс салгаж, гаднаас антимикробийн эмчилгээг өдөрт нэг эсвэл хоёр удаа түрхэнэ.
4. Шуухийн хаалт
   - a. Шуухийн хаалт нь халдвар авах болон шингэн алдагдлаас сэргийлдэг.
   - b. Хаалт нь эдгэрэлтийг дэмждэг.
   - c. Хаалт нь контрактуруудаас сэргийлнэ.
   - d. Гэмтлийн дараа ихэвчлэн 5–21 дэх хоногт шарх хаагддаг,

шаталтын зэргээс хамаарна.

5. Шуугийн бүрхүүл (69-10-р хайрцаг)

6. Өөрөө шилжүүлэн суулгах

   a. Автографтинг нь өвчтөний өөрийн түлэгдээгүй арьсны нимгэн давхаргыг мэс заслын аргаар авч, үүнийг тайрсан түлэгдлийн шарханд наах арга юм.
   b. Автографтинг нь сорвиг байнгын хугацаагаар бүрхдэг.
   c. Автографтингийг мэс заслын өрөөнд, өвчтөнд мэдээ алдуулалт хийсэн нөхцөлд хийдэг.
   d. Графтын дараах цус алдалтыг анхааралтай хянаарай, учир нь автографтын доорх цус алдалт наалдахад саад болж болно.
   e. Хэрэв зааварлагдсан бол стериль марлиар графтын төвөөс зах руу шингэнийг зөөлөн гулсуулж бага хэмжээний цус эсвэл серум шингээж авч болно.
   f. Их хэмжээний цус хуримтлагдсан тохиолдолд PHCP нь жижиг голтой зүү, шприц ашиглан цусыг соруулан авч болно.
   g. Автографтыг мэс заслын дараа 3–7 хоног хөдөлгөөнгүй байлгадаг нь шархны ортой наалдаж бэхжихэд шаардлагатай хугацаа юм.
   h. Graft-ийн хөдөлгөөн, гулсахаас сэргийлэхийн тулд өвчтөнийг тогтвортой байрлуулж, graft-ийн хэсгийг өндөрт өргөн байлга.

7. Графтын талбайн арчилгаа

   a. Графтын талбайг өргөж, хөдөлгөөнөөс хамгаал.
   b. Газрыг даралтаас чөлөөтэй байлга.
   c. Жнь дарахгүй байх.
   d. Граффт амжилттай наалдсаны дараа, заасан тохиолдолд, экссудатыг арилгахын тулд графтын гадаргуу дээр хөвөн үзүүртэй аппликатор эргүүлэн арчилна; учир нь экссудат нь халдвар үүсгэж, графтын наалдахад саад болдог.
   e. Халуун үнэртэй ялгадас, халуурал, цагаан эсүүдийн тоо нэмэгдэх, хематом үүсэх болон шингэн хуримтлагдахыг хяна.
   f. Өвчтөнд материал ашиглахгүй байхыг зааж өг

Угаалгын зөөлрүүлэгч болон ширүүн угаалгын бодисууд.

g. Өвчтөнд эдгэрч буй арьсаа заасан эмийн бодисоор тосолж арчлахыг зааварлана.

h. Өвчилсөн хэсгийг нарны гэрлээс хамгаалахыг үйлчлүүлэгчид зааж өг.

i. Клиентд заасан дагуу шилбүүр болон дэмжлэг үзүүлэх хувцас хэрэглэхийг зааварлах.

8. Донорын талбайн арчилгаа

a. Арьс арчилгааны арга нь анхан шатны эрүүл мэндийн мэргэжилтний (PHCP) сонголтоос хамаарч өөр өөр байдаг.

b. Мэс заслын үед даралт хадгалах, ялгаралт зогсоох зорилгоор наалдацгүй марлийн боолтыг тавьж болно; боолт тавьснаар ил гарсан мэдрэлийн төгсгөлөөс үүдэх таагүй мэдрэмжийг бууруулна; мэс засалчийн хүсэлтийг үргэлж шалгана.

c. PHCP нь сайтыг вазелинтай марля эсвэл биосинтетик боолтоор эмчлэх жорыг бичиж өгөх боломжтой.

d. Донорын талбайг цэвэр, хуурай, даралтгүй байлга.

e. Өвчтөнийг донор газартаа хумсаа хүргэхээс сэргийл.

f. Донор талбай эдгэрсний дараа зөөлрүүлэх лосьон түрхэж, загатнааг бууруулна.

g. Өгөлтийн талбайг эдгэрсний дараа дахин ашиглаж болно (зөв арчилгаатай бол 7–14 хоногийн дотор өөрөө эдгэрнэ).

L. Сэргээн засах үе шат (69-7-р хүснэгтийг үзнэ үү)

1. Тайлбар: Сэргээн засах эмчилгээ нь түлэгдэлтийн арчилгааны эцсийн шат юм.

2. Зорилтууд

a. Шуухирны эдгэрэлтийг дэмжих.

b. Муруй гажигийг багасгах.

c. Хүч чадал, үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх.

d. Сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх.

M. Физик эмчилгээ

1. Сэргэн засах хурц үеийн эхэн шатанд үйл ажиллагаа болон гоо зүйн үр дүнг дээд зэргээр хангахын тулд тусгайлан боловсруулсан шингэлэгч, байрлал тогтоох, дасгал хөдөлгөөн, алхах болон өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

2. Хавдрыг бууруулах, булчингийн хүч болон үе мөчний үйл ажиллагааг хадгалах зорилгоор заасан дагуу хөдөлгөөн дасгалыг хийх.
3. Доод мөчний хүчийг хадгалахын тулд үйлчлүүлэгчийг зааврын дагуу алхуулах.
4. Шугамыг заасан ёсоор хэрэглэн үеийн зөв байрлалыг хадгалж, булцуу үүсэхээс сэргийлнэ.
    a. Статик шингэлэгч нь үе мөчийг хөдөлгөөнгүй болгож, хөдөлгөөнгүй байлгах үед, унтах үед болон зөв байрлалаа хадгалж чадахгүй өвчтөнд хэрэглэнэ.
    b. Динамик шингэлгүүд нь гэмтсэн үеийг дасгалжуулдаг.
    c. Шинеж зүүх үед арьсны хэсэгт даралт өгөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй, учир нь энэ нь эд болон мэдрэлийн гэмтлийг улам нэмэгдүүлэх аюултай.
5. Сорилт үүсэх явцыг арьс эмзэг, гулсах хүчинд өртөмтгий үед тасралтгүй даралт үзүүлэх уян боолт, туузаар хянадаг.
6. Шархны сорвины эсрэг дэмжлэгийн хувцас нь ихэвчлэн шархны сорвины эд бүрэлдэж бэхжих хүртэл өдөрт 23 цаг өмсөхөөр зааварлагддаг бөгөөд энэ нь 18–24 сар үргэлжилдэг.

VI. Нарийн төвөгтэй гематологийн болон онкологийн асуудлууд

A. Онкологийн яаралтай байдал: сепсис болон тархсан цусны судсанд коагуляци (DIC), зохисгүй антидиуретик дааврын синдром (SIADH), нугасны даралт, гиперкальцеми, дээд ховдны синдром

B. Сепсис ба ДИК
1. Тайлбар: Хорт хавдартай өвчтөнд халдварт өртөх эрсдэл өндөр байдаг, ялангуяа грам-сөрөг бичил биетээр цусны халдвар (сепсис буюу септицеми) болон сепсистэй ихэвчлэн холбоотой, амь насанд аюултай гематологийн хүндрэл болох тархсан судасны доторх коагуляцийн синдром (DIC)-ийн эрсдэл нэмэгддэг.
2. Оролцоо
    a. Сепсис болон DIC-ийн өндөр эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчдийг эрт илрүүлж, хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх.
    b. Иммун тогтолцоо суларсан өвчтөнд хатуу асептын техник баримталж, халдвар болон цус алдалтын шинж тэмдгүүдийг нягт хянах.
    c. Зааврын дагуу антибиотикийг судсаар тарьж өгнө.
    d. Антикоагулянтыг эхний үе шатанд зааврааар олгох

DIC.

e. DIC хүндэрч, гол асуудал цус алдалт болсон үед зааврaар криопреципитаттай бүлэн үүсгэх хүчин зүйлсийг хэрэглэнэ.

Хэрэв ...-ийн шинж тэмдэг илэрвэл PHCP-д даруй мэдэгдэнэ онкологийн яаралтай байдал илэрвэл.

C. SIADH

1. Тайлбар

a. Хавдрууд антидиуретик дааврыг дуурайсан бодис үүсгэж, ялгаруулж эсвэл үүний үйлдлийг өдөөж болно.

b. Хөнгөн шинж тэмдгүүдэд сулралт, булчингийн агшилт, өлсгөлөн буурах, ядаргаа орно; серумын натрийн хэмжээ 115–120 mEq/L (115–120 ммоль/л).

c. Илүү ноцтой шинж тэмдгүүд нь усны хордлоготой холбоотой бөгөөд жин нэмэх, зан ааш өөрчлөгдөх, төөрөгдөл, маш их булчингийн сулралыг агуулдаг.

d. Серумын натрийн хэмжээ 110 mEq/L (110 mmol/L)-д ойртож эхлэхэд таталт, кома үүсч, хэрэв нөхцлийг хурдан эмчлэхгүй бол эцэстээ үхэлд хүргэнэ.

2. Оролцоо

a. Жороор тогтоосон ёсоор шингэн хязгаарлах, натрийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхийг эхлүүлнэ.

b. Жороор антидиуретик дааврын антагонист эмчилгээг хийх.

c. Сийвэнгийн натрийн хэмжээг хянах.

d. Хавдрыг багасгахын тулд хими эмчилгээ эсвэл цацраг эмчилгээгээр үндсэн шалтгааныг эмчлэх.

D. Нугасны шахалт

1. Тайлбар

a. Нугасны шахалт нь хавдар шууд нугас руу нэвтрэх эсвэл хавдрын нэвтрэлтээс болж нурууны тулгуур нугас нурах үед үүсч, нугасыг шахаж эхэлдэг.

b. Нугасны шахалт нь ихэвчлэн мэдрэлийн дутагдал илрэхээс өмнө нурууны өвдөлт үүсгэдэг.

c. Нейрологийн дутагдал нь шахалтын нурууны түвшинтэй холбоотой бөгөөд мэдрэхүйн бууралт; зөөлөн хатгалга; шээс гаргах, үтрээ болон шулуун гэдэсний мэдрэхүй алдагдах; булчингийн сулрал зэрэг шинж тэмдгүүдийг агуулна.

2. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. Эрт илрүүлэлт: Нурууны өвдөлт болон мэдрэлийн гажигийг үнэлнэ.

b. Нугасны эргэн тойрон дахь хавдрыг бууруулж, шинж тэмдгийг намжаахын тулд өндөр тунтай кортикостероидуудыг хэрэглэнэ.

c. Хавдрын хэмжээг багасгах, шахалтыг намжаах зорилгоор үйлчлүүлэгчийг яаралтай цацраг туяа эмчилгээ болон/эсвэл хими эмчилгээнд бэлтгэх.

d. Хавдрыг авах, нугасны мэдрэлийн даралтыг бууруулахын тулд мэс засал хийх шаардлагатай байж болно.

e. Хэрэв зааварлагдсан бол хүзүү эсвэл нурууны бэхлэгч хэрэглэхийг зааж өг.

E. Гиперкальцеми

1. Тайлбар

a. Гиперкальцеми нь өргөн цар хүрээтэй хавдрын хожуу илрэх шинж тэмдэг бөгөөд ихэвчлэн ясны метастазын үед яс кальцийг цусны эргэлтэд ялгаруулснаар үүсдэг.

b. Физик хөдөлгөөн буурах нь гиперкальцеми үүсгэх эсвэл түүнийг улам хүндрүүлэхэд нөлөөлдөг.

c. Эрт илрэх шинж тэмдгүүдэд ядаргаа, хоолны дуршил буурах, дотор муухайрах, бөөлжих, өтгөн хаталт, их шээх зэрэг орно.

d. Илүү ноцтой шинж тэмдгүүдэд хүнд булчингийн сулрал, гүн шөрмөсийн рефлексийн бууралт, паралитик илеус, шингэн дутагдал, электрокардиограммын өөрчлөлт орно.

2. Оролцоо

a. Сийвэнгийн кальцийн хэмжээг болон ЭКГ-ийн өөрчлөлтийг хянах.

b. Зааврын дагуу аман болон эмийн замын шингэн өгөх.

c. Кальцийн хэмжээг бууруулах, дотор муухайрах, бөөлжихыг хянах эмийг зааврaар олго.

d. Хэрэв нөхцөл байдал амь насанд аюултай болж эсвэл бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан бол үйлчлүүлэгчийг диализэд бэлтгэх.

e. Ясны эрдэс бодисын алдагдлыг бууруулахын тулд алхахыг уриалах.

F. Дээд хоолойн синдром

1. Тайлбар

a. Дээд хоолойн (superior vena cava, SVC) хам шинж нь SVC хорт хавдрын өсөлтөөс шахагдах эсвэл бөглөрөх үед үүсдэг (ихэвчлэн уушгины хорт хавдар болон лимфоматай холбоотой).

b. Тэмдэг, шинж тэмдгүүд нь толгой, хүзүү, дээд биеийн венийн цусны урсгал хаагдсанаас үүдэлтэй.

c. Эрт илрэх шинж тэмдгүүд ихэвчлэн өглөө илэрч, нүүр, ялангуяа нүдний эргэн тойрон хавагнаж, цамц эсвэл блузны зах шахагдах (Стоуксийн шинж) зэрэг орно.

d. Өвчний байдал хүндрэх тусам гар, гарын хаван, амьсгал давчдах, биеийн дээд хэсгийн улайлт, цээж, хүзүүний судсууд томорч, хамрын цус алдалт илэрнэ.

e. Амь насанд аюултай шинж тэмдгүүдэд амьсгалын замын бөглөрөл, цус алдалт, цианоз, сэтгэл зүйн байдлын өөрчлөлт, зүрхний гарал багассан, даралт буурах зэрэг орно.

2. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. Дээд ховдлын синдромын эхний шинж тэмдгүүдийг үнэл.

b. Өвчтөнийг хагас Фоулер байрлалд байрлуулж, зааврааp кортикостероид болон диуретик (шээс хөөх эм) өгнө.

c. Өвчтөнийг медиастиналь бүсэд өндөр тунгийн цацраг туяаны эмчилгээ болон их биеийн вена кава-д металл стент суулгах боломжит мэс засалд бэлтгэх.

G. Хавдрын лизисийн хам шинж

1. Тайлбар

a. Хавдрын эсийн их хэмжээний устгал хурдан явагдаж, эс доторх кали, шээсний хүчил зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд биеийн зайлуулах чадлаас хурдан цусанд ялгарах үед хавдрын эсийн ууралтын хам шинж үүсдэг.

b. Хавдрын эсийн задран ууслын хам шинж нь дараахыг илтгэж болно:

Хавдрын эмчилгээ нь хавдрын эсүүдийг устгадаг; гэхдээ эмчилгээг зогсоовол эд эсийн ноцтой гэмтэл, үхэлд хүргэж болно.

c. Гиперкалиеми, гиперфосфатемийн улмаас үүсэх гипокальцеми, гиперурикеми тохиолддог; гиперурикеми нь элэгний хурц гэмтэлд хүргэж болно.

2. Оролцоо

a. Амны хэсгээр шингэн хэрэглээг дэмжинэ; шаардлагатай бол судсаар шингэн эмчилгээ зааж өгч болно; бөөрний үйл ажиллагаа болон орсон, гарсан шингэний хэмжээг хянаж, өвчтөнд кали, фосфор багатай бөөрний тусгай хоолны дэглэм баримталж байгааг баталгаажуулна.

b. Эмчийн зааврааp шээсний урсгалыг нэмэгдүүлэхийн тулд диуретик (шээс хөөх эм) хэрэглэнэ.

c. Жороор аллопуринол зэрэг пурин ялгаралтыг нэмэгдүүлэх эмүүдийг олгоно.

d. Гиперкалиемийн эмчилгээнд цус судсаар глюкоз, инсулины холимог тарилга хийхэд бэлтгэх.

e. Эмчилгээний дараа ч гиперкалиеми ба гиперурикеми үргэлжилбэл үйлчлүүлэгчийг диализэд бэлтгэх.

VII. Нарийн төвөгтэй эндокрин асуудлууд

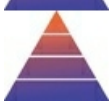
A. **Чихрийн шижингийн кетоацидоз (DKA)**

1. Тайлбар (Зураг 69-19)

a. Чихрийн шижингийн кетоацидоз нь 1-р төрлийн чихрийн шижинтэй хүнд инсулины хүнд дутагдал үүсэхэд үүсдэг амь насанд аюултай хүндрэл юм.

b. Гол клиник илрэлүүдэд цусны сахар ихсэх, шингэн дутагдал, кетоз, хүчилшилт орно.

2. Үнэлгээ (69-9-р хүснэгт)



3. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. Эргэлтэд буй цусны эзлэхүүнийг нөхөж, тархи, зүрхний булчирхай болон бөөрний цусны хангамжийн дутагдлаас хамгаалах.

b. Ус-электролитийн тэнцвэргүй байдлыг эмчлэхдээ зааврын дагуу 0.9% эсвэл 0.45% натрийн хлоридын уусмалыг хурдан судсаар дусааж; цусны глюкозын хэмжээ 250–300 мг/дЛ (14–

17 ммоль/л). Судаснаас шингэн хэт хурдан тарих; буруу төрлийн судасны шингэн, ялангуяа гипотоник шингэн хэрэглэх; мөн цусны сахарын хэмжээг хэт хурдан нөхөхийн улмаас тархины хавагнал үүсч болно.

c. Гипергликемийг зааврын дагуу судсаар тарьсан инсулинээр эмчилна.

d. Электролитийн тэнцвэргүй байдлыг засах (ус дуталт болон хүчилшилтийн улмаас калийн хэмжээ өндөр байж болно).

e. Калийн хэмжээг анхааралтай хянаарай, учир нь өвчтөнд шингэн дутагдал, хүчилшилд эмчилгээ хийх үед сийвэнгийн калийн хэмжээ буурч, кали нөхөх шаардлага гарч болно.

f. ДКА-тай өвчтөнд цусны серум дахь калигийн түвшний хэвийн бус байдлаас үүдэх эрсдлээс сэргийлэхийн тулд зүрхний хяналт тасралтгүй явагдах ёстой.

4. Инсулиныг судсаар тарьж хэрэглэх

a. Зөвхөн богино хугацааны инсулин хэрэглэнэ.

b. Тасралтгүй дусалжуулалт эхлэхээс өмнө богино хугацааны U-100 жишиг инсулины IV болюс тунг (ихэвчлэн 5–10 нэгж) зааж өгч болно.

c. Тасралтгүй дусалжуулалтад зориулсан инсулины IV тунг зааврааp 0.9% эсвэл 0.45% натрийн хлоридын уусмалд бэлтгэнэ.

d. Инсулины тамирыг үргэлж IV тамир хяналтын төхөөрөмж дээр тохируулан тавина.

e. Инсулиныг арьсан доорх тарилга дахин эхлэх хүртэл тасралтгүй дусааж, цусны глюкозын түвшин дахин өсөхөөс сэргийлнэ.

f. Амьсгал, зүрх судасны чухал үзүүлэлтүүдийг хянах.

g. Шээсний гарцыг хянаж, шингэн хэт их хуримтлагдах шинж тэмдгүүдийг ажигла.

h. Калийн болон глюкозын түвшинг, мөн тархины даралт нэмэгдэх шинж тэмдгүүдийг хянана.

i. Эмчилгээ эхэлснээс хойш эхний нэг цагийн дотор ус дутагдал болон хүчилшил эмчлэгдэхийн хэрээр калийн хэмжээ хурдан буурна.

j. Калийг эмчийн зааврaар шингэрүүлсэн уусмалд судсаар өгдөг; кали өгөхөөс өмнө бөөрний хэвийн үйл ажиллагаатай байгаа эсэхийг баталгаажуулна.

5. Клиентийн сургалт (69-11-р хайрцаг)

ДКА-гаар эмчлэгдэж буй үйлчлүүлэгчийг шинж тэмдгүүдийн хувьд нарийн ажиглах тархины дотоод даралт нэмэгдэх. Хэрэв цусны глюкозын хэмжээ тархи тэнцвэрт орох хугацаагаа өгөхгүйгээр хэт их эсвэл хэт хурдан буурвал цуснаас тархи-нугасны шингэнд болон тархинд ус татагдаж, тархины хавагнал үүсч, тархины дотоод даралт нэмэгддэг.

B. **Гиперосмоларын гипергликемийн синдром (HHS)**

1. Тайлбар

a. Кетоз болон ацидозгүйгээр маш их гипергликеми тохиолддог.

b. Энэхүү хам шинж ихэвчлэн 2-р төрлийн чихрийн шижинтэй хүмүүст илэрдэг.

c. Гол ялгаа нь

ба DKA-ийн гол ялгаа нь HHS-д кетоз ба оз үүсдэггүй явдал юм; HHS-д эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын тулд өөхний задралыг зогсоох хангалттай инсулин байдаг тул кетоз үүсдэггүй.

2. Үнэлгээ (69-9-р хүснэгтийг үзнэ үү)

3. Арга хэмжээ

a. Эмчилгээ нь DKA-гийн эмчилгээтэй адил.

b. Эмчилгээ нь шингэн нөхөх, электролитийн тэнцвэргүй байдлыг засах, инсулин хэрэглэхээс бүрдэнэ.

c. Зүрхний дутагдал үүсэх эрсдэлтэй тул ахмад настай өвчтөнд шингэн нөхөх эмчилгээг маш болгоомжтой хийх шаардлагатай.

d. HHS-ийн эмчилгээнд инсулины үүрэг DKA-ийн эмчилгээндэй харьцуулахад харьцангуй бага ач холбогдолтой, учир нь кетоз ба ацидоз үүсдэггүй; зөвхөн шингэн нөхөх нь цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулж болно.

VIII. Нарийн төвөгтэй хоол боловсруулах замын асуудлууд

A. Хоол боловсруулах хоолойн варикос судсууд

1. Тайлбар

a. Хоолойн доод салстын доорх өргөсөж, мушгирсан судсууд.

b. Порталын гипертензийн улмаас үүсдэг, ихэвчлэн элэгний **циррозтой** хамт тохиолддог; порталын эргэлтийн даралт нэмэгдэхэд хагарах өндөр эрсдэлтэй

c. Цус алдаж буй варикос судсууд нь яаралтай тусламж шаарддаг.

d. Эмчилгээний зорилго нь цус алдалтыг хянах, хүндрэлээс сэргийлэх, цус алдалтыг дахин гаргахаас сэргийлэх явдал юм.

2. Үнэлгээ

a. Гемотемезис

b. **Мелена**

c. Асцит

d. Шарлалт

e. Элэг томорсон ба цөс томорсон

f. Хэвлийн судаснууд өргөссөн

g. Шокын шинж тэмдгүүд

Хагаралт ба үүсэх цус алдалт

Хоол боловсруулах хоолойн варикос өргөсөл нь амь насанд аюултай нөхцөл тул хамгийн гол анхаарах асуудал юм.

3. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн температур зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүдийг хянана.

b. Орны толгойг өргө.

c. Ортостатик гипотензийг хянах.

d. Уушгины авиа болон амьсгалын хүндрэл байгаа эсэхийг хянах.

e. Эсэд гипокси үүсэхээс сэргийлэхийн тулд заасан ёсоор хүчилтөрөгч өг.

f. Ухамсарын түвшинг хянах.

g. Хоол хүнс оруулахгүй (NPO) байдлыг хадгалах.

h. Шингэн болон электролитийн тэнцвэргүй байдлыг нөхөхийн тулд эмчийн зааврааp судсаар шингэн сэлбэх; орсон болон гадагшилсан шингэний хэмжээг хянах.

i. Гемоглобин, гематокрит болон цус бүлэгнэлтийн хүчин зүйлсийн үзүүлэлтийг хянах.

j. Зааврын дагуу цус болон цусны бүлэгнэлтийн хүчин зүйлс шилжүүлнэ.

k. Зааврын дагуу хоолойн хоолой (NG-хоолой) оруулах эсвэл бөмбөлөгтэй тампонад хийхэд туслах; бөмбөлөгтэй тампонад нь үйлчлүүлэгчид маш таагүй, хүндрэл үүсгэх эрсдэлтэй тул ховор хэрэглэгддэг.

l. Тайлбарлагдсан эмчилгээг хийхэд туслахаар бэлтгэх

судас агшиж цус алдалтыг бууруулах эм бэлдмэл.

m. Өвчтөнд вазовагаль хариу үүсгэх үйл ажиллагаанаас зайлсхийхийг зааварлах.

n. Өвчтөнийг зааврын дагуу эндоскопын эсвэл мэс заслын процедуруудад бэлтгэх.

4. Эндоскопын тарилга (склеротерапи)

a. Энэхүү процедур нь цус алдаж буй варикоз судсуудын дотор болон эргэн тойронд нь склерозон бодис тарьж хийдэг.

b. Хүндрэлүүдэд цээжний өвдөлт, уушгины бүрхүүлийн шингэн хуримтлагдалт, амьсгалын замд шингэн шилжихээс үүдсэн уушгины хатгалгаа, хоолойн нарийсал болон хоолойн нүхжилт орно.

5. Эндоскопын венийн зангилаа боох мэс засал

a. Энэхүү процедур нь варикос судсыг уян резинэн туузаар боохыг агуулдаг.

b. 3–7 хоногийн дотор холболтын бүсэд эд салж, дараа нь гадаргуугийн шарх үүсдэг.

6. Шантингийн процедурууд

a. Тайлбар: Эдгээр процедурууд хоол боловсруулах замын дээд хэсгийн ходоод-хоолойн варикос судсуудаас цусыг тойруулан гадагш урсгах зорилготой

b. Порта-кавал шунталт нь порталь венийг доод ховдны венийн хоолойд холбох мэс засал бөгөөд энэ нь порталь системийн цусыг ерөнхий цусны эргэлтэд чиглүүлдэг (Зураг 69-20).

c. Дисталь спленореналь шунт: Энэ шунт нь цулцаны венийг зүүн бөөрний венийн хооронд холбох; цулцаны булчирхай өндөр даралттай варикос судсаас цусыг бага даралттай бөөрний вени рүү дамжуулдаг (зураг 69-20-ыг үзнэ үү).

d. Мезокавал шунталт нь дээд мезентерийн венийг доод вена кавагийн ойролцоох эхлэл хэсэгтэй хажуугийн анастомозоор холбохыг хэлнэ.

e. Трансжугуляр интрахепатик портал-системийн шунт (TIPS): Энэхүү процедур нь элэгний хэвийн судасны анатомийг металл стент ашиглан шунт үүсгэхэд ашигладаг; шунт нь элэг дотор портал болон системийн венийн системийн хооронд байрлаж, порталь гипертензийг бууруулах зорилготой.

B. Хоол боловсруулах замын (GI) цус алдалт

1. Тайлбар: Хоол боловсруулах замын ямар нэг хэсэгт гардаг цус алдалт; дээд хоол боловсруулах замын цус алдалт болон доод хоол боловсруулах замын цус алдалт гэж ангилагддаг.

2. Дээд хоол боловсруулах замын цус алдалтын шалтгаанууд нь пептик шархлаа, стресс-тай холбоотой эрозив синдром, хоолой эсвэл ходоодны варикос судс, хоол боловсруулах замын хана тасарч цус алдалт, хоолойн үрэвсэл, хавдар, аортоэнтерик фистула болон ангиодисплази юм.

3. Доод хоол боловсруулах замын цус алдалтын шалтгаанууд нь дивертикулез, ангиодисплази, хавдар, үрэвсэлт гэдэсний өвчин, гэмтэл, халдварт колит, цацрагийн колит, ишеми, аортоэнтерофистула болон геморoид юм.

4. Хоол боловсруулах замын цус алдалт буюу цус гоожих нь амь насанд аюултай яаралтай нөхцөл байдал юм.

5. Үнэлгээ

a. Гемотезис

b. Гематокези

c. Мелена

d. Гемоглобин ба гематокритийн түвшин буурна (хурц цус алдалтын үед өөрчлөлт гарахын тулд 24–72 цаг шаардлагатай байж болно)

6. Ишгэн тавилт

a. Эмчлүүлэгчийн гемодинамик тогтворжисны дараа эндескопи хийх

b. Марктай улаан эсийн скан хийх, ангиографи эсвэл хоёрыг нь зэрэг хэрэглэн цус алдалтын эх үүсвэрийг тодорхойлж болно.

7. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. Зорилго нь цус алдалтыг зогсоох, цус алдалтын шалтгааныг тогтоох явдал юм.

b. Гемодинамикийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд шингэн нөхөн сэргээх эмчилгээ шаардлагатай.

c. Шаардлагатай бол гиперкоагуляцийн эмчилгээ

d. Цус алдалтыг хянах эсвэл зогсоох эмчилгээний арга хэмжээ

e. Ходоодны хүчилийг дарах эсвэл идэвхгүйжүүлэх эмүүд, түүний дотор гистамин-2 рецепторын антагонистууд болон протон шахуурга дарангуйлагчид

f. Эдгээр эмүүд нь өвчтөнд бактерийн колонизаци болон түүнтэй холбоотой халдварын эрсдэл үүсгэж болзошгүйг анхаарна уу.

g. Шингэн нөхөн сэргээх эмчилгээ хийгдсэн ч гемодинамик тогтвортой байдал хадгалагдсаар байгаа өвчтөнд мэс засал хэрэглэж болно.

IX. Нарийн төвөгтэй амьсгалын замын асуудлууд

A. Амьсгалын эмчилгээ

1. Хөхний физиотерапи (CPT)

a. Тайлбар: Хөнгөн цохилт, чичиргээ болон байрлалын дренажийн аргуудыг цээжний хөндийд хийж, уушгины өвчилсөн хэсэгт хуримтлагдсан ялгадсыг сулруулж, төв агаар дамжуулах замууд руу шилжүүлдэг.

b. Харшил ба оролцоо (69-12-р хайрцаг)

B. Хүчилтөрөгч

1. Нэмэлт хүчилтөрөгч нийлүүлэх системүүд (Хүснэгт 69-10)

a. Бага урсгалтай хамрын канюла: Архаг агаарын урсгал хязгаарлалттай болон удаан хугацааны хүчилтөрөгч хэрэглэх шаардлагатай өвчтөнд ашиглана (Зураг 69-21)

b. Хамрын өндөр урсгалтай (NHF) амьсгалын эмчилгээ: Хөнгөн болон дунд зэргийн амьсгалын хүндрэлтэй, гипоксемитэй өвчтөнд ашиглана (69-13-р хайрцаг)

c. Энгийн нүүрний маск: Богино хугацааны хүчилтөрөгчийн эмчилгээнд эсвэл яаралтай үед хүчилтөрөгч өгөхөд ашиглагддаг (Зураг 69-22)

d. Вентури маск: Гэнэтийн амьсгалын дутагдалд өртөх эрсдэлтэй эсвэл амьсгалын дутагдалтай өвчтөнд ашиглана (Зураг 69-23)

e. Хэсэгчилсэн дахин амьсгалын маск: Оксигений концентрацийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай үед ашиглагддаг; хроникийн обструктив уушгины өвчтэй (ХОУӨ) өвчтөнд ерөнхийдөө зааварладаггүй

f. Дахин амьсгалахгүй маск: Амьсгалын байдал дордож, интубаци шаардлагатай болж болзошгүй өвчтөнд хамгийн их хэрэглэгддэг (Зураг 69-24)

g. Трахеотомийн хүзүүний боолт ба Т-бар эсвэл Т-хэсэг: Трахеотомийн хүзүүний боолтыг трахеотоми хийлгэсэн өвчтөнд өндөр чийгшил болон шаардлагатай хүчилтөрөгчийг нийлүүлэхэд ашигладаг; Т-бар эсвэл Т-хэсгийг шаардлагатай FiO_2-ийг нийлүүлэхэд ашигладаг трахеотоми, ларингектоми эсвэл эндотрахеал хоолойтой өвчтөнд (зураг 69-25).

h. Нүүрний майхан: Нүүрний гэмтэлтэй өвчтөнд зориулан чанга таарсан маскийг орлох зориулалттай

нүүрний гэмтэл эсвэл түлэгдэлтэй өвчтөнд ашиглана.

2. Тасралтгүй эерэг агаар дамжуулах даралт (CPAP) ба хоёр түвшний эерэг агаар дамжуулах даралт (BiPAP) (BiPAP-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг IX бүлэг, C, 7 [Нэвтрэхгүй эерэг даралттай амьсгалын дэмжлэг буюу BiPAP]-ээс үзнэ үү)
   a. CPAP нь амьсгал татах болон амьсгал гаргах үед тогтмол эерэг агаар даралтыг хадгалдаг; бөглөрөлттэй нойрны апноэ эсвэл ХОБС-ийн хурц даамжиралтай өвчтөнд ашигтай.
   b. BiPAP нь амьсгал татах үед агаар дамжуулах сувгийг эерэг даралтаар дэмжиж, амьсгал гаргах үед дэмжлэгээ зогсоодог; амьсгал гаргах үед агаар дамжуулах сувгийг нээлттэй байлгахад шаардлагатай даралт л үйлчилдэг; ихэвчлэн CPAP үр дүнгүй тохиолдолд хэрэглэгддэг.
   c. CPAP болон BiPAP нь амьсгалын замыг дэмжих замаар хүчилтөрөгчийн хангамжийг сайжруулдаг.

3. Ерөнхий арга хэмжээ
   a. Эмчилгээний өмнө болон явцад арьсны өнгө, пульс оксиметрийн уншилт, амьсгал болон зүрх судасны чухал үзүүлэлтүүдийг үнэлнэ.
   b. Өвчтөний орны хажууд "*Оксиген ашиглаж байна*" гэсэн тэмдэг өлгө.
   c. Архаг уушгины асуудал байгаа эсэхийг үнэлнэ.
   d. Шаардлагатай бол хүчилтөрөгчийг чийгшүүлнэ.
   e. Нэмэлт хүчилтөрөгч нийлүүлэх тус бүрийн системийн онцгой анхаарах асуудлуудыг 69-10-р хүснэгтээс үзнэ үү.

Гипоксемитэй, архаг

Гиперкапния нь минутанд 1–2 л хүчилтөрөгч нийлүүлэх бага түвшний хүчилтөрөгчийн хангамж шаардлага, учир нь артерийн хүчилтөрөгчийн түвшин бага байх нь өвчтөний амьсгалын гол өдөөгч хүчин зүйл юм; үргэлж PHCP-ийн жор зааврыг шалгаарай.

C. **Механик амьсгалын аппаратыг ашиглах**
1. Төрөлд даралт-циклтэй амьсгалын аппарат, хугацаа-циклтэй амьсгалын аппарат, эзлэхүүн-циклтэй амьсгалын аппарат болон микропроцессортой амьсгалын аппарат орно
2. Даралтын циклтэй амьсгалын аппаратыг: Амьсгалын аппарат нь тодорхой агаар дамжуулах даралт хүртэл уушги руу агаарыг шахаж оруулдаг; энэ нь богино хугацаанд, жишээлбэл наркозын дараах асаргааны тасагт ашиглагддаг.
3. Цаг хугацаагаар цикллэгддэг амьсгалын аппаратыг: Аппарат агаарт шахаж оруулдаг

улираагүй тогтоосон хугацаа дуусах хүртэл агаар шахаж өгдөг; энэ нь хүүхэд эсвэл нярай үйлчлүүлэгчдэд зориулагдсан.

4. Эзлэхүүнээр цикллэгддэг амьсгалын аппаратыг ашиглана.
    a. Амьсгалын аппарат нь урьдчилан тогтоосон эзлэхүүн хүрэх хүртэл уушгинд агаарыг шахаж оруулдаг.
    b. Уушги болон цээжний ханы таталцал эсвэл өвчтөн эсвэл амьсгалын аппаратын агаар дамжуулах эсэргүүцэл хэрхэн өөрчлөгдсөнөөс үл хамааран тогтмол давалгын эзлэхүүн нийлүүлдэг.
5. Микропроцессортой амьсгалын аппаратыг ашигладаг.
    a. Амьсгалын аппаратын дотор компьютерийн эсвэл микропроцессор суурилуулсан байдаг бөгөөд энэ нь амьсгалын үйл ажиллагаа, дохиоллын систем болон өвчтөний параметрүүдийг тасралтгүй хянах боломжийг олгодог.
    b. Энэ төрлийн амьсгалын аппаратыг хүнд хэлбэрийн уушгины өвчтэй эсвэл удаан хугацааны таталт шаарддаг өвчтөнд илүү тохиромжтой.
6. Амьсгалын горим: инвазив бус эерэг даралттай амьсгал эсвэл BiPAP, хяналттай, туслах хяналттай, болон синхрончилсон завсрын албадлагын амьсгал (SIMV)
7. Нэвтрэлтгүй эерэг даралттай амьсгалын дэмжлэг буюу BiPAP (Зураг 69-26)
    a. Эндотрахеал хоолой эсвэл трахеостомын хоолой ашиглахгүйгээр амьсгалын дэмжлэг үзүүлдэг; оронд нь амны болон хамрын маск ашиглана.
    b. Империатив эерэг агаар даралтын (IPAP) болон экспиратив эерэг агаар даралтын (EPAP) түвшинг шаардлагатай даралттай дэмжлэг болон эерэг төгсгөлийн амьсгалын даралт (PEEP) түвшинд тохируулан том хэмжээний амьсгалын аппаратууд эсвэл бага урсгал үүсгэгч амьсгалын аппаратууд дээр тохируулдаг. Энэ нь булчинд хэвийн үйл ажиллагаа шаардахгүйгээр уушги руу илүү их агаар орж, гарах боломжийг олгодог.
    c. ХОХС-ийн хүндрэл, зүрхний дутагдал, **астма**, уушгины хавагналт болон гиперкапник амьсгалын дутагдал зэрэг тодорхой нөхцөлд ашиглаж болно.

Бэг-клапан маск нь байх ёстой

механик амьсгалын аппаратаар эмчилгээ авч буй бух өвчтөнд орны хажууд бэлэн байх ёстой.

8. Хяналттай

a. Өвчтөнд тогтмол хэмжээний уушгины эргэлтийн хэмжээг тогтмол хурдтайгаар өгдөг.

b. Амьсгалын хүчин чармайлт эхлүүлэх боломжгүй өвчтөнүүдэд ашиглана

c. Хамгийн цөөн ашиглагддаг горим; хэрэв өвчтөн амьсгал эхлүүлэх гэж оролдвол, амьсгалын аппарат өвчтөний амьсгал татах оролдлогыг хаадаг.

9. Туслах-хяналт

a. Хэвлийн эзлэхүүн болон амьсгалын давтамжийг амьсгалын аппаратад урьдчилан тохируулсан байдаг.

b. Амьсгалын аппарат өвчтөний амьсгалын ажлыг бүрэн гүйцэтгэдэг.

c. Хэрэв үйлчлүүлэгч амьсгал эхлүүлэх оролдлого хийвэл амьсгалын аппарат түүнийг хүлээн авч хариу үйлдэл үзүүлэхээр програмчлагдсан.

d. Өвчтөн амьсгал эхлэхэд амьсгалын аппарат урьдчилан тогтоосон титалын эзлэхүүнийг нийлүүлж, амьсгалын давтамжийг өвчтөнд хянах боломж олгодог.

e. Хэрэв өвчтөний спонтан

ийн их амьсгалын давтамж нэмэгдсэн тохиолдолд амьсгалын аппарат тус бүрт урьдчилан тогтоосон титалын эзлэхүүнийг нийлүүлсээр байдаг нь гипервентиляци болон амьсгалын алкалоз үүсгэж болно.

10. SIMV

a. Энэ нь туслах-хяналтын амьсгалын горимтой төстэй бөгөөд амьсгалын аппаратад давалгын эзлэхүүн ба амьсгалын давтамжийг урьдчилан тогтоодог

b. Амьсгалын аппаратын амьсгал өгөх хооронд өвчтөнд өөрийн хүссэн давтамж, титалын эзлэхүүнээрээ чөлөөтэй амьсгал авах боломж олгодог

c. Үндсэн амьсгалын горим болон аппаратаас гарах (weaning) горимоор ашиглаж болно

d. SIMV-ийг тусгаарлах горим болгон ашиглах үед SIMV амьсгалын тоог аажмаар бууруулж, өвчтөн аажмаар өөрийн амьсгалаа сэргээдэг.

11. Амьсгалын аппаратын удирдлага ба тохиргоо (69-11-р хүснэгт)

12. Оролцоо

Механик амьсгалын аппаратаар амьсгал авч буй өвчтөнд үргэлж үнэлгээ хийх эхлээд өвчтөнийг, дараа нь амьсгалын аппаратыг үнэл.

a. Амьсгалны чухал үзүүлэлтүүд, уушгины чимээ, амьсгалын байдал болон амьсгалын хэв маягийг үнэл (өвчтөн амьсгалын аппаратад тохируулсан давтамжаас доогуур амьсгалахгүй).
b. Арьсны өнгө, ялангуяа уруул болон хумсны доорх арьсны өнгөнд анхааралтай хяналт тавь.
c. Хөхний хоёр талын өргөжилтийг хянаарай.
d. Пульс оксиметрийн үзүүлэлтийг ав.
e. ABG-ийн үр дүнг хянана.
f. Шуурах шаардлагыг үнэлж, ялгаралтын төрөл, өнгө, хэмжээг ажигла.
g. Амьсгалын аппаратын тохиргоог үнэлнэ.
h. Шингэн шүршигч (humidifier)-ийн усны түвшин болон чийгшүүлэх системийн температурыг шалгана, учир нь температурын хэт өөрчлөлт нь амьсгалын замын салст давхаргыг гэмтээж болно.
i. Alarм тохируулсан эсэхийг баталгаажуул.
j. Хэрэв дохиоллын шалтгаан тодорхой болохгүй бол асуудал шийдэгдтэл уутанд-хавхлагатай амьсгалын тусламжийн маск ашиглан өвчтөнд гараар амьсгал өг.
k. Чийг хуримтлагдсан үед амьсгалын аппаратын хоолойг хоосло.
l. Хөдөлгөөнгүй байдлаас үүдэх хүндрэлээс сэргийлэхийн тулд үйлчлүүлэгчийг дор хаяж хоёр цаг тутамд эргүүлэх эсвэл зааврын дагуу орноос босгох.
m. Орон дор сэргээн амьлуулах тоног төхөөрөмжийг бэлэн байлга.

13. Амьсгалын аппаратын дохиоллын шалтгаанууд (69-14-р хайрцаг)

14. Alarмны аюулгүй байдал ба alarмны ядаргаа

a. Alarм дуугарсныг эмнэлгийн сувилагчийн анхааралтай сонсох үүрэг бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчийн асуудал үүссэнийг илтгэнэ.

b. Сувилагч нь дохиоллын дуу гарсан даруйд шууд хариу үйлдэл үзүүлж, нэн даруй үйлчлүүлэгчийг үнэлэх шаардлагатай.

c. Хамтарсан Комиссын (TJC) мэдээлснээр сэрэмжлүүлэгтэй холбоотой ноцтой осол үүсэхэд хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйл нь сэрэмжлүүлгийн ядаргаа бөгөөд олон удаагийн сэрэмжлүүлэг болон үүсэх дуу чимээ сувилагчдын мэдрэмжийг бууруулж, сэрэмжлүүлгийг үл тоомсорлох эсвэл бүр унтраахад хүргэдэг.

d. TJC-ийн зарим зөвлөмжүүдэд дохиоллын аюулгүй байдлыг байгууллагын бодлого болгох, анхдагч дохиоллын тохиргоог тодорхойлох, удирдах хамгийн чухал дохиоллуудыг тодорхойлох, дохиоллыг удирдах бодлого, журам боловсруулах, ажилтнуудыг сургах зэрэг орно.

e. Нэмэлт мэдээлэл авах бол www.pwrnewmedia.com/2013/joint_co хаягаар хандана уу.

Амьсгалын аппаратын дохиоллын тохиргоог хэзээ ч унтраах байрлалд тавихгүй.

15. Гэмт үр дагавар

a. Эерэг даралт хэрэглэсэнээр үүсэх гипотензи нь цээжний хөндийн даралт нэмэгдэж, цус зүрх рүү буцах явцыг саатуулдаг

b. Эерэг даралттай эмчилгээний улмаас пневмоторакс эсвэл арьсны доорхи **эмфисема** зэрэг амьсгалын хүндрэлүүд

c. Стрессийн шарх гэх мэт хоол боловсруулах замын өөрчлөлтүүд

d. Хоол тэжээл хангалтгүй бол хоол тэжээлийн дутагдал үүснэ

e. Халдвар

f. Цээжний эерэг даралт нь цээжний доторх даралт нэмэгдүүлж, зүрх рүү цус буцахыг сааруулснаас үүдэлтэй гипотензи үүсгэдэгЭер

g. Амьсгалын аппаратаас хамааралтай эсвэл аппаратаас салгах боломжгүй

h. Цээжний доторх даралт нэмэгдэх эсвэл вагалын хариу идэвхжихийн улмаас үүссэн брадикарди

16. Амьсгалын аппаратаас салгах: амьсгалын аппаратаас хэвийн амьсгалд шилжих процесс; аргууд нь SIMV, T-хэсэг, даралтын дэмжлэг (pressure support) зэрэг орно

хамгаалалттай амьсгалаас зүрхний амьсгалд шилжих; аргууд нь SIMV, T-хэсэг, даралтын дэмжлэг

17. SIMV

a. Өвчтөн механик амьсгалын аппаратын минутанд урьдчилан тогтоосон амьсгалын давтамжийн хооронд амьсгална.

b. SIMV-ийн давтамжийг аажмаар бууруулж, өвчтөн амьсгалын аппаратыг ашиглахгүйгээр өөрөө амьсгалах хүртэл үргэлжлүүлнэ.

18. T-хоолой

a. Өвчтөнийг амьсгалын аппаратаас салгаж, оронд нь чийгшүүлсэн хүчилтөрөгч нийлүүлдэг T-хэлбэрийн хоолой эсвэл CPAP-ыг холбодог.

b. Эхэндээ өвчтөнийг богино хугацаагаар амьсгалын аппаратаас салгаж, чөлөөт амьсгалахыг зөвшөөрдөг.

c. Амьсгалын аппаратаас гарах явц нь өвчтөн улам урт хугацаанд аппаратаас хамааралгүй амьсгалах чадвартай болсноор ахицтай явагддаг.

19. Даралтын дэмжлэг

a. Даралтын дэмжлэг нь өвчтөний амьсгалын хүчийг дэмжихийн тулд амьсгалын аппаратад урьдчилан тогтоосон даралт юм.

b. Амьсгалын аппаратаас салгах явц үргэлжлэх тусам даралт аажмаар буурна.

c. Шахалтын дэмжлэг ашиглах үед амьсгалын аппаратын минутанд урьдчилан тогтоосон амьсгалын тоог аажмаар бууруулж байх үед шахалтыг тогтмол хадгалж болно.

D. Хүзүүний ясны хугарал

1. Шууд цохилтоор үүссэн цээжний бэртэл нь пневмоторакс, гемоторакс эсвэл уушгины няцрал зэрэг цээжний доторх гэмтэл үүсгэх эрсдэлтэй

2. Хөдөлгөөн хийх, гүн амьсгал авах, ханиалгах үед өвдөлт үүсч, агаар солилцоо алдагдаж, ялгаралтыг хангалттай цэвэрлэж чадахгүй болдог.

3. Үнэлгээ

a. Өвдөлт, мэдрэгшил

гэмтсэн хэсэгт амьсгаа авахад нэмэгддэг өвдөлт

b. Гадны амьсгал

c. Клиент цээжний тулгуур бэхэлгээ хийж байна

d. Цээжний рентген зурагт хугаралт илэрсэн

4. Оролцоо

a. Хавирга ихэвчлэн өөрөө эдгэрч нийлдэг гэдгийг анхаарна уу.

b. Өвчтөнийг Фоулерын байрлалд байрлуул.

c. Өвдөлт намдаах эмчилгээг өгөх

агааржуулалтын хангалттай байдлыг хадгалах зорилгоор зааварласан.

d. Амьсгалын хүндрэл нэмэгдэх эсэхийг хянах.

e. Өвчтөнд гараа, ханцуйгаа эсвэл дэр ашиглан өөрөө шинжлэх (splint хийх) заавар өг.

f. Нээлттэй тогтоолт ба дотоод

Хавирганы нүхэн доторх тогтворжуулалт (хавирганы хавтан суулгах) хийж болно

Жишээ нь: хэрэв өвдөлт хүчтэй бол зааврын дагуу хавирга хоорондын мэдрэлийн блокад бэлтгэх.

E. Тогтворгүй цээжний хана

1. Осол гэмтэлтэй холбоотой цохилтод хөхний гэмтлээс үүсдэг бөгөөд энэ нь хемоторакс болон хавирганы хугарал руу хүргэж болно.

2. Хөхний ханы сул хэсэг нь үлдсэн хэсгийн өргөжилт, агшилтад эсрэгээр хөдөлдөг.

3. Үнэлгээ

a. Парадоксаль амьсгал (дотогш

амьсгал авах үед цээжний хэсгийн хөдөлгөөн, амьсгал гаргах үед гадагш чиглэсэн хөдөлгөөн)

b. Хүчтэй цээжний өвдөлт

c. Амьсгал давчдах

d. Цианоз

e. Тахикарди

f. Цусны даралт буурах

g. Хурдан, гүн биш амьсгал

h. Амьсгалын чимээ сулрах

4. Амралтын арга хэмжээ

a. Клиентийг Фоулерын байрлалд байлга.

b. Зааврын дагуу хүчилтөрөгч өгөх.

c. Амьсгалын хүндрэл нэмэгдэх эсэхийг хянах.

d. Хоолой гаргах болон гүнзгий амьсгалахад уриалах.

e. Өвдөлтийн эмчилгээг зааврын дагуу хийх.

f. Оксигений хэрэгцээг бууруулахын тулд орны амралтыг баримталж, хөдөлгөөнийг хязгаарлана.

g. Хавирганы нээлттэй засалт, дотоод бэхэлгээ (хавирганы хавтан суулгах) хийж болно.

h. Интубацид бэлтгэх механик амьсгалын аппаратыг PEEP-тэй ашиглан амьсгалын дутагдал, цочролд хамааралтай хүнд хэлбэрийн тогтворгүй цээж (flail chest)-д бэлдэх.

F. Уушгины няцрал

1. Интерстициаль цус алдалт нь альвеолийн цус алдалттай хамт явагддаг бөгөөд энэ нь уушгины эзлэхүүн дасан зохицох чадварыг бууруулдаг

2. Гол хүндрэл нь цочмог амьсгалын дутагдлын хам шинж.

3. Үнэлгээ

a. Амьсгал давчдах

b. Тайвангүй байдал

c. Бронхийн ялгаралт ихсэх

d. Гипоксеми

e. Цусны бөөлжис

f. Амьсгалын чимээ сулрах

g. Хялхийлэх, хяхтах

4. Оролцоо

a. Амьсгалын замыг чөлөөтэй, агааржуулалтыг хангалттай байлга.

b. Клиентийг Фоулерын байрлалд байрлуулна

c. Оксигенийг зааврын дагуу өг.

d. Амьсгалын хүндрэл нэмэгдэх эсэхийг хянах.

e. Оксигенийн хэрэгцээг бууруулахын тулд орны амралтыг хадгалж, хөдөлгөөнийг хязгаарлана.

f. Механик агааржуулалтад бэлтгэх Шаардлагатай бол PEEP-тэй механик амьсгалын дэмжлэг үзүүлэх.

G. **Пневмоторакс** (Зураг 69-27)

1. Плевралын хөндийд агаар хуримтлагдах нь цээжний доторх даралт нэмэгдэхэд хүргэдэг ба

амьдралын багтаамж буурсан

2. Хавдрын доторх сөрөг даралт алдагдсанаар уушги нугардаг.
3. Өөрөөсөө үүссэн пневмоторакс нь уушгины блеб буюу уушгины гүн дахь жижиг агаар агуулсан хөндий хагарснаас үүсдэг.
4. Нээлттэй пневмоторакс нь цээжний хана дамжин эерэг агаар мандалын даралтыг плеврагийн хөндийд нэвтрэх боломж олгодог үед үүсдэг.
5. Тензэн пневмоторакс нь цээжний хөнгөн гэмтэл эсвэл PEEP-тэй механик амьсгалын аппаратын хэрэглээнээс үүдэн плеврагийн хөндийд эерэг даралт хуримтлагдсанаас үүсдэг.
6. Үнэлгээ (69-15-р хайрцаг)

7. Эмчилгээ

a. Пневмотораксыг оношлохдоо цээжний рентген зураг ашиглана.
b. Нээлттэй цээжний шарханд нэвтрэхгүй боолт тавина.
c. Оксигенийг зааврын дагуу өг.
d. Өвчтөнийг Фоулерын байрлалд байрлуул.
e. Хөхний хоолой суулгахад бэлтгэх ба энэ хоолойг уушги бүрэн дэлгэрэх хүртэл байрлуулсан хэвээр үлдээнэ (хөхний хоолойн талаарх мэдээллийг IV, O хэсэгт үзнэ үү).
f. Хөхний хоолойн гаргалтын системийг хянаарай.
g. Арьсны доорх эмфисэмийг хянаарай.

Амьсгалын замын эмгэгтэй өвчтөнийг орны толгойг өргөж байрлуулна.

Н. Хурц амьсгалын дутагдал

1. Цус руу хангалттай хүчилтөрөгч тээвэрлэгдэхгүй эсвэл уушгинаас хангалттай нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулж чадахгүй болж, өвчтөний нөхөн төлөх механизмүүд нь хангалтгүй болсон үед үүсдэг
2. Үүний шалтгаанд уушиг эсвэл цээжний хананы механик гажиг, тархины амьсгалын хяналтын төвийн гэм, амьсгалын булчингийн үйл ажиллагааны алдагдал орно.

3. Оксигенацийн дутагдал буюу гипоксемитэй үед

алын дутагдалд хүчилтөрөгч уутанцралд хүрдэг ч шимэгдэж, ıагдаж чадахгүйгээс болж, үр дүнд нь

PaO_2 нь 60 мм Hg-ээс бага, артерийн хүчилтөрөгчийн ханылга (SaO_2) нь 90%-аас доош, эсвэл артерийн нүүрстөрөгчийн давхар ислийн хэсэгчилсэн даралт ($PaCO_2$)нь 50 мм Hg-ээс их, хүчилшилттэй хамт илэрнэ.

4. Амьсгалын дутагдал нь гипоксеми, гиперкапни эсвэл аль алиныг нь. Хүчилтөрөгчийн солилцоо хангалтгүй байх нь дутагдлын механизм юм. Цусны хүчилтөрөгч, нүүрстөрөгчийн давхар исэл эсвэл аль аль нь хэвийн түвшинд байж чадахгүйгээс дутагдал үүсдэг.
5. Олон өвчтөнүүд гипоксеми болон гиперкапник амьсгалын дутагдлыг зэрэгцүүлэн туулдаг бөгөөд уутанцраас хуримтлагдсан нүүрстөрөгчийн давхар ислийн хийн агууламж хүчилтөрөгчийг шахаж гаргаснаар гипоксемид нөлөөлдөг.
6. Амьсгалын дутагдлын илрэлүүд нь PaO_2ба $PaCO_2$-ийн өөрчлөлтийн хэмжээ, хурдтай холбоотой.
7. Үнэлгээ
    a. Амьсгал давчдах
    b. Тайвангүй байдал
    c. Төөрөгдөл
    d. Тахикарди
    e. Дээд цусны даралт
    f. Ритмийн эмгэг
    g. Ухамсарын түвшин буурах
    h. Амьсгал ба амьсгалын чимээний өөрчлөлт
    i. Толгой өвдөх (илүү ховор)

8. Эмчилгээний арга хэмжээ
    a. Амьсгалын дутагдлын шалтгааныг тогтоож, эмчил.
    b. $PaO2$-ынтүвшинг 60–70 ммHg-ээс дээш байлгахын тулд хүчилтөрөгч өг.
    c. Өвчтөнийг Фоулерын байрлалд байрлуул.
    d. Гүнзгий амьсгалахыг уриалах.
    e. Жороор заасан бронходилататоруудыг өг.
    f. Хэрэв нэмэлт хүчилтөрөгч өгөх нь хүлээн зөвшөөрөгдөх PaO_2ба $PaCO_2$түвшинг хадгалж чадахгүй бол үйлчлүүлэгчийг механик амьсгалын аппаратад бэлтгэх.

I. Хурц амьсгалын хүндрэлтэй хам шинж

1. Таралттай уушгины гэмтэл эсвэл ноцтой өвчний улмаас үүссэн хүндрэлээр илэрч, уушгины судас хоорондын зайд шингэн хуримтлагдахад хүргэдэг хурц амьсгалын дутагдлын нэг хэлбэр.
2. Гомдлын гол газар нь уушгины капилляр юм.

мембран.

3. Интерстициаль эдэм нь сүүлийн агаар дамжуулах сувгуудыг шахаж, бөглөснөөр уушгины эзлэхүүн болон уян хатан чанарыг бууруулдаг.

4. ABG-ийн үзүүлэлтүүд нь амьсгалын хүчилшлийг илрүүлнэ үчилтөрөгчийн хувийг нэмэгдүүлсэн ч хариу өгөхгүй гипоксеми.

5. Хөхний рентген зураг нь хоёр талын интерстициаль болон альвеоляр шингэн хуримтлалыг харуулдаг; интерстициаль эдэм нь шингэний агууламж 30%-иар нэмэгдэх хүртэл илрэхгүй байж болно.

6. Үүний шалтгаанд сепсис, шингэний хэт ачаалал, цочрол, гэмтэл, мэдрэлийн гэмтэл, түлэгдэлт, тархсан судсны коагуляцийн эмгэг (DIC), эмийн хордлого, амьсгал доторх шингэн уусмал (аспираци), мөн хортой бодис амьсгалах зэрэг орно.

7. Үнэлгээ

   a. Тахипне
   b. Амьсгал давчдах
   c. Амьсгалын чимээ сулрах
   d. ABG-ийн үзүүлэлтүүд муудах
   e. Өндөр концентрацитай хүчилтөрөгч нийлүүлсэн ч гипоксеми
   f. Уушгины эзлэхүүн буурсан
   g. Уушгины инфильтрат

8. Эмчилгээний арга хэмжээ

   a. Хурц амьсгалын хүндрэлтэй хам шинжийн шалтгааныг тодорхойлж эмчлэх.
   b. Заасан ёсоор хүчилтөрөгч өгөх.
   c. Клиентийг Фоулерын байрлалд байрлуул.
   d. Шингэн хэрэглээг зааврын дагуу хязгаарлах.
   e. Зааврын дагуу амьсгалын эмчилгээг хийх.
   f. Жороор заасан дагуу диуретик, цус бүлэгнэлтийн эсрэг эм болон кортикостероидыг өг.
   g. PEEP ашиглан өвчтөнийг интубаци болон механик амьсгалын аппаратад бэлтгэх.

X. Нарийн төвөгтэй зүрх-судасны асуудлууд

А. Кардиоген шок

1. Кардиоген шок нь зүрхний шахуурын үйл ажиллагаа доголдсоноос зүрхний гарал буурч, эд эсийн цусны хангамж алдагддаг.

хангалттайгаар шахах чадвараа алдсанаар зүрхний гаралтыг бууруулж, эд эсийн цусны хангамжийг алдагдуулдаг.

2. Зүүн ховдлын 40%-аас дээш хэсгийн некроз, ихэвчлэн томоохон коронар судаснууд бөглөрснөөс үүдэн кардиоген шок үүсгэдэг.
3. Эмчилгээний зорилго нь эд эсийн хүчилтөрөгчийн хангамж, цусны урсгалыг хадгалах, зүрхний шахах чадварыг сайжруулах явдал юм.
4. Үнэлгээ
   a. Гипотензи: систолын даралт 90 ммHg-ээс доогуур эсвэл өвчтөний суурь үзүүлэлтээс 30 ммHg-ээр буурсан
   b. Шээсний ялгаралт 30 мл/цагаас бага
   c. Хүйтэн, чийглэг арьс
   d. Гарах болон хөлний судасны цохилт сул
   e. Тахикарди, тахипнэ
   f. Уушгины бөглөрөл
   g. Зорилгогүй төөрөлт, тайвангүй байдал, будлиан
   h. Хөхний таагүй мэдрэмж үргэлжлэх
5. Оролцоо
   a. Зааврын дагуу хүчилтөрөгч өгөх.
   b. Уушгины бөглөрлийг бууруулж, цээжний өвдөлтийг намдаахын тулд зааврын дагуу морфин сульфатыг судсаар тарьж өгнө.
   c. Интубаци болон механик амьсгалын аппаратад бэлтгэх.
   d. Цусны даралтыг тасралтгүй хянаж, зааврын дагуу диуретик болон нитратуудыг өг.
   e. Эд эрхтний цусны хангамжийг хадгалахын тулд эмчийн зааврааp вазопрессор болон эерэг инотроп эмүүдийг хэрэглэнэ.
   f. Хэрэв заасан бол коронар артерийн цусны урсгалыг сайжруулах, зүрхний гаралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аортын доторх бөмбөлөгт насос суулгахад өвчтөнийг бэлтгэх.
   g. Өвчтөнийг перкутан транслуминал коронар зэрэг шуурхай реперфузийн процедуруудад бэлтгэх

ангиопластик (ПТКА) эсвэл коронар артерийн шугаман хагалгаа.

h. Артерийн цусны хийний түвшинг хянах ба тэнцвэргүй байдлыг эмчлэхэд бэлдэх.

i. Шээсний гаралтыг хянах.

j. Зүрхний дутагдлын зэргийг үнэлэхийн тулд уушгины артерийн (Сван-Ганц) катетер суулгахад туслах (Зураг 69-28).

B. Гемодинамикийн хяналт: төв венийн даралт (CVP), уушгины артерийн даралт, дундаж артерийн даралт (MAP) (зураг 69-28-ыг үзнэ үү)

B. **Төв венийн даралт** (CVP)

1. CVP нь дээд вена кава доторх даралт бөгөөд цус дээд вена кава болон баруун дэлс рүү буцаж ирэхэд үйлчилдэг даралтыг илтгэнэ.
2. CVP-ийг дээд ховд орчимд байрлах төв ховдны шугамаар хэмждэг.
3. Энгийн CVP даралт нь ойролцоогоор 3–8 мм м.у. (ммHg) хооронд хэлбэлздэг.
4. Өндөр CVP нь натри болон ус тогтоолтын улмаас, хэт их судсанд шингэн тарилга, шингэний тэнцвэрийн алдагдал эсвэл бөөрний дутагдал зэрэг шалтгаанаар цусны эргэлтийн хэмжээ нэмэгдсэнийг илтгэнэ.
5. CVP буурсан нь эргэлтэнд байгаа цусны хэмжээ буурсныг илтгэнэ; энэ нь шингэний тэнцвэргүй байдал, цус алдалт эсвэл хүчтэй судал тэлэлтээс болж цус хөл, гарын үзүүрт хуримтлагдсанаар венийн буцах урсгалыг хязгаарладаг.

D. Цусны төвийн венийн даралт (CVP)-ийг хэмжих

1. Баруун дэлс нь хавирганы хоорондын дөрөвдүгээр завсрын шугамд байрладаг; дамжуулагчийн тэг цэг нь баруун дэлсний түвшинд байх ёстой.
2. Өвчтөн тайван байх ёстой; хоолой доторх даралтыг нэмэгдүүлдэг үйлдэл, жишээлбэл ханиалгах, хүчтэй амьсгал гаргах нь хэмжилтэд худал өсөлт үүсгэнэ.
3. Хэрэв өвчтөн механик амьсгалын аппаратад холбогдсон бол уншилтыг амьсгал гаргалтын төгсгөлд (end-expiration) авна.
4. Төв венийн шугамыг нээлттэй байлгахын тулд бага хэмжээний шингэнийг тасралтгүй даралтаар нийлүүлдэг.

E. Уушгины артерийн даралт

1. Баруун зүрхний болон шууд бус байдлаар зүүн зүрхний даралт хэмжихийн тулд уушгины артерийн катетер ашиглагддаг.
2. **Уушгины артерийн хавчуурын даралт (PAWP)**-ыг мөн уушгины артерийн хаалттай даралт гэж нэрлэдэг

(PAOP) болон уушгины капиллярын хавчуурын даралт (PCWP) гэж нэрлэдэг.

3. Энэхүү хэмжилтийг уушгины артерийн катетерийн бөмбөлгийг түр зуур хөвүүлэх үед авч, зүүн ховдлын диастолын төгсгөлийн даралт (end-diastolic pressure)-ыг илтгэнэ.
4. PAWP нь ерөнхийдөө ойролцоогоор 4–12 мм рт.ст-ийн хооронд хэлбэлздэг; өсөлт нь зүүн ховдлын дутагдал, гиперволеми, митраль регюргитаци эсвэл зүрхний доторх шунтыг илтгэж болдог бол бууралт нь гиповолеми эсвэл даралт ачааллын бууралтыг илтгэнэ.
5. Элэгний артерийн (RA) хэвийн даралт ойролцоогоор 2–6 ммHg хооронд хэлбэлздэг; нэмэгдэл нь баруун ховдлын дутагдалтай холбоотой бол бууралт нь гиповолемиг илтгэж болно.
6. Уушгины артерийн хэвийн даралт (PAP) нь ойролцоогоор 15–30 мм рт.ст систолын/8–15 мм рт.ст диастолын хооронд хэлбэлздэг.

F. **Дундаж артерийн даралт (MAP)**

1. Зүрхний цохилтын мөчлөгийн туршид систем эргэлтийн дундаж даралтны ойролцоо тооцоо
2. MAP нь ойролцоогоор 70–105 ммHg хооронд хэлбэлздэг.

G. Насанд хүрэгчдэд зориулсан CPR хийх заавар: 52-р бүлгийг үзнэ үү; мөн Америкийн Зүрхний Холбоо: *CPR ба ECC-ийн заавар,* 2015 он болон *Тусгай шинэчлэлтүүд*, 2017 он. https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/ сайтаас авсан.

H. Цусны эргэлтийн цохилтгүй ритмүүдийн дэвшилтэт эмчилгээ

1. Эхний алхмууд
   a. CPR-ийг эхлүүл; монитор эсвэл дефибрилляторыг холбо.
   b. Ритм шоконд өртөх эсэх, өртөхгүйг тодорхойлох.
   c. Цусны даралттай боловч цохилтгүй ритмүүдэд зүрхний булчирхайн фибрилляци болон зүрхний булчирхайн тахикардиа орно.
   d. Цусны даралтгүй, цохилтгүй ритмүүдэд асистоли ба цахилгаан идэвхтэй боловч цохилтгүй (PEA) ритмүүд орно.
2. Цахилгаан цохилт өгөх боломжтой ритмүүд: зүрхний булчирхайн фибрилляци ба зүрхний булчирхайн тахикарди
   a. CPR эхлүүлж, монитор холбож, ритмийг тодорхойлсны дараа анхны тунгаар 100–200 J-ээр цохилт өгөх ба хоёр фазтай бол тунг нэмэгдүүлнэ; нэг фазтай бол 360 J ашиглана.
   b. Сэхээн сэргээх үйлдлийг үргэлжлүүлж, хэрэв өмнө нь тавиагүй бол судсаар (IV) эсвэл ясны дотор (IO) хангамж нээнэ.

c. Ритмийг шинжил; хэрэв цахилгаан цохилт шаардлагатай бол дахин цохилт өг.

d. Жороор заасан ёсоор 3–5 минутын зайтай 1 мг эпинефрин тарьж бэлд.

e. Дэвшилтэт амьсгалын замыг авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд сэргээн амьлуулах үйл явцын чанарыг тодорхойлоход капнографи ашиглах шаардлагатай.

f. Цусны эргэлтийн сэргээх үйлдлийг (CPR) үргэлжлүүлж, ритмийг шинжилж, хэрэв шок өгөх боломжтой ритм илэрвэл цахилгаан шок өг. Хэрэв ритм шок өгөх боломжгүй бол шок өгөх боломжгүй ритмийн аргачлалыг дага.

g. Зааврын дагуу амиодарон 300 мг-ыг IV/IO болюс хэлбэрээр тарьж, дараа нь дараагийн тохирох мөчлөгт шаардлагатай бол 150 мг-ыг IV/IO хэлбэрээр тарьж бэлд.

h. Эргэн сэргэх боломжтой шалтгаануудыг авч үзэх: гипокси, гиповолемия, хүчилийн ионууд буюу ацидоз, гиперкалиеми эсвэл гипокалиеми (5 H-үүд) болон даралттай пневмоторакс, перкардиаль тампонад, хорт бодис, тромбоз (уушгины тромбоэмболи), эсвэл тромбоз (урьдчилан сэргийлэх боломжгүй цочмог коронар синдром; 5 T-үүд).

i. Энэхүү алхмуудыг дахин дахин давтан гүйцэтгэж, бие даан цусны эргэлт сэргэх (ROSC) хүртэл эсвэл сэргээх цээжний массаж (CPR)-ийг зогсоох хүртэл үргэлжлүүлнэ.

3. Цахилгаан цохилт өгөх боломжгүй ритмүүд: асистоли ба PEA

a. CPR эхлүүлж, монитор холбож, ритмийг тогтоосны дараа хэрэв өмнө нь тавиагүй бол IV эсвэл IO хангамж нээнэ.

b. Заасан ёсоор 3–5 минутын зайтай 1 мг эпинефрин тарьж бэлд.

c. Дэвшилтэт амьсгалын замыг авч үзэх ба CPR-ийн чанарыг тодорхойлоход капнографи ашиглах.

d. CPR-ийг үргэлжлүүлж, ритмийн шинжилгээ хийж, хэрэв ритм цохилтод орох бол цахилгаан цохилт өгөх алгоритмыг дагана.

e. Эргэн сэргээгдэх боломжтой шалтгаануудыг авч үзэх: гипокси, гиповолемия, хүчилийн ион эсвэл ацидоз, гиперкалиеми эсвэл гипокалиеми (5 Hs) болон даралттай пневмоторакс, перкардиаль тампонад, хорт бодис, тромбоз (уушгины тромбоэмболи), эсвэл тромбоз (урьдчилан сэргийлэх боломжгүй коронар синдром; 5 Ts).

f. Энэхүү алхмуудыг автомат эргэлт (ROSC) буюу сэргээх оролдлогыг зогсоох хүртэл давтан гүйцэтгэнэ.

4. Зүрхний цочролын дараах асаргаа

a. Хэрэв ROSC-д хүрсэн бол өмнө нь хийгдээгүй бол амьсгалын дэвшилтэт замыг нэвтрүүлж, хүчилтөрөгчийн ханыг 94%-аас дээш байлгаж, хэт агааржуулалтаас зайлсхийх хэрэгтэй.

b. Хэрэв гипотензи (систолын даралт 90 ммHg-аас бага) илэрвэл вазопрессор болон судсаар богино хугацаанд их хэмжээний шингэн (IV bolus) шаардлагатай.

c. IV шингэнүүдэд 1–2 литр хэвийн давсны шингэн эсвэл лактаттай Рингерийн шингэн орно.

d. Вазопрессорууд нь эпинефрин венийн дусал 0.1–0.5 мг/кг/мин, допамин венийн дусал 5–10 мкг/кг/мин, эсвэл норэпинефрин 0.1–0.5 мкг/кг/мин.

e. 12-холболтын электрокардиограмм хийх шаардлагатай.

f. Хэрэв өвчтөн тушаал дагаж байгаа бол мэдрэлийн үйл ажиллагааг хамгаалах зорилгоор зорилтот температурын удирдлагыг авч үзэж, IV шингэнийг 4°C-д хөргөж хэрэглэх хэрэгтэй.

g. Хэрэв ST-д өргөрөг үүссэн миокардын инфаркт (STEMI) эсвэл бусад хэлбэрийн хурц миокардын инфаркт сэжиглэгдвэл коронар реперфузийн эмчилгээ хийж, өвчтөнийг эрчимт эмчилгээний тасагт хяналт дор эмчлэх ёстой.

h. Зүрхний цочмог зогсолтын дараах асаргааны заавар: Америкийн Зүрхний Холбооноос авсан. (2018). *7-р хэсэг: Дээд зэргийн зүрх-судасны амьдралыг дэмжих тусламж.* https://eccguidelines.heart.org/index.ph ecc-guidelines-2/part-7-adult- advanced-cardiovascular-life-support/

I. Зүрхний тампонад

1. Перикардийн шингэн хуримтлал нь перикардын ханагийн гадаргуугийн давхарга болон дотор давхаргын хоорондох зай шингэнээр дүүрэх үед үүсдэг.

2. Перикардийн шингэн хуримтлал нь өвчтөнд зүрхний

тампонад, перикардын хөндийд шингэн хуримтлагдах.

3. Тампонад нь ховдлын дүүргэлтийг хязгаарлаж, зүрхний гарал буурдаг.

Хурц зүрхний тампонад нь перикард дотор бага хэмжээний (20–50 мл) шингэн хурдан хуримтлагдсанаар үүсч болно.

4. Үнэлгээ

a. Пулсус парадоксус
b. Цусны төвийн даралт нэмэгдсэн
c. Цус харвах булчирхайн судас томорсон, уушги хэвийн
d. Холын, сул сонсогдох зүрхний чимээ
e. Зүрхний гарал багассан
f. **Пульсийн даралт** нарийссан

5. Оролцоо

a. Өвчтөнийг гемодинамикийн хяналтад оруулахын тулд эрчимт эмчилгээний тасагт байршуулна.
b. Зүрхний гарал буурсантай холбоотойгоор зааврын дагуу судсаар шингэн эмчилгээ хийх.
c. Өвчтөнийг цээжний рентген зураг эсвэл эхокардиографид бэлтгэх.
d. Зааварлагдсан бол перикардийн шингэнийг гаргах зорилгоор перикардиоцентезист бэлтгэх.
e. Перикардиоцентезийн дараах таампонадын давталтыг хянах.
f. Хэрэв өвчтөнд дахин тампонад эсвэл давтан шингэн хуримтлагдах, эсвэл архаг перикардитаас наалдамхай үүсэх үед зүрхний ховдлуудыг хангалттай дүүргэж агших боломж олгохын тулд перикардын хэсэг (перикардын цонх) эсвэл бүх перикардыг (перикардиэктоми) авч болно.

F. Коронаартерийн шугаталт хагалгаа

1. Хаагдсан коронар артериудыг өвчтөний өөрийн венийн эсвэл артерийн судаснуудаар тойруулдаг.
2. Сафенийн вена, дотоод хөхний артери эсвэл бусад артериудыг коронар артерийн бөглөрөлүүдийг тойруулан холбоход ашиглаж болно.
3. Коронар артерийн шугамал хагалгаа дараах үед хийгддэг

өвчтөн коронар артерийн өвчнийг эмнэлгийн аргаар эмчлэхэд хариу өгөхгүй эсвэл судаснууд хүндээр бөглөрсөн үед хийгддэг.

4. Хамгийн бага нэвтрэх шууд коронар артерийн шугалт (MIDCAB) нь зүүн урд коронар артери (LAD)-д гэмтэлтэй зарим өвчтөнд сонголт байж болно; энэ мэс засалд хэвлийн яс задлах шаардлагагүй (ихэвчлэн зүүн талын 5 см [2 инч] хэмжээтэй цээжний хагалгаа хийгддэг) бөгөөд кардиопульмональ шугалт шаардлагагүй.
5. Мэс заслын өмнөх арга хэмжээнүүд
    a. Өвчтөн болон түүний гэр бүлийг зүрхний мэс заслын эрчимт эмчилгээний тасагтай танилцуулах.
    b. Өвчтөнд цээжний ясны засалт, гар эсвэл хөлний хэсэгт зүсэлт хийгдэж болох, 1 эсвэл 2 цээжний дренаж, Фолейн катетер болон хэд хэдэн судсанд шингэн тарих катетер байрлуулахыг мэдэгдэнэ.
    c. Өвчтөнд хоолойн хоолойн хоолой түр хугацаанд суурилагдаж, тэрээр ярьж чадахгүй гэдгийг мэдэгд.
    d. Өвчтөнд механик амьсгалын аппаратад холбогдох тул аппаратаар амьсгалж, түүнтэй тэмүүлэхгүй байхыг зааварлах.
    e. Мэс заслын дараах өвдөлт тохиолдох бөгөөд өвчин намдаах эм бэлдмэл олгогдохыг үйлчлүүлэгчид зааж өг.
    f. Өвчтөнд хөхний хэрчийн туузаар бэхлэх, ханиалгах, гүн амьсгал авах, урамшуулах спирометр ашиглах, гар, хөлний дасгалыг хэрхэн хийх талаар зааварлах.
    g. Өвчтөн болон түүний гэр бүлийг мэс засалтай холбоотой түгшүүр, айдсаа ярилцахад нь урамшуулах.
    h. Заагдсан эмүүдийг мэс заслын өмнөхөн зогсоох боломжтойг анхаарна уу (ихэвчлэн диуретик эмүүдийг мэс заслын өмнөх 2–3 хоногт, дигоксиныг мэс заслын өмнөх 12 цагт, аспирин болон цус шингэрүүлэгч эмүүдийг мэс заслын өмнөх 1 долоо хоногт).
    i. Жороор заасан эмийг зааврын дагуу өгөх ба үүнд калийн хлорид, гипертензийн эсрэг эм, ритмийн эмгэгт зориулсан эм, антибиотик орж болно.

6. Зүрхний мэс заслын тасгийн мэс заслын дараах үе шатны арга хэмжээ
    a. Механик амьсгалын аппаратыг үргэлжлүүлнэ

6-аас 24 цагийн турш эмчийн зааврaар.

b. Зүрхний цохилт, ритм, уушгины артерийн болон ерөнхий артерийн даралт, шээсний гарал, мэдрэлийн байдлыг нарийвчлан хянана.

c. Медиастиналь болон плевраль цээжний хоолойг заасан сорох хүчтэй усны битүүмжлэлтэй дренажийн системд холбосон; дренаж 100–150 мл/цаг-аас их байвал мэс заслын эмчид мэдэгдэнэ.

d. Эпикардийн пейсингийн утаснуудыг ариутгасан тагтай эсвэл түр зуурын пейсмейкер генераторт холбосон; ашиглагдаж буй бүх тоног төхөөрөмжийг микро цохилтоос сэргийлэхийн тулд зөв газардуулсан байна.

e. Шингэн болон электролитийн тэнцвэрийг нарийн хянана; өвчтөнд ихэвчлэн хаван үүсдэг тул шингэнийг ерөнхийдөө 1500–2000 мл-ээр хязгаарладаг.

f. **Цусны даралт** хяналттай хянагддаг; гипотензи нь судсаар хийгдсэн графтын нуралт үүсгэж болдог бол гипертензи нь даралт нэмэгдүүлж, оёдлын шугамаар шингэн гоожиж цус алдалт үүсгэдэг.

g. Хүний биеийн температурыг хянаж, температур 96.8°F (36.0°C)-ээс доош буурвал дулаан эсвэл термофольга хөнжил ашиглан дахин халаах үйл явцыг эхлүүлнэ; чичирхийлэл үүсгэхгүйн тулд өвчтөнийг цагт 1.8°F-аас хурдан халаахгүй, температур ойртож байвал дахин халаах үйл явцыг зогсооно
98.6° F (37.0° C).

h. Калийн түвшинг 4–5 мЭкв/л (4–5 ммоль/л) хооронд тогтвортой байлгахын тулд эмчийн зааврaар калиумыг судсаар тариулна.

i. Өвчтөнд зүрхний тампонадын шинж тэмдгүүд илрэх эсэхийг хянана: өмнө нь их хэмжээгээр явагдаж байсан медиастиналь шингэн гарах нь гэнэт зогсох, цээжний өргөн судсаар тодорхой амьсгалын чимээ сонсогдох, баруун дэлс (RA) даралтын хэмжээ болон уушгины артерийн хавтан даралтын тэнцвэржилт, пульсус парадоксус (X.I хэсгийг үзнэ үү).

j. Өвдөлтийг хянаж, стернотомийн өвдөлтийг ангина өвдөлтөөс ялгах бөгөөд ангина өвдөлт нь графтын амжилтгүй байдлыг илтгэнэ.

7. Alarm safety ба alarm fatigue: IX бүлгийн C хэсгийн 14-р заалтыг үзнэ үү.

8. Зүрхний мэс заслын тасгаасаа үйлчлүүлэгчийг шилжүүлэх талбар

a. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралтыг хянах, ухамсарын түвшин болон периферийн цусны хангамжийг хянах.

b. Ритм алдааг хянах.

c. Уушги сонсож, амьсгалын байдлыг үнэл.

d. Өвчтөнд зүсэлтийг туузаар бэхлэх, ханиалгах, гүн амьсгал авах, ялгаралтыг нэмэгдүүлж ателектазыг урьдчилан сэргийлэхийн тулд урамшуулалтай спирометр ашиглахыг уриалах.

e. Халуун болон цагаан эсүүдийн тоог хянаж, хэрэв 3–4 хоногийн дараа өссөн бол халдварын шинж тэмдэг гэж үзнэ.

f. Шүлтийг шингэрүүлэхийн тулд зааврын дагуу хангалттай шингэн болон усыг нөхөх.

g. Оёдлын шугам болон цээжний сувгийн суулт хийсэн газруудад улайлт, идээ гарсан байдал, халдварын шинж тэмдгүүд илэрч байгааг шалга.

h. Стерналь оёдлын шугамыг тогтворгүй байдлаар үнэлэх ба энэ нь халдварын шинж тэмдэг байж болно.

i. Өвчтөнд үйл ажиллагаагаа аажмаар сэргээхэд нь зааварчилгаа өг.

j. Үйл ажиллагааны өмнө, явцад болон дараа өвчтөнд тахикарди, **байрлалын (ортостатик) гипотензи** болон ядаргааны шинж тэмдгийг үнэлнэ.

k. Цусны даралт 10–20 ммHg-аар буурсан эсвэл зүрхний цохилт минутанд 10-аас дээш удаа нэмэгдсэн тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсооно.

l. Өвдөлтийн давтамжийг нарийн ажигла.

m. Гэрийн асаргааны зааврыг 69-16 дугаар хайрцагт үзнэ үү.

XI. Нарийн төвөгтэй бөөр болон шээс дамжуулах замын асуудлууд

A. Уросепсис

1. Уросепсис нь шээсний замаас эхлэн үүсдэг грамма-сөрөг бактериеми юм.

2. Хамгийн түгээмэл үүсгэгч организм нь *Escherichia coli* юм.

3. Иммун тогтолцоо султай үйлчлүүлэгчид, а Ерөнхий шалтгаан нь дотор суурилуулсан шээс гаргах катетер эсвэл эмчлээгүй шээсний замын халдвар (UTI) юм.

4. Гол асуудал нь энэ бактери эсэргүүцэлтэй омгууд үүсгэх чадвартай явдал юм.

5. Уросепсис нь эрчимтэй эмчилгээ хийгдээгүй тохиолдолд септик шок үүсгэж болно.

6. Үнэлгээ: Халуурч байх нь хамгийн түгээмэл бөгөөд хамгийн эрт илэрдэг шинж тэмдэг юм.

7. Хэмжээ авах арга хэмжээ

   a. Антибиотик эмчилгээ эхлэхээс өмнө шээсний сорьцыг шээсний сувгийн судалгаа болон эмзэг байдлын шинжилгээнд авна.

   b. Антибиотикийг зааврааp судсаар, ихэвчлэн өвчтөн 3–5 хоног халуунгүй байх хүртэл өгнө.

   c. 3–5 хоног халуураагүй үед зааврааp аман антибиотик руу шилжинэ.

B. Тасралтгүй бөөрний орлуулах эмчилгээ

1. Тасралтгүй бөөрний орлуулах эмчилгээ (CRRT) нь 8–24 цагийн турш эсийн гаднах шингэнийг тасралтгүй ультрафильтраци хийж, шээсний хорт бодисыг цэвэрлэдэг; голчлон хурц бөөрний гэмтэл (AKI) эсвэл гемодиализийг тэсвэрлэж чадахгүй хүнд хэлбэрийн архаг бөөрний өвчтэй (CKD) өвчтөнүүдэд хэрэглэгддэг.

2. Ус, электролит болон бусад ууссан бодисууд нь өвчтөний цус гемофильтрын мембранаар дамжих үед зайлуулагддаг.

3. Ус болон электролитын хурдан хэлбэлзэл ерөнхийдөө тохиолддоггүй тул гемофильтрацийг хүнд өвчтэй өвчтөнүүд илүү сайн тэсвэрлэдэг.

4. CRRT-ийн 5 төрөл (69-17 дугаар хайрцагт) байдаг бөгөөд зарим нь гемодиализийн аппарат шаарддаг бол зарим нь системийг ажиллуулахдаа өвчтөний цусны даралтад тулгуурладаг.

5. Хэрэв CRRT-д гемодиализийн аппарат шаардагдахгүй бол өвчтөний дундаж артерийн даралт 60 ммHg-ээс дээш байлгах шаардлагатай бөгөөд артери ба венийн хангамжийн цэгүүд хэрэгтэй.

XII. Нарийн төвөгтэй мэдрэлийн асуудлууд

A. Травматик толгойн гэмтэл

1. Толгойн гэмтэл нь хавчгийн ясанд учирсан гэмтэл бөгөөд тархинд хөнгөнөөс өргөн цар хүрээтэй гэмтэл үүсгэдэг.

2. Шууд хүндрэлүүдэд тархины цус алдалт орно,

гематома, хяналтгүй өссөн тархины дотоод даралт (ICP), халдвар, болон таталт.

3. Зан ааш, зан төлөвийн өөрчлөлт, тархины мэдрэлийн дутагдал болон бусад үлдэгдэл дутагдал нь гэмтлийн байршил, гэмтлийн цар хүрээнээс хамаарна.

B. Толгойн гэмтлийн төрөл (Бох 69-18)

1. Нээлттэй
   a. Толгойн арьсны урагдал
   b. Гавлын ясны хугарал
   c. Хатуу эдийн тасалдал
2. Хаалттай
   a. Толгой цохилт
   b. Цохилтоос үүссэн гэмтэл
   c. Ясны хугарал

C. Цусны хураагдал

1. Субарахноидын цус алдалт эсвэл тархины доторх цус алдалтын улмаас эдэд цус хурагдах.

2. Үнэлгээ
   a. Үнэлгээний дүгнэлт гэмтлийн төрлөөс хамаарна.
   b. Клиник илрэлүүд ихэвчлэн тархины даралт (ICP) нэмэгдсэнээс үүсдэг.
   c. Өвчтөнд мэдрэлийн шинж тэмдгүүдийн өөрчлөлт
   d. Ухамсрын түвшний өөрчлөлт
   e. Амьсгалын зам ба амьсгалын хэв маягийн өөрчлөлтүүд
   f. Амьсгал, зүрхний цохилт, цусны даралт зэрэг амин чухал үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөж, тархины даралт нэмэгдсэнийг илтгэнэ (цусны даралт өсөж, зүрхний цохилтын даралт өргөжиж, цохилт удааширна)
   g. Толгой өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжих
   h. Харааны алдагдал, соовийн өөрчлөлт, папиллем
   i. **Хоёр хүзүүний булчингийн хатууралт** (нугасны гэмтлийг үгүйсгэсэн тохиолдолд туршиж болохгүй)
   j. Чих эсвэл хамарнаас тархи-нугасны шингэн (ЦНСШ) гоожих
   k. Сулралт ба саажилт
   l. Биеийн байрлал тогтоох
   m. Мэдрэхүй буурах эсвэл мэдрэхүй байхгүй болох
   n. Рефлексийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүд
   o. Таталт

ЦНС-ийн шингэнийг бусад шингэнүүдээс ялгаж болно

Шингэнийг цагаан ариутгасан дэвсгэр (жишээ нь марля) дээр тавихад төвөөсөө радиаль чиглэлд тархсан бөгжүүд (цусархаг шингэнийг шаргал туяагаар хүрээлсэн; хало шинж) илэрдэг. Мөн спинал шингэнийг тест туузаар шалгах үед глюкозын агууламж эерэг гардаг.

3. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. Амьсгалын байдлыг хянаж, амьсгалын замыг нээлттэй байлгах шаардлагатай, учир нь нүүрстөрөгчийн давхар исэл (CO_2)-ийн хэмжээ ихсэх нь тархины хаванг нэмэгдүүлдэг.

b. Нервийн байдал болон амин чухал үзүүлэлтүүдийг хянах тэмдгүүд, тэр дундаа температурыг хянах.

c. Тархины даралт нэмэгдэх эсэхийг хянах.

d. Сул булчирхайн даралт бууруулахын тулд толгойг өргөж байлга.

e. Хатууг нугарахыг сэргийл.

f. Халууралтыг бууруулахын тулд нормотермийн арга хэмжээг эхлүүлнэ.

g. Толгойн мэдрэлийн үйл ажиллагаа, рефлекс болон хөдөлгөөн, мэдрэхүйн үйл ажиллагааг үнэл.

h. Таталтын эсрэг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ав.

i. Өвдөлт, тайвангүй байдлыг хянана.

j. Вентиляторт байгаа толгой гэмтэлтэй өвчтөнд үүссэн түгшүүр, өвдөлтөөс үүдэлтэй тайвангүй байдлыг бууруулахын тулд морфин сульфат эсвэл опиоид эм бичиж өгч болно; уушгины амьсгалыг сааруулдаг тул болгоомжтой хэрэглэх ба тархины даралт нэмэгдэх эрсдэлтэй.

k. Хамраас эсвэл чихнээс ялгаралт гарч байгааг ажиглаарай, учир нь энэ шингэн тархи-ны шингэн байж болно.

l. Хамрыг цэвэрлэх гэж оролдохгүй эсвэл ялгаралт гарвал соруулах; үйлчлүүлэгч хамраа үлээхгүй байх хэрэгтэй.

m. Шингэн гоожиж байвал чихийг битгий цэвэрлэ илэрсэн бол, сул, хуурай, стериль боолтыг тавьж өгнө.

n. Шингэнээс тархины нугасны шингэн) байгаа эсэхийг шалгана.

o. Гадагшилт илэрвэл анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид мэдэгдээрэй

чихэн эсвэл хамарнаас ялгадас гарсан тохиолдолд болон ялгадас цэврүү шингэний шинжилгээ эерэг гарсан үед.

p. Өвчтөнд ханиалгахгүй байхыг зааж өг, учир нь энэ нь тархины дотоод даралт (ТДД)-ыг нэмэгдүүлдэг.

q. Халдварын шинж тэмдгүүдийг хянаарай.

r. Хөдөлгөөнгүй байдлаас үүдэх хүндрэлээс сэргийл.

s. Клиент болон түүний гэр бүлд тохиолдож болох зан байдлын өөрчлөлтүүдийн талаар, түүний дотор урьдчилан хүлээгдэж болох болон мэдэгдэх шаардлагатай өөрчлөлтүүдийн талаар мэдээлэх.

D. Краниотоми

1. Хуйхыг зүсэж хуримтлагдсан цус эсвэл хавдрыг авах мэс засал
2. Энэхүү процедурын хүндрэлүүдэд тархины хавагнаас үүдэлтэй тархины шүүрэлтийн даралт (ICP) нэмэгдэх, цус алдалт эсвэл цэврүү шингэний хэвийн урсгалыг хаах зэрэг орно.
3. Нэмэлт хүндрэлүүдэд гематома, гиповолемийн шок, гидроцефали, амьсгал болон мэдрэлийн гаралтай хүндрэл, уушгины хавагналт, шархны халдвар орно.
4. Шингэн болон электролитын холбоотой хүндрэлүүд

эн болон электролитийн тэнцвэргүй байдал нь инсипидус ийн шижин болон антидиуретик гормоны зохисгүй ялгаралтыг багтаана.

5. Стереотаксийн радиохирурги (SRS) нь уламжлалт мэс засалд орлуулагч байж болох ба ихэвчлэн хавдар болон артериовенозын малформацийг эмчлэхэд ашиглагддаг.

6. Мэс заслын өмнөх арга хэмжээ

a. Өвчтөн болон түүний гэр бүлд процедурыг тайлбарлах.

b. Өвчтөний толгойг зааврын дагуу хусах бэлтгэл хийх (ихэвчлэн мэс заслын өрөөнд) ба толгойг тохирох бүрхүүлээр бүрхэнэ.

c. Мэс засалд орохоос өмнө өвчтөнийг тогтворжуулах.

7. Мэс заслын дараах арга хэмжээ (69-19-р хайрцаг)
8. Мэс заслын дараах байрлал (69-20-р хайрцаг)

E. тархины даралт ихсэлт

1. Толгойн доторх даралт нэмэгдэх нь гэмтэл, цус алдалт, өсөлт эсвэл хавдар, гидроцефали, хаван эсвэл үрэвсэл.
2. Толгойн доторх даралт ихсэх нь тархинд цусны эргэлтийг саатуулж, цэнгэг булчирхайн шингэний шингээлтийг саатуулж, мэдрэлийн эсүүдийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж, тархины язгуур хэсгийг шахаж,

үхэл.

3. Үнэлгээ

a. Ухамсарын түвшин өөрчлөгдөх нь тархины даралт нэмэгдэж байгааг илтгэх хамгийн мэдрэг, эртний шинж тэмдэг юм
b. Толгой өвдөх
c. Амьсгалын хэвийн бус байдал
d. Цусны даралт өсөх, зүрхний цохилтын даралт өргөжих
e. Цусны цохилтын удаашил
f. Халуурал
g. Бүлтгэнэ
h. Соёо өөрчлөлт

4. Тархины даралт ихсэх хожуу шинж тэмдгүүдэд дараах зүйлс орно:

систолын цусны даралт, пульсийн даралт өргөсөх, зүрхний цохилтын давтамж удаашрах.

5. Бусад хожуу илрэх шинж тэмдгүүдэд сулралаас эхлэн хемиплеги хүртэлх хөдөлгөөний үйл ажиллагааны өөрчлөлт, эерэг **Бабинскийн рефлекс**, декортикацийн эсвэл декоцеребрацийн байрлал, таталт орно.

6. Эмчилгээний арга хэмжээ

a. Амьсгалын байдлыг хянах ба гипокси үүсэхээс сэргийлэх.
b. Гипокси үүсэхээс сэргийлэхийн тулд амьсгалыг дарангуйлагч морфин сульфат болон бусад опиоидыг хэрэглэхээс зайлсхий.
c. Заасан ёсоор механик амьсгалын аппаратыг үргэлжлүүлэн ашиглах; $_{PaCO_2}$-ийг 30–35 ммHg-д тогтвортой барих нь тархины судаснуудыг агшааж, цусны урсгалыг бууруулдаг.

   цусны урсгал буурч, улмаар тархины дотоод даралт буурна.
d. Биеийн температурыг тогтвортой барих.
e. Халууралт үүсэхээс сэргийлэх, учир нь энэ нь тархины даралт (ICP)-г нэмэгдүүлдэг.
f. Орчны өдөөлтийг бууруул.
g. Электролитийн түвшин болон хүчил-баасын тэнцвэрийг хянах.
h. Орц, гаралтыг хянах.
i. Шингэн хэрэглээг зааврын дагуу өдөрт 1200 мл-ээр хязгаарлах.
j. Клиентээс хүчтэй ханиалгах болон гэх мэт хүчтэй ачаалалтай үйлдлээс зайлсхийхийг зааварла.

ханиалгах.

k. Өвчтөнд Вальсальвагийн аргаар дарахгүй байхыг зааварлах.

Тархины дотоод даралт өндөр өвчтөнд толгойг өргөх орны толгойг 30–40°-аар өргөх, Тренделенбургийн байрлалыг зайлсхийх, хүзүү, бэлхүүсийн нугалалтыг сэргийлэх.

7. Эм бэлдмэлүүд (69-21-р хайрцаг)
8. Мэс заслын оролцоо: Мөн 38-р бүлэгт вентрикулоперитонеал шунтуудын (69-22-р хайрцаг) талаар нэмэлт мэдээлэл байна.

F. Нугасны гэмтэл

1. Нугасны гэмтэл нь мэдрэлийн замууд болон нейронуудын хэсэгчилсэн эсвэл бүрэн тасалдлыг үүсгэдэг.
2. Гэмтэл нь мөгөөрсний цохилт, урагдал эсвэл шахалтыг агуулж болно.
3. Нугасны хавдар үүсч; капиллярын эргэлт болон венийн буцалт доголдож, нугасны некроз үүсч болно.
4. Хөдөлгөөний үйл ажиллагаа, мэдрэхүй, рефлексийн үйл ажиллагаа, мөн гэдэс ба шээс хяналт алдагдах зэрэг үр дагаврууд үүсч болно.
5. Хамгийн түгээмэл шалтгаанд автомашины мөргөлдөөн, уналт, спортын болон үйлдвэрийн осол, бууны сумны болон хутганы шарх орно.
6. Гэмтэлтэй холбоотой хүндрэлүүдэд амьсгалын дутагдал, **автоном дисрефлексиа**, нугасны цочрол, нугасны дахин гэмтэл, нас баралт орно.
7. Ихэвчлэн гэмтдэг нугасны яс
   a. Цагаан хоолойн—C5, C6, C7
   b. Хэвлий—L1
   c. Бэлхүүсний—L1

G. Утас таслагдах

1. Сул сээр нугасны бүрэн таслалт: Сул сээр нугас бүрэн таслагдаж, гэмтлийн доорх хэсэгт мэдрэхүй, хөдөлгөөн болон рефлексийн үйл ажиллагаа бүрэн алдагддаг.
2. Сул сээр нугасны хэсэгчилсэн таслалт
   a. Нугасны мэдрэлийн зангилаа хэсэгчлэн гэмтсэн эсвэл тасарсан байна.
   b. Шинж тэмдгүүд гэмтлийн цар хүрээ, байршлаас хамаарна.
   c. Хэрвээ мөгөөрс сэргээшгүй гэмтэл аваагүй бол хэсэгчилсэн гэмтлийг бүрэн, байнгын гэмтэл болгохгүйн тулд эрт эмчилгээ хийх шаардлагатай.

H. Хагас таслагдалт эсвэл гэмтлийн үед үүсэх нугасны синдромууд (Зураг 69-29)

1. Төв мөгөөрсний синдром
    a. Нугасны төв хэсгийн гэмтлээс үүсдэг
    b. Хөдөлгөөний функцийн алдагдал дээд мөчүүдэд илүү тод илэрч, мэдрэхүйн янз бүрийн зэрэг, хэв маяг хэвийн үлддэг.
2. Урд утасны хам шинж
    a. Нугасны хар болон цагаан бодисын урд хэсэг гэмтсэнээс үүсдэг
    b. Хөдөлгөөний үйл ажиллагаа, өвдөлт болон температурын мэдрэмж гэмтлийн түвшнээс доош алдагддаг; харин байрлал, чичиргээ, хүрэлцэх мэдрэмж хэвээр үлддэг.
3. Хойд утасны хам шинж
    a. Сүүлэн утасны саарал болон цагаан бодисын арын хэсэг гэмтсэнээс үүдэлтэй
    b. Хөдөлгөөний үйл ажиллагаа хэвийн үлддэг ч өвчтөн чичиргээ мэдрэх, бүдүүн хүрэх болон байрлалын мэдрэмжээ алддаг.
4. Браун-Секардын хам шинж
    a. Хэвлийн нугасны хагарал үүсгэх эсвэл нугасны тал хувийг гэмтээх нэвтрэх гэмтлүүдийн үр дүн
    b. Хөдөлгөөний функц, чичиргээний мэдрэмж, биеийн байрлалын мэдрэмж болон гүн мэдрэх мэдрэмж гэмтэл эсвэл мөгөөрсний гэмтсэн тал дээр (ipsilateral) алдагддаг.
    c. Гэмтэл эсвэл мөгөөрсний гэмтлийн эсрэг талд (контралатераль) өвдөлт, температур болон хөнгөн хүрэх мэдрэмж алдагддаг.
5. Конус медиулларисийн хам шинж
    a. Бэлхүүсний мэдрэлийн үндэс болон нугасны конус медиуларис гэмтэхэд үүсдэг
    b. Өвчтөн гэдэс, давсагны рефлексгүй болон доод мөчнүүд сул байдаг.
    c. Хэрэв гэмтэл нурууны мэдрэлийн дээд сакрумын сегментүүдэд хязгаарлагдвал,

булбоспонгиозус пенис (босох) болон шээх рефлексүүд хадгалагдана.

6. Морьны сүүлний хам шинж
   a. Конус медилларисын доорх люмбосакраль мэдрэлийн үндсүүд гэмтсэнээс үүсдэг
   b. Өвчтөн гэдэс, давсагны болон доод рефлексийн арефлексиатай байна.

I. Нугасны гэмтлийн үнэлгээ (69-23-р хайрцаг)

1. Хонголын гэмтлийн түвшнээс хамаарна
2. Нугасны гэмтлийн түвшин: Мотор болон мэдрэхүйн үйл ажиллагаа хэвийн байгаа хамгийн доод нугасны сегмент

3. Амьсгалын төлөвт өөрчлөлтүүд
4. Гэмтлийн түвшнээс доош хөдөлгөөн ба мэдрэхүйн өөрчлөлтүүд
5. Гэмтлийн түвшнээс доош мэдрэхүйн бүрэн алдагдал ба хөдөлгөөний саажилт
6. Гэмтлийн түвшнээс доош рефлексийн алдагдал
7. Шээс ба өтгөний хяналтыг алдах
8. Шээс тогтолт ба давсагны суналт
9. Парализтэй хэсгүүдэд илэрдэггүй хөлс ялгаралт

J. Мэйлэгийн гэмтэл

1. C2–C3-ийн гэмтэл ихэвчлэн үхэлд хүргэдэг.
2. C4 нь френик мэдрэлийн тусламжтайгаар хөөвөр булчинд гол мэдрэлийн хангамж өгдөг.
3. C4-өөс дээш хэсэг гэмтэхэд амьсгалын хүндрэл болон дөрвөн мөч дамран саажилт үүсдэг.
4. Хэрвээ гэмтэл C5–C8-д тохиолдсон бол үйлчлүүлэгч мөрөө хөдөлгөж чадах бөгөөд амьсгалын нөөц нь буурсан байж болно.

K. Цээжний түвшний гэмтлүүд

1. Гэмтлийн түвшнээс хамааран цээж, биеийн туурь, гэдэс, давсаг болон хөлний хөдөлгөөн алдагдаж болно.
2. Хөл саажилт (параплегия) тохиолдож болно.
3. T6-аас дээш түвшний гэмтэл болон хүзүүний гэмтэлд автоном дисрефлекс үүсч болно.
4. Шээсний давсаг дүүрсэн эсвэл шулуун гэдэс бөглөрсөн зэрэг хортой өдөөлтөөс гэдэсний дүүрэлт үүсч, хөлс гарч, зүрхний цохилт удааширч, цусны даралт ихсэж, хамар битүүрэх, арьс үст босох зэрэг хариу урвал үүсгэж болно.

L. Бэлхүүс ба сүүлний түвшний гэмтэл

1. Доод мөчний хөдөлгөөн, мэдрэхүй алдагдах тохиолдол гарч болно.
2. S2 ба S3 төвүүд нь шээс гаргах үйлдэлд төвлөрдөг; тиймээс энэ төвүүдийн доор

түвшнээс доош давсаг агшиж, бохир гарахгүй (нейроген давсаг) болдог.

3. Эрэгтэйчүүдэд S2-ээс дээш түвшинд гэмтэл авсан тохиолдолд босох чадвартай байдаг ч симпатик мэдрэлийн гэмтлийн улмаас шингээлт хийж чадахгүй.
4. S2 ба S4-ийн хоорондох гэмтэл симпатик болон парасимпатик хариу үйлдлийг гэмтээж, босох болон шингээх үйлдлийг боломжгүй болгодог.

М. Яаралтай арга хэмжээ

Гэмтэл тохиолдсон үед нугасны гэмтэлгүй гэж баталгаажих хүртэл үргэлж нугасны гэмтэл болсон байж магадгүй гэж таамагла

бөглөгдөөгүй гэмтэл бүрэн болж хувирахаас сэргийлэхийн тулд өвчтөнийг толгойг нь төв байрлалд байлгаж, нурууны хавтан дээр тогтворжуулна.

1. Яаралтай тусламж зайлшгүй чухал бөгөөд буруу хөдөлгөөн нь илүү их гэмтэл үүсгэж, мэдрэлийн үйл ажиллагаа алдагдахад хүргэдэг.
2. Амьсгалын хэв маягийг үнэлж, амьсгалын замыг нээлттэй байлга.

3. Толгойг нугарах, эргэх эсвэл сунгахыг сэргийл.
4. Хөдөлгөөнгүй байлгах явцад толгойн таталт болон шулуун байрлалыг хадгалахын тулд чихний хоёр талд гараа тавьж тогтооно.
5. Толгойг сунгасан байрлалд хадгалах.
6. Өвчтөнийг логрролл аргаар эргүүлнэ.
7. Биеийн ямар ч хэсгийг мушгиж, эргүүлэх ёсгүй бөгөөд үйлчлүүлэгчийг суух байрлалд шилжихыг хориглоно.
8. Яаралтай тусламжийн тасагт хүзүүний ясны хугаралтай өвчтөнийг хүзүүний нугасыг хөдөлгөөнгүй байлгаж, хугарал болон шилжилтийг багасгахын тулд толгойн хавчаар эсвэл хэло таталтаар яаралтай скелетийн таталтанд оруулах ёстой.

N. Хэвтэн эмчлүүлэх үеийн арга хэмжээнүүд

1. Амьсгалын тогтолцоо
   a. Амьсгалын байдлыг үнэл, учир нь C4 гэмтэлтэй үед хавирган болон хэвлийн булчингийн саажилт үүсдэг.
   b. Артерийн цусны хийний түвшинг хянах ба ялангуяа хүзүүний гэмтлийн үед амьсгалын зогсолтоос сэргийлэхийн тулд зааварлагдсан бол механик амьсгалын аппаратыг үргэлжлүүлэн ашиглах.
   c. Гүнзгий амьсгал авах болон урамшуулах спирометр ашиглахыг уриалах.

d. Халдварын шинж тэмдгүүд, ялангуяа уушгины хатгалгааг хянах.

2. Зүрх-судасны тогтолцоо

a. Зүрхний ритмийн эмгэг илрэх эсэхийг хянах.

b. Ясны хугарлын орчимд цус алдалт эсвэл цус гоожих шинж тэмдгийг үнэлнэ.

c. Цус барах шинж тэмдгүүд, жишээлбэл цусны даралт буурах, зүрхний цохилт түргэсэх, сул ба нимгэн цохилт зэргийг үнэлнэ.

d. Доод мөчнүүдэд гүн судасны тромбоз илрүүлэх.

e. Булчингийн болон гуяны тойргийг хэмжиж, хэмжээ ихсэхийг илрүүлнэ.

f. Эмчийн зааврааp антиэмболийн оймс өмсүүлэх; арьсны бүрэн бүтэн байдлыг шалгахын тулд өдөр бүр тайлах.

g. Өвчтөний байрлалыг өөрчлөх үед ортостатик гипотензийг хянана.

3. Нейромускулын систем

a. Нервийн системийн байдлыг үнэл.

b. Гэмтлийн түвшинг тодорхойлохын тулд хөдөлгөөн ба мэдрэхүйн байдлыг үнэл.

c. Өвчтөний гарыг шахах, хуруунуудаа дэлгэх, хөлийн хуруунуудаа хөдөлгөх, хөлийг эргүүлэх чадварыг шалгах замаар хөдөлгөөний чадамжийг үнэлнэ.

d. Арьсыг хуруугаар хавчих эсвэл зүүгээр хатгах замаар мэдрэхүйн алдагдал, мэдрэх чадвар буурах эсвэл мэдрэх чадвар нэмэгдэхийг мөрнөөс эхлэн гар, хөл рүү доош шалгах.

e. Автоном дисрефлекси болон нугасны цочролын шинж тэмдгүүдийг хянаарай.

f. Өвчтөнийг хөдөлгөөнгүй байлгах замаар эдгэрэлтийг дэмжиж, цаашдын гэмтлээс сэргийлнэ.

g. Өвдөлтийг үнэл.

h. Өвдөлтийг бууруулах арга хэмжээг авч эхлэх.

i. Өвчин намдаах эмчилгээг зааврааp олгоно.

j. Хөдөлгөөнгүй байдлаас үүдэх хүндрэлүүдийг хянах.

k. Өвчтөнийг заасан тохиолдолд декомпрессийн ламинэктоми, нугасны нэгтгэл эсвэл багаж төхөөрөмж, саваа суулгах мэс засалд бэлтгэх.

l. Физиотерапевт болон хөдөлмөрийн эмчилгээний мэргэжилтэнтэй хамтран тохиромжтой дасгалын техникүүдийг тодорхойлж, гарын хэрэгцээг үнэлнэ

мөн бугуйн шилбүүр хэрэгслүүд, хөл унжихаас сэргийлэх зохистой төлөвлөгөө боловсруулах.

4. Хоол боловсруулах зам
    a. Хэвлийг хавагналт болон цус алдалттай эсэхийг үнэлнэ.
    b. Гутлын дуу чимээг хянаж, паралитик илеусыг үнэлнэ.
    c. Шээх-биеийн гацахыг урьдчилан сэргийлэх.
    d. Шаардлагатай бол гэдэсний хөдөлгөөнийг хянах хөтөлбөр эхлүүлэх.
    e. Хангалттай тэжээллэг хооллолт болон өндөр ширхэглэгтэй хоол хүнс хэрэглэх.
5. Бөөрний систем
    a. Шээс хавдлаас сэргийлэх.
    b. Шээс алдалтыг хянах хөтөлбөрийг шаардлагатай үед эхлүүлэх.
    c. Шингэн болон электролитийн тэнцвэрийг хадгалах.
    d. Хэрэв эсрэг заалтгүй бол өдөрт 2000 мл шингэн хангалттай хэмжээгээр хэрэглэнэ.
    e. Шээсний замын халдвар болон чулуужилт илрүүлэх.
6. Арьс ба салстын тогтолцоо
    a. Арьсны бүтэн байдлыг үнэл.
    b. Клиентийн доорх хөнжлийн даавуу үрчлээгүй байхыг хангана.
    c. Өвчтөнийг 2 цаг тутамд эргүүлнэ.
7. Сэтгэлзүйн болон нийгмийн бүрэн бүтэн байдал
    a. Сэтгэлзүйн болон нийгмийн байдлыг үнэл.
    b. Өвчтөнд уур хилэн, гутрал, алдагдлын мэдрэмжээ илэрхийлэхийг урамшуулах.
    c. Клиентийн бэлгийн асуудлуудыг хэлэлцэх.
    d. Өвчтөний боломжит үйл ажиллагааны түвшинд тулгуурлан бодитой зорилтуудыг тогтоож, өөрөө арчилгаа хийх арга хэмжээг ашиглан сэргээн засах үйл явцыг дэмжих.
    e. Тохиромжтой олон нийтийн нөөцтэй холбогдохыг дэмжинэ.

О. Хүзүүний болон мэдрэлийн шок

1. **Нугасны шок**: гэмтлийн дараах нугасны хариу үйлдэл болж, хөдөлгөөн, мэдрэхүй, рефлекс болон автоном мэдрэлийн үйл ажиллагаа бүрэн боловч түр зуурын хугацаанд алдагддаг. Ихэвчлэн 48 цагаас бага үргэлжилдэг ч хэдэн долоо хоног хүртэл үргэлжлэх тохиолдол бий.
2. **Нейроген шок**: Т6-аас дээш түвшний гэмтэлтэй өвчтөнүүдэд хамгийн түгээмэл тохиолдож, ихэвчлэн гэмтлийн дараах эхний үед илэрдэг. Судас их хэмжээгээр тэлж, цус судсанд болон эдүүдэд хуримтлагддаг.

цусны хангамж буурах, эсийн бодисын солилцоо алдагдах.

3. Үнэлгээ (69-23 дугаар хайрцгийг үзнэ үү)

4. Оролцоо

   a. Нугасны гэмтлийн дараах цочролын шинж тэмдгүүдийг хянах.
   b. Цусны даралт буурах, брадикардиа ажиглах.
   c. Рефлексийн үйл ажиллагааг хянах.
   d. Гутлын чимээг үнэл.
   e. Гарц болон шээс тогтохыг хянах.
   f. Шинж тэмдгийн илрэх байдлыг харгалзан эмчийн зааврааар дэмжлэгийн арга хэмжээ ав.
   g. Рефлексийн сэргэлтийг хянах.

P. **Автоном гиперрефлексиа**

1. Мөн автоном гиперрефлекси гэж нэрлэдэг
2. Энэ нь ихэвчлэн нугасны шок арилсны дараа үүсдэг бөгөөд T6-аас дээш байрлах гэмтэл, мөн хүзүүний гэмтэлтэй үед илэрдэг.
3. Энэ нь ихэвчлэн дүүрсэн давсаг эсвэл бөглөрсөн шулуун гэдэснээс үүдэлтэй дотоод эрхтний суналтаас үүсдэг.
4. Энэ нь мэдрэлийн яаралтай тусламж шаарддаг нөхцөл бөгөөд гипертензив харвалтаас сэргийлэхийн тулд яаралтай эмчилгээ шаардлагатай.
5. Үнэлгээ (69-23 дугаар хайрцгийг үзнэ үү)
6. Оролцоо (энэ нь Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх үйлдлүүд хэсгийг үзнэ үү)

Эмнэлгийн сувилахуйн тэргүүлэх арга хэмжээ

Нугасны гэмтэлтэй үйлчлүүлэгчийн автоном дисрефлекс

1. Орны толгойг өргөж, анхны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч (PHCP)-д мэдэгдэхийг хүс.
2. Өвчтөний чанга хувцсыг сулруул.
3. Шээсний давсагны томорсон эсэх болон бусад өвдөлтийн өдөөгч хүчин зүйлсийг шалга.
4. Цусны даралт бууруулах эм өг.
5. Тохиолдол, эмчилгээ болон хариу үйлдлийг баримтжуулна.

Дүгнэлт

Ignatavicius, Workman, Rebar (2018), 898-р тал.

Q. Хүзүүний нугасны таталт хүзүүний гэмтэлд

1. Ясны таталт нь хугаралтыг тогтворжуулах эсвэл

зүсэлт буюу дээд цээжний нугасны гаралтыг тогтворжуулахад ашиглагддаг.

2. Хүзүүний сунгалтыг хийхэд ашигладаг хоёр төрлийн тоног төхөөрөмж нь толгойн (хүзүүний) хавчаар болон хэло сунгалтын төхөөрөмж (хэло бэхэлгээний төхөөрөмж) юм.
3. Гавлын хавчаар
    a. Толгойн хавчаарыг үйлчлүүлэгчийн толгойн гадна талд суулгаж, таталт үйлддэг.
    b. Жин нь холбогддог

аранд, өвчтөнийг эсрэг таталтанд лана. Сувилагч жинг нэмэх эсвэл хасах ёсгүй.
    c. Тархины таталтанд нэмэх заасан жингийн хэмжээг тодорхойлно.
    d. Жинүүд бүх үед бат бөх, чөлөөтэй өлгөөтэй байхыг баталгаажуул.
    e. Тархины сунгалтын олсууд пуулийн дотор үлдэж байгааг баталгаажуулна.
    f. Биеийн байрлалыг зөв барьж, зааврын дагуу тусгай ор (жишээ нь RotoRest ор эсвэл Stryker, Foster каркас) дээр үйлчлүүлэгчийн асаргааг хийх.
    g. Клиентийг хоёр цаг тутамд эргүүлж бай.
    h. Хавчуурга зүүсэн газрыг халдвартай эсэхээр үнэл.
    i. Заасан ёсоор стериль зүүний талбайн арчилгаа хийх.
4. Хало таталт
    a. Halo traction нь статик таталтын төхөөрөмж бөгөөд толгойн хэсэгт 4 штифт (урд 2, хойд 2) суулгасан малгай хэлбэрийн толгойн бэхэлгээс бүрдэнэ.
    b. Хэрвээ нуруу тогтвортой бол металл хало бөгжийг хантааз (jacket) эсвэл гипст холбож, үйлчлүүлэгчийн хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
    c. Өвчтөний хөдөлгөөн эсвэл хүч сулрах зэрэг мэдрэлийн байдалд гарч буй өөрчлөлтийг хянана.
    d. Өвчтөнийг хэзээ ч хөдөлгөх, эргүүлэхгүй

таталтын төхөөрөмжийг барьж эсвэл татаж.
    e. Куртканы чангалалыг шалгахдаа куртканы доор нэг хуруу оруулах боломжтой эсэхийг баталгаажуулна.